

**INFORMACIÓN GENERAL**

Fecha de Impresión: 07/09/2026 16:00

Centro de atención: Z01 - Zaragoza

Paciente: CC 1050007455 - ANDERSON CASTILLO CARMONA

Fecha de Nacimiento: 25/07/1981

Religión:

Régimen: 2 - Subsidiado

Dirección: BRR BRUCELAS SECTOR LA COJUELA MZ E LOTE 2

Teléfono: 3145794157

Ocupación: 999: PERSONAS QUE NO HAN DECLARADO

OCUPACION

Grupo Poblacional:

Acompañante: SOLO

Teléfono Acomp.: 3145794157

Dirección Acomp.: MSMA DIRECCION

Responsable:

Teléfono Resp.: 3145794157

Dirección Resp.:

Médico Tratante: ARIEL ALONSO BELLO ESPINOSA

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Fecha de Atención: 13/04/2022 19:46

Admisión: AD706188

Edad: 40 año(s), 8 mes(es) 19 día(s)

Creencia:

Nivel: 1

Lugar: Cartagena Bolívar

Raza:

Parentesco Acomp.:

Parentesco Resp.: SOLO

Especialidad: MEDICINA INTERNA

Impreso por: FCAMACHO

Sexo: M

Estado Civil: Unión Libre

Carnet:

Etnia:

Tipo Vinculación:

EPICRISIS**DATOS DE LA CONSULTA**

Historia Clínica: Registro clínico de urgencias

Fecha de Ingreso: 12/01/2022 18:52

Cama: 4--15

Motivo de la Consulta:

" TENGO DIFICULTAD PARA RESPIRAR"

ANTECEDENTES:

* 1-> TUBERCULOSIS

* 2-> NIEGA

* 5-> NIEGA

* 6-> NIEGA

* 9-> 2 DOSIS DE SINOVAC

Síntesis de la Enfermedad:

PACIENTE MASCULINO DE 40 AÑOS DE EDAD INGRESA POR CUADRO CLINICO DE 40 AÑOS DE EDAD INGRESA POR CUADRO CLINICO DE 1 MES DE EVOLUCION CONSISTENTE EN TOS , HEMOPTISIS Y DISNEA MOTIVO POR EL CUAL CONSULTA

PACIENTE MASCULINO DE 40 AÑOS DE EDAD CON ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS, ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR. SE ACLARA QUE EL PACIENTE ES VIH NEGATIVO. ACTUALMENTE EN TRATAMIENTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR, QUIEN A PESAR DE 70 DÍAS DE TRATAMIENTO CON ADECUADA ADHERENCIA A ESQUEMA INTRAHOSPITALARIO, HA PERSISTIDO CON BK POSITIVO, POR LO TANTO, SE SOLICITÓ PRUEBA DE SENSIBILIDAD CON RESULTADO SENSIBLE EL 08/04/2022, DE ACUERDO A ESTOS HALLAZGOS, NO SE REALIZA MODIFICACIÓN EN TRATAMIENTO ESTABLECIDO, SE REALIZARÁ EXTENSIÓN DE TRATAMIENTO DE PRIMERA FASE PARA COMPLETAR 3 MESES, Y SE REALIZARÁ NUEVAMENTE BACILOSCOPIAS EN 3 SEMANAS PARA DEFINIR PASO A SEGUNDA FASE. SE ACORDO CON TRABAJADORA SOCIAL Y HOSTAL PERMANENCIA EN HABITACIÓN INDIVIDUAL. POR LO TANTO, SE AUTORIZA Y ESPERA TRASLADO A HOSTAL DONDE DEBERÁ CONTINUAR TRATAMIENTO ESTABLECIDO. SE EXPLICA A PACIENTE CONDUCTA MÉDICA A TOMAR, SE SOLUCIONAN DUDAS, REFIERE COMPRENDER.

Revisión Por Sistema:

NIEGA DEPOSICIONES LIQUIDAS, VOMITOS, MAREOS, CEFALEA, ARTRALGIAS, MIALGIAS

EXAMEN FISICO:**Apariencia a su llegada:**

REGULARES CONDICIONES GENERALES, SAPO2:97%

Cabeza, cara y órganos de los sentidos:

NORMOCEFALO, PUPILAS ISOCORICAS NORMOREACTIVAS A LA LUZ, MUCOSA ORAL SEMIHUMEDA, NO LESIONES, CUELLO SIMETRICO SIN MASAS NI ADENOPATIAS

Tórax:

SIMETRICO EXPANSIBLE SIN TIRAJES, RUIDOS CARDIACOS RITMICOS SIN SOPLOS, MURMULLO VESICULAR DISMINUIDO

Abdomen:

BLANDO DEPRESIBLE NO DOLOROSO, NO MASAS NI MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACION PERITONEAL

Piel y faneras:

NO PALIDEZ, NO ICTERICIA, NO HERIDAS, NO ULCERAS POR PRESION

Genito-Urinario:

No revisado

Extremidades:

SIMETRICAS HIPOTROFICAS SIN EDEMA LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS, PULSOS PERIFERICOS PRESENTES SIMETRICOS DE BUENA INTENSIDAD

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

Sistema nervioso central:

SIN DEFICIT APARENTE MOTOR NI SENSITIVO, CONSCIENTE, ALERTA, ORIENTADO, GLASGOW 15/15

Análisis:

PACIENTE MASCULINO DE 40 AÑOS DE EDAD INGRESA POR CUADRO CLINICO DE 40 AÑOS DE EDAD INGRESA POR CUADRO CLINICO DE 1 MES DE EVOLUCION CONSISTENTE EN TOS, HEMOPTISIS Y DISNEA MOTIVO POR EL CUAL CONSULTA A PUESTO DE SALUD DONDE DECIDEN REMITIR PARA VALORACION POR MEDICINA INTERNA. ACTUALMENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, SIGNOS VITALES DENTRO DE METAS, MURMULLO VESICULAR DISMINUIDO, POR LO ANTERIOR SE INGRESA PARA MANEJO

DIAGNÓSTICOS DE ENTRADA:

Diagnóstico Principal: A159 : TUBERCULOSIS RESPIRATORIA NO ESPECIFICADA, CONFIRMADA BACTERIOLOGICAMENTE E HISTOLOGICAMENTE

Diagnóstico Relacionado 1: U072 : COVID-19 (virus no identificado)

EVOLUCIONES:

Fecha: 13/01/2022: 13:14:54, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: JOSE DENNIS GONZALEZ CASTRO, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

1. SINDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA SECUNDARIA A:

1.1 CASO PROBABLE TUBERCULOSIS PULMONAR

1.2 NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD A DOCUMENTAR

2. HISTORIAL DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

3. INFECCIÓN POR TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS

Subjetivo:

SE VALORA PACIENTE QUIEN REFIERE HABER PASADO BUENA NOCHE, REFIERE MEJORIA DE LA DISNEA, TOS OCASIONAL, NIEGA SENSACIÓN FEBRIL. SIN NINGUN OTRO SINTOMA DE IMPORTANCIA

Objetivo:

TA: 138/91 MMHG FC: 107 LPM SAT: 94 % FIO2 21% FR: 24 RPMT 36.7°C GLASGOW 15/15

PACIENTE REGULARES CONDICIONES GENERALES, ALERTA, ORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA, TAQUICARDICO, TAQUIPNEICO, SIN CIANOSIS

CABEZA Y CUELLO: NORMOCEFALO, PUPILAS ISOCORICAS NORMOREACTIVAS A LA LUZ, MUCOSA ORAL SECA, CUELLO MOVL, SIMETRICO, NO ADENOPATIAS, SIN RIGIDEZ DE NUCA

TORAX: RUIDOS CARDIACOS TAQUICARDICOS SIN SOPLOS, NO S3, RUIDOS RESPIRATORIOS PRESENTES PERO DISMINUIDOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO DERECHO, NO CREPITOS, SIBILANCIAS OCASIONALES.

ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL.

EXTREMIDADES: SIMETRICAS HIPOTROFICAS SIN EDEMA LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS, PULSOS PERIFERICOS PRESENTES SIMETRICOS DE BUENA INTENSIDAD

SNC: SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE. GLASGOW 15/15.

PARACLÍNICOS

CL 98, K 4.4, NA 136, GLU 84, BUN 17, CREA 1.31, PCR 8.4, BT 0.3, BD 0.1, BI 0.20, AST 28, ALT 42

LEUC 19.61, N 17.17, L 1.01, E 0.03, HGB 12.1, HTO 43.4, VCM 72.3, HCM 20.3, CHB CM 28.0, IDE 20.4, PLT 551, TP 10.4, CONTROL 10.4, INR 1.0, TPT 28.8, CONTROL 27.8, VIH NEGATIVO

ANTIGENO SARS VOC 2 NEGATIVO

2022-01-12 TAC DE TÓRAX:

El parénquima pulmonar presenta opacidades reticulonodulares y opacidades alveolares en ambos campos pulmonares con areas de cavitacion por proceso inflamatorio cronico de origen granulomatoso . Atelectasia del pulmon izquierdo con desviacion del mediastino y de la silueta cardiaca hacia la izquierda. La vascularización pulmonar no presenta alteraciones.

Análisis:

PACIENTE MASCULINO EN LA QUINTA DECADA DE LA VIDA CON ANTECEDENTES DE TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS + REINFECCIÓN DE TUBERCULOSIS PULMONAR HACE 5 MESES QUE REQUIRIO HOSPITALIZACION EN UCI DEBIDO A CHOQUE HIPOVOLEMICO SECUNDARIO A HEMOPTISIS MASIVA, ADEMÁS CON ESTENOSIS ESOFAGICA MODERADA, DURANTE ESTANCIA PACIENTE SOLICITA DE ALTA VOLUNTARIA SIN TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO AMBULATORIO PARA TUBERCULOSIS PULMONAR . ACTUALMENTE INGRESA EN CONTEXTO DE SINDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA SECUNDARIA A POSIBLE TUBERCULOSIS PULMONAR VS NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD A DOCUMENTAR. CUENTA CON VIH NEGATIVO, TAC DE TÓRAX CON EL PARÉNQUIMA PULMONAR PRESENTA OPACIDADES RETICULONODULARES Y OPACIDADES ALVEOLARES EN AMBOS CAMPOS PULMONARES CON AREAS DE CAMTACION POR PROCESO INFLAMATORIO CRONICO DE ORIGEN GRANULOMATOSO . ATELECTASIA DEL PULMON IZQUIERDO CON DESVIACION DEL MEDIASTINO Y DE LA SILUETA CARDIACA HACIA LA IZQUIERDA. PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES CLINICA Y PROTEICOCALÓRICAS, CIFRAS TENSIONALES EN METAS, TAQUICARDICO, TAQUIPNEICO, ADECUADA SATURACIÓN A OXIGENO AMBIENTE, TOLERANDO VIA ORAL, AFEBRIL, DIURESIS PRESENTE. AL EXAMEN FISICO SE AUSCULTA DISMINUCION DE MURMULLO VESICULAR DE PREDOMINIO DERECHO Y LEVE BRONCOESPASMO. SE CONSIDERA HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGIA, SE SOLICITA BK SERIADO DE ESPUTO, CULTIVO DE ESPUTO CON EL FIN DE ESTABLECER CONFIRMACION BACTERIOLOGICA Y DESCARTAR RESISTENCIAS POR TUBERCULOSIS PULMONAR. ADEMÁS SE INDICA MANEJO DE RESCATE CON INHALADORES SABA Y LABA. SE EXPLICA A PACIENTE QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR.

Fecha: 14/01/2022: 08:47:08, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: JOSE DENNIS GONZALEZ CASTRO, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

PACIENTE MASCULINO DE 40 AÑOS DE EDAD CON DIAGNOSTICOS DE : 1. SINDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA SECUNDARIA A: 1.1 TUBERCULOSIS PULMONAR 1.2 NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD A DOCUMENTAR 2. HISTORIAL DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 3. INFECCIÓN POR TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS

Subjetivo:

PACIENTE QUIEN REFIERE HABER PASADO BUENA NOCHE CON MEJORIA DE LA DISNEA Y TOS, NIEGA OTRA SINTOMATOLOGIA ASOCIADA

Objetivo:

TA: 120/90 MMHG FC: 92 LPM SAT: 96 % CON CANULA NASAL A 3 LIT/MIN FR: 20 RPMT 36.7°C GLASGOW 15/15

PACIENTE EN ACEPTABLES CONDICIONES GENERALES, ALERTA, ORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA, EUCARDICO, EUNEIPCO, SIN CIANOSIS CABEZA Y CUELLO: NORMOCEFALO, PUPILAS ISOCORICAS NORMOREACTIVAS A LA LUZ, MUCOSA ORAL SECA, CUELLO MOVL, SIMETRICO, NO ADENOPATIAS, SIN RIGIDEZ DE NUCA TORAX: RUIDOS CARDIACOS RITMICOS SIN SOPLOS, NO S3, RUIDOS RESPIRATORIOS PRESENTES PERO DISMINUIDOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO DERECHO, NO CREPITOS, SIBILANCIAS OCASIONALES. ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMIDADES: SIMETRICAS HIPOTROFICAS SIN EDEMA LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS, PULSOS PERIFERICOS PRESENTES SIMETRICOS DE BUENA

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

INTENSIDAD SNC: SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE. GLASGOW 15/15.

PARACLÍNICOS 13/01/2022

CL 98, K 4.4, NA 136, GLU 84, BUN 17, CREA 1.31, PCR 8.4, BT 0.3, BD 0.1, BI 0.20, AST 28, ALT 42 LEUC 19.61, N 17.17, L 1.01, E 0.03, HGB 12.1, HTO 43.4, VCM 72.3, HCM 20.3, CHB CM 28.0, IDE 20.4, PLT 551, TP 10.4, CONTROL 10.4, INR 1.0, TPT 28.8, CONTROL 27.8, VIH NEGATIVO ANTIGENO SARS VOC 2 NEGATIVO

2022-01-12 TAC DE TÓRAX: El parénquima pulmonar presenta opacidades reticulonodulares y opacidades alveolares en ambos campos pulmonares con áreas de cavitación por proceso inflamatorio crónico de origen granulomatoso. Atelectasia del pulmón izquierdo con desviación del mediastino y de la silueta cardíaca hacia la izquierda. La vascularización pulmonar no presenta alteraciones.

Análisis:

PACIENTE MASCULINO EN LA QUINTA DECADA DE LA VIDA CON ANTECEDENTES DE TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS + REINFECCIÓN DE TUBERCULOSIS PULMONAR HACE 5 MESES QUE REQUIRIO HOSPITALIZACIÓN EN UCI DEBIDO A CHOQUE HIPOVOLEMICO SECUNDARIO A HEMOPTISIS MASIVA, ADEMÁS CON ESTENOSIS ESOFAGICA MODERADA, DURANTE ESTANCIA PACIENTE SOLICITA DE ALTA VOLUNTARIA SIN TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO AMBULATORIO PARA TUBERCULOSIS PULMONAR. ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE SINDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA SECUNDARIA A TUBERCULOSIS PULMONAR VS NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD A DOCUMENTAR. CUENTA CON VIH NEGATIVO, TAC DE TÓRAX CON EL PARÉNQUIMA PULMONAR PRESENTA OPACIDADES RETICULONODULARES Y OPACIDADES ALVEOLARES EN AMBOS CAMPOS PULMONARES CON ÁREAS DE CAVITACIÓN POR PROCESO INFLAMATORIO CRÓNICO DE ORIGEN GRANULOMATOSO. ATELECTASIA DEL PULMÓN IZQUIERDO CON DESVIACIÓN DEL MEDIASTINO Y DE LA SILUETA CARDÍACA HACIA LA IZQUIERDA. PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES PROTEICOCALÓRICAS, CIFRAS TENSIONALES EN METAS, EUCARDICO, EUPNEICO, ADECUADA SATURACIÓN CON CANULA NASAL A 3 LIT/MIN, TOLERANDO VIA ORAL, AFEBRIL, DIURESIS PRESENTE. SE ORDENA HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGIA, EN MANEJO CON INHALADORES SABA Y LABA, A LA ESPERA DE VALORACIÓN POR INFECTOLOGIA CRITICA Y RESULTADOS DE BK SERIADO DE ESPUTO, CULTIVO DE ESPUTO CON EL FIN DE ESTABLECER CONFIRMACIÓN BACTERIOLOGICA Y DESCARTAR RESISTENCIAS POR TUBERCULOSIS PULMONAR. SE EXPLICA A PACIENTE QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR.

Fecha: 15/01/2022: 10:23:41, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: DIEGO MORENO, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

PACIENTE MASCULINO DE 40 AÑOS DE EDAD CON DIAGNOSTICOS DE :

1. TUBERCULOSIS PULMONAR
2. HISTORIAL DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
3. INFECCIÓN POR TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS

Subjetivo:

PACIENTE QUIEN REFIERE HABER PASADO BUENA NOCHE CON MEJORA DE LA DISNEA Y TOS, NIEGA OTRA SINTOMATOLOGIA ASOCIADA

Objetivo:

TA: 120/90 MMHG FC: 92 LPM SAT: 96 % CON CANULA NASAL A 3 LIT/MIN FR: 20 RPM T 36.7°C GLASGOW 15/15 PACIENTE EN ACEPTABLES CONDICIONES GENERALES, ALERTA, ORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA, CABEZA Y CUELLO: PUPILAS ISOCORICAS NORMOREACTIVAS A LA LUZ, MUCOSA ORAL SECA, CUELLO MOVIL, SIMETRICO, NO ADENOPATIAS, SIN RIGIDEZ DE NUCA. TORAX: RUIDOS CARDIACOS RITMICOS SIN SOPLOS, NO S3, RUIDOS RESPIRATORIOS PRESENTES PERO DISMINUIDOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO DERECHO, NO CREPITOS, SIBILANCIAS OCASIONALES. ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMIDADES: SIMETRICAS HIPOTROFICAS SIN EDEMA LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS, PULSOS PERIFERICOS PRESENTES SIMETRICOS DE BUENA INTENSIDAD SNC: SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE. GLASGOW 15/15.

PARACLÍNICOS 13/01/2022

CL 98, K 4.4, NA 136, GLU 84, BUN 17, CREA 1.31, PCR 8.4, BT 0.3, BD 0.1, BI 0.20, AST 28, ALT 42 LEUC 19.61, N 17.17, L 1.01, E 0.03, HGB 12.1, HTO 43.4, VCM 72.3, HCM 20.3, CHB CM 28.0, IDE 20.4, PLT 551

TP 10.4, CONTROL 10.4, INR 1.0, TPT 28.8, CONTROL 27.8

VIH NEGATIVO ANTIGENO SARS COV 2 NEGATIVO

2022-01-12 TAC DE TÓRAX: El parénquima pulmonar presenta opacidades reticulonodulares y opacidades alveolares en ambos campos pulmonares con áreas de cavitación por proceso inflamatorio crónico de origen granulomatoso. Atelectasia del pulmón izquierdo con desviación del mediastino y de la silueta cardíaca hacia la izquierda. La vascularización pulmonar no presenta alteraciones.

Análisis:

PACIENTE MASCULINO EN LA QUINTA DECADA DE LA VIDA CON ANTECEDENTES DE TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS + REINFECCIÓN DE TUBERCULOSIS PULMONAR HACE 5 MESES QUE REQUIRIO HOSPITALIZACIÓN EN UCI DEBIDO A CHOQUE HIPOVOLEMICO SECUNDARIO A HEMOPTISIS MASIVA, ADEMÁS CON ESTENOSIS ESOFAGICA MODERADA, DURANTE ESTANCIA PACIENTE SOLICITA DE ALTA VOLUNTARIA SIN TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO AMBULATORIO PARA TUBERCULOSIS PULMONAR. TUBERCULOSIS PULMONAR VS NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD A DOCUMENTAR. CUENTA CON VIH NEGATIVO, TAC DE TÓRAX CON EL PARÉNQUIMA PULMONAR PRESENTA OPACIDADES RETICULONODULARES Y OPACIDADES ALVEOLARES EN AMBOS CAMPOS PULMONARES CON ÁREAS DE CAVITACIÓN POR PROCESO INFLAMATORIO CRÓNICO DE ORIGEN GRANULOMATOSO. ATELECTASIA DEL PULMÓN IZQUIERDO CON DESVIACIÓN DEL MEDIASTINO Y DE LA SILUETA CARDÍACA HACIA LA IZQUIERDA. PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES PROTEICOCALÓRICAS, CIFRAS TENSIONALES EN METAS, ADECUADA SATURACIÓN CON CANULA NASAL A 3 LIT/MIN, TOLERANDO VIA ORAL, AFEBRIL, DIURESIS PRESENTE. SE RECIBE REPORTE DE BACILOSCOPIA #1 Y 2 POSITIVOS, VALORADO POR INFECTOLOGIA CRITICA QUIEN CONSIDERA EVALUAR POR NEUMOLOGIA PARA BUSCAR RESISTENCIAS POR MALA ADHERENCIA DEL PACIENTE. SE ORDENA HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGIA, SE INICIA MANEJO CON TERAPIA RIPE Y PIRIDOXINA, CONTINUA MANEJO CON INHALADORES SABA Y LABA, SE EXPLICA A PACIENTE CONDICIÓN ACTUAL QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR.

Fecha: 16/01/2022: 16:00:11, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: DIEGO MORENO, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

PACIENTE MASCULINO DE 40 AÑOS DE EDAD CON DIAGNOSTICOS DE : 1. TUBERCULOSIS PULMONAR 2. HISTORIAL DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 3. INFECCIÓN POR TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS POR HC

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE DIFICULTAD PARA RESPIRAR Y AMLESTR GENERAL.

Objetivo:

TA: 120/90 MMHG FC: 92 LPM SAT: 96 % CON CANULA NASAL A 3 LIT/MIN FR: 20 RPM T 36.7°C GLASGOW 15/15

PACIENTE EN ACEPTABLES CONDICIONES GENERALES, ALERTA, ORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA, CABEZA Y CUELLO: PUPILAS ISOCORICAS NORMOREACTIVAS A LA LUZ, MUCOSA ORAL SECA, CUELLO MOVIL, SIMETRICO, NO ADENOPATIAS, SIN RIGIDEZ DE NUCA. TORAX: RUIDOS CARDIACOS RITMICOS SIN SOPLOS, NO S3, RUIDOS RESPIRATORIOS PRESENTES PERO DISMINUIDOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO DERECHO, NO CREPITOS, SIBILANCIAS OCASIONALES. ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMIDADES: SIMETRICAS HIPOTROFICAS SIN EDEMA LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS, PULSOS PERIFERICOS PRESENTES SIMETRICOS DE BUENA INTENSIDAD SNC: SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE. GLASGOW

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

15/15.

** PARACLÍNICOS 13/01/2022 CL 98, K 4.4, NA 136, GLU 84, BUN 17, CREA 1.31, PCR 8.4, BT 0.3, BD 0.1, BI 0.20, AST 28, ALT 42 LEUC 19.61, N 17.17, L 1.01, E 0.03, HGB 12.1, HTO 43.4, VCM 72.3, HCM 20.3, CHB CM 28.0, IDE 20.4, PLT 551 TP 10.4, CONTROL 10.4, INR 1.0, TPT 28.8, CONTROL 27.8 VIH NEGATIVO ANTIGENO SARS COV 2 NEGATIVO 2022-01-12

TAC DE TÓRAX: El parénquima pulmonar presenta opacidades reticulonodulares y opacidades alveolares en ambos campos pulmonares con áreas de cavitación por proceso inflamatorio crónico de origen granulomatoso. Atelectasia del pulmón izquierdo con desviación del mediastino y de la silueta cardiaca hacia la izquierda. La vascularización pulmonar no presenta alteraciones.

Análisis:

PACIENTE MASCULINO EN LA QUINTA DECADA DE LA VIDA CON ANTECEDENTES DE TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS + REINFECCIÓN DE TUBERCULOSIS PULMONAR HACE 5 MESES QUE REQUIRió HOSPITALIZACIÓN EN UCI DEBIDO A CHOQUE HIPOVOLEMICO SECUNDARIO A HEMOPTISIS MASIVA, ADEMÁS CON ESTENOSIS ESOFAGICA MODERADA, DURANTE ESTANCIA PACIENTE SOLICITA DE ALTA VOLUNTARIA SIN TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO AMBULATORIO PARA TUBERCULOSIS PULMONAR. ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR VS NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD A DOCUMENTAR. CUENTA CON VIH NEGATIVO, TAC DE TÓRAX CON EL PARÉNQUIMA PULMONAR PRESENTA OPACIDADES RETICULONODULARES Y OPACIDADES ALVEOLARES EN AMBOS CAMPOS PULMONARES CON ÁREAS DE CAVITACIÓN POR PROCESO INFLAMATORIO CRÓNICO DE ORIGEN GRANULOMATOSO. ATELECTASIA DEL PULMON IZQUIERDO CON DESVIACIÓN DEL MEDIASINO Y DE LA SILUETA CARDIACA HACIA LA IZQUIERDA. PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES PROTEICOCALÓRICAS, CIFRAS TENSIONALES EN METAS, ADECUADA SATURACIÓN CON CANULA NASAL A 3 LIT/MIN, TOLERANDO VIA ORAL, AFEBRIL, TAQUIPNEICO, DIURESIS PRESENTE. SE RECIBE REPORTE DE BACILOSCOPIA #1 Y 2 POSITIVOS, VALORADO POR INFECTOLOGIA CRITICA QUIEN CONSIDERA EVALUAR POR NEUMOLOGIA PARA BUSCAR RESISTENCIAS POR MALA ADHERENCIA DEL PACIENTE. SE ORDENA HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGIA, SE INICIA MANEJO CON TERAPIA RIPE Y PIRIDOXINA, CONTINUA MANEJO CON INHALADORES SABA Y LABA, SE SOLICITAN GASES ARTERIALES A ESPERA DE RESULTADO, SE EXPLICA A PACIENTE CONDICION ACTUAL QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR. ATENTOS A EVOLUCION.

Fecha: 17/01/2022: 08:49:54, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: JOSE DENNIS GONZALEZ CASTRO, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

DIAGNOSTICOS DE:

1. TUBERCULOSIS PULMONAR
2. HISTORIAL DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
3. INFECCIÓN POR TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS POR HC

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE HABER PASADO BUENA NOCHE, CON LEVE MEJORIA DE SINTOMATOLOGIA DE INGRESO

Objetivo:

TA: 120/90 MMHG FC: 92 LPM SAT: 96 % CON CANULA NASAL A 3 LIT/MIN FR: 20 RPM T 36.7°C GLASGOW 15/15 PACIENTE EN ACEPTABLES CONDICIONES GENERALES, ALERTA, ORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA, CABEZA Y CUELLO: PUPILAS ISOCORICAS NORMOREACTIVAS A LA LUZ, MUCOSA ORAL SECA, CUELLO MOVIL, SIMETRICO, NO ADENOPATIAS, SIN RIGIDEZ DE NUCA. TORAX: RUIDOS CARDIACOS RITMICOS SIN SOPLOS, NO S3, RUIDOS RESPIRATORIOS PRESENTES PERO DISMINUIDOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO DERECHO, NO CREPITOS, SIBILANCIAS OCASIONALES. ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMIDADES: SIMETRICAS HIPOTROFICAS SIN EDEMA LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS, PULSOS PERIFERICOS PRESENTES SIMETRICOS DE BUENA INTENSIDAD SNC: SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE. GLASGOW 15/15.

PARACLÍNICOS

- 13/01/2022 CL 98, K 4.4, NA 136, GLU 84, BUN 17, CREA 1.31, PCR 8.4, BT 0.3, BD 0.1, BI 0.20, AST 28, ALT 42 LEUC 19.61, N 17.17, L 1.01, E 0.03, HGB 12.1, HTO 43.4, VCM 72.3, HCM 20.3, CHB CM 28.0, IDE 20.4, PLT 551 TP 10.4, CONTROL 10.4, INR 1.0, TPT 28.8, CONTROL 27.8 VIH NEGATIVO ANTIGENO SARS COV 2 NEGATIVO

* 13/01/2021 bk 1, 2 y 3 POSITIVO PARA BARR

* 16/01/2021 GASES ARTERIALES: PH 7.365, PCO2 47.5, PO 66.2, HCO3 25.0, BE 1.2, SO2 90.0, PO2/FIO2 2.07, LACTATO 4.04, T 38.0, FIO2 32.0, AnGAP 10.8

IMAGENES

- 2022-01-12 TAC DE TÓRAX: El parénquima pulmonar presenta opacidades reticulonodulares y opacidades alveolares en ambos campos pulmonares con áreas de cavitación por proceso inflamatorio crónico de origen granulomatoso. Atelectasia del pulmón izquierdo con desviación del mediastino y de la silueta cardiaca hacia la izquierda. La vascularización pulmonar no presenta alteraciones.

Análisis:

PACIENTE MASCULINO EN LA QUINTA DECADA DE LA VIDA CON ANTECEDENTES DE TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS + REINFECCIÓN DE TUBERCULOSIS PULMONAR HACE 5 MESES QUE REQUIRió HOSPITALIZACIÓN EN UCI DEBIDO A CHOQUE HIPOVOLEMICO SECUNDARIO A HEMOPTISIS MASIVA, ADEMÁS CON ESTENOSIS ESOFAGICA MODERADA, DURANTE ESTANCIA PACIENTE SOLICITA DE ALTA VOLUNTARIA SIN TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO AMBULATORIO PARA TUBERCULOSIS PULMONAR. ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR VS NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD A DOCUMENTAR. CUENTA CON VIH NEGATIVO, TAC DE TÓRAX CON EL PARÉNQUIMA PULMONAR PRESENTA OPACIDADES RETICULONODULARES Y OPACIDADES ALVEOLARES EN AMBOS CAMPOS PULMONARES CON ÁREAS DE CAVITACIÓN POR PROCESO INFLAMATORIO CRÓNICO DE ORIGEN GRANULOMATOSO. ATELECTASIA DEL PULMON IZQUIERDO CON DESVIACIÓN DEL MEDIASINO Y DE LA SILUETA CARDIACA HACIA LA IZQUIERDA. PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES PROTEICOCALÓRICAS, CIFRAS TENSIONALES EN METAS, ADECUADA SATURACIÓN CON CANULA NASAL A 3 LIT/MIN, TOLERANDO VIA ORAL, AFEBRIL, TAQUIPNEICO, DIURESIS PRESENTE. SE RECIBE REPORTE DE BACILOSCOPIA #1, #2 Y #3 POSITIVOS, VALORADO POR INFECTOLOGIA CRITICA QUIEN CONSIDERA EVALUAR POR NEUMOLOGIA PARA BUSCAR RESISTENCIAS POR MALA ADHERENCIA DEL PACIENTE, LA CUAL SE ENCUENTRA PENDIENTE. SE ORDENA HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGIA, RECIBIENDO MANEJO CON TERAPIA RIPE Y PIRIDOXINA, CONTINUA MANEJO CON INHALADORES SABA Y LABA, ADEMÁS SE SOLICITA GENEXPERT. SE EXPLICA A PACIENTE CONDICION ACTUAL QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR. ATENTOS A EVOLUCION.

Fecha: 18/01/2022: 08:55:21, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: JOSE DENNIS GONZALEZ CASTRO, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

PACIENTE MASCULINO DE 40 AÑOS DE EDAD CON DIAGNOSTICOS DE: 1. TUBERCULOSIS PULMONAR 2. HISTORIAL DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 3. INFECCIÓN POR TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS POR HC

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE HABER PASADO BUENA NOCHE, CON LEVE MEJORIA DE SINTOMATOLOGIA DE INGRESO

Objetivo:

TA: 110/70 MMHG FC: 90 LPM SAT: 97 % CON CANULA NASAL A 3 LIT/MIN FR: 20 RPM T 36.5°C

PACIENTE EN ACEPTABLES CONDICIONES GENERALES, ALERTA, ORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA, CABEZA Y CUELLO: PUPILAS ISOCORICAS NORMOREACTIVAS A LA LUZ, MUCOSA ORAL SECA, CUELLO MOVIL, SIMETRICO, NO ADENOPATIAS, SIN RIGIDEZ DE NUCA. TORAX: RUIDOS

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

CARDIACOS RITMICOS SIN SOPLOS, NO S3, RUIDOS RESPIRATORIOS PRESENTES PERO DISMINUIDOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO DERECHO, NO CREPITOS, SIBILANCIAS OCASIONALES. ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMIIDADES: SIMÉTRICAS HIPOTROFICAS SIN EDEMA LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS, PULSOS PERIFÉRICOS PRESENTES SIMÉTRICOS DE BUENA INTENSIDAD SNC: SIN DÉFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE. GLASGOW 15/15.

Análisis:

PACIENTE MASCULINO EN LA QUINTA DÉCADA DE LA VIDA CON ANTECEDENTES DE TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS + REINFECCIÓN DE TUBERCULOSIS PULMONAR HACE 5 MESES QUE REQUIRIR HOSPITALIZACIÓN EN UCI DEBIDO A CHOQUE HIPOVOLEMICO SECUNDARIO A HEMOPTISIS MASIVA, ADÉMÁS CON ESTENOSIS ESOFAGICA MODERADA, DURANTE ESTANCIA PACIENTE SOLICITA DE ALTA VOLUNTARIA SIN TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO AMBULATORIO PARA TUBERCULOSIS PULMONAR. ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR. DURANTE RONDA MEDICA PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES PROTEICOCALÓRICAS, CLÍNICA Y HEMODINÁMICAMENTE ESTABLE, CIFRAS TENSIONALES EN METAS, EUCÁRDICO, EUNEIPCO, ADECUADA SATURACIÓN CON CANULA NASAL A 3 LIT/MIN, TOLERANDO VIA ORAL, AFEBRIL, DIURESIS PRESENTE. CUENTA CON VIH NEGATIVO, TAC DE TÓRAX CON EL PARÉNCQUIMA PULMONAR PRESENTA OPACIDADES RETICULONODULARES Y OPACIDADES ALVEOLARES EN AMBOS CAMPOS PULMONARES CON ÁREAS DE CAMTACION POR PROCESO INFLAMATORIO CRÓNICO DE ORIGEN GRANULOMATOSO. ATELECTASIA DEL PULMON IZQUIERDO CON DESVIACIÓN DEL MEDIASTINO Y DE LA SILUETA CARDIACA HACIA LA IZQUIERDA. REPORTE DE BACILOSCOPIA #1, #2 Y #3 POSITIVOS, FUE VALORADO POR NEUMOLOGÍA QUIENES CONSIDERAN QUE SE DEBE ENVIAR CULTIVO PARA BAAR CON PRUEBAS DE RESISTENCIA. TRATAMIENTO RIPE SE EXTENDERÁ LA PRIMERA FASE HASTA CUANDO EL CULTIVO Y LA RESISTENCIA SEA REPORTADA. ADÉMÁS SOLICITAR GENEXPERT MTB/RIF EN ESPUTO Y SI ESTE ES POSITIVO Y LA RESISTENCIA ES POSITIVA A RIFAMPICINA SUPONDREMOS TAMBIÉN RESISTENCIA A ISONIACIDA Y PROCEDEREMOS EN CONSECUENCIA POR EL MOMENTO CONTINUAR CON ORDEN DE HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA, EN MANEJO CON PIRIDOXINA, INHALADORES SABA Y LABA. SE INDICA TERAPIA RIPE SIN EMBARGO ACTUALMENTE NO SE ESTÁ ADMINISTRANDO POR TRÁMITES ADMINISTRATIVOS. PENDIENTE REPORTE DE GENEXPERT. SE EXPLICA A PACIENTE CONDICIÓN ACTUAL QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR. ATENTOS A EVOLUCIÓN.

Fecha: 19/01/2022: 08:39:03, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: JOSE DENNIS GONZALEZ CASTRO, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

PACIENTE MASCULINO DE 40 AÑOS DE EDAD CON DIAGNOSTICOS DE: 1. TUBERCULOSIS PULMONAR 2. HISTORIAL DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 3. INFECCIÓN POR TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS POR HC.

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE HABER PASADO BUENA NOCHE, CON LEVE MEJORA DE SINTOMATOLOGÍA DE INGRESO. SIN EMBARGO REFIERE SEGUIR AGITADO.

Objetivo:

TA: 115/80 MMHG FC: 90 LPM SAT: 8 % CON CANULA NASAL A 4 LIT/MIN FR: 20 RPM T 36.5°C PACIENTE EN ACEPTABLES CONDICIONES GENERALES, ALERTA, ORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA. CABEZA Y CUELLO: PUPILAS ISOCÓRICAS NORMOREACTIVAS A LA LUZ, MUCOSA ORAL SECA, CUELLO MOVIL, SIMÉTRICO, NO ADENOPATIAS, SIN RIGIDEZ DE NUCA. TORAX: RUIDOS CARDIACOS RÍTMICOS SIN SOPLOS, NO S3, RUIDOS RESPIRATORIOS PRESENTES PERO DISMINUIDOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO DERECHO, NO CREPITOS, SIBILANCIAS OCASIONALES. ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMIIDADES: SIMÉTRICAS HIPOTROFICAS SIN EDEMA LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS, PULSOS PERIFÉRICOS PRESENTES SIMÉTRICOS DE BUENA INTENSIDAD SNC: SIN DÉFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE. GLASGOW 15/15.

Análisis:

PACIENTE MASCULINO EN LA QUINTA DÉCADA DE LA VIDA CON ANTECEDENTES DE TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS + REINFECCIÓN DE TUBERCULOSIS PULMONAR HACE 5 MESES QUE REQUIRIR HOSPITALIZACIÓN EN UCI DEBIDO A CHOQUE HIPOVOLEMICO SECUNDARIO A HEMOPTISIS MASIVA, ADÉMÁS CON ESTENOSIS ESOFAGICA MODERADA, DURANTE ESTANCIA PACIENTE SOLICITA DE ALTA VOLUNTARIA SIN TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO AMBULATORIO PARA TUBERCULOSIS PULMONAR. ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR. DURANTE RONDA MEDICA PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES PROTEICOCALÓRICAS, CLÍNICA Y HEMODINÁMICAMENTE ESTABLE, CIFRAS TENSIONALES EN METAS, EUCÁRDICO, EUNEIPCO, ADECUADA SATURACIÓN CON CANULA NASAL A 3 LIT/MIN, TOLERANDO VIA ORAL, AFEBRIL, DIURESIS PRESENTE. CUENTA CON VIH NEGATIVO, TAC DE TÓRAX CON EL PARÉNCQUIMA PULMONAR PRESENTA OPACIDADES RETICULONODULARES Y OPACIDADES ALVEOLARES EN AMBOS CAMPOS PULMONARES CON ÁREAS DE CAMTACION POR PROCESO INFLAMATORIO CRÓNICO DE ORIGEN GRANULOMATOSO. ATELECTASIA DEL PULMON IZQUIERDO CON DESVIACIÓN DEL MEDIASTINO Y DE LA SILUETA CARDIACA HACIA LA IZQUIERDA. REPORTE DE BACILOSCOPIA #1, #2 Y #3 POSITIVOS, FUE VALORADO POR NEUMOLOGÍA QUIENES CONSIDERAN QUE SE DEBE ENVIAR CULTIVO PARA BAAR CON PRUEBAS DE RESISTENCIA. TRATAMIENTO RIPE SE EXTENDERÁ LA PRIMERA FASE HASTA CUANDO EL CULTIVO Y LA RESISTENCIA SEA REPORTADA. ADÉMÁS PENDIENTE GENEXPERT MTB/RIF EN ESPUTO Y SI ESTE ES POSITIVO Y LA RESISTENCIA ES POSITIVA A RIFAMPICINA SUPONDREMOS TAMBIÉN RESISTENCIA A ISONIACIDA Y PROCEDEREMOS EN CONSECUENCIA POR EL MOMENTO CONTINUAR CON ORDEN DE HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA, EN MANEJO CON PIRIDOXINA, INHALADORES SABA Y LABA. SE INDICA TERAPIA RIPE SIN EMBARGO ACTUALMENTE NO SE ESTÁ ADMINISTRANDO POR TRÁMITES ADMINISTRATIVOS. PENDIENTE REPORTE DE GENEXPERT. SE EXPLICA A PACIENTE CONDICIÓN ACTUAL QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR. ATENTOS A EVOLUCIÓN.

Fecha: 20/01/2022: 11:57:20, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGÍA

Problema:

PACIENTE MASCULINO DE 40 AÑOS DE EDAD CON DIAGNOSTICOS DE:

1. TUBERCULOSIS PULMONAR
2. HISTORIAL DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
3. INFECCIÓN POR TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS POR HC

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE HABER PASADO BUENA NOCHE, CON LEVE MEJORA DE SINTOMATOLOGÍA DE INGRESO. SIN EMBARGO REFIERE SEGUIR AGITADO.

Objetivo:

TA: 100/80 MMHG FC: 119 LPM FR: 22 RPM SAT: 98 % CON CANULA NASAL A 3 LIT/MIN FR: 20 RPM T 36.5°C PACIENTE EN ACEPTABLES CONDICIONES GENERALES, ALERTA, ORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA. CABEZA Y CUELLO: PUPILAS ISOCÓRICAS NORMOREACTIVAS A LA LUZ, MUCOSA ORAL SECA, CUELLO MOVIL, SIMÉTRICO, NO ADENOPATIAS, SIN RIGIDEZ DE NUCA. TORAX: RUIDOS CARDIACOS RÍTMICOS SIN SOPLOS, NO S3, RUIDOS RESPIRATORIOS PRESENTES PERO DISMINUIDOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO DERECHO, NO CREPITOS, SIBILANCIAS OCASIONALES. ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMIIDADES: SIMÉTRICAS HIPOTROFICAS SIN EDEMA LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS, PULSOS PERIFÉRICOS PRESENTES SIMÉTRICOS DE BUENA INTENSIDAD SNC: SIN DÉFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE. GLASGOW 15/15.

Análisis:

PACIENTE MASCULINO EN LA QUINTA DÉCADA DE LA VIDA CON ANTECEDENTES DESCRITOS ANTERIORMENTE ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR. DURANTE RONDA MEDICA PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES PROTEICOCALÓRICAS, CLÍNICA Y HEMODINÁMICAMENTE ESTABLE, CIFRAS TENSIONALES EN METAS, EUCÁRDICO, EUNEIPCO, ADECUADA SATURACIÓN CON CANULA NASAL A 3 LIT/MIN, TOLERANDO VIA ORAL, AFEBRIL, DIURESIS PRESENTE. CUENTA CON VIH NEGATIVO, EN EL DÍA DE HOY SE ENVIA TRATAMIENTO RIPE POR EL CUAL SE ESTÁ A LA ESPERA LA ADMINISTRACIÓN POR PARTE DE DADIS. ADÉMÁS POR EL MOMENTO CONTINUAR CON ORDEN DE HOSPITALIZACIÓN, EN MANEJO CON PIRIDOXINA, INHALADORES SABA Y LABA. SE SOLICITA HEMOGRAMA, PCR, TRANSAMINASAS CONTROL, FUNCIÓN RENAL CONTROL POR LO QUE

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

QUEDAMOS ATENTOS A EL REPORTE DE RESULTADOS PARA DEFINIR TERAPIA ANTIBIOTICA . PENDIENTE REPORTE DE GENEXPERT. SE EXPLICA A PACIENTE CONDICION ACTUAL QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR.QUEDAMOS ATENTOS A EVOLUCION.

Fecha: 21/01/2022: 09:42:00, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

PACIENTE MASCULINO DE 40 AÑOS DE EDAD CON DIAGNOSTICOS DE: 1. TUBERCULOSIS PULMONAR 2. HISTORIAL DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 3. INFECCIÓN POR TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS POR HC

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE HABER PASADO BUENA NOCHE, CON LEVE MEJORIA DE SINTOMATOLOGIA DE INGRESO. NIEGA FIEBRE, NAUSEAS U OTRA SINTOMATOLOGIA DE IMPORTANCIA

Objetivo:

TA: 100/70 MMHG FC: 103 LPM FR:20 RPM SAT: 98 % CON CANULA NASAL A 3 LIT/MIN FR: 20 RPM T 37°C PACIENTE EN ACEPTABLES CONDICIONES GENERALES, ALERTA, ORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA, CABEZA Y CUELLO: PUPILAS ISOCORICAS NORMOREACTIVAS A LA LUZ, MUCOSA ORAL SECA, CUELLO MOVIL, SIMETRICO, NO ADENOPATIAS, SIN RIGIDEZ DE NUCA. TORAX: RUIDOS CARDIACOS RITMICOS SIN SOPLOS, NO S3, RUIDOS RESPIRATORIOS PRESENTES PERO DISMINUIDOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO DERECHO, NO CREPITOS, SIBILANCIAS OCASIONALES. ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMIDADES: SIMETRICAS HIPOTROFICAS SIN EDEMA LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS, PULSOS PERIFERICOS PRESENTES SIMETRICOS DE BUENA INTENSIDAD SNC: SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE. GLASGOW 15/15.

Análisis:

PACIENTE MASCULINO EN LA QUINTA DECADA DE LA VIDA CON ANTECEDENTES DESCRITOS ANTERIORMENTE ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR. DURANTE RONDA MEDICA PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES PROTEICOCALÓRICAS, CLINICA Y HEMODINAMICAMENTE ESTABLE, CIFRAS TENSIONALES EN METAS, EUCARDICO, EUNEIPCO, ADECUADA SATURACIÓN CON CANULA NASAL A 3 LIT/MIN, TOLERANDO VIA ORAL, AFEBRIL, DIURESIS PRESENTE. CUENTA CON VIH NEGATIVO, EN EL DIA DE HOY SE SOLICITA TRATAMIENTO RIPE POR EL CUAL SE ESTAA LA ESPERA LA ADMINISTRACION POR PARTE DE DADIS ADEMÁS POR EL MOMENTO CONTINUA CON ORDEN DE HOSPITALIZACION, EN MANEJO CON PIRIDOXINA, INHALADORES SABA Y LABA. SE SOLICITA HEMOGRAMA, PCR, TRANSAMINASAS CONTROL, FUNCION RENAL CONTROL POR LO QUE QUEDAMOS ATENTOS A EL REPORTE DE RESULTADOS PARA DEFINIR TERAPIA ANTIBIOTICA . PENDIENTE REPORTE DE GENEXPERT. SE EXPLICA A PACIENTE CONDICION ACTUAL QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR.QUEDAMOS ATENTOS A EVOLUCION.

Fecha: 22/01/2022: 12:39:43, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: ORLANDO SANGUINO OMAÑA, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

PACIENTE MASCULINO DE 40 AÑOS DE EDAD CON DIAGNOSTICOS DE: 1. TUBERCULOSIS PULMONAR 2. HISTORIAL DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 3. INFECCIÓN POR TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS POR HC

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE HABER PASADO BUENA NOCHE, CON LEVE MEJORIA DE SINTOMATOLOGIA DE INGRESO. NIEGA FIEBRE, NAUSEAS U OTRA SINTOMATOLOGIA DE IMPORTANCIA

Objetivo:

TA: 100/70 MMHG FC: 103 LPM FR:20 RPM SAT: 98 % CON CANULA NASAL A 3 LIT/MIN FR: 20 RPM T 37°C PACIENTE EN ACEPTABLES CONDICIONES GENERALES, ALERTA, ORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA, CABEZA Y CUELLO: PUPILAS ISOCORICAS NORMOREACTIVAS A LA LUZ, MUCOSA ORAL SECA, CUELLO MOVIL, SIMETRICO, NO ADENOPATIAS, SIN RIGIDEZ DE NUCA. TORAX: RUIDOS CARDIACOS RITMICOS SIN SOPLOS, NO S3, RUIDOS RESPIRATORIOS PRESENTES PERO DISMINUIDOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO DERECHO, NO CREPITOS, SIBILANCIAS OCASIONALES. ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMIDADES: SIMETRICAS HIPOTROFICAS SIN EDEMA LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS, PULSOS PERIFERICOS PRESENTES SIMETRICOS DE BUENA INTENSIDAD SNC: SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE. GLASGOW 15/15.

Análisis:

PACIENTE MASCULINO EN LA QUINTA DECADA DE LA VIDA CON ANTECEDENTES DESCRITOS ANTERIORMENTE ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR. DURANTE RONDA MEDICA PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES PROTEICOCALÓRICAS, CLINICA Y HEMODINAMICAMENTE ESTABLE, CIFRAS TENSIONALES EN METAS, EUCARDICO, EUNEIPCO, ADECUADA SATURACIÓN CON CANULA NASAL A 3 LIT/MIN, TOLERANDO VIA ORAL, AFEBRIL, DIURESIS PRESENTE. CUENTA CON VIH NEGATIVO, EN EL DIA DE HOY SE SOLICITA TRATAMIENTO RIPE POR EL CUAL SE ESTAA LA ESPERA LA ADMINISTRACION POR PARTE DE DADIS ADEMÁS POR EL MOMENTO CONTINUA CON ORDEN DE HOSPITALIZACION, EN MANEJO CON PIRIDOXINA, INHALADORES SABA Y LABA. SE SOLICITA HEMOGRAMA, PCR, TRANSAMINASAS CONTROL, FUNCION RENAL CONTROL POR LO QUE QUEDAMOS ATENTOS A EL REPORTE DE RESULTADOS PARA DEFINIR TERAPIA ANTIBIOTICA . PENDIENTE REPORTE DE GENEXPERT. SE EXPLICA A PACIENTE CONDICION ACTUAL QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR.QUEDAMOS ATENTOS A EVOLUCION.

Fecha: 23/01/2022: 07:40:29, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: JAIME SARMIENTO CALDERON, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

PACIENTE MASCULINO DE 40 AÑOS DE EDAD CON DIAGNOSTICOS DE: 1. TUBERCULOSIS PULMONAR 2. HISTORIAL DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 3. INFECCIÓN POR TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS POR HC

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE PASAR BUENA NOCHE, CON PERSISTENCIA DE SINTOMAS RESPIRATORIOS

Objetivo:

TA: 100/70 MMHG FC: 103 LPM FR:20 RPM SAT: 98 % CON CANULA NASAL A 3 LIT/MIN FR: 20 RPM T 37°C PACIENTE EN ACEPTABLES CONDICIONES GENERALES, ALERTA, ORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA, CABEZA Y CUELLO: PUPILAS ISOCORICAS NORMOREACTIVAS A LA LUZ, MUCOSA ORAL SECA, CUELLO MOVIL, SIMETRICO, NO ADENOPATIAS, SIN RIGIDEZ DE NUCA. TORAX: RUIDOS CARDIACOS RITMICOS SIN SOPLOS, NO S3, RUIDOS RESPIRATORIOS PRESENTES PERO DISMINUIDOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO DERECHO, NO CREPITOS, SIBILANCIAS OCASIONALES. ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMIDADES: SIMETRICAS HIPOTROFICAS SIN EDEMA LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS, PULSOS PERIFERICOS PRESENTES SIMETRICOS DE BUENA INTENSIDAD SNC: SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE. GLASGOW 15/15

Análisis:

PACIENTE MASCULINO EN LA QUINTA DECADA DE LA VIDA CON ANTECEDENTES DESCRITOS ANTERIORMENTE ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR. DURANTE RONDA MEDICA PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES PROTEICOCALÓRICAS, CLINICA Y HEMODINAMICAMENTE ESTABLE, CIFRAS TENSIONALES EN METAS, EUCARDICO, EUNEIPCO, ADECUADA SATURACIÓN CON CANULA NASAL A 3 LIT/MIN, TOLERANDO VIA ORAL, AFEBRIL, DIURESIS PRESENTE. CUENTA CON VIH NEGATIVO, EN EL DIA DE HOY SE INICIA TRATAMIENTO RIPE, CON MANEJO DIA 2 DE ANTIBIOTICOS POR EL CUAL QUEDAMOS ATENTOS A SU EVOLUCION ADEMÁS POR EL MOMENTO CONTINUA CON ORDEN DE HOSPITALIZACION, EN MANEJO CON PIRIDOXINA, INHALADORES SABA Y LABA. . PENDIENTE REPORTE DE GENEXPERT. PENDIENTE HEMOCULTIVO Y CULTIVO DE ESPUTO. SE EXPLICA A PACIENTE CONDICION ACTUAL QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR.QUEDAMOS ATENTOS A EVOLUCION.

Fecha: 24/01/2022: 13:36:10, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

PACIENTE MASCULINO DE 40 AÑOS DE EDAD CON DIAGNOSTICOS DE:

1. TUBERCULOSIS PULMONAR
2. HISTORIAL DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
3. INFECCIÓN POR TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS POR HC

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE PASAR BUENA NOCHE, CON PERSISTENCIA DE SINTOMAS RESPIRATORIOS

Objetivo:

TA: 115/70 MMHG FC: 90 LPM FR:20 RPM SAT: 99 % CON MASCARA RESERVORIO A 15 LIT/MIN FR: 20 RPM T 37°C PACIENTE EN ACEPTABLES CONDICIONES GENERALES, ALERTA, ORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA, CABEZA Y CUELLO: PUPILAS ISOCORICAS NORMOREACTIVAS A LA LUZ, MUCOSA ORAL SECA, CUELLO MOVIL, SIMETRICO, NO ADENOPATIAS, SIN RIGIDEZ DE NUCA. TORAX: RUIDOS CARDIACOS RITMICOS SIN SOPLOS, NO S3, RUIDOS RESPIRATORIOS PRESENTES PERO DISMINUIDOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO DERECHO, NO CREPITOS, SIBILANCIAS OCASIONALES. ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMIDADES: SIMETRICAS HIPOTROFICAS SIN EDEMA LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS, PULSOS PERIFERICOS PRESENTES SIMETRICOS DE BUENA INTENSIDAD SNC: SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE. GLASGOW 15/15

Análisis:

PACIENTE MASCULINO EN LA QUINTA DECADA DE LA VIDA CON ANTECEDENTES DESCRITOS ANTERIORMENTE ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR. DURANTE RONDA MEDICA PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES PROTEICOCALÓRICAS, CLINICA Y HEMODINAMICAMENTE ESTABLE, CIFRAS TENSIONALES EN METAS, EUCARDICO, EUNEIPCO, SATURACIÓN EN METAS CON MASCARA DE NO REHINALACION A 15 L/MIN, POR LO CUAL SE INDICA DESTETE DE O2 SEGUN TOLERANCIA, SE SOLICITA GASES ARTERIALES Y REACTANTES DE FASE AGUDA CONTROL, SE ENCUENTRA PENDIENTE INICIAR TRATAMIENTO RIPE, TOLERADA ADECUADAMENTE, CON MANEJO DIA 3 DE ANTIBIOTICOS, CONTINUAMOS SEGUIMIENTO CLINICO. PENDIENTE REPORTE DE GENEXPERT. PENDIENTE HEMOCULTIVO Y CULTIVO DE ESPUTO. SE EXPLICA A PACIENTE CONDICION ACTUAL QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR. QUEDAMOS ATENTOS A EVOLUCION.

Fecha: 25/01/2022: 10:11:09, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

PACIENTE MASCULINO DE 40 AÑOS DE EDAD CON DIAGNOSTICOS DE: 1. TUBERCULOSIS PULMONAR 2. HISTORIAL DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 3. INFECCIÓN POR TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS POR HC

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE PASAR MALA NOCHE, REFIERE PERSISTENCIA DE DISNEA A MINIMOS ESFUERZOS, NIEGA FIEBRE Y OTRA SINTOMATOLOGIA

Objetivo:

TA: 110/80 MMHG FC: 63 LPM FR:20 RPM SAT: 99 % CON MASCARA RESERVORIO A 15 LIT/MIN FR: 20 RPM T 37°C PACIENTE EN ACEPTABLES CONDICIONES GENERALES, ALERTA, ORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA, CABEZA Y CUELLO: PUPILAS ISOCORICAS NORMOREACTIVAS A LA LUZ, MUCOSA ORAL SECA, CUELLO MOVIL, SIMETRICO, NO ADENOPATIAS, SIN RIGIDEZ DE NUCA. TORAX: RUIDOS CARDIACOS RITMICOS SIN SOPLOS, NO S3, RUIDOS RESPIRATORIOS PRESENTES PERO DISMINUIDOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO DERECHO, NO CREPITOS, SIBILANCIAS OCASIONALES. ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMIDADES: SIMETRICAS HIPOTROFICAS SIN EDEMA LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS, PULSOS PERIFERICOS PRESENTES SIMETRICOS DE BUENA INTENSIDAD SNC: SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE. GLASGOW 15/15

Análisis:

PACIENTE MASCULINO EN LA QUINTA DECADA DE LA VIDA CON ANTECEDENTES DESCRITOS ANTERIORMENTE ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR. DURANTE RONDA MEDICA PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES PROTEICOCALÓRICAS, CLINICA Y HEMODINAMICAMENTE ESTABLE, CIFRAS TENSIONALES EN METAS, EUCARDICO, EUNEIPCO, SATURACIÓN EN METAS CON MASCARA DE NO REHINALACION A 15 L/MIN, POR LO CUAL SE INDICA DESTETE DE O2 SEGUN TOLERANCIA, CON REPORTE DE GASES ARTERIALES Y REACTANTES DE FASE AGUDA CONTROL, DENTRO DE LIMITES. NOS ENCONTRAMOS PENDIENTE CON TRATAMIENTO RIPE EN EL CUAL SE TIENE PREVISTO DAR INICIO EL DIA DE HOY, CON MANEJO DIA 4 DE ANTIBIOTICOS, CONTINUAMOS SEGUIMIENTO CLINICO. PENDIENTE REPORTE DE GENEXPERT. PENDIENTE HEMOCULTIVO Y CULTIVO DE ESPUTO. SE EXPLICA A PACIENTE CONDICION ACTUAL QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR. QUEDAMOS ATENTOS A EVOLUCION

Fecha: 26/01/2022: 10:33:47, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

PACIENTE MASCULINO DE 40 AÑOS DE EDAD CON DIAGNOSTICOS DE: 1. TUBERCULOSIS PULMONAR 2. HISTORIAL DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 3. INFECCIÓN POR TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS POR HC

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE TENER BUEN NOCHE, NIEGA FIEBRE, REFIERE PERSISTENCIA DE DISNEA A PEQUEÑOS ESFUERZOS, NIEGA NAUSEAS, VOMITOS U OTRA SINTOMATOLOGIA

Objetivo:

TA: 110/80 MMHG FC: 117 LPM FR:22 RPM SAT: 97 % CON MASCARA RESERVORIO AL 50% FR: 20 RPM T 37°C PACIENTE EN ACEPTABLES CONDICIONES GENERALES, ALERTA, ORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA, CABEZA Y CUELLO: PUPILAS ISOCORICAS NORMOREACTIVAS A LA LUZ, MUCOSA ORAL SECA, CUELLO MOVIL, SIMETRICO, NO ADENOPATIAS, SIN RIGIDEZ DE NUCA. TORAX: RUIDOS CARDIACOS RITMICOS SIN SOPLOS, NO S3, RUIDOS RESPIRATORIOS PRESENTES PERO DISMINUIDOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO DERECHO, NO CREPITOS, SIBILANCIAS OCASIONALES. ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMIDADES: SIMETRICAS HIPOTROFICAS SIN EDEMA LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS, PULSOS PERIFERICOS PRESENTES SIMETRICOS DE BUENA INTENSIDAD SNC: SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE. GLASGOW 15/15

Análisis:

PACIENTE MASCULINO EN LA QUINTA DECADA DE LA VIDA CON ANTECEDENTES DESCRITOS ANTERIORMENTE ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR. DURANTE RONDA MEDICA PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES PROTEICOCALÓRICAS, CLINICA Y HEMODINAMICAMENTE ESTABLE, CIFRAS TENSIONALES EN METAS, EUCARDICO, EUNEIPCO, SATURACIÓN EN METAS CON MASCARA DE NO REHINALACION EL DIA DE HOY SE LE DECIDE BAJAR AL 50% POR MEJORIA PRESENTADA, EL DIA DE SE INICIA TRATAMIENTO RIPE EN EL CUAL NOS ENCONTRAMOS ATENTOS A SU EVOLUCION ANTE EL MISMO, CON MANEJO DIA 5 DE ANTIBIOTICOS, CONTINUAMOS SEGUIMIENTO CLINICO. PENDIENTE REPORTE DE GENEXPERT. PENDIENTE HEMOCULTIVO Y CULTIVO DE ESPUTO. SE EXPLICA A PACIENTE CONDICION ACTUAL QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR. QUEDAMOS ATENTOS A EVOLUCION

Fecha: 27/01/2022: 10:47:20, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: JORGE YEPES CARO, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

PACIENTE MASCULINO DE 40 AÑOS DE EDAD CON DIAGNOSTICOS DE: 1. TUBERCULOSIS PULMONAR 2. HISTORIAL DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 3. INFECCIÓN POR TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS POR HC

Subjetivo:

REFIERE TENER BUENA NOCHE NIEGA FIEBRE, REFIERE SINTOMATOLOGIAS RESPIRATORIAS, NIEGA CEFALIAS U OTRAS SINTOMATOLOGIAS

Objetivo:

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

TA: 100/60 MMHG FC: 91 LPM FR: 21 RPM SAT: 98 % CON MASCARA RESERVORIO AL 50% PACIENTE EN ACEPTABLES CONDICIONES GENERALES, ALERTA, ORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA. CABEZA Y CUELLO: PUPILAS ISOCORICAS NORMOREACTIVAS A LA LUZ, MUCOSA ORAL SECA, CUELLO MOVIL, SIMETRICO, NO ADENOPATIAS, SIN RIGIDEZ DE NUCA. TORAX: RUIDOS CARDIACOS RITMICOS SIN SOPLOS, NO S3, RUIDOS RESPIRATORIOS PRESENTES PERO DISMINUIDOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO DERECHO, NO CREPITOS, SIBILANCIAS OCASIONALES. ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACION, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACION PERITONEAL. EXTREMIDADES: SIMETRICAS HIPOTROFICAS SIN EDEMA LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS, PULSOS PERIFERICOS PRESENTES SIMETRICOS DE BUENA INTENSIDAD SNC: SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE. GLASGOW 15/15

Análisis:

PACIENTE MASCULINO EN LA QUINTA DECADA DE LA VIDA CON ANTECEDENTES DESCRITOS ANTERIORMENTE ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR. DURANTE RONDA MEDICA PACIENTE EN ACEPTABLES CONDICIONES PROTEICOCALÓRICAS, CLINICA Y HEMODINAMICAMENTE ESTABLE, CIFRAS TENSIONALES EN METAS, EUCARDICO, EUNEIPCO, SATURACIÓN EN METAS CON MASCARA DE NO REHINALACION EL DIA DE HOY SE LE DECIDE COLOCAR VENTURI AL 50% POR MEJORIA PRESENTADA POR LO TANTO SEGUIMOS OENDIENTE AL DESTETE DE OXIGENO SEGUN SEA TOLERANCIA DEL PACIENTE, EN EL DIA DE HOY NOS ENCONTRAMOS EN DIA 2 DE TRATAMIENTO RIPE EN EL CUAL ESTAMOS ATENTOS A SU EVOLUCION ANTE EL MISMO, CON MANEJO DIA 6 DE ANTIBIOTICOS, CONTINUAMOS SEGUIMIENTO CLINICO. PENDIENTE REPORTE DE GENEXPERT. PENDIENTE HEMOCULTIVO Y CULTIVO DE ESPUTO. SE EXPLICA A PACIENTE CONDICION ACTUAL QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR. QUEDAMOS ATENTOS A EVOLUCION

Fecha: 28/01/2022: 11:05:28, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

PACIENTE MASCULINO DE 40 AÑOS DE EDAD CON DIAGNOSTICOS DE: 1. TUBERCULOSIS PULMONAR 2. HISTORIAL DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 3. INFECCIÓN POR TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS POR HC

Subjetivo:

PACIENTE HABER TENIDO BUENA NOCHE, NIEGA FIEBRE, REFIERE DISNEA A MEDIADOS ESFUERZOS, NIEGA TOS U OTRA SINTOMATOLOGIA

Objetivo:

TA: 100/60 MMHG FC: 91 LPM FR: 21 RPM SAT: 98 % CON MASCARA RESERVORIO AL 50% PACIENTE EN ACEPTABLES CONDICIONES GENERALES, ALERTA, ORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA. CABEZA Y CUELLO: PUPILAS ISOCORICAS NORMOREACTIVAS A LA LUZ, MUCOSA ORAL SECA, CUELLO MOVIL, SIMETRICO, NO ADENOPATIAS, SIN RIGIDEZ DE NUCA. TORAX: RUIDOS CARDIACOS RITMICOS SIN SOPLOS, NO S3, RUIDOS RESPIRATORIOS PRESENTES PERO DISMINUIDOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO DERECHO, NO CREPITOS, SIBILANCIAS OCASIONALES. ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACION, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACION PERITONEAL. EXTREMIDADES: SIMETRICAS HIPOTROFICAS SIN EDEMA LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS, PULSOS PERIFERICOS PRESENTES SIMETRICOS DE BUENA INTENSIDAD SNC: SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE. GLASGOW 15/15 REPORTE DE ULTIMOS PARACLINICOS: 27/01/2022 LEUCOS 9.03, NEUTROF 82.3, HB 8.9, HTO 32.9, PLT 661, PCR 16.3,

Análisis:

PACIENTE MASCULINO EN LA QUINTA DECADA DE LA VIDA CON ANTECEDENTES DESCRITOS ANTERIORMENTE ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR. DURANTE RONDA MEDICA PACIENTE EN ACEPTABLES CONDICIONES PROTEICOCALÓRICAS, CLINICA Y HEMODINAMICAMENTE ESTABLE, CIFRAS TENSIONALES EN METAS, EUCARDICO, EUNEIPCO, SATURACIÓN EN METAS CON OXIGENO PVENTURY AL 50% POR MEJORIA PRESENTADA POR CONSIGUIENTE PENDIENTE A DESTETE DE OXIGENO SEGUN SEA TOLERANCIA DEL PACIENTE, EN EL DIA DE HOY NOS ENCONTRAMOS EN DIA 3 DE TRATAMIENTO RIPE EN EL CUAL ESTAMOS ATENTOS A SU EVOLUCION ANTE EL MISMO, CON MANEJO DIA 7 DE ANTIBIOTICOS, ADEMÁS SEGUIMOS EN MANEJO CON BRONCODILADORES INHALADOS Y SE SOLICITA VALORACION POR NUTRICION EL DIA DE HOY PARA CAMBIO DE DIETA ANTE MEJORIA PRESENTADA DEL PACIENTE. CONTINUAMOS ATENTOS A SU EVOLUCION CLINICA. PENDIENTE REPORTE DE GENEXPERT. PENDIENTE HEMOCULTIVO Y CULTIVO DE ESPUTO. SE EXPLICA A PACIENTE CONDICION ACTUAL QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR. QUEDAMOS ATENTOS A EVOLUCION

Fecha: 29/01/2022: 12:29:54, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: ORLANDO SANGUINO OMAÑA, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

PACIENTE MASCULINO DE 40 AÑOS DE EDAD CON DIAGNOSTICOS DE: 1. TUBERCULOSIS PULMONAR 2. HISTORIAL DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 3. INFECCIÓN POR TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS POR HC

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE TENER NOCHE REGULAR, REFIERE DISNEA A PEQUEÑOS ESFUERZOS, NIEGA TOS, NIEGA FIEBRE U OTRA SINTOMATOLOGIA

Objetivo:

TA: 100/60 MMHG FC: 91 LPM FR: 21 RPM SAT: 98 % CON MASCARA RESERVORIO AL 50% PACIENTE EN ACEPTABLES CONDICIONES GENERALES, ALERTA, ORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA. CABEZA Y CUELLO: PUPILAS ISOCORICAS NORMOREACTIVAS A LA LUZ, MUCOSA ORAL SECA, CUELLO MOVIL, SIMETRICO, NO ADENOPATIAS, SIN RIGIDEZ DE NUCA. TORAX: RUIDOS CARDIACOS RITMICOS SIN SOPLOS, NO S3, RUIDOS RESPIRATORIOS PRESENTES PERO DISMINUIDOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO DERECHO, NO CREPITOS, SIBILANCIAS OCASIONALES. ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACION, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACION PERITONEAL. EXTREMIDADES: SIMETRICAS HIPOTROFICAS SIN EDEMA LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS, PULSOS PERIFERICOS PRESENTES SIMETRICOS DE BUENA INTENSIDAD SNC: SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE. GLASGOW 15/15

Análisis:

PACIENTE MASCULINO EN LA QUINTA DECADA DE LA VIDA CON ANTECEDENTES DESCRITOS ANTERIORMENTE ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR. DURANTE RONDA MEDICA PACIENTE EN ACEPTABLES CONDICIONES PROTEICOCALÓRICAS, CLINICA Y HEMODINAMICAMENTE ESTABLE, CIFRAS TENSIONALES EN METAS, EUCARDICO, EUNEIPCO, SATURACIÓN EN METAS CON OXIGENO EN EL DIA DE HOY SE DECIDE CAMBIAR A MASCARA DE NO REHINALACION POR DISNEA PRESENTADA A PEQUEÑOS ESFUERZOS, ADEMÁS NOS ENCONTRAMOS EN DIA 4 DE TRATAMIENTO RIPE EN EL CUAL ESTAMOS ATENTOS A SU EVOLUCION ANTE EL MISMO, SE DECIDE SUSPENDER TERAPIA CON MANEJO DE ANTIBIOTICOS POR CUMPLIMIENTO ANTE EL TRATAMIENTO ESTABLECIDO, ADEMÁS SEGUIMOS EN MANEJO CON BRONCODILADORES INHALADOS CONTINUAMOS ATENTOS A SU EVOLUCION CLINICA. PENDIENTE REPORTE DE GENEXPERT. PENDIENTE HEMOCULTIVO Y CULTIVO DE ESPUTO. SE EXPLICA A PACIENTE CONDICION ACTUAL QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR. QUEDAMOS ATENTOS A EVOLUCION

Fecha: 30/01/2022: 11:46:24, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: ORLANDO SANGUINO OMAÑA, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

PACIENTE MASCULINO DE 40 AÑOS DE EDAD CON DIAGNOSTICOS DE: 1. TUBERCULOSIS PULMONAR 2. HISTORIAL DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 3. INFECCIÓN POR TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS POR HC.

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE PASAR NOCHE REGULAR. REGIERE DISNEA A PEQUEÑOS ESFUERZOS, NIEGA FIEBRE U OTRA SINTOMATOLOGIA

Objetivo:

A: 120/70 MMHG FC: 89 LPM FR: 22 RPM SAT: 98 % CON MASCARA RESERVORIO AL 50% PACIENTE EN ACEPTABLES CONDICIONES GENERALES, ALERTA, ORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA. CABEZA Y CUELLO: PUPILAS ISOCORICAS NORMOREACTIVAS A LA LUZ, MUCOSA ORAL SECA, CUELLO MOVIL, SIMETRICO, NO ADENOPATIAS, SIN RIGIDEZ DE NUCA. TORAX: RUIDOS CARDIACOS RITMICOS SIN SOPLOS, NO S3, RUIDOS RESPIRATORIOS PRESENTES PERO DISMINUIDOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO DERECHO, NO CREPITOS, SIBILANCIAS OCASIONALES. ABDOMEN:

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMIDADES: SIMÉTRICAS HIPOTROFICAS SIN EDEMA LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS, PULSOS PERIFÉRICOS PRESENTES SIMÉTRICOS DE BUENA INTENSIDAD SNC: SIN DÉFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE. GLASGOW 15/15

Análisis:

PACIENTE DE QUINTA DÉCADA DE LA VIDA CON ANTECEDENTES DESCRITOS ANTERIORMENTE, CON DIAGNÓSTICOS DE TUBERCULOSIS PULMONAR. ACTUALMENTE HEMODINÁMICAMENTE ESTABLE CON CIFRAS TENSIONALES EN METAS, TOLERANDO VÍA ORAL, CON CIFRAS DE SATURACIÓN EN METAS REQUIRIENDO MÁSCARA DE NO REHINALACIÓN A 10 LTS/MIN, EUCÁRDICO, EUPNEICO. EN RADIOGRAFÍA DE TÓRAX EN EL CUAL FUE TOMADO EL DÍA DE AYER REPORTA OPACIDADES PARENQUIMATOSAS DE OCUPACIÓN ALVEOLAR AMPLIAMENTE DISTRIBUIDAS LO LARGO DE HEMITORAX DERECHO ADEMÁS DE UNA HIPEROINSUFLACIÓN DEL MISMO. EL DÍA DE HOY SE LE SUSPENDE TERAPIA ANTIBIÓTICA DEBIDO A CUMPLIMIENTO REQUERIDO. CONTINUA CON TERAPIA RIPE EN EL CUAL SE ENCUENTRA EN DÍA 4. Y SE SOLICITA EL DÍA DE HOY ECOCARDIOGRAMA DEBIDO A EDEMA DE MIEMBROS INFERIORES Y DIFICULTAD RESPIRATORIA POR LO QUE NOS ENCONTRAMOS ATENTOS ANTE EL REPORTE. SE LE EXPLICA AL PACIENTE QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR

Fecha: 31/01/2022: 12:12:08, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGÍA

Problema:

PACIENTE MASCULINO DE 40 AÑOS DE EDAD CON DIAGNÓSTICOS DE:

1. TUBERCULOSIS PULMONAR
2. HISTORIAL DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
3. INFECCIÓN POR TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS POR HC

Subjetivo:

PACIENTE NIEGA DOLOR AL TRAGAR Y AL COMER REFIERE DISNEA AL BAJAR EL OXÍGENO

Objetivo:

TA: 100/70 MMHG FC: 103 LPM FR: 20 RPM SAT: 98 % CON CÁNULA NASAL A 3 LIT/MIN FR: 20 RPM T 37°C PACIENTE EN ACEPTABLES CONDICIONES GENERALES, ALERTA, ORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA. CABEZA Y CUELLO: PUPILAS ISOCÓRICAS NORMOREACTIVAS A LA LUZ, MUCOSA ORAL SECA, CUELLO MOVIL, SIMÉTRICO, NO ADENOPATIAS, SIN RIGIDEZ DE NUCA. TÓRAX: RUIDOS CARDÍACOS RÍTMICOS SIN SOPLOS, NO S3, RUIDOS RESPIRATORIOS PRESENTES PERO DISMINUIDOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO DERECHO, NO CREPITOS, SIBILANCIAS OCASIONALES. ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMIDADES: SIMÉTRICAS HIPOTROFICAS SIN EDEMA LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS, PULSOS PERIFÉRICOS PRESENTES SIMÉTRICOS DE BUENA INTENSIDAD SNC: SIN DÉFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE. GLASGOW 15/15

Análisis:

PACIENTE MASCULINO EN LA QUINTA DÉCADA DE LA VIDA CON ANTECEDENTES DESCRITOS ANTERIORMENTE ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR. DURANTE RONDA MÉDICA PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES PROTEICOLÓRICAS, CLÍNICA Y HEMODINÁMICAMENTE ESTABLE, CIFRAS TENSIONALES EN METAS, EUCÁRDICO, EUNEIPCO, SATURACIÓN EN METAS CON MÁSCARA DE NO REHINALACIÓN A 15 L/MIN, POR LO CUAL SE INDICA DESTETE DE O₂ SEGÚN TOLERANCIA, SIN EMBARGO AL INTENTAR DISMINUIR O₂ PACIENTE SE QUEJA DE DISNEA POR LO CUAL SE SOLICITA ECOCARDIOGRAMA DE MOMENTO SE CONTINUA TERAPIA RIPE INSTAURADA, TOLERADA ADECUADAMENTE, YA COMPLETO TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO PARA COINFECCIÓN POR LO CUAL SE SUSPENDE, CONTINUAMOS SEGUIMIENTO CLÍNICO. PENDIENTE REPORTE DE GENEXPERT. PENDIENTE HEMOCULTIVO Y CULTIVO DE ESPUTO. SE EXPLICA AL PACIENTE CONDICIÓN ACTUAL QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR. QUEDAMOS ATENTOS A EVOLUCIÓN.

Fecha: 01/02/2022: 13:11:30, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGÍA

Problema:

PACIENTE MASCULINO DE 40 AÑOS DE EDAD CON DIAGNÓSTICOS DE:

1. TUBERCULOSIS PULMONAR
2. HISTORIAL DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
3. INFECCIÓN POR TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS POR HC

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE PASAR BUENA NOCHE, CON PERSISTENCIA DE SÍNTOMAS RESPIRATORIOS

Objetivo:

TA: 140/80 MMHG FC: 71 LPM FR: 23 RPM SAT: 99 % CON CÁNULA NASAL A 3 LIT/MIN. PACIENTE EN ACEPTABLES CONDICIONES GENERALES, ALERTA, ORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA. CABEZA Y CUELLO: PUPILAS ISOCÓRICAS NORMOREACTIVAS A LA LUZ, MUCOSA ORAL SECA, CUELLO MOVIL, SIMÉTRICO, NO ADENOPATIAS, SIN RIGIDEZ DE NUCA. TÓRAX: RUIDOS CARDÍACOS RÍTMICOS SIN SOPLOS, NO S3, RUIDOS RESPIRATORIOS PRESENTES PERO DISMINUIDOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO DERECHO, NO CREPITOS, SIBILANCIAS OCASIONALES. ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMIDADES: SIMÉTRICAS HIPOTROFICAS SIN EDEMA LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS, PULSOS PERIFÉRICOS PRESENTES SIMÉTRICOS DE BUENA INTENSIDAD SNC: SIN DÉFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE. GLASGOW 15/15

Análisis:

PACIENTE MASCULINO EN LA QUINTA DÉCADA DE LA VIDA CON ANTECEDENTES DESCRITOS ANTERIORMENTE ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR. DURANTE RONDA MÉDICA PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES PROTEICOLÓRICAS, CLÍNICA Y HEMODINÁMICAMENTE ESTABLE, CIFRAS TENSIONALES EN METAS, EUCÁRDICO, EUNEIPCO, SATURACIÓN EN METAS CON MÁSCARA DE NO REHINALACIÓN A 10 L/MIN, QUE VENÍA EN DESTETE POR LO CUAL SE DECIDE SUSPENDER Y PASAR A VENTURÍA AL 50%, CON BUENA TOLERANCIA. DE MOMENTO SE CONTINUA TERAPIA RIPE INSTAURADA, TOLERADA ADECUADAMENTE, CONTINUAMOS SEGUIMIENTO CLÍNICO. PENDIENTE REPORTE DE GENEXPERT. PENDIENTE HEMOCULTIVO Y CULTIVO DE ESPUTO. PENDIENTE ECOCARDIOGRAMA TRAS TÓRAX. SE SOLICITA VALORACIÓN POR SERVICIO DE NUTRICIÓN PARA APOYO DE CONDICIONES NUTRICIONALES. SE EXPLICA AL PACIENTE CONDICIÓN ACTUAL QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR. QUEDAMOS ATENTOS A EVOLUCIÓN.

Fecha: 02/02/2022: 13:21:45, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGÍA

Problema:

PACIENTE MASCULINO DE 40 AÑOS DE EDAD CON DIAGNÓSTICOS DE:

1. TUBERCULOSIS PULMONAR
2. HISTORIAL DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
3. INFECCIÓN POR TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS POR HC

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE PASAR BUENA NOCHE, CON PERSISTENCIA DE SÍNTOMAS RESPIRATORIOS

Objetivo:

TA: 140/80 MMHG FC: 82 LPM FR: 22 RPM SAT: 98%. PACIENTE EN ACEPTABLES CONDICIONES GENERALES, ALERTA, ORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA. CABEZA Y CUELLO: PUPILAS ISOCÓRICAS NORMOREACTIVAS A LA LUZ, MUCOSA ORAL HUMEDA, CUELLO MOVIL, SIMÉTRICO, NO ADENOPATIAS, SIN RIGIDEZ DE NUCA. TÓRAX: RUIDOS CARDÍACOS RÍTMICOS SIN SOPLOS, NO S3, RUIDOS RESPIRATORIOS PRESENTES PERO DISMINUIDOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO DERECHO, NO CREPITOS, SIBILANCIAS OCASIONALES. ABDOMEN: BLANDO,

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMIDADES: SIMÉTRICAS HIPOTROFICAS SIN EDEMA LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS, PULSOS PERIFÉRICOS PRESENTES SIMÉTRICOS DE BUENA INTENSIDAD SNC: SIN DÉFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE. GLASGOW 15/15

PARACLINICOS:

01/02/22

-BUN:3 CREA0,66 K:3,9 NA:137 CL: 102 -AST:28 ALT:16 -LEU:10,70 NEU:80.3 LINF:6,6 HB:8,7 HTO:32,0 VCM:73,6 HCM:20 ADE:18,8 PLT:682

HEMOCULTIVO 1: NEGATIVO HEMOCULTIVO 2: NEGATIVO

BACILOSCOPIAS SERIADAS X3 POSITIVO PARA BAAR (+++)

Análisis:

PACIENTE MASCULINO DE 40 AÑOS DE EDAD CON ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS, ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR. DURANTE RONDA MÉDICA PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES PROTEICOCALÓRICAS, CLÍNICA Y HEMODINÁMICAMENTE ESTABLE, CIFRAS TENSIONALES ELEVADAS, EUCÁRDICO, EUNEIPCO, SATURACIÓN EN METAS CON MÁSCARA DE NO REHINALACIÓN A 10 L MN, QUE VENÍA EN DESTETE POR LO CUAL SE DECIDE SUSPENDER Y PASAR A VENTURIA AL 50%, CON BUENA TOLERANCIA, CON HEMOGRAMA QUE EVIDENCIA ANEMIA MICROCÍTICA HIPOCROMICA MODERADA SIN ALTERACIÓN DE LAS DEMÁS LINEAS CELULARES, FUNCIÓN HEPÁTICA Y RENAL CONSERVADA, CON HEMOCULTIVOS NEGATIVOS Y BACILOSCOPIAS POSITIVAS PARA BAAR. DE MOMENTO SE CONTINUA TERAPIA RIPE INSTAURADA, TOLERADA ADECUADAMENTE, CONTINUAMOS SEGUIMIENTO CLÍNICO. PENDIENTE REPORTE DE GENEXPERT. PENDIENTE ECOCARDIOGRAMA TRASNTORACICO. SE SOLICITA VALORACIÓN POR SERVICIO DE NUTRICIÓN PARA APOYO DE CONDICIONES NUTRICIONALES. SE EXPLICA A PACIENTE CONDICIÓN ACTUAL QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR. QUEDAMOS ATENTOS A EVOLUCIÓN.

Fecha: 03/02/2022: 13:09:47, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

PACIENTE MASCULINO DE 40 AÑOS DE EDAD CON DIAGNOSTICOS DE:

1. TUBERCULOSIS PULMONAR

2. HISTORIAL DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

3. INFECCIÓN POR TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS POR HC

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE PASAR BUENA NOCHE, CON PERSISTENCIA DE SÍNTOMAS RESPIRATORIOS

Objetivo:

TA: 140/80 MMHG FC: 82 LPM FR: 22 RPM SAT: 98%. PACIENTE EN ACEPTABLES CONDICIONES GENERALES, ALERTA, ORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA, CABEZA Y CUELLO: PUPILAS ISOCÓRICAS NORMOREACTIVAS A LA LUZ, MUCOSA ORAL HUMEDA, CUELLO MOVIL, SIMÉTRICO, NO ADENOPATIAS, SIN RIGIDEZ DE NUCA. TORAX: RUIDOS CARDÍACOS RÍTMICOS SIN SOPLOS, NO S3, RUIDOS RESPIRATORIOS PRESENTES PERO DISMINUIDOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO DERECHO, NO CREPITOS, SIBILANCIAS OCASIONALES. ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMIDADES: SIMÉTRICAS HIPOTROFICAS SIN EDEMA LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS, PULSOS PERIFÉRICOS PRESENTES SIMÉTRICOS DE BUENA INTENSIDAD SNC: SIN DÉFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE. GLASGOW 15/15

PARACLINICOS:

01/02/22

-BUN:3 CREA0,66 K:3,9 NA:137 CL: 102 -AST:28 ALT:16 -LEU:10,70 NEU:80.3 LINF:6,6 HB:8,7 HTO:32,0 VCM:73,6 HCM:20 ADE:18,8 PLT:682

HEMOCULTIVO 1: NEGATIVO HEMOCULTIVO 2: NEGATIVO

BACILOSCOPIAS SERIADAS X3 POSITIVO PARA BAAR (+++)

01/02/2022 REPORTE ECOCARDIOGRÁFICO

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA C.C: 1050007455

Edad: 40 años Sexo: M Entidad: MUTUAL SER

Fecha: 01 / 02 / 2022 4 PISO CAMA -15

Con Ecógrafo digital VMD S6. Transductor multipropósito y armónicas. Proyecciones paraesternal eje corto y largo, apical dos cámaras, eje largo, subcostal y paraesternal, con doppler pulsado, tisular, continuo y color se obtuvieron los siguientes resultados.

ESTRUCTURAMEDIDAS EN mm ESTRUCTURADOPPLER

Aurícula Izquierda Gradiente mitrales

Aorta Ondas E / A ? índice 93 / 43

Diám. Diastólico VI 47 Onda E prima lateral Septal ? 8 lateral ? 10 E/E ? 10.3

Diám. Sistólico VI 29 Área valvular mitral

F. de Acoramiento Desaceleración de E 137ms

F. de Eyección 69% TRIV

Pared Posterior 8 Gradientes aórticos

Septum IV 8 Presión sistólica pulmonar

Aurícula derecha Frecuencia cardíaca 78lpm

Ventrículo derecho 46 ÁREAS Y VOLUMENES

Vena cava inf. 12 Área ? volumen de la aurícula izquierda 18cm² / 51ml

Aorta abdominal Área ? volumen de la aurícula derecha 19cm² / 49ml

1. VENTRÍCULO IZQUIERDO: De tamaño normal, movimiento plano del septum durante sístole y diástole, masa 121gms, índice 90gm/m², grosor relativo 0.33, sin alteraciones de la contractilidad, volumen de fin de diástole 90ml, volumen de fin de sístole 36ml, calculándose fracción de eyección 60%.

2. AURÍCULA IZQUIERDA: Área 18cm², volumen 38ml/m². se observa incremento de refringencia posterior a la aurícula izquierda que puede corresponder con calcificaciones. Flujo turbulento en vena pulmonar superior derecha con velocidad máxima 2.13m/s.

3. AURÍCULA DERECHA: Área 19cm², volumen 36ml/m²

4. VALVULA MITRAL: Estructuralmente normal, insuficiencia trivial.

5. VALVULA TRICUSPIDE: Estructuralmente normal, insuficiencia leve calculándose presión sistólica del ventrículo derecho en 73mmHg, velocidad del jet regurgitante 4.21m/s TAPSE: 25mm, velocidad sistólica del anillo tricuspideo por doppler tisular 11cm/s.

6. VALVULA AÓRTICA: Trivalva, sin alteraciones por doppler.

7. VALVULA PULMONAR: Estructuralmente normal, sin alteraciones por doppler. Tronco, arteria pulmonar y ramas de aspecto normal.

8. VENTRÍCULO DERECHO: Dilatado, hipertrofia de la pared libre (9) mm de grosor, diámetro basal (46mm), cambio fraccional de área 40%.

9. SEPTAS: Integra sin evidencia de cortocircuitos.

10. AORTA Y GRANDES VASOS: Valsalva 32mm, unión sinotubular 24mm, ascendente 26mm, arco y descendente de calibre normal.

11. PERICARDIO: Libre.

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

12. VENA CAVA INFERIOR: 12mm, colapso inspiratorio mayor del 50%.

CONCLUSIONES:

Dilatación de cavidades derechas.

Hipertensión pulmonar severa.

Estenosis de vena pulmonar superior derecha (fibrosis mediastinal por TBC).

Insuficiencia tricúspidea leve.

Nota: Ritmo sinusal FC 78lpm.

Nota: se sugiere angeografía de venas pulmonares por TC.

DR EDINSON GARCIA TORRES CARDIOLOGO ECOCARDIOGRAFISTA RM. 012440091

Análisis:

PACIENTE MASCULINO DE 40 AÑOS DE EDAD CON ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS, ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR. DURANTE RONDA MEDICA PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES PROTEICOCALÓRICAS, CLINICA Y HEMODINAMICAMENTE ESTABLE, CIFRAS TENSIONALES ELEVADAS, EUCARDICO, EUNEIPCO, SATURACIÓN EN METAS CON MASCARA DE NO REHINALACION A 10 L MIN, QUE VENIA EN DESTETE POR LO CUAL SE DECIDE SUSPENDER Y PASAR A VENTURY AL 50%, CON BUENA TOLERANCIA, CON HEMOGRAMA QUE EVIDENCIA ANEMIA MICROCITICA HIPOCROMICA MODERADA SIN ALTERACION DE LAS DEMAS LINEAS CELULARES, FUNCION HEPÁTICA Y RENAL CONSERVADA, CON HEMOCULTIVOS NEGATIVOS Y BACILOSCOPIAS POSITIVAS PARA BAAR. DE MOMENTO SE CONTINUA TERAPIA RIPE INSTAURADA, TOLERADA ADECUADAMENTE, CONTINUAMOS SEGUIMIENTO CLINICO. PENDIENTE REPORTE DE GENEXPERT. SE RECIBE REPORTE DE ECOCARDIOGRAMA TRASNTORACICO EL CUAL EVIDENCIA Dilatación de cavidades derechas. Hipertensión pulmonar severa. Estenosis de vena pulmonar superior derecha (fibrosis mediastinal por TBC). Insuficiencia tricúspidea leve. Y SUGIERE REALIZACIÓN DE CATETERISMO. VALORADO POR SERVICIO DE NUTRICIÓN QUIENES INICIARAN SUPLEMENTACION NUTRICIONAL COMO REFUERZO A LAS COMIDAS PRINCIPAL CON UN APORTE DE PROTEINA DE 41.2 G POR TOMA Y 90 GR DE CARBOHIDRATOS. SE EXPLICA A PACIENTE CONDICION ACTUAL QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR. QUEDAMOS ATENTOS A EVOLUCION.}

Fecha: 04/02/2022: 12:40:30, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

1. TUBERCULOSIS PULMONAR
2. HISTORIAL DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
3. INFECCIÓN POR TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS POR HC

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE PASAR BUENA NOCHE, CON PERSISTENCIA DE SINTOMAS RESPIRATORIOS

Objetivo:

PACIENTE EN ACEPTABLES CONDICIONES GENERALES, ALERTA, ORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA, CABEZA Y CUELLO: PUPILAS ISOCORICAS NORMOREACTIVAS A LA LUZ, MUCOSA ORAL HUMEDA, CUELLO MOML, SIMETRICO, NO ADENOPATIAS, SIN RIGIDEZ DE NUCA. TORAX: RUIDOS CARDIACOS RITMICOS SIN SOPLOS, NO S3, RUIDOS RESPIRATORIOS PRESENTES PERO DISMINUIDOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO DERECHO, NO CREPITOS, SIBILANCIAS OCASIONALES. ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMIDADES: SIMETRICAS HIPOTROFICAS SIN EDEMA LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS, PULSOS PERIFERICOS PRESENTES SIMETRICOS DE BUENA INTENSIDAD SNC: SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE. GLASGOW 15/15

Análisis:

PACIENTE MASCULINO DE 40 AÑOS DE EDAD CON ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS, ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR. DURANTE RONDA MEDICA PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES PROTEICOCALÓRICAS, CLINICA Y HEMODINAMICAMENTE ESTABLE, CIFRAS TENSIONALES ELEVADAS, EUCARDICO, EUNEIPCO, SATURACIÓN EN METAS CON MASCARA DE NO REHINALACION A 10 L MIN, QUE VENIA EN DESTETE POR LO CUAL SE DECIDE SUSPENDER Y PASAR A VENTURY AL 50%, CON BUENA TOLERANCIA, CON HEMOGRAMA QUE EVIDENCIA ANEMIA MICROCITICA HIPOCROMICA MODERADA SIN ALTERACION DE LAS DEMAS LINEAS CELULARES, FUNCION HEPÁTICA Y RENAL CONSERVADA, CON HEMOCULTIVOS NEGATIVOS Y BACILOSCOPIAS POSITIVAS PARA BAAR. POR REPORTE ECOCARFIOGRAFICO QUE EVIDENCIA HIPERTENSIÓN PULMONAR SEVEREA, ESTENOSIS DE VENA PULMONAR SUPERIOR DERECHA SE SOLICITA CATETERISMO CARDIACO DERECHO COMO MANEJO TERAPEUTICO. DE MOMENTO SE CONTINUA TERAPIA RIPE INSTAURADA, TOLERADA ADECUADAMENTE, CONTINUAMOS SEGUIMIENTO CLINICO. PENDIENTE REPORTE DE GENEXPERT.

Fecha: 05/02/2022: 13:17:38, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: JAIME SARMIENTO CALDERON, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

ACIENTE MASCULINO DE 40 AÑOS DE EDAD CON DIAGNOSTICOS DE:

1. TUBERCULOSIS PULMONAR
2. HISTORIAL DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
3. INFECCIÓN POR TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS POR HC

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE PASAR BUENA NOCHE, CON PERSISTENCIA DE SINTOMAS RESPIRATORIOS

Objetivo:

TA: 140/80 MMHG FC: 82 LPM FR: 22 RPMSAT: 98%.

PACIENTE EN ACEPTABLES CONDICIONES GENERALES, ALERTA, ORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA, CABEZA Y CUELLO: PUPILAS ISOCORICAS NORMOREACTIVAS A LA LUZ, MUCOSA ORAL HUMEDA, CUELLO MOML, SIMETRICO, NO ADENOPATIAS, SIN RIGIDEZ DE NUCA. TORAX: RUIDOS CARDIACOS RITMICOS SIN SOPLOS, NO S3, RUIDOS RESPIRATORIOS PRESENTES PERO DISMINUIDOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO DERECHO, NO CREPITOS, SIBILANCIAS OCASIONALES. ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMIDADES: SIMETRICAS HIPOTROFICAS SIN EDEMA LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS, PULSOS PERIFERICOS PRESENTES SIMETRICOS DE BUENA INTENSIDAD SNC: SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE. GLASGOW 15/15

04/02/2022: BUN:11 CREAT: 0.52 SODIO:137 CLORO:102 K:4.0 TP 10.5 INR 1.0 TPP 30.3

HEMOGRAMA: LEU:11.19 NEU:9.12 LINF: 0.67 HB: 9.2 HTO:33.3 PLQ:698

Análisis:

PACIENTE MASCULINO DE 40 AÑOS DE EDAD CON ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS, ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR. DURANTE RONDA MEDICA PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES PROTEICOCALÓRICAS, CLINICA Y HEMODINAMICAMENTE ESTABLE, CIFRAS TENSIONALES ELEVADAS, EUCARDICO, EUNEIPCO, SATURACIÓN EN METAS CON MASCARA DE NO REHINALACION A 10 L MIN, QUE VENIA EN DESTETE POR LO CUAL SE DECIDE SUSPENDER Y PASAR A VENTURY AL 50%, CON BUENA TOLERANCIA, CON HEMOGRAMA QUE EVIDENCIA ANEMIA MICROCITICA HIPOCROMICA MODERADA SIN ALTERACION DE LAS DEMAS LINEAS CELULARES, FUNCION RENAL CONSERVADA, PACIENTE EN CONDICION DE HABITANTE DE LA CALLE ACTUALMENTE OXIGENO DEPENDIENTE POR LO CUAL SE SOLICITA VALORACIÓN POR TRABAJO SOCIAL, SE EXPLICA CONDUCTA A PACIENTE QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

Fecha: 06/02/2022: 11:40:11, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: JAIME SARMIENTO CALDERON, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

1. DISNEA SEC:

1.1. TUBERCULOSIS PULMONAR ACTIVA

1.1.1. TUBERCULOSIS MEDISTINICA

1.1.1.1. HIPERTENSION PULMONAR SEVERA

1.1.1.1.1 ESTENOSIS DE LA VENA PULMONAR IZQUIERDA SUPERIOR

1.2. NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD CURB 65 2 PUNTOS RESUELTA

2. ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIA PSICOATIVAS

3. ANTECEDENTES DE TBC HACE 4 AÑOS NO ADHERENTE AL TRATAMIENTO

4. ANTECEDENTES DE HEMOPTISIS MASIVA (2021)

5. ANTECEDENTES DE ESTENOSIS ESOFAGICA(UNION ESOFAGO PROXIMA Y MEDIO DE 2CM) CON REQUERIMIENTO DE DILATACIÓN NTES DE TBC HACE 4 AÑOS NO ADHERENTE AL TRATAMIENTO

4. ANTECEDENTES DE HEMOPTISIS MASIVA (2021)

5. ANTECEDENTES DE ESTENOSIS ESOFAGICA(UNION ESOFAGO PROXIMA Y MEDIO DE 2CM) CON REQUERIMIENTO DE DILATACIÓN

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE PASAR BUENA NOCHE, CON PERSISTENCIA DE SINTOMAS RESPIRATORIOS

Objetivo:

TA: 110/60 MMHG FC: 98 LPM FR: 22 RPM SAT: 99%.

PACIENTE EN ACEPTABLES CONDICIONES GENERALES, ALERTA, ORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA, CABEZA Y CUELLO: PUPILAS ISOCORICAS NORMOREACTIVAS A LA LUZ, MUCOSA ORAL HUMEDA, CUELLO MOVIL, SIMETRICO, NO ADENOPATIAS, SIN RIGIDEZ DE NUCA. TORAX: RUIDOS CARDIACOS RITMICOS SIN SOPLOS, NO S3, RUIDOS RESPIRATORIOS PRESENTES PERO DISMINUIDOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO DERECHO, NO CREPITOS, SIBILANCIAS OCASIONALES. ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMIDADES: SIMETRICAS HIPOTROFICAS SIN EDEMA LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS, PULSOS PERIFERICOS PRESENTES SIMETRICOS DE BUENA INTENSIDAD SNC: SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE. GLASGOW 15/15

04/02/2022: BUN:11 CREAT: 0.52 SODIO:137 CLORO:102 K:4.0 TP 10.5 INR 1.0 TPP 30.3

HEMOGRAMA: LEU:11.19 NEU:9.12 LINF: 0.67 HB: 9.2 HTO:33.3 PLQ:698

Análisis:

PACIENTE MASCULINO DE 40 AÑOS DE EDAD CON ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOATIVAS Y TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS, ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR. DURANTE RONDA MEDICA PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES PROTEICOCALÓRICAS, CLINICA Y HEMODINAMICAMENTE ESTABLE, CIFRAS TENSIONALES ELEVADAS, EUCARDICO, EUNEIPCO, SATURACIÓN EN METAS, MANIFIESTA QUE DESEA QUE LE RETIREN EL VENTURY POR LO CUAL SE ORDENA OXIGENOTERAPIA CON CÁNULA NASAL, CON HEMOGRAMA QUE EVIDENCIA ANEMIA MICROCITICA HIPOCROMICA MODERADA SIN ALTERACION DE LAS DEMAS LINEAS CELULARES, FUNCION RENAL CONSERVADA, PACIENTE EN CONDICION DE HABITANTE DE LA CALLE ACTUALMENTE OXIGENO DEPENDIENTE POR LO CUAL SE ENCUENTRA PENDIENTE LA VALORACIÓN POR TRABAJO SOCIAL, SE EXPLICA CONDUCTA A PACIENTE QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR

Fecha: 07/02/2022: 12:17:59, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

1. DISNEA SEC:

1.1. TUBERCULOSIS PULMONAR ACTIVA

1.1.1. TUBERCULOSIS MEDISTINICA

1.1.1.1. HIPERTENSION PULMONAR SEVERA

1.1.1.1.1 ESTENOSIS DE LA VENA PULMONAR IZQUIERDA SUPERIOR

1.2. NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD CURB 65 2 PUNTOS RESUELTA

2. ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIA PSICOATIVAS

3. ANTECEDENTES DE TBC HACE 4 AÑOS NO ADHERENTE AL TRATAMIENTO

4. ANTECEDENTES DE HEMOPTISIS MASIVA (2021)

5. ANTECEDENTES DE ESTENOSIS ESOFAGICA(UNION ESOFAGO PROXIMA Y MEDIO DE 2CM) CON REQUERIMIENTO DE DILATACIÓN NTES DE TBC HACE 4 AÑOS NO ADHERENTE AL TRATAMIENTO

4. ANTECEDENTES DE HEMOPTISIS MASIVA (2021)

5. ANTECEDENTES DE ESTENOSIS ESOFAGICA(UNION ESOFAGO PROXIMA Y MEDIO DE 2CM) CON REQUERIMIENTO DE DILATACIÓN

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE PASAR BUENA NOCHE, CON DISMINUCIÓN EN LA PERSISTENCIA DE SINTOMAS RESPIRATORIOS

Objetivo:

TA: 120/80 MMHG FC: 103 LPM FR: 22 RPM SAT: 100%.

PACIENTE EN ACEPTABLES CONDICIONES GENERALES, ALERTA, ORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA, CABEZA Y CUELLO: PUPILAS ISOCORICAS NORMOREACTIVAS A LA LUZ, MUCOSA ORAL HUMEDA, CUELLO MOVIL, SIMETRICO, NO ADENOPATIAS, SIN RIGIDEZ DE NUCA. TORAX: RUIDOS CARDIACOS RITMICOS SIN SOPLOS, NO S3, RUIDOS RESPIRATORIOS PRESENTES PERO DISMINUIDOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO DERECHO, NO CREPITOS, SIBILANCIAS OCASIONALES. ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMIDADES: SIMETRICAS HIPOTROFICAS SIN EDEMA LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS, PULSOS PERIFERICOS PRESENTES SIMETRICOS DE BUENA INTENSIDAD SNC: SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE. GLASGOW 15/15

04/02/2022: BUN:11 CREAT: 0.52 SODIO:137 CLORO:102 K:4.0 TP 10.5 INR 1.0 TPP 30.3

HEMOGRAMA: LEU:11.19 NEU:9.12 LINF: 0.67 HB: 9.2 HTO:33.3 PLQ:698

Análisis:

PACIENTE MASCULINO DE 40 AÑOS DE EDAD CON ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOATIVAS Y TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS, ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR. DURANTE RONDA MEDICA PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES PROTEICOCALÓRICAS, CLINICA Y HEMODINAMICAMENTE ESTABLE, CIFRAS TENSIONALES NORMALES, EUCARDICO, EUNEIPCO, SATURACIÓN EN METAS, EN OXIGENOTERAPIA CON CÁNULA NASAL, CON ULTIMO HEMOGRAMA QUE EVIDENCIA ANEMIA MICROCITICA HIPOCROMICA MODERADA SIN ALTERACION DE LAS DEMAS LINEAS CELULARES, FUNCION RENAL CONSERVADA, PACIENTE EN CONDICION DE HABITANTE DE LA CALLE ACTUALMENTE OXIGENO DEPENDIENTE POR LO CUAL SE ENCUENTRA PENDIENTE LA VALORACIÓN POR TRABAJO SOCIAL, SE SOLICITA TOMOGRAFIA DE TÓRAX SIMPLE Y CONTRASTADA, EN ESPERA DE REALIZACIÓN DE ANGIOTAC DE TÓRAX Y CATETERISMO CARDIACO DERECHO. SE EXPLICA CONDUCTA A PACIENTE QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

Fecha: 08/02/2022: 11:17:26, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: ARIEL BELLO, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

1. DISNEA SEC:

1.1. TUBERCULOSIS PULMONAR ACTIVA

1.1.1. TUBERCULOSIS MEDISTINICA

1.1.1.1. HIPERTENSION PULMONAR SEVERA

1.1.1.1.1 ESTENOSIS DE LA VENA PULMONAR IZQUIERDA SUPERIOR

1.2. NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD CURB 65 2 PUNTOS RESUELTA

2. ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIA PSICOATIVAS

3. ANTECEDENTES DE TBC HACE 4 AÑOS NO ADHERENTE AL TRATAMIENTO

4. ANTECEDENTES DE HEMOPTISIS MASIVA (2021)

5. ANTECEDENTES DE ESTENOSIS ESOFAGICA(UNION ESOFAGO PROXIMA Y MEDIO DE 2CM) CON REQUERIMIENTO DE DILATACIÓN NTES DE TBC HACE 4 AÑOS NO ADHERENTE AL TRATAMIENTO

4. ANTECEDENTES DE HEMOPTISIS MASIVA (2021)

5. ANTECEDENTES DE ESTENOSIS ESOFAGICA(UNION ESOFAGO PROXIMA Y MEDIO DE 2CM) CON REQUERIMIENTO DE DILATACIÓN

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE PASAR BUENA NOCHE, CON DISMINUCIÓN EN LA PERSISTENCIA DE SINTOMAS RESPIRATORIOS

Objetivo:

PACIENTE EN ACEPTABLES CONDICIONES GENERALES, ALERTA, ORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA, CABEZA Y CUELLO: PUPILAS ISOCORICAS NORMOREACTIVAS A LA LUZ, MUCOSA ORAL HUMEDA, CUELLO MOML, SIMETRICO, NO ADENOPATIAS, SIN RIGIDEZ DE NUCA. TORAX: RUIDOS CARDIACOS RITMICOS SIN SOPLOS, NO S3, RUIDOS RESPIRATORIOS PRESENTES PERO DISMINUIDOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO DERECHO, NO CREPITOS, SIBILANCIAS OCASIONALES. ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMIDADES: SIMETRICAS HIPOTROFICAS SIN EDEMA LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS, PULSOS PERIFERICOS PRESENTES SIMETRICOS DE BUENA INTENSIDAD SNC: SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE. GLASGOW 15/15

07/02/22 TROPONINA I <0.2

04/02/2022: BUN:11 CREAT: 0.52 SODIO:137 CLORO:102 K:4.0 TP 10.5 INR 1.0 TPP 30.3

HEMOGRAMA: LEU:11.19 NEU:9.12 LINF: 0.67 HB: 9.2 HTO:33.3 PLQ:698

Análisis:

PACIENTE MASCULINO DE 40 AÑOS DE EDAD CON ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOATIVAS Y TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS, ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR. DURANTE RONDA MEDICA PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES PROTEICOCALÓRICAS, CLINICA Y HEMODINAMICAMENTE ESTABLE, CIFRAS TENSIONALES NORMALES, EUCARDICO, EUNEIPCO, SATURACIÓN EN METAS, EN OXIGENOTERAPIA CON CÁNULA NASAL, CON ULTIMO HEMOGRAMA QUE EVIDENCIA ANEMIA MICROCITICA HIPOCROMICA MODERADA SIN ALTERACION DE LAS DEMAS LINEAS CELULARES, FUNCION RENAL CONSERVADA, TROPONINA EN NORMALIDAD, PACIENTE EN CONDICION DE HABITANTE DE LA CALLE ACTUALMENTE OXIGENO DEPENDIENTE POR LO CUAL SE ENCUENTRA PENDIENTE LA VALORACIÓN POR TRABAJO SOCIAL, TIENE PENDIENTE REALIZACIÓN DE PARACLINICOS CONTROL, TOMOGRAFIA DE TÓRAX SIMPLE Y CONTRASTADA, EN ESPERA DE REALIZACIÓN DE ANGIOTAC DE TÓRAX Y CATETERISMO CARDIACO DERECHO. SE EXPLICA CONDUCTA A PACIENTE QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR

Fecha: 09/02/2022: 12:48:50, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

1. DISNEA SEC:

1.1. TUBERCULOSIS PULMONAR ACTIVA

1.1.1. TUBERCULOSIS MEDISTINICA

1.1.1.1. HIPERTENSION PULMONAR SEVERA

1.1.1.1.1 ESTENOSIS DE LA VENA PULMONAR IZQUIERDA SUPERIOR

1.2. NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD CURB 65 2 PUNTOS RESUELTA

2. ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIA PSICOATIVAS

3. ANTECEDENTES DE TBC HACE 4 AÑOS NO ADHERENTE AL TRATAMIENTO

4. ANTECEDENTES DE HEMOPTISIS MASIVA (2021)

5. ANTECEDENTES DE ESTENOSIS ESOFAGICA(UNION ESOFAGO PROXIMA Y MEDIO DE 2CM) CON REQUERIMIENTO DE DILATACIÓN NTES DE TBC HACE 4 AÑOS NO ADHERENTE AL TRATAMIENTO

4. ANTECEDENTES DE HEMOPTISIS MASIVA (2021)

5. ANTECEDENTES DE ESTENOSIS ESOFAGICA(UNION ESOFAGO PROXIMA Y MEDIO DE 2CM) CON REQUERIMIENTO DE DILATACIÓN

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE PASAR BUENA NOCHE, CON DISMINUCIÓN EN LA PERSISTENCIA DE SINTOMAS RESPIRATORIOS

Objetivo:

TA: 120/60 MMHG FC: 107 LPM FR:23 RPM SAT: 97%.

PACIENTE EN ACEPTABLES CONDICIONES GENERALES, ALERTA, ORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA, CABEZA Y CUELLO: PUPILAS ISOCORICAS NORMOREACTIVAS A LA LUZ, MUCOSA ORAL HUMEDA, CUELLO MOML, SIMETRICO, NO ADENOPATIAS, SIN RIGIDEZ DE NUCA. TORAX: RUIDOS CARDIACOS RITMICOS SIN SOPLOS, NO S3, RUIDOS RESPIRATORIOS PRESENTES PERO DISMINUIDOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO DERECHO, NO CREPITOS, SIBILANCIAS OCASIONALES. ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMIDADES: SIMETRICAS HIPOTROFICAS SIN EDEMA LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS, PULSOS PERIFERICOS PRESENTES SIMETRICOS DE BUENA INTENSIDAD SNC: SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE. GLASGOW 15/15

07/02/22 TROPONINA I <0.2

04/02/2022: BUN:11 CREAT: 0.52 SODIO:137 CLORO:102 K:4.0 TP 10.5 INR 1.0 TPP 30.3

HEMOGRAMA: LEU:11.19 NEU:9.12 LINF: 0.67 HB: 9.2 HTO:33.3 PLQ:698

Análisis:

PACIENTE MASCULINO DE 40 AÑOS DE EDAD CON ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOATIVAS Y TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS, ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR. DURANTE RONDA MEDICA PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES PROTEICOCALÓRICAS, CLINICA Y HEMODINAMICAMENTE ESTABLE, CIFRAS TENSIONALES NORMALES, EUCARDICO, EUNEIPCO, SATURACIÓN EN METAS, EN OXIGENOTERAPIA CON CÁNULA NASAL, CON ULTIMO HEMOGRAMA QUE EVIDENCIA ANEMIA MICROCITICA HIPOCROMICA MODERADA SIN ALTERACION DE LAS DEMAS LINEAS CELULARES, FUNCION RENAL CONSERVADA, TROPONINA EN NORMALIDAD. SE RECIBE TAC DE TORX SIMPLE Y CONTRASTADO QUE REPORTA ATELECTASIA DE PULMON IZQUIERDO, DESVIACION DEL MEDIASTIANO Y OPACIDADES Y CAVITACIONES EN PARENQUIMA. PACIENTE EN CONDICION DE HABITANTE DE LA CALLE ACTUALMENTE OXIGENO DEPENDIENTE POR LO CUAL SE ENCUENTRA

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

PENDIENTE LA VALORACIÓN POR TRABAJO SOCIAL, TIENE PENDIENTE REALIZACIÓN DE PARACLINICOS CONTROL, EN ESPERA DE REALIZACIÓN DE ANGIOTAC DE TÓRAX Y CATETERISMO CARDIACO DERECHO. SE EXPLICA CONDUCTA A PACIENTE QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR.

Fecha: 10/02/2022: 13:09:22, **Historia:** Evolución Clínica General, **Prestador:** FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, **Especialidad:** INFECTOLOGIA

Problema:

1. DISNEA SEC:

1.1. TUBERCULOSIS PULMONAR ACTIVA

1.1.1. TUBERCULOSIS MEDISTINICA

1.1.1.1. HIPERTENSION PULMONAR SEVERA

1.1.1.1.1. ESTENOSIS DE LA VENA PULMONAR IZQUIERDA SUPERIOR

1.2. NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD CURB 65 2 PUNTOS RESUELTA

2. ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIA PSICOACTIVAS

3. ANTECEDENTES DE TBC HACE 4 AÑOS NO ADHERENTE AL TRATAMIENTO

4. ANTECEDENTES DE HEMOPTISIS MASIVA (2021)

5. ANTECEDENTES DE ESTENOSIS ESOFAGICA(UNION ESOFAGO PROXIMA Y MEDIO DE 2CM) CON REQUERIMIENTO DE DILATACIÓN NTES DE TBC HACE 4 AÑOS NO ADHERENTE AL TRATAMIENTO

4. ANTECEDENTES DE HEMOPTISIS MASIVA (2021)

5. ANTECEDENTES DE ESTENOSIS ESOFAGICA(UNION ESOFAGO PROXIMA Y MEDIO DE 2CM) CON REQUERIMIENTO DE DILATACIÓN

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE PASAR BUENA NOCHE, CON DISMINUCIÓN EN LA PERSISTENCIA DE SINTOMAS RESPIRATORIOS

Objetivo:

TA: 120/60 MMHG FC: 100 LPM FR: 20 RPM SAT: 97%.

PACIENTE EN ACEPTABLES CONDICIONES GENERALES, ALERTA, ORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA, CABEZA Y CUELLO: PUPILAS ISOCORICAS NORMOREACTIVAS A LA LUZ, MUCOSA ORAL HUMEDA, CUELLO MOML, SIMETRICO, NO ADENOPATIAS, SIN RIGIDEZ DE NUCA. TORAX: RUIDOS CARDIACOS RITMICOS SIN SOPLOS, NO S3, RUIDOS RESPIRATORIOS PRESENTES PERO DISMINUIDOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO DERECHO, NO CREPITOS, SIBILANCIAS OCASIONALES. ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMIDADES: SIMETRICAS HIPOTROFICAS SIN EDEMA LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS, PULSOS PERIFERICOS PRESENTES SIMETRICOS DE BUENA INTENSIDAD SNC: SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE. GLASGOW 15/15

09/02/22

BUN 18 ; CREAT 0.65

TP 12.0 CONTROL 12.1 INR 1.1 ; TTP 31.6 CONTROL 26.5

LEU 13.42 ; NEU 11.03 ; HB 8.7 ; HTO 31.7 ; VCM 74.4 ; HCM 20.5 ; PLAQ 639

Análisis:

PACIENTE MASCULINO DE 40 AÑOS DE EDAD CON ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS, ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR. DURANTE RONDA MEDICA PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES PROTEICOALÓRICAS, CLINICA Y HEMODINAMICAMENTE ESTABLE, CIFRAS TENSIONALES NORMALES, EUCARDICO, EUNEIPCO, SATURACIÓN EN METAS, EN OXIGENOTERAPIA CON CÁNULA NASAL, CON ULTIMO HEMOGRAMA QUE EVIDENCIA ANEMIA MICROCITICA HIPOCROMICA MODERADA SIN ALTERACION DE LAS DEMAS LINEAS CELULARES, FUNCION RENAL CONSERVADA, TROPONINA EN NORMALIDAD. SE RECIBE TAC DE TORX SIMPLE Y CONTRASTADO QUE REPORTA ATELECTASIA DE PULMON IZQUIERDO, DESMACION DEL MEDIASTIANO Y OPACIDADES Y CAVITACIONES EN PARENQUIMA. PACIENTE EN CONDICION DE HABITANTE DE LA CALLE ACTUALMENTE OXIGENO DEPENDIENTE POR LO CUAL SE ENCUENTRA PENDIENTE LA VALORACIÓN POR TRABAJO SOCIAL, TIENE PENDIENTE REALIZACIÓN DE PARACLINICOS CONTROL, EN ESPERA DE REALIZACIÓN DE ANGIOTAC DE TÓRAX Y CATETERISMO CARDIACO DERECHO. SE EXPLICA CONDUCTA A PACIENTE QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR.

Fecha: 11/02/2022: 11:34:50, **Historia:** Evolución Clínica General, **Prestador:** ARIEL BELLO, **Especialidad:** MEDICINA INTERNA

Problema:

1. DISNEA SEC:

1.1. TUBERCULOSIS PULMONAR ACTIVA

1.1.1. TUBERCULOSIS MEDISTINICA

1.1.1.1. HIPERTENSION PULMONAR SEVERA

1.1.1.1.1. ESTENOSIS DE LA VENA PULMONAR IZQUIERDA SUPERIOR

1.2. NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD CURB 65 2 PUNTOS RESUELTA

2. ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIA PSICOACTIVAS

3. ANTECEDENTES DE TBC HACE 4 AÑOS NO ADHERENTE AL TRATAMIENTO

4. ANTECEDENTES DE HEMOPTISIS MASIVA (2021)

5. ANTECEDENTES DE ESTENOSIS ESOFAGICA(UNION ESOFAGO PROXIMA Y MEDIO DE 2CM) CON REQUERIMIENTO DE DILATACIÓN NTES DE TBC HACE 4 AÑOS NO ADHERENTE AL TRATAMIENTO

4. ANTECEDENTES DE HEMOPTISIS MASIVA (2021)

5. ANTECEDENTES DE ESTENOSIS ESOFAGICA(UNION ESOFAGO PROXIMA Y MEDIO DE 2CM) CON REQUERIMIENTO DE DILATACIÓN

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE PASAR BUENA NOCHE, CON DISMINUCIÓN EN LA PERSISTENCIA DE SINTOMAS RESPIRATORIOS

Objetivo:

TA: 110/60 MMHG FC: 69 LPM FR: 18 RPM SAT: 99%.

PACIENTE EN ACEPTABLES CONDICIONES GENERALES, ALERTA, ORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA, CABEZA Y CUELLO: PUPILAS ISOCORICAS NORMOREACTIVAS A LA LUZ, MUCOSA ORAL HUMEDA, CUELLO MOML, SIMETRICO, NO ADENOPATIAS, SIN RIGIDEZ DE NUCA. TORAX: RUIDOS CARDIACOS RITMICOS SIN SOPLOS, NO S3, RUIDOS RESPIRATORIOS PRESENTES PERO DISMINUIDOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO DERECHO, NO CREPITOS, SIBILANCIAS OCASIONALES. ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMIDADES: SIMETRICAS HIPOTROFICAS SIN EDEMA LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS, PULSOS PERIFERICOS PRESENTES SIMETRICOS DE BUENA INTENSIDAD SNC: SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE. GLASGOW 15/15

09/02/22

BUN 18 ; CREAT 0.65

TP 12.0 CONTROL 12.1 INR 1.1 ; TTP 31.6 CONTROL 26.5

LEU 13.42 ; NEU 11.03 ; HB 8.7 ; HTO 31.7 ; VCM 74.4 ; HCM 20.5 ; PLAQ 639

Análisis:

PACIENTE MASCULINO DE 40 AÑOS DE EDAD CON ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y TUBERCULOSIS PULMONAR

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

TRATADA HACE 4 AÑOS, ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR. DURANTE RONDA MEDICA PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES PROTEICOCALÓRICAS, CLINICA Y HEMODINAMICAMENTE ESTABLE, CIFRAS TENSIONALES NORMALES, EUCARDICO, EUNEIPCO, SATURACIÓN EN METAS, EN OXIGENOTERAPIA CON CÁNULA NASAL, CON ULTIMO HEMOGRAMA QUE EVIDENCIA ANEMIA MICROCITICA HIPOCROMICA MODERADA SIN ALTERACION DE LAS DEMAS LINEAS CELULARES, FUNCION RENAL CONSERVADA, TROPONINA EN NORMALIDAD. SE RECIBE TAC DE TORX SIMPLE Y CONTRASTADO QUE REPORTA ATELECTASIA DE PULMON IZQUIERDO, DESVIACION DEL MEDIASTIANO Y OPACIDADES Y CAVITACIONES EN PARENQUIMA. EN RONDA MEDICA SE HABLA EN CONJUNTO CON MEDICINA INTERNA CON HEMODINAMIA QUE ACUERDAN QUE SE DEBE CONOCER EXACTAMENTE LA ANATOMIA CARDIACA ANTES DE REALIZAR CUALQUIER PROCEDIMIENTO, POR LO QUE SE EMPIEZAN A REALIZAR TRAMITES PARA SOLICITAR LA TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA CARDIACA CON RECONSTRUCCIÓN 3D. SE EXPLICA CONDUCTA A PACIENTE QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR.

Fecha: 12/02/2022: 12:17:15, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: ORLANDO SANGUINO OMAÑA, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

1. DISNEA SEC:

1.1. TUBERCULOSIS PULMONAR ACTIVA

1.1.1. TUBERCULOSIS MEDISTINICA

1.1.1.1. HIPERTENSION PULMONAR SEVERA

1.1.1.1.1 ESTENOSIS DE LA VENA PULMONAR IZQUIERDA SUPERIOR

1.2. NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD CURB 65 2 PUNTOS RESUELTA

2. ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIA PSICOATIVAS

3. ANTECEDENTES DE TBC HACE 4 AÑOS NO ADHERENTE AL TRATAMIENTO

4. ANTECEDENTES DE HEMOPTISIS MASIVA (2021)

5. ANTECEDENTES DE ESTENOSIS ESOFAGICA(UNION ESOFAGO PROXIMA Y MEDIO DE 2CM) CON REQUERIMIENTO DE DILATACIÓN

NTER DE TBC HACE 4 AÑOS NO ADHERENTE AL TRATAMIENTO

4. ANTECEDENTES DE HEMOPTISIS MASIVA (2021)

5. ANTECEDENTES DE ESTENOSIS ESOFAGICA(UNION ESOFAGO PROXIMA Y MEDIO DE 2CM) CON REQUERIMIENTO DE DILATACIÓN

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE PASAR BUENA NOCHE, CON DISMINUCIÓN EN LA PERSISTENCIA DE SINTOMAS RESPIRATORIOS

Objetivo:

TA: 110/60 MMHG FC: 69 LPM FR: 18 RPM SAT: 99%.

PACIENTE EN ACEPTABLES CONDICIONES GENERALES, ALERTA, ORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA, CABEZA Y CUELLO: PUPILAS ISOCORICAS NORMOREACTIVAS A LA LUZ, MUCOSA ORAL HUMEDA, CUELLO MOML, SIMETRICO, NO ADENOPATIAS, SIN RIGIDEZ DE NUCA. TORAX: RUIDOS CARDIACOS RITMICOS SIN SOPLOS, NO S3, RUIDOS RESPIRATORIOS PRESENTES PERO DISMINUIDOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO DERECHO, NO CREPITOS, SIBILANCIAS OCASIONALES. ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMDADES: SIMETRICAS HIPOTROFICAS SIN EDEMA LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS, PULSOS PERIFERICOS PRESENTES SIMETRICOS DE BUENA INTENSIDAD SNC: SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE. GLASGOW 15/15

10/02/2022: CREAT 0.65 BUN 14 TPT 30.8 YP 12.4 CONTROL 12.1 INR 1.2 HEMOGRAMA LEU 18.35 NEU 86.9 LINF 4.1, MONO 6.5 HB 9.8 HTO 35.7 PLT 721

Análisis:

PACIENTE MASCULINO DE 40 AÑOS DE EDAD CON ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOATIVAS Y TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS, ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR. DURANTE RONDA MEDICA PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES PROTEICOCALÓRICAS, CLINICA Y HEMODINAMICAMENTE ESTABLE, CIFRAS TENSIONALES NORMALES, EUCARDICO, EUNEIPCO, SATURACIÓN EN METAS, EN OXIGENOTERAPIA CON CÁNULA NASAL, CON ULTIMO HEMOGRAMA QUE EVIDENCIA ANEMIA MICROCITICA HIPOCROMICA MODERADA SIN ALTERACION DE LAS DEMAS LINEAS CELULARES, FUNCION RENAL CONSERVADA. SE RECIBE TAC DE TORX SIMPLE Y CONTRASTADO QUE REPORTA ATELECTASIA DE PULMON IZQUIERDO, DESVIACION DEL MEDIASTIANO Y OPACIDADES Y CAVITACIONES EN PARENQUIMA. EN RONDA MEDICA SE HABLA EN CONJUNTO CON MEDICINA INTERNA CON HEMODINAMIA QUE ACUERDAN QUE SE DEBE CONOCER EXACTAMENTE LA ANATOMIA CARDIACA ANTES DE REALIZAR CUALQUIER PROCEDIMIENTO, POR LO QUE ESTA PENDIENTE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA CARDIACA CON RECONSTRUCCIÓN 3D. SE EXPLICA CONDUCTA A PACIENTE QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR.

Fecha: 13/02/2022: 09:02:40, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: ORLANDO SANGUINO OMAÑA, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

1. DISNEA SEC:

1.1. TUBERCULOSIS PULMONAR ACTIVA

1.1.1. TUBERCULOSIS MEDISTINICA

1.1.1.1. HIPERTENSION PULMONAR SEVERA

1.1.1.1.1 ESTENOSIS DE LA VENA PULMONAR IZQUIERDA SUPERIOR

1.2. NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD CURB 65 2 PUNTOS RESUELTA

2. ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIA PSICOATIVAS

3. ANTECEDENTES DE TBC HACE 4 AÑOS NO ADHERENTE AL TRATAMIENTO

4. ANTECEDENTES DE HEMOPTISIS MASIVA (2021)

5. ANTECEDENTES DE ESTENOSIS ESOFAGICA(UNION ESOFAGO PROXIMA Y MEDIO DE 2CM) CON REQUERIMIENTO DE DILATACIÓN

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE PASAR BUENA NOCHE, CON DISMINUCIÓN EN LA PERSISTENCIA DE SINTOMAS RESPIRATORIOS

Objetivo:

TA: 110/60 MMHG FC: 69 LPM FR: 18 RPM SAT: 99%.

PACIENTE EN ACEPTABLES CONDICIONES GENERALES, ALERTA, ORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA, CABEZA Y CUELLO: PUPILAS ISOCORICAS NORMOREACTIVAS A LA LUZ, MUCOSA ORAL HUMEDA, CUELLO MOML, SIMETRICO, NO ADENOPATIAS, SIN RIGIDEZ DE NUCA. TORAX: RUIDOS CARDIACOS RITMICOS SIN SOPLOS, NO S3, RUIDOS RESPIRATORIOS PRESENTES PERO DISMINUIDOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO DERECHO, NO CREPITOS, SIBILANCIAS OCASIONALES. ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMDADES: SIMETRICAS HIPOTROFICAS SIN EDEMA LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS, PULSOS PERIFERICOS PRESENTES SIMETRICOS DE BUENA INTENSIDAD SNC: SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE. GLASGOW 15/15

10/02/2022: CREAT 0.65 BUN 14 TPT 30.8 YP 12.4 CONTROL 12.1 INR 1.2 HEMOGRAMA LEU 18.35 NEU 86.9 LINF 4.1, MONO 6.5 HB 9.8 HTO 35.7 PLT 721

Análisis:

PACIENTE MASCULINO DE 40 AÑOS DE EDAD CON ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOATIVAS Y TUBERCULOSIS PULMONAR

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

TRATADA HACE 4 AÑOS, ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR. DURANTE RONDA MEDICA PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES PROTEICOALÓRICAS, CLINICA Y HEMODINAMICAMENTE ESTABLE, CIFRAS TENSIONALES NORMALES, EUCARDICO, EUNEIPCO, SATURACIÓN EN METAS, EN OXIGENOTERAPIA CON CÁNULA NASAL, CON ULTIMO HEMOGRAMA QUE EVIDENCIA ANEMIA MICROCITICA HIPOCROMICA MODERADA SIN ALTERACION DE LAS DEMAS LINEAS CELULARES, FUNCION RENAL CONSERVADA. SE RECIBE TAC DE TORX SIMPLE Y CONTRASTADO QUE REPORTA ATELECTASIA DE PULMON IZQUIERDO, DESVIACION DEL MEDIASTIANO Y OPACIDADES Y CAMTACIONES EN PARENQUIMA. EN RONDA MEDICA SE HABLA EN CONJUNTO CON MEDICINA INTERNA CON HEMODINAMIA QUE ACUERDAN QUE SE DEBE CONOCER EXACTAMENTE LA ANATOMIA CARDIACA ANTES DE REALIZAR CUALQUIER PROCEDIMIENTO, POR LO QUE ESTA PENDIENTE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA CARDIACA CON RECONSTRUCCIÓN 3D. SE EXPLICA CONDUCTA A PACIENTE QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR.

Fecha: 13/02/2022: 10:07:26, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: ORLANDO SANGUINO OMAÑA, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

1. DISNEA SEC:

1.1. TUBERCULOSIS PULMONAR ACTIVA

1.1.1. TUBERCULOSIS MEDISTINICA

1.1.1.1. HIPERTENSION PULMONAR SEVERA

1.1.1.1.1. ESTENOSIS DE LA VENA PULMONAR IZQUIERDA SUPERIOR

1.2. NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD CURB 65 2 PUNTOS RESUELTA

2. ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIA PSICOATIVAS

3. ANTECEDENTES DE TBC HACE 4 AÑOS NO ADHERENTE AL TRATAMIENTO

4. ANTECEDENTES DE HEMOPTISIS MASIVA (2021)

5. ANTECEDENTES DE ESTENOSIS ESOFAGICA (UNION ESOFAGO PROXIMA Y MEDIO DE 2CM) CON REQUERIMIENTO DE DILATACIÓN

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE PASAR BUENA NOCHE, CON DISMINUCIÓN EN LA PERSISTENCIA DE SINTOMAS RESPIRATORIOS

Objetivo:

TA: 110/60 MMHG FC: 69 LPM FR: 18 RPM SAT: 99%.

PACIENTE EN ACEPTABLES CONDICIONES GENERALES, ALERTA, ORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA, CABEZA Y CUELLO: PUPILAS ISOCORICAS NORMOREACTIVAS A LA LUZ, MUCOSA ORAL HUMEDA, CUELLO MOML, SIMETRICO, NO ADENOPATIAS, SIN RIGIDEZ DE NUCA. TORAX: RUIDOS CARDIACOS RITMICOS SIN SOPLOS, NO S3, RUIDOS RESPIRATORIOS PRESENTES PERO DISMINUIDOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO DERECHO, NO CREPITOS, SIBILANCIAS OCASIONALES. ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMDADES: SIMETRICAS HIPOTROFICAS SIN EDEMA LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS, PULSOS PERIFERICOS PRESENTES SIMETRICOS DE BUENA INTENSIDAD SNC: SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE. GLASGOW 15/15

10/02/2022: CREAT 0.65 BUN 14 TPT 30.8 YP 12.4 CONTROL 12.1 INR 1.2 HEMOGRAMA LEU 18.35 NEU 86.9 LIN 4.1, MONO 6.5 HB 9.8 HTO 35.7 PLT 721

Análisis:

PACIENTE MASCULINO DE 40 AÑOS DE EDAD CON ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOATIVAS Y TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS, ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR. DURANTE RONDA MEDICA PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES PROTEICOALÓRICAS, CLINICA Y HEMODINAMICAMENTE ESTABLE, CIFRAS TENSIONALES NORMALES, EUCARDICO, EUNEIPCO, SATURACIÓN EN METAS, EN OXIGENOTERAPIA CON VENTURY AL 35% TOLERANDO DESTETE, CON ULTIMO HEMOGRAMA QUE EVIDENCIA ANEMIA MICROCITICA HIPOCROMICA MODERADA SIN ALTERACION DE LAS DEMAS LINEAS CELULARES, FUNCION RENAL CONSERVADA. SE RECIBE TAC DE TORX SIMPLE Y CONTRASTADO QUE REPORTA ATELECTASIA DE PULMON IZQUIERDO, DESVIACION DEL MEDIASTIANO Y OPACIDADES Y CAMTACIONES EN PARENQUIMA. EN RONDA MEDICA SE HABLA EN CONJUNTO CON MEDICINA INTERNA CON HEMODINAMIA QUE ACUERDAN QUE SE DEBE CONOCER EXACTAMENTE LA ANATOMIA CARDIACA ANTES DE REALIZAR CUALQUIER PROCEDIMIENTO, POR LO QUE ESTA PENDIENTE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA CARDIACA CON RECONSTRUCCIÓN 3D. SE EXPLICA CONDUCTA A PACIENTE QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR.

Fecha: 14/02/2022: 08:52:39, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

1. DISNEA SEC:

1.1. TUBERCULOSIS PULMONAR ACTIVA

1.1.1. TUBERCULOSIS MEDISTINICA

1.1.1.1. HIPERTENSION PULMONAR SEVERA

1.1.1.1.1. ESTENOSIS DE LA VENA PULMONAR IZQUIERDA SUPERIOR

1.2. NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD CURB 65 2 PUNTOS RESUELTA

2. ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIA PSICOATIVAS

3. ANTECEDENTES DE TBC HACE 4 AÑOS NO ADHERENTE AL TRATAMIENTO

4. ANTECEDENTES DE HEMOPTISIS MASIVA (2021)

5. ANTECEDENTES DE ESTENOSIS ESOFAGICA (UNION ESOFAGO PROXIMA Y MEDIO DE 2CM) CON REQUERIMIENTO DE DILATACIÓN

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE PASAR BUENA NOCHE, CON DISMINUCIÓN EN LA PERSISTENCIA DE SINTOMAS RESPIRATORIOS

Objetivo:

TA: 110/60 MMHG FC: 69 LPM FR: 18 RPM SAT: 99%.

PACIENTE EN ACEPTABLES CONDICIONES GENERALES, ALERTA, ORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA, CABEZA Y CUELLO: PUPILAS ISOCORICAS NORMOREACTIVAS A LA LUZ, MUCOSA ORAL HUMEDA, CUELLO MOML, SIMETRICO, NO ADENOPATIAS, SIN RIGIDEZ DE NUCA. TORAX: RUIDOS CARDIACOS RITMICOS SIN SOPLOS, NO S3, RUIDOS RESPIRATORIOS PRESENTES PERO DISMINUIDOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO DERECHO, NO CREPITOS, SIBILANCIAS OCASIONALES. ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMDADES: SIMETRICAS HIPOTROFICAS SIN EDEMA LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS, PULSOS PERIFERICOS PRESENTES SIMETRICOS DE BUENA INTENSIDAD SNC: SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE. GLASGOW 15/15

Análisis:

PACIENTE MASCULINO DE 40 AÑOS DE EDAD CON ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOATIVAS Y TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS, ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR. DURANTE RONDA MEDICA PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES PROTEICOALÓRICAS, CLINICA Y HEMODINAMICAMENTE ESTABLE, CIFRAS TENSIONALES NORMALES, EUCARDICO, EUNEIPCO, SATURACIÓN EN METAS, EN OXIGENOTERAPIA CON VENTURY AL 35% TOLERANDO DESTETE, CON ULTIMO HEMOGRAMA QUE EVIDENCIA ANEMIA MICROCITICA HIPOCROMICA MODERADA SIN ALTERACION DE LAS DEMAS LINEAS CELULARES, FUNCION RENAL CONSERVADA. SE RECIBE TAC DE TORX SIMPLE Y CONTRASTADO QUE REPORTA ATELECTASIA DE PULMON IZQUIERDO, DESVIACION DEL MEDIASTIANO Y OPACIDADES Y CAMTACIONES EN PARENQUIMA. EN RONDA MEDICA SE HABLA EN CONJUNTO CON MEDICINA INTERNA CON HEMODINAMIA QUE ACUERDAN QUE SE DEBE CONOCER

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

EXACTAMENTE LA ANATOMIA CARDIACA ANTES DE REALIZAR CUALQUIER PROCEDIMIENTO, POR LO QUE ESTA PENDIENTE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA CARDIACA CON RECONSTRUCCIÓN 3D. PACIENTE QUE NO ESTA RECIBIENDO TERAPIA RIPE HACE 3 DIAS POR PROBLEMA ADMINISTRATIVOS. SE EXPLICA CONDUCTA A PACIENTE QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR.

Fecha: 15/02/2022: 11:27:39, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

1. DISNEA SEC: 1.1. TUBERCULOSIS PULMONAR ACTIVA 1.1.1. TUBERCULOSIS MEDISTINICA 1.1.1.1. HIPERTENSION PULMONAR SEVERA 1.1.1.1.1 ESTENOSIS DE LA VENA PULMONAR IZQUIERDA SUPERIOR 1.2. NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD CURB 65 2 PUNTOS RESUELTA 2. ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIA PSICOATIVAS 3. ANTECEDENTES DE TBC HACE 4 AÑOS NO ADHERENTE AL TRATAMIENTO 4. ANTECEDENTES DE HEMOPTISIS MASIVA (2021) 5. ANTECEDENTES DE ESTENOSIS ESOFAGICA(UNION ESOFAGO PROXIMA Y MEDIO DE 2CM) CON REQUERIMIENTO DE DILATACIÓN

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE PASAR BUENA NOCHE, CON DISMINUCIÓN EN LA PERSISTENCIA DE SINTOMAS RESPIRATORIOS

Objetivo:

TA: 100/70 MMHG FC: 86 LPM FR: 18 RPM SAT: 99%. PACIENTE EN ACEPTABLES CONDICIONES GENERALES, ALERTA, ORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA, CABEZA Y CUELLO: PUPILAS ISOCORICAS NORMOREACTIVAS A LA LUZ, MUCOSA ORAL HUMEDA, CUELLO MOVIL, SIMETRICO, NO ADENOPATIAS, SIN RIGIDEZ DE NUCA TORAX: RUIDOS CARDIACOS RITMICOS SIN SOPLOS, NO S3, RUIDOS RESPIRATORIOS PRESENTES PERO DISMINUIDOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO DERECHO, NO CREPITOS, SIBILANCIAS OCASIONALES. ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMIDADES: SIMETRICAS HIPOTROFICAS SIN EDEMA LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS, PULSOS PERIFERICOS PRESENTES SIMETRICOS DE BUENA INTENSIDAD SNC: SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE. GLASGOW 15/15 14/02/2021 HMOGRAMA LEUCOCITOS 15.24 NEUTROFILOS % 83.4 NEUTROFILOS # 12.71 LINFOCITOS % 3.3 LINFOCITOS # 0.50 HEMOGLOBINA 9.2 HEMATOCRITO 33.2 VCM 74.9 HCM 20.7 CCMH 27.6 PLAQUETAS 668 BUN 14 CR 0.55 AST 29 ALT 22 PCR 11.9 SODIO 139

Análisis:

PACIENTE MASCULINO DE 40 AÑOS DE EDAD CON ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOATIVAS Y TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS, ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR. DURANTE RONDA MEDICA PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES PROTEICOALÓRICAS, CLINICA Y HEMODINAMICAMENTE ESTABLE, CIFRAS TENSIONALES NORMALES, EUCARDICO, EUNEIPCO, SATURACIÓN EN METAS, EN OXIGENOTERAPIA CON VENTURY AL 35% TOLERANDO DESTETE, SE RECIBE PARA CLINICOS LOS CUALES REPORTAN HEMOGRAFA QUE EVIDENCIA ANEMIA MCROCITICA HIPOCROMICA MODERADA SIN ALTERACION DE LAS DEMAS LINEAS CELULARES, FUNCION RENAL CONSERVADA EN RONDA MEDICA SE HABLA EN CONJUNTO CON MEDICINA INTERNA CON HEMODINAMIA QUE ACUERDAN QUE SE DEBE CONOCER EXACTAMENTE LA ANATOMIA CARDIACA ANTES DE REALIZAR CUALQUIER PROCEDIMIENTO, POR LO QUE CONTINUA PENDIENTE RESONANCIA CARDIACA CON RECONSTRUCCIÓN 3D. PACIENTE QUE NO ESTA RECIBIENDO TERAPIA RIPE HACE 4 DIAS POR PROBLEMA ADMINISTRATIVOS, QUEDAN ATENTOS A EMPEZAR NUEVAMENTE EL DIA DE HOY. SE EXPLICA CONDUCTA A PACIENTE QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR.

Fecha: 16/02/2022: 12:09:58, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

1. DISNEA SEC:

1.1. TUBERCULOSIS PULMONAR ACTIVA

1.1.1. TUBERCULOSIS MEDISTINICA

1.1.1.1. HIPERTENSION PULMONAR SEVERA

1.1.1.1.1 ESTENOSIS DE LA VENA PULMONAR IZQUIERDA SUPERIOR

1.2. NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD CURB 65 2 PUNTOS RESUELTA

2. ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIA PSICOATIVAS

3. ANTECEDENTES DE TBC HACE 4 AÑOS NO ADHERENTE AL TRATAMIENTO

4. ANTECEDENTES DE HEMOPTISIS MASIVA (2021)

5. ANTECEDENTES DE ESTENOSIS ESOFAGICA(UNION ESOFAGO PROXIMA Y MEDIO DE 2CM) CON REQUERIMIENTO DE DILATACIÓN

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE PASAR BUENA NOCHE, CON DISMINUCIÓN EN LA PERSISTENCIA DE SINTOMAS RESPIRATORIOS

Objetivo:

TA: 100/60 MMHG FC: 100 LPM FR: 22 RPM SAT: 98%.

PACIENTE EN ACEPTABLES CONDICIONES GENERALES, ALERTA, ORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA, CABEZA Y CUELLO: PUPILAS ISOCORICAS NORMOREACTIVAS A LA LUZ, MUCOSA ORAL HUMEDA, CUELLO MOVIL, SIMETRICO, NO ADENOPATIAS, SIN RIGIDEZ DE NUCA TORAX: RUIDOS CARDIACOS RITMICOS SIN SOPLOS, NO S3, RUIDOS RESPIRATORIOS PRESENTES PERO DISMINUIDOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO DERECHO, NO CREPITOS, SIBILANCIAS OCASIONALES. ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMIDADES: SIMETRICAS HIPOTROFICAS SIN EDEMA LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS, PULSOS PERIFERICOS PRESENTES SIMETRICOS DE BUENA INTENSIDAD SNC: SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE. GLASGOW 15/15

Análisis:

PACIENTE MASCULINO DE 40 AÑOS DE EDAD CON ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOATIVAS Y TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS, ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR. DURANTE RONDA MEDICA PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES PROTEICOALÓRICAS, CLINICA Y HEMODINAMICAMENTE ESTABLE, CIFRAS TENSIONALES NORMALES, EUCARDICO, EUNEIPCO, SATURACIÓN EN METAS, EN OXIGENOTERAPIA CON VENTURY AL 35% TOLERANDO DESTETE. EN RONDA MEDICA SE HABLA EN CONJUNTO CON MEDICINA INTERNA CON HEMODINAMIA QUE ACUERDAN QUE SE DEBE CONOCER EXACTAMENTE LA ANATOMIA CARDIACA ANTES DE REALIZAR CUALQUIER PROCEDIMIENTO, POR LO QUE CONTINUA PENDIENTE RESONANCIA CARDIACA CON RECONSTRUCCIÓN 3D PARA PROCEDER SEGUN RESULTADOS. PACIENTE QUE NO ESTA RECIBIENDO TERAPIA RIPE HACE DIAS POR PROBLEMA ADMINISTRATIVOS. SE EXPLICA CONDUCTA A PACIENTE QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR.

Fecha: 17/02/2022: 11:37:15, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

1. DISNEA SEC:

1.1. TUBERCULOSIS PULMONAR ACTIVA

1.1.1. TUBERCULOSIS MEDISTINICA

1.1.1.1. HIPERTENSION PULMONAR SEVERA

1.1.1.1.1 ESTENOSIS DE LA VENA PULMONAR IZQUIERDA SUPERIOR

1.2. NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD CURB 65 2 PUNTOS RESUELTA

2. ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIA PSICOATIVAS

3. ANTECEDENTES DE TBC HACE 4 AÑOS NO ADHERENTE AL TRATAMIENTO

4. ANTECEDENTES DE HEMOPTISIS MASIVA (2021)

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

5. ANTECEDENTES DE ESTENOSIS ESOFAGICA(UNION ESOFAGO PROXIMA Y MEDIO DE 2CM) CON REQUERIMIENTO DE DILATACIÓN

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE PASAR BUENA NOCHE, CON DISMINUCIÓN EN LA PERSISTENCIA DE SINTOMAS RESPIRATORIOS

Objetivo:

TA: 100/60 MMHG FC:100 LPMFR:22 RPMSAT: 98%.

PACIENTE EN ACEPTABLES CONDICIONES GENERALES, ALERTA, ORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA, CABEZA Y CUELLO: PUPILAS ISOCORICAS NORMOREACTIVAS A LA LUZ, MUCOSA ORAL HUMEDA, CUELLO MOML, SIMETRICO, NO ADENOPATIAS, SIN RIGIDEZ DE NUCA. TORAX: RUIDOS CARDIACOS RITMICOS SIN SOPLOS, NO S3, RUIDOS RESPIRATORIOS PRESENTES PERO DISMINUIDOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO DERECHO, NO CREPITOS, SIBILANCIAS OCASIONALES. ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMIDADES: SIMETRICAS HIPOTROFICAS SIN EDEMA LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS, PULSOS PERIFERICOS PRESENTES SIMETRICOS DE BUENA INTENSIDAD SNC: SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE. GLASGOW 15/15

Análisis:

PACIENTE MASCULINO DE 40 AÑOS DE EDAD CON ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS, ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR. DURANTE RONDA MEDICA PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES PROTEICOCALÓRICAS, CLINICA Y HEMODINAMICAMENTE ESTABLE, CIFRAS TENSIONALES NORMALES, EUCARDICO, EUNEIPCO, SATURACIÓN EN METAS, EN OXIGENOTERAPIA CON VENTURY AL 35% TOLERANDO DESTETE. EN RONDA MEDICA SE HABLA EN CONJUNTO CON MEDICINA INTERNA CON HEMODINAMIA QUE ACUERDAN QUE SE DEBE CONOCER EXACTAMENTE LA ANATOMIA CARDIACA ANTES DE REALIZAR CUALQUIER PROCEDIMIENTO, POR LO QUE CONTINUA PENDIENTE RESONANCIA CARDIACA CON RECONSTRUCCIÓN 3D, TOMOGRAFIA COMPUTADA DE CORONARIAS, TOMOGRAFIA COMPUTADA RECONSTRUCCION VIRTUAL, CATETERISMO CARDIAO DERECHO PARA PROCEDER SEGUN RESULTADOS. PACIENTE QUE NO ESTA RECIBIENDO TERAPIA RIPE HACE DIAS POR PROBLEMA ADMINISTRATIVOS. SE EXPLICA CONDUCTA A PACIENTE QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR.

Fecha: 18/02/2022: 11:56:17, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

1. DISNEA SEC:

1.1. TUBERCULOSIS PULMONAR ACTIVA

1.1.1. TUBERCULOSIS MEDISTINICA

1.1.1.1. HIPERTENSION PULMONAR SEVERA

1.1.1.1.1. ESTENOSIS DE LA VENA PULMONAR IZQUIERDA SUPERIOR

1.2. NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD CURB 65 2 PUNTOS RESUELTA

2. ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIA PSICOATIVAS

3. ANTECEDENTES DE TBC HACE 4 AÑOS NO ADHERENTE AL TRATAMIENTO

4. ANTECEDENTES DE HEMOPTISIS MASIVA (2021)

5. ANTECEDENTES DE ESTENOSIS ESOFAGICA(UNION ESOFAGO PROXIMA Y MEDIO DE 2CM) CON REQUERIMIENTO DE DILATACIÓN

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE PASAR BUENA NOCHE, CON DISMINUCIÓN EN LA PERSISTENCIA DE SINTOMAS RESPIRATORIOS

Objetivo:

TA: 110/60 MMHG FC:99 LPMFR:20 RPMSAT: 98%.

PACIENTE EN ACEPTABLES CONDICIONES GENERALES, ALERTA, ORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA, CABEZA Y CUELLO: PUPILAS ISOCORICAS NORMOREACTIVAS A LA LUZ, MUCOSA ORAL HUMEDA, CUELLO MOML, SIMETRICO, NO ADENOPATIAS, SIN RIGIDEZ DE NUCA. TORAX: RUIDOS CARDIACOS RITMICOS SIN SOPLOS, NO S3, RUIDOS RESPIRATORIOS PRESENTES PERO DISMINUIDOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO DERECHO, NO CREPITOS, SIBILANCIAS OCASIONALES. ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMIDADES: SIMETRICAS HIPOTROFICAS SIN EDEMA LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS, PULSOS PERIFERICOS PRESENTES SIMETRICOS DE BUENA INTENSIDAD SNC: SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE. GLASGOW 15/15

Análisis:

PACIENTE MASCULINO DE 40 AÑOS DE EDAD CON ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS, ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR. DURANTE RONDA MEDICA PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES PROTEICOCALÓRICAS, CLINICA Y HEMODINAMICAMENTE ESTABLE, CIFRAS TENSIONALES NORMALES, EUCARDICO, EUNEIPCO, SATURACIÓN EN METAS, EN OXIGENOTERAPIA CON VENTURY AL 35% TOLERANDO DESTETE. EN RONDA MEDICA SE HABLA EN CONJUNTO CON MEDICINA INTERNA CON HEMODINAMIA QUE ACUERDAN QUE SE DEBE CONOCER EXACTAMENTE LA ANATOMIA CARDIACA ANTES DE REALIZAR CUALQUIER PROCEDIMIENTO, EL DÍA DE HOY CONTINUA PENDIENTE RESONANCIA CARDIACA CON RECONSTRUCCIÓN 3D PARA PROCEDER SEGUN RESULTADOS. PACIENTE QUE COMENZÓ A RECIBIR TERAPIA RIPE CONTINUA CON MANEJO INSTAURADO. SE EXPLICA CONDUCTA A PACIENTE QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR.

Fecha: 19/02/2022: 11:05:34, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: JORGE YEPES CARO, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

1. DISNEA SEC: 1.1. TUBERCULOSIS PULMONAR ACTIVA 1.1.1. TUBERCULOSIS MEDISTINICA 1.1.1.1. HIPERTENSION PULMONAR SEVERA

1.1.1.1.1. ESTENOSIS DE LA VENA PULMONAR IZQUIERDA SUPERIOR 1.2. NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD CURB 65 2 PUNTOS RESUELTA 2.

ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIA PSICOATIVAS 3. ANTECEDENTES DE TBC HACE 4 AÑOS NO ADHERENTE AL TRATAMIENTO 4.

ANTECEDENTES DE HEMOPTISIS MASIVA (2021) 5. ANTECEDENTES DE ESTENOSIS ESOFAGICA(UNION ESOFAGO PROXIMA Y MEDIO DE 2CM) CON REQUERIMIENTO DE DILATACIÓN

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE PASAR BUENA NOCHE, CON DISMINUCIÓN EN LA PERSISTENCIA DE SINTOMAS RESPIRATORIOS

Objetivo:

TA: 120/80 MMHG FC:117 LPMFR:20 RPMSAT: 98%.

PACIENTE EN ACEPTABLES CONDICIONES GENERALES, ALERTA, ORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA, CABEZA Y CUELLO: PUPILAS ISOCORICAS NORMOREACTIVAS A LA LUZ, MUCOSA ORAL HUMEDA, CUELLO MOML, SIMETRICO, NO ADENOPATIAS, SIN RIGIDEZ DE NUCA. TORAX: RUIDOS CARDIACOS RITMICOS SIN SOPLOS, NO S3, RUIDOS RESPIRATORIOS PRESENTES PERO DISMINUIDOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO DERECHO, NO CREPITOS, SIBILANCIAS OCASIONALES. ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMIDADES: SIMETRICAS HIPOTROFICAS SIN EDEMA LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS, PULSOS PERIFERICOS PRESENTES SIMETRICOS DE BUENA INTENSIDAD SNC: SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE. GLASGOW 15/15

Análisis:

PACIENTE MASCULINO DE 40 AÑOS DE EDAD CON ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS, ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR. DURANTE RONDA MEDICA PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES PROTEICOCALÓRICAS, CLINICA Y HEMODINAMICAMENTE ESTABLE, CIFRAS TENSIONALES NORMALES, TAQUICARDICO, EUNEIPCO,

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

SATURACIÓN EN METAS, EN OXIGENOTERAPIA CON VENTURY AL 35% TOLERANDO DESTETE. EN RONDA MEDICA SE HABLA EN CONJUNTO CON MEDICINA INTERNA CON HEMODINAMIA QUE ACUERDAN QUE SE DEBE CONOCER EXACTAMENTE LA ANATOMIA CARDIACA ANTES DE REALIZAR CUALQUIER PROCEDIMIENTO, EL DÍA DE HOY CONTINUA PENDIENTE RESONANCIA CARDIACA CON RECONSTRUCCIÓN 3D PARA PROCEDER SEGUN RESULTADOS. PACIENTE QUE COMENZÓ A RECIBIR TERAPIA RIPE CONTINUA CON MANEJO INSTAURADO. SE EXPLICA CONDUCTA A PACIENTE QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR.

Fecha: 19/02/2022: 12:41:00, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: JORGE YEPES CARO, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

1. DISNEA SEC: 1.1. TUBERCULOSIS PULMONAR ACTIVA 1.1.1. TUBERCULOSIS MEDISTINICA 1.1.1.1. HIPERTENSION PULMONAR SEVERA 1.1.1.1.1. ESTENOSIS DE LA VENA PULMONAR IZQUIERDA SUPERIOR 1.2. NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD CURB 65 2 PUNTOS RESUELTA 2. ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIA PSICOATIVAS 3. ANTECEDENTES DE TBC HACE 4 AÑOS NO ADHERENTE AL TRATAMIENTO 4. ANTECEDENTES DE HEMOPTISIS MASIVA (2021) 5. ANTECEDENTES DE ESTENOSIS ESOFAGICA(UNION ESOFAGO PROXIMA Y MEDIO DE 2CM) CON REQUERIMIENTO DE DILATACIÓN

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE PASAR BUENA NOCHE, CON DISMINUCIÓN EN LA PERSISTENCIA DE SINTOMAS RESPIRATORIOS

Objetivo:

TA: 120/80 MMHG FC:117 LPM FR:20 RPM SAT: 98%. PACIENTE EN ACEPTABLES CONDICIONES GENERALES, ALERTA, ORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA, CABEZA Y CUELLO: PUPILAS ISOCORICAS NORMOREACTIVAS A LA LUZ, MUCOSA ORAL HUMEDA, CUELLO MOVIL, SIMETRICO, NO ADENOPATIAS, SIN RIGIDEZ DE NUCA TORAX: RUIDOS CARDIACOS RITMICOS SIN SOPLOS, NO S3, RUIDOS RESPIRATORIOS PRESENTES PERO DISMINUIDOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO DERECHO, NO CREPITOS, SIBILANCIAS OCASIONALES. ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMIDADES: SIMETRICAS HIPOTROFICAS SIN EDEMA LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS, PULSOS PERIFERICOS PRESENTES SIMETRICOS DE BUENA INTENSIDAD SNC: SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE. GLASGOW 15/15

Análisis:

PACIENTE MASCULINO DE 40 AÑOS DE EDAD CON ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOATIVAS Y TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS, ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR. DURANTE RONDA MEDICA PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES PROTEICOALÓRICAS, CLINICA Y HEMODINAMICAMENTE ESTABLE, CIFRAS TENSIONALES NORMALES, TAQUICARDICO, EUNEIPCO, SATURACIÓN EN METAS, EN OXIGENOTERAPIA CON VENTURY AL 35% TOLERANDO DESTETE. EN RONDA MEDICA SE HABLA EN CONJUNTO CON MEDICINA INTERNA CON HEMODINAMIA QUE ACUERDAN QUE SE DEBE CONOCER EXACTAMENTE LA ANATOMIA CARDIACA ANTES DE REALIZAR CUALQUIER PROCEDIMIENTO, PENDIENTE TOMOGRAFIA CORONARIA . PACIENTE CURSANDO CON PROCESO INFECCIOSO MEDIASTINAL Y REPERCUSIONES CIRCULATORIAS CON OBSTRUCCION DE VENA PULMONAR IZQUIERDA E HIPERTENSION PULMONAR SEVERA, POR LO QUE SE ENCUENTRA PENDIENTE TOMOGRAFIA CARDÍACA CON RECONSTRUCCION VIRTUAL Y CATETERISMO CARDÍACO PARA PROCEDER SEGUN RESULTADOS, PACIENTE QUE COMENZÓ A RECIBIR TERAPIA RIPE CONTINUA CON MANEJO INSTAURADO. SE EXPLICA CONDUCTA A PACIENTE QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR.

Fecha: 20/02/2022: 10:45:37, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: JORGE YEPES CARO, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

1. DISNEA SEC:

1.1. TUBERCULOSIS PULMONAR ACTIVA

1.1.1. TUBERCULOSIS MEDISTINICA

1.1.1.1. HIPERTENSION PULMONAR SEVERA

1.1.1.1.1. ESTENOSIS DE LA VENA PULMONAR IZQUIERDA SUPERIOR

1.2. NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD CURB 65 2 PUNTOS RESUELTA

2. ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIA PSICOATIVAS

3. ANTECEDENTES DE TBC HACE 4 AÑOS NO ADHERENTE AL TRATAMIENTO

4. ANTECEDENTES DE HEMOPTISIS MASIVA (2021)

5. ANTECEDENTES DE ESTENOSIS ESOFAGICA(UNION ESOFAGO PROXIMA Y MEDIO DE 2CM) CON REQUERIMIENTO DE DILATACIÓN

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE PASAR BUENA NOCHE, CON DISMINUCIÓN EN LA PERSISTENCIA DE SINTOMAS RESPIRATORIOS

Objetivo:

TA: 100/60 MMHG FC:91 LPM FR:22 RPM SAT: 99%.

PACIENTE EN ACEPTABLES CONDICIONES GENERALES, ALERTA, ORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA, CABEZA Y CUELLO: PUPILAS ISOCORICAS NORMOREACTIVAS A LA LUZ, MUCOSA ORAL HUMEDA, CUELLO MOVIL, SIMETRICO, NO ADENOPATIAS, SIN RIGIDEZ DE NUCA TORAX: RUIDOS CARDIACOS RITMICOS SIN SOPLOS, NO S3, RUIDOS RESPIRATORIOS PRESENTES PERO DISMINUIDOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO DERECHO, NO CREPITOS, SIBILANCIAS OCASIONALES. ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMIDADES: SIMETRICAS HIPOTROFICAS SIN EDEMA LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS, PULSOS PERIFERICOS PRESENTES SIMETRICOS DE BUENA INTENSIDAD SNC: SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE. GLASGOW 15/15

Análisis:

PACIENTE MASCULINO DE 40 AÑOS DE EDAD CON ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOATIVAS Y TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS, ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR. DURANTE RONDA MEDICA PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES PROTEICOALÓRICAS, CLINICA Y HEMODINAMICAMENTE ESTABLE, CIFRAS TENSIONALES NORMALES, EUCARDICO, EUNEIPCO, SATURACIÓN EN METAS, EN OXIGENOTERAPIA CON VENTURY AL 35% TOLERANDO DESTETE. EN RONDA MEDICA SE HABLA EN CONJUNTO CON MEDICINA INTERNA CON HEMODINAMIA QUE ACUERDAN QUE SE DEBE CONOCER EXACTAMENTE LA ANATOMIA CARDIACA ANTES DE REALIZAR CUALQUIER PROCEDIMIENTO, EL DÍA DE HOY CONTINUA PENDIENTE RESONANCIA CARDIACA CON RECONSTRUCCIÓN 3D PARA PROCEDER SEGUN RESULTADOS. PACIENTE QUE CONTINUA RECIBIENDO TERAPIA RIPE. SIGUE CON MANEJO INSTAURADO. SE EXPLICA CONDUCTA A PACIENTE QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR.

Fecha: 21/02/2022: 10:40:45, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

1. DISNEA SEC:

1.1. TUBERCULOSIS PULMONAR ACTIVA

1.1.1. TUBERCULOSIS MEDISTINICA

1.1.1.1. HIPERTENSION PULMONAR SEVERA

1.1.1.1.1. ESTENOSIS DE LA VENA PULMONAR IZQUIERDA SUPERIOR

1.2. NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD CURB 65 2 PUNTOS RESUELTA

2. ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIA PSICOATIVAS

3. ANTECEDENTES DE TBC HACE 4 AÑOS NO ADHERENTE AL TRATAMIENTO

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

4. ANTECEDENTES DE HEMOPTISIS MASIVA (2021)

5. ANTECEDENTES DE ESTENOSIS ESOFAGICA(UNION ESOFAGO PROXIMA Y MEDIO DE 2CM) CON REQUERIMIENTO DE DILATACIÓN

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE PASAR BUENA NOCHE, CON DISMINUCIÓN EN LA PERSISTENCIA DE SINTOMAS RESPIRATORIOS

Objetivo:

TA: 100/60 MMHG FC:120 LPM FR:22 RPM SAT: 99%.

PACIENTE EN ACEPTABLES CONDICIONES GENERALES, ALERTA, ORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA, CABEZA Y CUELLO: PUPILAS ISOCORICAS NORMOREACTIVAS A LA LUZ, MUCOSA ORAL HUMEDA, CUELLO MOVIL, SIMETRICO, NO ADENOPATIAS, SIN RIGIDEZ DE NUCA. TORAX: RUIDOS CARDIACOS RITMICOS SIN SOPLOS, NO S3, RUIDOS RESPIRATORIOS PRESENTES PERO DISMINUIDOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO DERECHO, NO CREPITOS, SIBILANCIAS OCASIONALES. ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMIDADES: SIMETRICAS HIPOTROFICAS SIN EDEMA LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS, PULSOS PERIFERICOS PRESENTES SIMETRICOS DE BUENA INTENSIDAD SNC: SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE. GLASGOW 15/15

Análisis:

PACIENTE MASCULINO DE 40 AÑOS DE EDAD CON ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS, ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR. DURANTE RONDA MEDICA PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES PROTEICOCALÓRICAS, CLINICA Y HEMODINAMICAMENTE ESTABLE, CIFRAS TENSIONALES NORMALES, EUCARDICO, EUNEIPCO, SATURACIÓN EN METAS, EN OXIGENOTERAPIA CON VENTURY AL 50% NO TOLERANDO DESTETE. EN RONDA MEDICA SE HABLA EN CONJUNTO CON MEDICINA INTERNA CON HEMODINAMIA QUE ACUERDAN QUE SE DEBE CONOCER EXACTAMENTE LA ANATOMIA CARDIACA ANTES DE REALIZAR CUALQUIER PROCEDIMIENTO, EL DÍA DE HOY CONTINUA PENDIENTE RESONANCIA CARDIACA CON RECONSTRUCCIÓN 3D PARA PROCEDER SEGUN RESULTADOS. PACIENTE QUE CONTINUA RECIBIENDO TERAPIA RIPE. SIGUE CON MANEJO INSTAURADO. SE EXPLICA CONDUCTA A PACIENTE QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR.

Fecha: 21/02/2022: 11:21:57, **Historia:** Evolución Clínica General, **Prestador:** FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, **Especialidad:** INFECTOLOGIA

Problema:

1. DISNEA SEC:

1.1. TUBERCULOSIS PULMONAR ACTIVA

1.1.1. TUBERCULOSIS MEDISTINICA

1.1.1.1. HIPERTENSION PULMONAR SEVERA

1.1.1.1.1. ESTENOSIS DE LA VENA PULMONAR IZQUIERDA SUPERIOR

1.2. NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD CURB 65 2 PUNTOS RESUELTA

2. ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIA PSICOATIVAS

3. ANTECEDENTES DE TBC HACE 4 AÑOS NO ADHERENTE AL TRATAMIENTO

4. ANTECEDENTES DE HEMOPTISIS MASIVA (2021)

5. ANTECEDENTES DE ESTENOSIS ESOFAGICA(UNION ESOFAGO PROXIMA Y MEDIO DE 2CM) CON REQUERIMIENTO DE DILATACIÓN

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE PASAR BUENA NOCHE, CON DISMINUCIÓN EN LA PERSISTENCIA DE SINTOMAS RESPIRATORIOS

Objetivo:

TA: 100/60 MMHG FC:120 LPM FR:22 RPM SAT: 99%.

PACIENTE EN ACEPTABLES CONDICIONES GENERALES, ALERTA, ORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA, CABEZA Y CUELLO: PUPILAS ISOCORICAS NORMOREACTIVAS A LA LUZ, MUCOSA ORAL HUMEDA, CUELLO MOVIL, SIMETRICO, NO ADENOPATIAS, SIN RIGIDEZ DE NUCA. TORAX: RUIDOS CARDIACOS RITMICOS SIN SOPLOS, NO S3, RUIDOS RESPIRATORIOS PRESENTES PERO DISMINUIDOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO DERECHO, NO CREPITOS, SIBILANCIAS OCASIONALES. ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMIDADES: SIMETRICAS HIPOTROFICAS SIN EDEMA LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS, PULSOS PERIFERICOS PRESENTES SIMETRICOS DE BUENA INTENSIDAD SNC: SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE. GLASGOW 15/15

Análisis:

PACIENTE MASCULINO DE 40 AÑOS DE EDAD CON ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS, ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR. DURANTE RONDA MEDICA PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES PROTEICOCALÓRICAS, CLINICA Y HEMODINAMICAMENTE ESTABLE, CIFRAS TENSIONALES NORMALES, EUCARDICO, EUNEIPCO, SATURACIÓN EN METAS, EN OXIGENOTERAPIA CON VENTURY AL 50% NO TOLERANDO DESTETE. EN RONDA MEDICA SE HABLA EN CONJUNTO CON MEDICINA INTERNA CON HEMODINAMIA QUE ACUERDAN QUE SE DEBE CONOCER EXACTAMENTE LA ANATOMIA CARDIACA ANTES DE REALIZAR CUALQUIER PROCEDIMIENTO, EL DÍA DE HOY CONTINUA PENDIENTE REALIZACION DE TOMOGRAFIA COMPUTADA DE CORONARIAS CODIGO CUPS 879902 TOMOGRAFIA COMPUTADA RECONSTRUCCION VIRTUAL CODIGO CUPS 879911 3D PARA PROCEDER SEGUN RESULTADOS. PACIENTE QUE CONTINUA RECIBIENDO TERAPIA RIPE. SIGUE CON MANEJO INSTAURADO. SE EXPLICA CONDUCTA A PACIENTE QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR

Fecha: 22/02/2022: 10:14:02, **Historia:** Evolución Clínica General, **Prestador:** FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, **Especialidad:** INFECTOLOGIA

Problema:

1. DISNEA SEC:

1.1. TUBERCULOSIS PULMONAR ACTIVA

1.1.1. TUBERCULOSIS MEDISTINICA

1.1.1.1. HIPERTENSION PULMONAR SEVERA

1.1.1.1.1. ESTENOSIS DE LA VENA PULMONAR IZQUIERDA SUPERIOR

1.2. NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD CURB 65 2 PUNTOS RESUELTA

2. ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIA PSICOATIVAS

3. ANTECEDENTES DE TBC HACE 4 AÑOS NO ADHERENTE AL TRATAMIENTO

4. ANTECEDENTES DE HEMOPTISIS MASIVA (2021)

5. ANTECEDENTES DE ESTENOSIS ESOFAGICA(UNION ESOFAGO PROXIMA Y MEDIO DE 2CM) CON REQUERIMIENTO DE DILATACIÓN

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE PASAR BUENA NOCHE, CON DISMINUCIÓN EN LA PERSISTENCIA DE SINTOMAS RESPIRATORIOS

Objetivo:

TA: 120/90 MMHG FC:96 LPM FR:20 RPM SAT: 98%.

PACIENTE EN ACEPTABLES CONDICIONES GENERALES, ALERTA, ORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA, CABEZA Y CUELLO: PUPILAS ISOCORICAS NORMOREACTIVAS A LA LUZ, MUCOSA ORAL HUMEDA, CUELLO MOVIL, SIMETRICO, NO ADENOPATIAS, SIN RIGIDEZ DE NUCA. TORAX: RUIDOS CARDIACOS RITMICOS SIN SOPLOS, NO S3, RUIDOS RESPIRATORIOS PRESENTES PERO DISMINUIDOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO DERECHO, NO CREPITOS, SIBILANCIAS OCASIONALES. ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMIDADES: SIMETRICAS HIPOTROFICAS SIN EDEMA LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS, PULSOS PERIFERICOS PRESENTES SIMETRICOS DE BUENA INTENSIDAD SNC: SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE. GLASGOW

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

15/15

Análisis:

PACIENTE MASCULINO DE 40 AÑOS DE EDAD CON ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS, ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR. DURANTE RONDA MEDICA PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES PROTEICOALÓRICAS, CLINICA Y HEMODINAMICAMENTE ESTABLE, CIFRAS TENSIONALES NORMALES, EUCARDICO, EUNEIPCO, SATURACIÓN EN METAS, EN OXIGENOTERAPIA CON VENTURY AL 50% NO TOLERANDO DESTETE. EN RONDA MEDICA SE HABLA EN CONJUNTO CON MEDICINA INTERNA CON HEMODINAMIA QUE ACUERDAN QUE SE DEBE CONOCER EXACTAMENTE LA ANATOMIA CARDIACA ANTES DE REALIZAR CUALQUIER PROCEDIMIENTO, EL DÍA DE HOY CONTINUA PENDIENTE REALIZACION DE TOMOGRAFIA COMPUTADA DE CORONARIAS CODIGO CUPS 879902 TOMOGRAFIA COMPUTADA RECONSTRUCCION VIRTUAL CODIGO CUPS 879911 3D PARA PROCEDER SEGUN RESULTADOS. PACIENTE QUE CONTINUA RECIBIENDO TERAPIA RIPE. SIGUE CON MANEJO INSTAURADO. SE EXPLICA CONDUCTA A PACIENTE QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR.

Fecha: 23/02/2022: 10:52:44, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

1. DISNEA SEC:

1.1. TUBERCULOSIS PULMONAR ACTIVA

1.1.1. TUBERCULOSIS MEDISTINICA

1.1.1.1. HIPERTENSION PULMONAR SEVERA

1.1.1.1.1 ESTENOSIS DE LA VENA PULMONAR IZQUIERDA SUPERIOR

1.2. NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD CURB 65 2 PUNTOS RESUELTA

2. ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIA PSICOATIVAS

3. ANTECEDENTES DE TBC HACE 4 AÑOS NO ADHERENTE AL TRATAMIENTO

4. ANTECEDENTES DE HEMOPTISIS MASIVA (2021)

5. ANTECEDENTES DE ESTENOSIS ESOFAGICA (UNION ESOFAGO PROXIMA Y MEDIO DE 2CM) CON REQUERIMIENTO DE DILATACIÓN

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE PASAR BUENA NOCHE, CON DISMINUCIÓN EN LA PERSISTENCIA DE SINTOMAS RESPIRATORIOS

Objetivo:

TA: 100/80 MMHG FC:98 LPM FR:20 RPM SAT: 99%.

PACIENTE EN ACEPTABLES CONDICIONES GENERALES, ALERTA, ORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA, CABEZA Y CUELLO: PUPILAS ISOCORICAS NORMOREACTIVAS A LA LUZ, MUCOSA ORAL HUMEDA, CUELLO MOVIL, SIMETRICO, NO ADENOPATIAS, SIN RIGIDEZ DE NUCA. TORAX: RUIDOS CARDIACOS RITMICOS SIN SOPLOS, NO S3, RUIDOS RESPIRATORIOS PRESENTES PERO DISMINUIDOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO DERECHO, NO CREPITOS, SIBILANCIAS OCASIONALES. ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMIDADES: SIMETRICAS HIPOTROFICAS SIN EDEMA LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS, PULSOS PERIFERICOS PRESENTES SIMETRICOS DE BUENA INTENSIDAD SNC: SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE. GLASGOW 15/15

Análisis:

PACIENTE MASCULINO DE 40 AÑOS DE EDAD CON ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS, ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR. DURANTE RONDA MEDICA PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES PROTEICOALÓRICAS, CLINICA Y HEMODINAMICAMENTE ESTABLE, CIFRAS TENSIONALES NORMALES, EUCARDICO, EUNEIPCO, SATURACIÓN EN METAS, EN OXIGENOTERAPIA CON VENTURY AL 50% NO TOLERANDO DESTETE. EN RONDA MEDICA SE HABLA EN CONJUNTO CON MEDICINA INTERNA CON HEMODINAMIA QUE ACUERDAN QUE SE DEBE CONOCER EXACTAMENTE LA ANATOMIA CARDIACA ANTES DE REALIZAR CUALQUIER PROCEDIMIENTO, EL DÍA DE HOY CONTINUA PENDIENTE REALIZACION DE TOMOGRAFIA COMPUTADA DE CORONARIAS CODIGO CUPS 879902 TOMOGRAFIA COMPUTADA RECONSTRUCCION VIRTUAL CODIGO CUPS 879911 3D PARA PROCEDER SEGUN RESULTADOS, LA CUAL FUE PROGRAMADA PARA EL DÍA DE HOY PERO POR NO CONTAR CON ACOMPAÑANTE NO PUDO SER TRASLADADO AL PROCEDIMIENTO. CONTINUA PENDIENTE NUEVA REPROGRAMACION. PACIENTE QUE CONTINUA RECIBIENDO TERAPIA RIPE. SIGUE CON MANEJO INSTAURADO. SE EXPLICA CONDUCTA A PACIENTE QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR.

Fecha: 24/02/2022: 12:12:04, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

1. DISNEA SEC:

1.1. TUBERCULOSIS PULMONAR ACTIVA

1.1.1. TUBERCULOSIS MEDISTINICA

1.1.1.1. HIPERTENSION PULMONAR SEVERA

1.1.1.1.1 ESTENOSIS DE LA VENA PULMONAR IZQUIERDA SUPERIOR

1.2. NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD CURB 65 2 PUNTOS RESUELTA

2. ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIA PSICOATIVAS

3. ANTECEDENTES DE TBC HACE 4 AÑOS NO ADHERENTE AL TRATAMIENTO

4. ANTECEDENTES DE HEMOPTISIS MASIVA (2021)

5. ANTECEDENTES DE ESTENOSIS ESOFAGICA (UNION ESOFAGO PROXIMA Y MEDIO DE 2CM) CON REQUERIMIENTO DE DILATACIÓN

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE PASAR BUENA NOCHE, CON DISMINUCIÓN EN LA PERSISTENCIA DE SINTOMAS RESPIRATORIOS

Objetivo:

TA: 100/60 MMHG FC:86 LPM FR:21 RPM SAT: 99%.

PACIENTE EN ACEPTABLES CONDICIONES GENERALES, ALERTA, ORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA, CABEZA Y CUELLO: PUPILAS ISOCORICAS NORMOREACTIVAS A LA LUZ, MUCOSA ORAL HUMEDA, CUELLO MOVIL, SIMETRICO, NO ADENOPATIAS, SIN RIGIDEZ DE NUCA. TORAX: RUIDOS CARDIACOS RITMICOS SIN SOPLOS, NO S3, RUIDOS RESPIRATORIOS PRESENTES PERO DISMINUIDOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO DERECHO, NO CREPITOS, SIBILANCIAS OCASIONALES. ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMIDADES: SIMETRICAS HIPOTROFICAS SIN EDEMA LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS, PULSOS PERIFERICOS PRESENTES SIMETRICOS DE BUENA INTENSIDAD SNC: SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE. GLASGOW 15/15

Análisis:

PACIENTE MASCULINO DE 40 AÑOS DE EDAD CON ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS, ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR. DURANTE RONDA MEDICA PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES PROTEICOALÓRICAS, CLINICA Y HEMODINAMICAMENTE ESTABLE, CIFRAS TENSIONALES NORMALES, EUCARDICO, EUNEIPCO, SATURACIÓN EN METAS, EN OXIGENOTERAPIA CON VENTURY AL 50% NO TOLERANDO DESTETE. EN RONDA MEDICA SE HABLA EN CONJUNTO CON MEDICINA INTERNA CON HEMODINAMIA QUE ACUERDAN QUE SE DEBE CONOCER EXACTAMENTE LA ANATOMIA CARDIACA ANTES DE REALIZAR CUALQUIER PROCEDIMIENTO, EL DÍA DE HOY CONTINUA PENDIENTE REALIZACION DE TOMOGRAFIA COMPUTADA DE CORONARIAS CODIGO CUPS 879902 TOMOGRAFIA COMPUTADA RECONSTRUCCION VIRTUAL CODIGO CUPS 879911 3D PARA PROCEDER SEGUN RESULTADOS, LA CUAL FUE PROGRAMADA PERO NO REALIZADA POR NO CONTAR CON ACOMPAÑANTE NO PUDO SER TRASLADADO AL PROCEDIMIENTO. ACTUALMENTE CONTINUA

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

A ESPERAS DE REPROGRAMACION. PACIENTE QUE CONTINUA RECIBIENDO TERAPIA RIPE. SIGUE CON MANEJO INSTAURADO. SE EXPLICA CONDUCTA A PACIENTE QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR.

Fecha: 25/02/2022: 10:47:40, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

1. DISNEA SEC: 1.1. TUBERCULOSIS PULMONAR ACTIVA 1.1.1. TUBERCULOSIS MEDISTINICA 1.1.1.1. HIPERTENSION PULMONAR SEVERA 1.1.1.1.1 ESTENOSIS DE LA VENA PULMONAR IZQUIERDA SUPERIOR 1.2. NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD CURB 65 2 PUNTOS RESUELTA 2. ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIA PSICOATIVAS 3. ANTECEDENTES DE TBC HACE 4 AÑOS NO ADHERENTE AL TRATAMIENTO 4. ANTECEDENTES DE HEMOPTISIS MASIVA (2021) 5. ANTECEDENTES DE ESTENOSIS ESOFAGICA(UNION ESOFAGO PROXIMA Y MEDIO DE 2CM) CON REQUERIMIENTO DE DILATACIÓN

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE PASAR BUENA NOCHE, CON DISMINUCIÓN EN LA PERSISTENCIA DE SINTOMAS RESPIRATORIOS

Objetivo:

TA: 120/80 MMHG FC:110 LPM FR:24RPM SAT: 97%. PACIENTE EN ACEPTABLES CONDICIONES GENERALES, ALERTA, ORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA, CABEZA Y CUELLO: PUPILAS ISOCORICAS NORMOREACTIVAS A LA LUZ, MUCOSA ORAL HUMEDA, CUELLO MOVIL, SIMETRICO, NO ADENOPATIAS, SIN RIGIDEZ DE NUCA TORAX: RUIDOS CARDIACOS RITMICOS SIN SOPLOS, NO S3, RUIDOS RESPIRATORIOS PRESENTES PERO DISMINUIDOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO DERECHO, NO CREPITOS, SIBILANCIAS OCASIONALES. ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMIDADES: SIMETRICAS HIPOTROFICAS SIN EDEMA LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS, PULSOS PERIFERICOS PRESENTES SIMETRICOS DE BUENA INTENSIDAD SNC: SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE. GLASGOW 15/15

Análisis:

PACIENTE MASCULINO DE 40 AÑOS DE EDAD CON ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS, ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR. DURANTE RONDA MEDICA PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES PROTEICOCALÓRICAS, CLINICA Y HEMODINAMICAMENTE ESTABLE, CIFRAS TENSIONALES NORMALES, EUCARDICO, EUNEIPCO, SATURACIÓN EN METAS, EN OXIGENOTERAPIA CON VENTURY AL 50% NO TOLERANDO DESTETE. EN RONDA MEDICA SE HABLA EN CONJUNTO CON MEDICINA INTERNA CON HEMODINAMIA QUE ACUERDAN QUE SE DEBE CONOCER EXACTAMENTE LA ANATOMIA CARDIACA ANTES DE REALIZAR CUALQUIER PROCEDIMIENTO, EL DÍA DE HOY CONTINUA PENDIENTE REALIZACION DE TOMOGRAFIA COMPUTADA DE CORONARIAS CODIGO CUPS 879902 TOMOGRAFIA COMPUTADA RECONSTRUCCION VIRTUAL CODIGO CUPS 879911 3D PARA PROCEDER SEGUN RESULTADOS, LA CUAL FUE PROGRAMADA PERO NO REALIZADA POR NO CONTAR CON ACOMPAÑANTE NO PUDO SER TRASLADADO AL PROCEDIMIENTO. ACTUALMENTE CONTINUA A ESPERAS DE REPROGRAMACION. PACIENTE QUE CONTINUA RECIBIENDO TERAPIA RIPE. SIGUE CON MANEJO INSTAURADO. SE EXPLICA CONDUCTA A PACIENTE QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR.

Fecha: 26/02/2022: 10:27:35, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: ORLANDO SANGUINO OMAÑA, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

1. DISNEA SEC: 1.1. TUBERCULOSIS PULMONAR ACTIVA 1.1.1. TUBERCULOSIS MEDISTINICA 1.1.1.1. HIPERTENSION PULMONAR SEVERA 1.1.1.1.1 ESTENOSIS DE LA VENA PULMONAR IZQUIERDA SUPERIOR 1.2. NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD CURB 65 2 PUNTOS RESUELTA 2. ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIA PSICOATIVAS 3. ANTECEDENTES DE TBC HACE 4 AÑOS NO ADHERENTE AL TRATAMIENTO 4. ANTECEDENTES DE HEMOPTISIS MASIVA (2021) 5. ANTECEDENTES DE ESTENOSIS ESOFAGICA(UNION ESOFAGO PROXIMA Y MEDIO DE 2CM) CON REQUERIMIENTO DE DILATACIÓN

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE SENTIRSE BIEN

Objetivo:

TA: 120/80 MMHG FC:110 LPM FR:24RPM SAT: 97%. PACIENTE EN ACEPTABLES CONDICIONES GENERALES, ALERTA, ORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA, CABEZA Y CUELLO: PUPILAS ISOCORICAS NORMOREACTIVAS A LA LUZ, MUCOSA ORAL HUMEDA, CUELLO MOVIL, SIMETRICO, NO ADENOPATIAS, SIN RIGIDEZ DE NUCA TORAX: RUIDOS CARDIACOS RITMICOS SIN SOPLOS, NO S3, RUIDOS RESPIRATORIOS PRESENTES PERO DISMINUIDOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO DERECHO, NO CREPITOS, SIBILANCIAS OCASIONALES. ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMIDADES: SIMETRICAS HIPOTROFICAS SIN EDEMA LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS, PULSOS PERIFERICOS PRESENTES SIMETRICOS DE BUENA INTENSIDAD SNC: SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE. GLASGOW 15/15

Análisis:

PACIENTE MASCULINO DE 40 AÑOS DE EDAD CON ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS, ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR. DURANTE RONDA MEDICA PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES PROTEICOCALÓRICAS, CLINICA Y HEMODINAMICAMENTE ESTABLE, CIFRAS TENSIONALES NORMALES, EUCARDICO, EUNEIPCO, SATURACIÓN EN METAS, EN OXIGENOTERAPIA CON VENTURY AL 50% NO TOLERANDO DESTETE. EN RONDA MEDICA SE HABLA EN CONJUNTO CON MEDICINA INTERNA CON HEMODINAMIA QUE ACUERDAN QUE SE DEBE CONOCER EXACTAMENTE LA ANATOMIA CARDIACA ANTES DE REALIZAR CUALQUIER PROCEDIMIENTO, EL DÍA DE HOY CONTINUA PENDIENTE REALIZACION DE TOMOGRAFIA COMPUTADA DE CORONARIAS CODIGO CUPS 879902 TOMOGRAFIA COMPUTADA RECONSTRUCCION VIRTUAL CODIGO CUPS 879911 3D PARA PROCEDER SEGUN RESULTADOS, LA CUAL FUE PROGRAMADA PERO NO REALIZADA POR NO CONTAR CON ACOMPAÑANTE NO PUDO SER TRASLADADO AL PROCEDIMIENTO. ACTUALMENTE CONTINUA A ESPERAS DE REPROGRAMACION. PACIENTE QUE CONTINUA RECIBIENDO TERAPIA RIPE. SIGUE CON MANEJO INSTAURADO. SE EXPLICA CONDUCTA A PACIENTE QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR.

Fecha: 27/02/2022: 11:06:13, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: ORLANDO SANGUINO OMAÑA, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

1. DISNEA SEC:

1.1. TUBERCULOSIS PULMONAR ACTIVA

1.1.1. TUBERCULOSIS MEDISTINICA

1.1.1.1. HIPERTENSION PULMONAR SEVERA

1.1.1.1.1 ESTENOSIS DE LA VENA PULMONAR IZQUIERDA SUPERIOR

1.2. NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD CURB 65 2 PUNTOS RESUELTA

2. ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIA PSICOATIVAS

3. ANTECEDENTES DE TBC HACE 4 AÑOS NO ADHERENTE AL TRATAMIENTO

4. ANTECEDENTES DE HEMOPTISIS MASIVA (2021)

5. ANTECEDENTES DE ESTENOSIS ESOFAGICA(UNION ESOFAGO PROXIMA Y MEDIO DE 2CM) CON REQUERIMIENTO DE DILATACIÓN

6. ANTECEDENTE DE TBC HACE 4 AÑOS NO ADHERENTE AL TRATAMIENTO

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE SENTIRSE BIEN

Objetivo:

TA: 100/70 MMHG FC:44 LPM FR:22RPM SAT: 98%. PACIENTE EN ACEPTABLES CONDICIONES GENERALES, ALERTA, ORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

PERSONA, CABEZA Y CUELLO: PUPILAS ISOCORICAS NORMOREACTIVAS A LA LUZ, MUCOSA ORAL HUMEDA, CUELLO MOVIL, SIMETRICO, NO ADENOPATIAS, SIN RIGIDEZ DE NUCA TORAX: RUIDOS CARDIACOS RITMICOS SIN SOPLOS, NO S3, RUIDOS RESPIRATORIOS PRESENTES PERO DISMINUIDOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO DERECHO, NO CREPITOS, SIBILANCIAS OCASIONALES. ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMIDADES: SIMETRICAS HIPOTROFICAS SIN EDEMA LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS, PULSOS PERIFERICOS PRESENTES SIMETRICOS DE BUENA INTENSIDAD SNC: SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE. GLASGOW 15/15

Análisis:

PACIENTE MASCULINO DE 40 AÑOS DE EDAD CON ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS, ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR. DURANTE RONDA MEDICA PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES PROTEICOCALÓRICAS, CLINICA Y HEMODINAMICAMENTE ESTABLE, CIFRAS TENSIONALES NORMALES, BRADICARDICO, TAQUIPNEICO, SATURACIÓN EN METAS, EN OXIGENOTERAPIA CON VENTURY AL 50% NO TOLERANDO DESTETE. EN RONDA MEDICA SE HABLA EN CONJUNTO CON MEDICINA INTERNA CON HEMODINAMIA QUE ACUERDAN QUE SE DEBE CONOCER EXACTAMENTE LA ANATOMIA CARDIACA ANTES DE REALIZAR CUALQUIER PROCEDIMIENTO, EL DÍA DE HOY CONTINUA PENDIENTE REALIZACION DE TOMOGRAFIA COMPUTADA DE CORONARIAS CODIGO CUPS 879902 TOMOGRAFIA COMPUTADA RECONSTRUCCION VIRTUAL CODIGO CUPS 879911 3D PARA PROCEDER SEGUN RESULTADOS, LA CUAL FUE PROGRAMADA PERO NO REALIZADA POR NO CONTAR CON ACOMPAÑANTE NO PUDO SER TRASLADADO AL PROCEDIMIENTO. ACTUALMENTE CONTINUA A ESPERAS DE REPROGRAMACION. PACIENTE QUE CONTINUA RECIBIENDO TERAPIA RIPE. SIGUE CON MANEJO INSTAURADO. SE EXPLICA CONDUCTA A PACIENTE QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR.

Fecha: 28/02/2022: 11:10:29, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

1. DISNEA SEC: 1.1. TUBERCULOSIS PULMONAR ACTIVA 1.1.1. TUBERCULOSIS MEDISTINICA 1.1.1.1. HIPERTENSION PULMONAR SEVERA 1.1.1.1.1. ESTENOSIS DE LA VENA PULMONAR IZQUIERDA SUPERIOR 1.2. NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD CURB 65 2 PUNTOS RESUELTA 2. ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIA PSICOACTIVAS 3. ANTECEDENTES DE TBC HACE 4 AÑOS NO ADHERENTE AL TRATAMIENTO 4. ANTECEDENTES DE HEMOPTISIS MASIVA (2021) 5. ANTECEDENTES DE ESTENOSIS ESOFAGICA(UNION ESOFAGO PROXIMA Y MEDIO DE 2CM) CON REQUERIMIENTO DE DILATACIÓN 6. ANTECEDENTE DE TBC HACE 4 AÑOS NO ADHERENTE AL TRATAMIENTO

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE SENTIRSE BIEN

Objetivo:

TA: 110/70 MMHG FC:99 LPM FR:22RPM SAT: 99%. PACIENTE EN ACEPTABLES CONDICIONES GENERALES, ALERTA, ORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA, CABEZA Y CUELLO: PUPILAS ISOCORICAS NORMOREACTIVAS A LA LUZ, MUCOSA ORAL HUMEDA, CUELLO MOVIL, SIMETRICO, NO ADENOPATIAS, SIN RIGIDEZ DE NUCA TORAX: RUIDOS CARDIACOS RITMICOS SIN SOPLOS, NO S3, RUIDOS RESPIRATORIOS PRESENTES PERO DISMINUIDOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO DERECHO, NO CREPITOS, SIBILANCIAS OCASIONALES. ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMIDADES: SIMETRICAS HIPOTROFICAS SIN EDEMA LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS, PULSOS PERIFERICOS PRESENTES SIMETRICOS DE BUENA INTENSIDAD SNC: SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE. GLASGOW 15/15

Análisis:

PACIENTE MASCULINO DE 40 AÑOS DE EDAD CON ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS, ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR. DURANTE RONDA MEDICA PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES PROTEICOCALÓRICAS, CLINICA Y HEMODINAMICAMENTE ESTABLE, CIFRAS TENSIONALES NORMALES, BRADICARDICO, TAQUIPNEICO, SATURACIÓN EN METAS, EN OXIGENOTERAPIA CON VENTURY AL 50% NO TOLERANDO DESTETE. EN RONDA MEDICA SE HABLA EN CONJUNTO CON MEDICINA INTERNA CON HEMODINAMIA QUE ACUERDAN QUE SE DEBE CONOCER EXACTAMENTE LA ANATOMIA CARDIACA ANTES DE REALIZAR CUALQUIER PROCEDIMIENTO, EL DÍA DE HOY CONTINUA PENDIENTE REALIZACION DE TOMOGRAFIA COMPUTADA DE CORONARIAS CODIGO CUPS 879902 TOMOGRAFIA COMPUTADA RECONSTRUCCION VIRTUAL CODIGO CUPS 879911 3D PARA PROCEDER SEGUN RESULTADOS, LA CUAL FUE PROGRAMADA PERO NO REALIZADA POR NO CONTAR CON ACOMPAÑANTE NO PUDO SER TRASLADADO AL PROCEDIMIENTO. ACTUALMENTE CONTINUA A ESPERAS DE REPROGRAMACION. PACIENTE QUE CONTINUA RECIBIENDO TERAPIA RIPE. SIGUE CON MANEJO INSTAURADO. SE EXPLICA CONDUCTA A PACIENTE QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR.

Fecha: 01/03/2022: 12:17:28, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

1. DISNEA SEC: 1.1. TUBERCULOSIS PULMONAR ACTIVA 1.1.1. TUBERCULOSIS MEDISTINICA 1.1.1.1. HIPERTENSION PULMONAR SEVERA 1.1.1.1.1. ESTENOSIS DE LA VENA PULMONAR IZQUIERDA SUPERIOR 1.2. NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD CURB 65 2 PUNTOS RESUELTA 2. ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIA PSICOACTIVAS 3. ANTECEDENTES DE TBC HACE 4 AÑOS NO ADHERENTE AL TRATAMIENTO 4. ANTECEDENTES DE HEMOPTISIS MASIVA (2021) 5. ANTECEDENTES DE ESTENOSIS ESOFAGICA(UNION ESOFAGO PROXIMA Y MEDIO DE 2CM) CON REQUERIMIENTO DE DILATACIÓN 6. ANTECEDENTE DE TBC HACE 4 AÑOS NO ADHERENTE AL TRATAMIENTO

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE SENTIRSE BIEN

Objetivo:

TA: 110/70 MMHG FC:118 LPM FR:24RPM SAT: 99%. PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, ALERTA, ORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA, CABEZA Y CUELLO: PUPILAS ISOCORICAS NORMOREACTIVAS A LA LUZ, MUCOSA ORAL HUMEDA, CUELLO MOVIL, SIMETRICO, NO ADENOPATIAS, SIN RIGIDEZ DE NUCA TORAX: RUIDOS CARDIACOS RITMICOS SIN SOPLOS, NO S3, RUIDOS RESPIRATORIOS PRESENTES PERO DISMINUIDOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO DERECHO, NO CREPITOS, SIBILANCIAS OCASIONALES. ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMIDADES: SIMETRICAS HIPOTROFICAS SIN EDEMA LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS, PULSOS PERIFERICOS PRESENTES SIMETRICOS DE BUENA INTENSIDAD SNC: SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE. GLASGOW 15/15

Análisis:

PACIENTE MASCULINO DE 40 AÑOS DE EDAD CON ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS, ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR. DURANTE RONDA MEDICA PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES PROTEICOCALÓRICAS, CLINICA Y HEMODINAMICAMENTE ESTABLE, CIFRAS TENSIONALES NORMALES, TAQUICARDICO, TAQUIPNEICO, SATURACIÓN EN METAS, EN OXIGENOTERAPIA CON VENTURY AL 50% NO TOLERANDO DESTETE. EN RONDA MEDICA SE HABLA EN CONJUNTO CON MEDICINA INTERNA CON HEMODINAMIA QUE ACUERDAN QUE SE DEBE CONOCER EXACTAMENTE LA ANATOMIA CARDIACA ANTES DE REALIZAR CUALQUIER PROCEDIMIENTO, EL DÍA DE HOY CONTINUA PENDIENTE REALIZACION DE TOMOGRAFIA COMPUTADA DE CORONARIAS CODIGO CUPS 879902 TOMOGRAFIA COMPUTADA RECONSTRUCCION VIRTUAL CODIGO CUPS 879911 3D PARA PROCEDER SEGUN RESULTADOS, LA CUAL FUE PROGRAMADA PERO NO REALIZADA POR NO CONTAR CON ACOMPAÑANTE NO PUDO SER TRASLADADO AL PROCEDIMIENTO. ACTUALMENTE CONTINUA A ESPERAS DE REPROGRAMACION. PACIENTE QUE CONTINUA MANEJO MEDICO PREVIAMENTE ESTABLECIDO Y SE SOLICITAN PARA CLINICOS DE CONTROL. ATENTOS A EVOLUCION CLINICA SE EXPLICA CONDUCTA A PACIENTE QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR.

Fecha: 02/03/2022: 13:19:49, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO VEGA SALAZAR, Especialidad: ANESTESIOLOGIA

Problema:

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

PACIENTE DE 40 AÑOS DE EDAD:

1. DISNEA SEC: 1.1. TUBERCULOSIS PULMONAR ACTIVA 1.1.1. TUBERCULOSIS MEDISTINICA 1.1.1.1. HIPERTENSION PULMONAR SEVERA 1.1.1.1.1 ESTENOSIS DE LA VENA PULMONAR IZQUIERDA SUPERIOR 1.2. NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD CURB 65 2 PUNTOS RESUELTA 2. ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIA PSICOATIVAS 3. ANTECEDENTES DE TBC HACE 4 AÑOS NO ADHERENTE AL TRATAMIENTO 4. ANTECEDENTES DE HEMOPTISIS MASIVA (2021) 5. ANTECEDENTES DE ESTENOSIS ESOFAGICA(UNION ESOFAGO PROXIMA Y MEDIO DE 2CM) CON REQUERIMIENTO DE DILATACIÓN 6. ANTECEDENTE DE TBC HACE 4 AÑOS NO ADHERENTE AL TRATAMIENTO

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE SENTIRSE BIEN, NIEGA DISNEA, NO DOLOR TORACICO, NIEGA OTROS SINTOMAS

Objetivo:

PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, ALERTA, ORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA, CABEZA Y CUELLO: PUPILAS ISOCORICAS NORMOREACTIVAS A LA LUZ, MUCOSA ORAL HUMEDA, CUELLO MOVIL, SIMETRICO, NO ADENOPATIAS, SIN RIGIDEZ DE NUCA TORAX: RUIDOS CARDIACOS RITMICOS SIN SOPLOS, NO S3, RUIDOS RESPIRATORIOS PRESENTES PERO DISMINUIDOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO DERECHO, NO CREPITOS, SIBILANCIAS OCASIONALES. ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMIDADES: SIMETRICAS HIPOTROFICAS SIN EDEMA LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS, PULSOS PERIFERICOS PRESENTES SIMETRICOS DE BUENA INTENSIDAD SNC: SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE. GLASGOW 15/15

Análisis:

PACIENTE MASCULINO DE 40 AÑOS DE EDAD CON ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS, ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR. DURANTE RONDA MEDICA PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES PROTEICOCALÓRICAS, CLINICA Y HEMODINAMICAMENTE ESTABLE, CIFRAS TENSIONALES NORMALES, TAQUICARDICO, TAQUIPNEICO, SATURACIÓN EN METAS, EN OXIGENOTERAPIA CON VENTURY AL 50% NO TOLERANDO DESTETE. EN RONDA MEDICA SE HABLA EN CONJUNTO CON MEDICINA INTERNA CON HEMODINAMIA QUE ACUERDAN QUE SE DEBE CONOCER EXACTAMENTE LA ANATOMIA CARDIACA ANTES DE REALIZAR CUALQUIER PROCEDIMIENTO, EL DÍA DE HOY CONTINUA PENDIENTE REALIZACION DE TOMOGRAFIA COMPUTADA DE CORONARIAS CODIGO CUPS 879902 TOMOGRAFIA COMPUTADA RECONSTRUCCION VIRTUAL CODIGO CUPS 879911 3D PARA PROCEDER SEGUN RESULTADOS, LA CUAL FUE PROGRAMADA PERO NO REALIZADA POR NO CONTAR CON ACOMPAÑANTE NO PUDO SER TRASLADADO AL PROCEDIMIENTO. ACTUALMENTE CONTINUA A ESPERAS DE REPROGRAMACION. PACIENTE QUE CONTINUA MANEJO MEDICO PREVIAMENTE ESTABLECIDO Y SE SOLICITAN PARA CLINICOS DE CONTROL. ATENTOS A EVOLUCION CLINICA SE EXPLICA CONDUCTA A PACIENTE QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR.

Fecha: 03/03/2022: 12:22:49, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

PACIENTE DE 40 AÑOS DE EDAD: 1. DISNEA SEC: 1.1. TUBERCULOSIS PULMONAR ACTIVA 1.1.1. TUBERCULOSIS MEDISTINICA 1.1.1.1. HIPERTENSION PULMONAR SEVERA 1.1.1.1.1 ESTENOSIS DE LA VENA PULMONAR IZQUIERDA SUPERIOR 1.2. NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD CURB 65 2 PUNTOS RESUELTA 2. ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIA PSICOATIVAS 3. ANTECEDENTES DE TBC HACE 4 AÑOS NO ADHERENTE AL TRATAMIENTO 4. ANTECEDENTES DE HEMOPTISIS MASIVA (2021) 5. ANTECEDENTES DE ESTENOSIS ESOFAGICA(UNION ESOFAGO PROXIMA Y MEDIO DE 2CM) CON REQUERIMIENTO DE DILATACIÓN 6. ANTECEDENTE DE TBC HACE 4 AÑOS NO ADHERENTE AL TRATAMIENTO

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE HABER PASADO BUENA NOCHE

Objetivo:

PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, ALERTA, ORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA, CABEZA Y CUELLO: PUPILAS ISOCORICAS NORMOREACTIVAS A LA LUZ, MUCOSA ORAL HUMEDA, CUELLO MOVIL, SIMETRICO, NO ADENOPATIAS, SIN RIGIDEZ DE NUCA TORAX: RUIDOS CARDIACOS RITMICOS SIN SOPLOS, NO S3, RUIDOS RESPIRATORIOS PRESENTES PERO DISMINUIDOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO DERECHO, NO CREPITOS, SIBILANCIAS OCASIONALES. ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMIDADES: SIMETRICAS HIPOTROFICAS SIN EDEMA LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS, PULSOS PERIFERICOS PRESENTES SIMETRICOS DE BUENA INTENSIDAD SNC: SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE. GLASGOW 15/15

Análisis:

PACIENTE MASCULINO DE 40 AÑOS DE EDAD CON ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS, ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR. DURANTE RONDA MEDICA PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES PROTEICOCALÓRICAS, CLINICA Y HEMODINAMICAMENTE ESTABLE, CIFRAS TENSIONALES NORMALES, TAQUICARDICO, TAQUIPNEICO, SATURACIÓN EN METAS, EN OXIGENOTERAPIA CON VENTURY AL 50% NO TOLERANDO DESTETE. EN RONDA MEDICA SE HABLA EN CONJUNTO CON MEDICINA INTERNA CON HEMODINAMIA QUE ACUERDAN QUE SE DEBE CONOCER EXACTAMENTE LA ANATOMIA CARDIACA ANTES DE REALIZAR CUALQUIER PROCEDIMIENTO, EL DÍA DE HOY CONTINUA PENDIENTE REALIZACION DE TOMOGRAFIA COMPUTADA DE CORONARIAS CODIGO CUPS 879902 TOMOGRAFIA COMPUTADA RECONSTRUCCION VIRTUAL CODIGO CUPS 879911 3D PARA PROCEDER SEGUN RESULTADOS, LA CUAL FUE PROGRAMADA PERO NO REALIZADA POR NO CONTAR CON ACOMPAÑANTE NO PUDO SER TRASLADADO AL PROCEDIMIENTO. ACTUALMENTE CONTINUA A ESPERAS DE REPROGRAMACION. PACIENTE QUE CONTINUA MANEJO MEDICO PREVIAMENTE ESTABLECIDO Y SE SOLICITAN PARA CLINICOS DE CONTROL. ATENTOS A EVOLUCION CLINICA SE EXPLICA CONDUCTA A PACIENTE QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR.

Fecha: 04/03/2022: 12:00:23, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

1. DISNEA SEC:

1.1. TUBERCULOSIS PULMONAR ACTIVA

1.1.1. TUBERCULOSIS MEDIASTINICA

1.1.1.1. HIPERTENSION PULMONAR SEVERA

1.1.1.1.1 ESTENOSIS DE LA VENA PULMONAR IZQUIERDA SUPERIOR

1.2. NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD CURB 65 2 PUNTOS RESUELTA 2. ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIA PSICOATIVAS

3. ANTECEDENTES DE TBC HACE 4 AÑOS NO ADHERENTE AL TRATAMIENTO

4. ANTECEDENTES DE HEMOPTISIS MASIVA (2021)

5. ANTECEDENTES DE ESTENOSIS ESOFAGICA(UNION ESOFAGO PROXIMA Y MEDIO DE 2CM) CON REQUERIMIENTO DE DILATACIÓN

6. ANTECEDENTE DE TBC HACE 4 AÑOS NO ADHERENTE AL TRATAMIENTO

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE HABER PASADO BUENA NOCHE

Objetivo:

PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, ALERTA, ORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA, CABEZA Y CUELLO: PUPILAS ISOCORICAS NORMOREACTIVAS A LA LUZ, MUCOSA ORAL HUMEDA, CUELLO MOVIL, SIMETRICO, NO ADENOPATIAS, SIN RIGIDEZ DE NUCA TORAX: RUIDOS CARDIACOS RITMICOS SIN SOPLOS, NO S3, RUIDOS RESPIRATORIOS PRESENTES PERO DISMINUIDOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO DERECHO, NO CREPITOS, SIBILANCIAS OCASIONALES. ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMIDADES: SIMETRICAS HIPOTROFICAS SIN EDEMA LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS, PULSOS PERIFERICOS PRESENTES SIMETRICOS DE BUENA INTENSIDAD SNC: SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE. GLASGOW

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

15/15.

ÚLTIMOS LABORATORIOS:

04/03/2022

FERRITINA 50.9, HIERRO SERICO 13, SAT DE TRANSFERRINA 4.7

02/03/2022

LEUCOS 10.15, NEUTROF 80.7, HB 10.7, HTO 38.4, HB 10.7, HTO 38.4, PLT 668

BUN 11, K 4.4, CREAT 0.58, NA 130, CL 93

Análisis:

PACIENTE MASCULINO DE 40 AÑOS DE EDAD CON ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS, ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR. DURANTE RONDA MEDICA PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES PROTEICOCALÓRICAS, CLINICA Y HEMODINAMICAMENTE ESTABLE, CIFRAS TENSIONALES NORMALES, TAQUICARDICO, TAQUIPNEICO, SATURACIÓN EN METAS, EN OXIGENOTERAPIA CON VENTURY AL 50% NO TOLERANDO DESTETE. EN RONDA MEDICA SE HABLA EN CONJUNTO CON MEDICINA INTERNA CON HEMODINAMIA QUE ACUERDAN QUE SE DEBE CONOCER EXACTAMENTE LA ANATOMIA CARDIACA ANTES DE REALIZAR CUALQUIER PROCEDIMIENTO, EL DÍA DE HOY CONTINUA PENDIENTE REALIZACION DE TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE CORONARIAS CODIGO CUPS 879902 TOMOGRAFIA COMPUTADA RECONSTRUCCION VIRTUAL CODIGO CUPS 879911 3D PARA PROCEDER SEGUN RESULTADOS, LA CUAL FUE PROGRAMADA PERO NO REALIZADA POR NO CONTAR CON ACOMPAÑANTE NO PUDO SER TRASLADADO AL PROCEDIMIENTO. ACTUALMENTE CONTINUA A ESPERAS DE REPROGRAMACIÓN. PENDIENTE GeneXpert MTB/RIF, CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS. PACIENTE QUE CONTINUA MANEJO MÉDICO PREVIAMENTE ESTABLECIDO Y SE SOLICITAN PARACLINICOS DE CONTROL. ATENTOS A EVOLUCIÓN CLINICA SE EXPLICA CONDUCTA A PACIENTE QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR.

Fecha: 05/03/2022: 13:00:33, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: JORGE YEPES CARO, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

1. DISNEA SEC: 1.1. TUBERCULOSIS PULMONAR ACTIVA 1.1.1. TUBERCULOSIS MEDIASTÍNICA 1.1.1.1. HIPERTENSION PULMONAR SEVERA 1.1.1.1.1 ESTENOSIS DE LA VENA PULMONAR IZQUIERDA SUPERIOR 1.2. NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD CURB 65 2 PUNTOS RESUELTA 2. ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIA PSICOACTIVAS 3. ANTECEDENTES DE TBC HACE 4 AÑOS NO ADHERENTE AL TRATAMIENTO 4. ANTECEDENTES DE HEMOPTISIS MASIVA (2021) 5. ANTECEDENTES DE ESTENOSIS ESOFAGICA(UNION ESOFAGO PROXIMA Y MEDIO DE 2CM) CON REQUERIMIENTO DE DILATACIÓN 6. ANTECEDENTE DE TBC HACE 4 AÑOS NO ADHERENTE AL TRATAMIENTO

Subjetivo:

REFIERE ESTAR PERDIENDO PESO PROGRESIVAMENTE

Objetivo:

PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, ALERTA, ORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA, CABEZA Y CUELLO: PUPILAS ISOCORICAS NORMOREACTIVAS A LA LUZ, MUCOSA ORAL HUMEDA, CUELLO MOVIL, SIMETRICO, NO ADENOPATIAS, SIN RIGIDEZ DE NUCA TORAX: RUIDOS CARDIACOS RITMICOS SIN SOPLOS, NO S3, RUIDOS RESPIRATORIOS PRESENTES PERO DISMINUIDOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO DERECHO, NO CREPITOS, SIBILANCIAS OCASIONALES. ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMIDADES: SIMETRICAS HIPOTROFICAS SIN EDEMA LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS, PULSOS PERIFERICOS PRESENTES SIMETRICOS DE BUENA INTENSIDAD SNC: SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE. GLASGOW 15/15.

Análisis:

PACIENTE MASCULINO DE 40 AÑOS DE EDAD CON ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS, ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR. DURANTE RONDA MEDICA PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES PROTEICOCALÓRICAS, CLINICA Y HEMODINAMICAMENTE ESTABLE, CIFRAS TENSIONALES NORMALES, TAQUICARDICO, TAQUIPNEICO, SATURACIÓN EN METAS, EN OXIGENOTERAPIA CON VENTURY AL 50% NO TOLERANDO DESTETE. EN RONDA MEDICA SE HABLA EN CONJUNTO CON MEDICINA INTERNA CON HEMODINAMIA QUE ACUERDAN QUE SE DEBE CONOCER EXACTAMENTE LA ANATOMIA CARDIACA ANTES DE REALIZAR CUALQUIER PROCEDIMIENTO, EL DÍA DE HOY CONTINUA PENDIENTE REALIZACION DE TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE CORONARIAS CODIGO CUPS 879902 TOMOGRAFIA COMPUTADA RECONSTRUCCION VIRTUAL CODIGO CUPS 879911 3D PARA PROCEDER SEGUN RESULTADOS. SE ESTA A LA ESPERA DE REALIZACION DE PROCEDIMIENTO DESDE 03/03/22 ACTUALMENTE CONTINUA A ESPERAS DE REPROGRAMACIÓN. PENDIENTE GeneXpert MTB/RIF, CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS. PACIENTE QUE CONTINUA MANEJO MÉDICO PREVIAMENTE ESTABLECIDO Y SE SOLICITAN PARACLINICOS DE CONTROL. ATENTOS A EVOLUCIÓN CLINICA SE EXPLICA CONDUCTA A PACIENTE QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR.

Fecha: 06/03/2022: 11:51:33, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: JORGE YEPES CARO, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

1. DISNEA SEC: 1.1. TUBERCULOSIS PULMONAR ACTIVA 1.1.1. TUBERCULOSIS MEDIASTÍNICA 1.1.1.1. HIPERTENSION PULMONAR SEVERA 1.1.1.1.1 ESTENOSIS DE LA VENA PULMONAR IZQUIERDA SUPERIOR 1.2. NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD CURB 65 2 PUNTOS RESUELTA 2. ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIA PSICOACTIVAS 3. ANTECEDENTES DE TBC HACE 4 AÑOS NO ADHERENTE AL TRATAMIENTO 4. ANTECEDENTES DE HEMOPTISIS MASIVA (2021) 5. ANTECEDENTES DE ESTENOSIS ESOFAGICA(UNION ESOFAGO PROXIMA Y MEDIO DE 2CM) CON REQUERIMIENTO DE DILATACIÓN 6. ANTECEDENTE DE TBC HACE 4 AÑOS NO ADHERENTE AL TRATAMIENTO

Subjetivo:

REFIERE ESTAR PERDIENDO PESO PROGRESIVAMENTE

Objetivo:

PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, ALERTA, ORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA, CABEZA Y CUELLO: PUPILAS ISOCORICAS NORMOREACTIVAS A LA LUZ, MUCOSA ORAL HUMEDA, CUELLO MOVIL, SIMETRICO, NO ADENOPATIAS, SIN RIGIDEZ DE NUCA TORAX: RUIDOS CARDIACOS RITMICOS SIN SOPLOS, NO S3, RUIDOS RESPIRATORIOS PRESENTES PERO DISMINUIDOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO DERECHO, NO CREPITOS, SIBILANCIAS OCASIONALES. ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMIDADES: SIMETRICAS HIPOTROFICAS SIN EDEMA LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS, PULSOS PERIFERICOS PRESENTES SIMETRICOS DE BUENA INTENSIDAD SNC: SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE. GLASGOW 15/15.

Análisis:

PACIENTE MASCULINO DE 40 AÑOS DE EDAD CON ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS, ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR. DURANTE RONDA MEDICA PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES PROTEICOCALÓRICAS, CLINICA Y HEMODINAMICAMENTE ESTABLE, CIFRAS TENSIONALES NORMALES, TAQUICARDICO, TAQUIPNEICO, SATURACIÓN EN METAS, EN OXIGENOTERAPIA CON VENTURY AL 50% NO TOLERANDO DESTETE. EN RONDA MEDICA SE HABLA EN CONJUNTO CON MEDICINA INTERNA CON HEMODINAMIA QUE ACUERDAN QUE SE DEBE CONOCER EXACTAMENTE LA ANATOMIA CARDIACA ANTES DE REALIZAR CUALQUIER PROCEDIMIENTO, EL DÍA DE HOY CONTINUA PENDIENTE REALIZACION DE TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE CORONARIAS CODIGO CUPS 879902 TOMOGRAFIA COMPUTADA RECONSTRUCCION VIRTUAL CODIGO CUPS 879911 3D PARA PROCEDER SEGUN RESULTADOS. SE ESTA A LA ESPERA DE REALIZACION DE PROCEDIMIENTO DESDE 03/03/22 ACTUALMENTE CONTINUA A ESPERAS DE REPROGRAMACIÓN. PENDIENTE GeneXpert MTB/RIF, CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS. PACIENTE QUE CONTINUA MANEJO MÉDICO PREVIAMENTE ESTABLECIDO Y SE SOLICITAN PARACLINICOS DE CONTROL. ATENTOS A EVOLUCIÓN CLINICA SE EXPLICA CONDUCTA A PACIENTE QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR.

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

Fecha: 07/03/2022: 12:01:04, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

1. DISNEA SEC: 1.1. TUBERCULOSIS PULMONAR ACTIVA 1.1.1. TUBERCULOSIS MEDIASTÍNICA 1.1.1.1. HIPERTENSION PULMONAR SEVERA 1.1.1.1.1. ESTENOSIS DE LA VENA PULMONAR IZQUIERDA SUPERIOR 1.2. NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD CURB 65 2 PUNTOS RESUELTA 2. ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIA PSICOATIVAS 3. ANTECEDENTES DE TBC HACE 4 AÑOS NO ADHERENTE AL TRATAMIENTO 4. ANTECEDENTES DE HEMOPTISIS MASIVA (2021) 5. ANTECEDENTES DE ESTENOSIS ESOFAGICA(UNION ESOFAGO PROXIMA Y MEDIO DE 2CM) CON REQUERIMIENTO DE DILATACIÓN 6. ANTECEDENTE DE TBC HACE 4 AÑOS NO ADHERENTE AL TRATAMIENTO

Subjetivo:

REFIERE ESTAR PERDIENDO PESO PROGRESIVAMENTE

Objetivo:

PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, ALERTA, ORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA, CABEZA Y CUELLO: PUPILAS ISOCORICAS NORMOREACTIVAS A LA LUZ, MUCOSA ORAL HUMEDA, CUELLO MOVL, SIMETRICO, NO ADENOPATIAS, SIN RIGIDEZ DE NUCA. TORAX: RUIDOS CARDIACOS RITMICOS SIN SOPLOS, NO S3, RUIDOS RESPIRATORIOS PRESENTES PERO DISMINUIDOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO DERECHO, NO CREPITOS, SIBILANCIAS OCASIONALES. ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMDADES: SIMETRICAS HIPOTROFICAS SIN EDEMA LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS, PULSOS PERIFERICOS PRESENTES SIMETRICOS DE BUENA INTENSIDAD SNC: SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE. GLASGOW 15/15.

Análisis:

PACIENTE MASCULINO DE 40 AÑOS DE EDAD CON ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS, ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR. DURANTE RONDA MEDICA PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES PROTEICOCALÓRICAS, CLINICA Y HEMODINAMICAMENTE ESTABLE, CIFRAS TENSIONALES NORMALES, TAQUICARDICO, TAQUIPNEICO, SATURACIÓN EN METAS, EN OXIGENOTERAPIA CON VENTURY AL 50% NO TOLERANDO DESTETE. EN RONDA MEDICA SE HABLA EN CONJUNTO CON MEDICINA INTERNA CON HEMODINAMIA QUE ACUERDAN QUE SE DEBE CONOCER EXACTAMENTE LA ANATOMIA CARDIACA ANTES DE REALIZAR CUALQUIER PROCEDIMIENTO, EL DÍA DE HOY CONTINUA PENDIENTE REALIZACION DE TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE CORONARIAS CODIGO CUPS 879902 TOMOGRAFIA COMPUTADA RECONSTRUCCION VIRTUAL CODIGO CUPS 879911 3D PARA PROCEDER SEGUN RESULTADOS. SE ESTA A LA ESPERA DE REALIZACION DE PROCEDIMIENTO DESDE 03/03/22 ACTUALMENTE CONTINUAA ESPERAS DE REPROGRAMACIÓN. PENDIENTE GeneXpert MTB/RIF, CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS. PACIENTE QUE CONTINUA MANEJO MÉDICO TERAPIA RIPE PREVIAMENTE ESTABLECIDO. ATENTOS A EVOLUCIÓN CLINICA SE EXPLICA CONDUCTA A PACIENTE QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR.

Fecha: 08/03/2022: 09:54:27, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

1. DISNEA SEC: 1.1. TUBERCULOSIS PULMONAR ACTIVA 1.1.1. TUBERCULOSIS MEDIASTÍNICA 1.1.1.1. HIPERTENSION PULMONAR SEVERA 1.1.1.1.1. ESTENOSIS DE LA VENA PULMONAR IZQUIERDA SUPERIOR 1.2. NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD CURB 65 2 PUNTOS RESUELTA 2. ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIA PSICOATIVAS 3. ANTECEDENTES DE TBC HACE 4 AÑOS NO ADHERENTE AL TRATAMIENTO 4. ANTECEDENTES DE HEMOPTISIS MASIVA (2021) 5. ANTECEDENTES DE ESTENOSIS ESOFAGICA(UNION ESOFAGO PROXIMA Y MEDIO DE 2CM) CON REQUERIMIENTO DE DILATACIÓN 6. ANTECEDENTE DE TBC HACE 4 AÑOS NO ADHERENTE AL TRATAMIENTO

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE PASAR BUENA NOCHE, SIN NINGUNA SINTOMATOLOGIA NUEVA

Objetivo:

PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, ALERTA, ORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA, CABEZA Y CUELLO: PUPILAS ISOCORICAS NORMOREACTIVAS A LA LUZ, MUCOSA ORAL HUMEDA, CUELLO MOVL, SIMETRICO, NO ADENOPATIAS, SIN RIGIDEZ DE NUCA. TORAX: RUIDOS CARDIACOS RITMICOS SIN SOPLOS, NO S3, RUIDOS RESPIRATORIOS PRESENTES PERO DISMINUIDOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO DERECHO, NO CREPITOS, SIBILANCIAS OCASIONALES. ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMDADES: SIMETRICAS HIPOTROFICAS SIN EDEMA LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS, PULSOS PERIFERICOS PRESENTES SIMETRICOS DE BUENA INTENSIDAD SNC: SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE. GLASGOW 15/15.

Análisis:

PACIENTE MASCULINO DE 40 AÑOS DE EDAD CON ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS, ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR. DURANTE RONDA MEDICA PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES PROTEICOCALÓRICAS, CLINICA Y HEMODINAMICAMENTE ESTABLE, CIFRAS TENSIONALES NORMALES, TAQUICARDICO, TAQUIPNEICO, SATURACIÓN EN METAS, EN OXIGENOTERAPIA CON VENTURY AL 50% NO TOLERANDO DESTETE. EN RONDA MEDICA SE HABLA EN CONJUNTO CON MEDICINA INTERNA CON HEMODINAMIA QUE ACUERDAN QUE SE DEBE CONOCER EXACTAMENTE LA ANATOMIA CARDIACA ANTES DE REALIZAR CUALQUIER PROCEDIMIENTO, EL DÍA DE HOY CONTINUA PENDIENTE REALIZACION DE TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE CORONARIAS CODIGO CUPS 879902 TOMOGRAFIA COMPUTADA RECONSTRUCCION VIRTUAL CODIGO CUPS 879911 3D PARA PROCEDER SEGUN RESULTADOS. SE ESTA A LA ESPERA DE REALIZACION DE PROCEDIMIENTO DESDE 03/03/22. ACTUALMENTE CONTINUAA ESPERAS DE REPROGRAMACIÓN. PENDIENTE GeneXpert MTB/RIF, CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS. PACIENTE QUE CONTINUA MANEJO MÉDICO TERAPIA RIPE PREVIAMENTE ESTABLECIDO. SE SOLICITA HLG, BUN, CREATININA, TP, TPT DE CONTROL. ATENTOS A EVOLUCIÓN CLINICA SE EXPLICA CONDUCTA A PACIENTE QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR.

Fecha: 09/03/2022: 10:58:04, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: ARIEL BELLO, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

1. DISNEA SEC: 1.1. TUBERCULOSIS PULMONAR ACTIVA 1.1.1. TUBERCULOSIS MEDIASTÍNICA 1.1.1.1. HIPERTENSION PULMONAR SEVERA 1.1.1.1.1. ESTENOSIS DE LA VENA PULMONAR IZQUIERDA SUPERIOR 1.2. NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD CURB 65 2 PUNTOS RESUELTA 2. ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIA PSICOATIVAS 3. ANTECEDENTES DE TBC HACE 4 AÑOS NO ADHERENTE AL TRATAMIENTO 4. ANTECEDENTES DE HEMOPTISIS MASIVA (2021) 5. ANTECEDENTES DE ESTENOSIS ESOFAGICA(UNION ESOFAGO PROXIMA Y MEDIO DE 2CM) CON REQUERIMIENTO DE DILATACIÓN 6. ANTECEDENTE DE TBC HACE 4 AÑOS NO ADHERENTE AL TRATAMIENTO

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE PASAR BUENA NOCHE, NIEGA FIEBRE, NIEGA DOLOR

Objetivo:

PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, ALERTA, ORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA, CABEZA Y CUELLO: PUPILAS ISOCORICAS NORMOREACTIVAS A LA LUZ, MUCOSA ORAL HUMEDA, CUELLO MOVL, SIMETRICO, NO ADENOPATIAS, SIN RIGIDEZ DE NUCA. TORAX: RUIDOS CARDIACOS RITMICOS SIN SOPLOS, NO S3, RUIDOS RESPIRATORIOS PRESENTES PERO DISMINUIDOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO DERECHO, NO CREPITOS, SIBILANCIAS OCASIONALES. ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMDADES: SIMETRICAS HIPOTROFICAS SIN EDEMA LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS, PULSOS PERIFERICOS PRESENTES SIMETRICOS DE BUENA INTENSIDAD SNC: SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE. GLASGOW 15/15.

ULTIMOS PARACLINICOS:

08/03/2022 HEMOGRAMA

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

LEU:9.77, NEU: 73.8, LINF: 7.4, MON: 10.1, EOS: 3.5, HB: 9.3, VCM: 75.3, HCM: 21.0, CCMH: 27.9, IDE:16.6, HTO: 33.2, PLAQ:594, VPM: 9.8
BUN: 17, CREAT: 0.67, TP: 12.2, TTP: 31.0

Análisis:

PACIENTE MASCULINO DE 40 AÑOS DE EDAD CON ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS, ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR. DURANTE RONDA MEDICA PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES PROTEICOCALÓRICAS, CLINICA Y HEMODINAMICAMENTE ESTABLE, CIFRAS TENSIONALES NORMALES, TAQUICARDICO, TAQUIPNEICO, SATURACIÓN EN METAS, EN OXIGENOTERAPIA CON VENTURY AL 50% NO TOLERANDO DESTETE. EN RONDA MEDICA SE HABLA EN CONJUNTO CON MEDICINA INTERNA CON HEMODINAMIA QUE ACUERDAN QUE SE DEBE CONOCER EXACTAMENTE LA ANATOMIA CARDIACA ANTES DE REALIZAR CUALQUIER PROCEDIMIENTO. CONTINUA PENDIENTE REALIZACION DE TOMOGRAFIA COMPUTADA DE CORONARIAS CODIGO CUPS 879902 TOMOGRAFIA COMPUTADA RECONSTRUCCION VIRTUAL CODIGO CUPS 879911 3D PARA PROCEDER SEGUN RESULTADOS. SE ESTA A LA ESPERA DE REALIZACION DE PROCEDIMIENTO DESDE 03/03/22. ACTUALMENTE CONTINUA A ESPERAS DE REPROGRAMACIÓN. PENDIENTE GeneXpert MTB/RIF, CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS. PACIENTE QUE CONTINUA MANEJO MÉDICO TERAPIA RIPE PREVIAMENTE ESTABLECIDO. EN RESULTADOS DE PARACLINICOS SE EVIDENCIA MODERADA ANEMIA, AZOADOS SIN ALTERACIONES. ATENTOS A EVOLUCIÓN CLINICA SE EXPLICA CONDUCTA A PACIENTE QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR.

Fecha: 11/03/2022: 12:35:41, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

1.. DISNEA SEC: 1.1. TUBERCULOSIS PULMONAR ACTIVA 1.1.1. TUBERCULOSIS MEDIASTÍNICA 1.1.1.1. HIPERTENSION PULMONAR SEVERA 1.1.1.1.1. ESTENOSIS DE LA VENA PULMONAR IZQUIERDA SUPERIOR 1.2. NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD CURB 65 2 PUNTOS RESUELTA 2. ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIA PSICOATIVAS 3. ANTECEDENTES DE TBC HACE 4 AÑOS NO ADHERENTE AL TRATAMIENTO 4. ANTECEDENTES DE HEMOPTISIS MASIVA (2021) 5. ANTECEDENTES DE ESTENOSIS ESOFAGICA(UNION ESOFAGO PROXIMA Y MEDIO DE 2CM) CON REQUERIMIENTO DE DILATACIÓN 6. ANTECEDENTE DE TBC HACE 4 AÑOS NO ADHERENTE AL TRATAMIENTO

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE DISNEA

Objetivo:

PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, ALERTA, ORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA, CABEZA Y CUELLO: PUPILAS ISOCORICAS NORMOREACTIVAS A LA LUZ, MUCOSA ORAL HUMEDA, CUELLO MOVIL, SIMETRICO, NO ADENOPATIAS, SIN RIGIDEZ DE NUCA. TORAX: RUIDOS CARDIACOS RITMICOS SIN SOPLOS, NO S3, RUIDOS RESPIRATORIOS PRESENTES PERO DISMINUIDOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO DERECHO, NO CREPITOS, SIBILANCIAS OCASIONALES. ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMIDADES: SIMETRICAS HIPOTROFICAS SIN EDEMA LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS, PULSOS PERIFERICOS PRESENTES SIMETRICOS DE BUENA INTENSIDAD SNC: SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE. GLASGOW 15/15. ULTIMOS PARACLINICOS: 11/03/22

ANGIOTAC CORONARIO

CONCLUSIONES:

1. ARTERIAS CORONARIAS CON ORIGENES Y TRAYECTOS HABITUALES. SIN ENFERMEDAD ATEROESCLEROTICA ZONA DE ESTENOSIS O DILATACIONES
2. VENAS PULMONARES CONECTADAS DE FORMA HABITUAL A LA AURICULA IZQUIERDA, SIN ZONAS DE ESTENOSIS, DILATACIONES O ANGULACIONES PATOLOGICAS EN SUS TRAYECTOS.

3. DILATACION DE TRONCO Y RAMAS PULMONARES

ESTUDIO LIMITADO PERO, PERO DIAGNOSTICO, POR INCAPACIDAD DEL PCTE DE HACER ADECUADA APNEA 08/03/2022 HEMOGRAMA LEU:9.77, NEU: 73.8, LINF: 7.4, MON: 10.1, EOS: 3.5, HB: 9.3, VCM: 75.3, HCM: 21.0, CCMH: 27.9, IDE:16.6, HTO: 33.2, PLAQ:594, VPM: 9.8 BUN: 17, CREAT: 0.67, TP: 12.2, TTP: 31.0

Análisis:

PACIENTE MASCULINO DE 40 AÑOS DE EDAD QUIEN SE ENCUENTRA EN OBSERVACION CON ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICOS ANOTADOS EN EL MOMENTO PACIENTE EN MALAS CONDICIONES GENERALES AFEBRIL HIDRATADO CON MAL PATRON RESPIRATORIO CON NECESIDAD DE OXIGENO SUPLEMENTARIO A ALTO FLUJO CIFRAS TENSIONALES CON TENDENCIA A LA HIPOTENSION TAQUICARDICO AL EXAMEN FISICO CON TIRAJES INTERCOSTALES CON RUIDOS RESPIRATORIOS DISMINUIDOS EN AMBOS CAMPOS PUKMINBARES DE PREDOMINIO DERECHO Y CON SIBILANTES OCASIONALES ADEMAS PACIENTE EN ESTADO DE ENACIACION CUENTA CON REPORTE DE ANGIOTAC CORONARIO QUE NO EVIDENCIA ESTENOSIS ATEROESCLEROSIS DILATACIONES O ANGULACIONES EN VENAS PULMONARES Y ARTERIAS CORONARIAS SIN EMBARGO CON DILATACION DEL TRONCO Y RAMAS PULMONARES SIN EMBARGO EL ESTUDIO ES LIMITADO POR INCAPACIDAD DE HACER APNEA ADECUADA, ANTE LO ANTEIOR SE CONTINUA MANEJO HOSPITALARIO CON OPTIMIZACION DE MANEJO MEDICA, SE SOLICITAN EXAMENES COMPLEMENTARIOS Y VALORACION POR NEUMOLOGIA, PACIENTE CON ALTO RIESGO DE MORBIMORTALIDAD A CORTO PLAZO, SE EXPLICA A PACIENTE Y FAMILIAR QUIENES ENTIENDEN Y ACEPTAN.

Fecha: 12/03/2022: 11:38:46, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: ORLANDO SANGUINO OMAÑA, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

1. DISNEA SECUNDARIO A:

1.1. TUBERCULOSIS PULMONAR ACTIVA

1.1.1. TUBERCULOSIS MEDISTINICA

1.1.1.1. HIPERTENSION PULMONAR SEVERA

1.1.1.1.1. ESTENOSIS DE LA VENA PULMONAR IZQUIERDA SUPERIOR

1.2. NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD CURB 65 2 PUNTOS RESUELTA 2. ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIA PSICOATIVAS

3. ANTECEDENTES DE TBC HACE 4 AÑOS NO ADHERENTE AL TRATAMIENTO

4. ANTECEDENTES DE HEMOPTISIS MASIVA (2021)

5. ANTECEDENTES DE ESTENOSIS ESOFAGICA(UNION ESOFAGO PROXIMA Y MEDIO DE 2CM) CON REQUERIMIENTO DE DILATACIÓN

6. DEFICIT ABSOLUTO DE HIERRO

Subjetivo:

REFIERE HABER PASADO MALA NOCHE, DISNEA, TAQUIPNEA

Objetivo:

PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, ALERTA, ORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA, CABEZA Y CUELLO: PUPILAS ISOCORICAS NORMOREACTIVAS A LA LUZ, MUCOSA ORAL HUMEDA, CUELLO MOVIL, SIMETRICO, NO ADENOPATIAS, SIN RIGIDEZ DE NUCA. TORAX: RUIDOS CARDIACOS RITMICOS SIN SOPLOS, NO S3, RUIDOS RESPIRATORIOS PRESENTES PERO DISMINUIDOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO DERECHO, NO CREPITOS, SIBILANCIAS OCASIONALES. ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMIDADES: SIMETRICAS HIPOTROFICAS SIN EDEMA LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS, PULSOS PERIFERICOS PRESENTES SIMETRICOS DE BUENA INTENSIDAD SNC: SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE. GLASGOW 15/15. ULTIMOS PARACLINICOS: 11/03/22 ANGIOTAC CORONARIO CONCLUSIONES: 1. ARTERIAS CORONARIAS CON ORIGENES Y TRAYECTOS HABITUALES. SIN ENFERMEDAD ATEROESCLEROTICA ZONA DE ESTENOSIS O DILATACIONES 2. VENAS PULMONARES CONECTADAS DE FORMA HABITUAL A LA AURICULA IZQUIERDA, SIN ZONAS DE ESTENOSIS, DILATACIONES O ANGULACIONES PATOLOGICAS EN SUS TRAYECTOS. 3. DILATACION DE TRONCO Y RAMAS PULMONARES ESTUDIO LIMITADO PERO, DIAGNOSTICADO. POR IMPOSIBILIDAD DEL PACIENTE DE HACER ADECUADA APNEA

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

Análisis:

PACIENTE MASCULINO DE 40 AÑOS DE EDAD QUIEN SE ENCUENTRA EN OBSERVACION CON ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICOS ANOTADOS EN EL MOMENTO PACIENTE EN MALAS CONDICIONES GENERALES AFEBRIL HIDRATADO CON MAL PATRON RESPIRATORIO CON NECESIDAD DE OXIGENO. PACIENTE CON NIVELES DE SAO₂ 82% DURANTE RONDA MEDICA POR LO CUAL SE ORDENA MASCARILLA CON RESERVORIO A ALTO FLUJO. CIFRAS TENSIONALES CON TENDENCIA A LA HIPOTENSION TAQUICARDICO AL EXAMEN FISICO CON TIRAJES INTERCOSTALES CON RUIDOS RESPIRATORIOS DISMINUIDOS EN AMBOS CAMPOS PULMONBARES DE PREDOMINIO DERECHO Y CON SIBILANTES OCASIONALES ADEMAS PACIENTE EN ESTADO DE EMACIACION CUENTA CON REPORTE DE ANGIOTAC CORONARIO QUE NO EVIDENCIA ESTENOSIS ATEROESCLEROSIS DILATACIONES O ANGULACIONES EN VENAS PULMONARES Y ARTERIAS CORONARIAS SIN EMBARGO CON DILATACION DEL TRONCO Y RAMAS PULMONARES SIN EMBARGO EL ESTUDIO ES LIMITADO POR INCAPACIDAD DE HACER APNEA ADECUADA, ANTE LO ANTEIROR SE CONTINUA MANEJO HOSPITALARIO CON OPTIMIZACION DE MANEJO MEDICO. PREDNISOLONA 40MG VO DIARIOS. SE SOLICITAN GASES ARTERIALES. PACIENTE CON ALTO RIESGO DE MORTALIDAD DEBIDO A PATOLOGIAS DE BASE. MAL PRONOSTICO. SE EXPLICA A PACIENTE CONTEXTO ACTUAL Y CONDUCTA A SEGUIR. ATENTOS A EVOLUCION CLINICA

Fecha: 13/03/2022: 10:16:49, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: ORLANDO SANGUINO OMAÑA, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

1. DISNEA SECUNDARIO A: 1.1. TUBERCULOSIS PULMONAR ACTIVA 1.1.1. TUBERCULOSIS MEDISTINICA 1.1.1.1. HIPERTENSION PULMONAR SEVERA 1.1.1.1.1 ESTENOSIS DE LA VENA PULMONAR IZQUIERDA SUPERIOR 1.2. NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD CURB 65 2 PUNTOS RESUELTA 2. ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIA PSICOATIVAS 3. ANTECEDENTES DE TBC HACE 4 AÑOS NO ADHERENTE AL TRATAMIENTO 4. ANTECEDENTES DE HEMOPTISIS MASIVA (2021) 5. ANTECEDENTES DE ESTENOSIS ESOFAGICA(UNION ESOFAGO PROXIMA Y MEDIO DE 2CM) CON REQUERIMIENTO DE DILATACIÓN 6. DEFICIT ABSOLUTO DE HIERRO

Subjetivo:

REFIERE HABER PASADO MALA NOCHE CON PROBELMAS PARA RESPIRAR

Objetivo:

PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, ALERTA, ORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA, CABEZA Y CUELLO: PUPILAS ISOCORICAS NORMOREACTIVAS A LA LUZ, MUCOSA ORAL HUMEDA, CUELLO MOVIL, SIMETRICO, NO ADENOPATIAS, SIN RIGIDEZ DE NUCA TORAX: RUIDOS CARDIACOS RITMICOS SIN SOPLOS, NO S3, RUIDOS RESPIRATORIOS PRESENTES PERO DISMINUIDOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO DERECHO, NO CREPITOS, SIBILANCIAS OCASIONALES. ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMDADES: SIMETRICAS HIPOTROFICAS SIN EDEMA LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS, PULSOS PERIFERICOS PRESENTES SIMETRICOS DE BUENA INTENSIDAD SNC: SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE. GLASGOW 15/15.

ULTIMOS PARACLINICOS: 12/03/2022: IONOGRAMA: CL 100 K 4.2 AST 117 ALT 172 NA 136 BUN 15 CR 0.72 BILI TOTAL 0.20 DIRECTA 0.1 HEMOGRAMA: LEU 9.340 NEU 7.570 MONO 770 LINFO 650 EOSI 180 BASO 80 HB 9.6 HTO 29.0 VCM 75.9 HCM 25.1 CCMH 33.0 PLT 475.000 VPM 9.8 PDW 34.1

Análisis:

PACIENTE MASCULINO DE 40 AÑOS DE EDAD QUIEN SE ENCUENTRA EN OBSERVACION CON ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICOS ANOTADOS EN EL MOMENTO PACIENTE EN MALAS CONDICIONES GENERALES AFEBRIL HIDRATADO CON MAL PATRON RESPIRATORIO CON NECESIDAD DE OXIGENO. PACIENTE CON NIVELES DE SAO₂ 82% DURANTE RONDA MEDICA POR LO CUAL SE ORDENA MASCARILLA CON RESERVORIO A ALTO FLUJO. CIFRAS TENSIONALES CON TENDENCIA A LA HIPOTENSION TAQUICARDICO AL EXAMEN FISICO CON TIRAJES INTERCOSTALES CON RUIDOS RESPIRATORIOS DISMINUIDOS EN AMBOS CAMPOS PULMONBARES DE PREDOMINIO DERECHO Y CON SIBILANTES OCASIONALES ADEMAS PACIENTE EN ESTADO DE EMACIACION CUENTA CON REPORTE DE ANGIOTAC CORONARIO QUE NO EVIDENCIA ESTENOSIS ATEROESCLEROSIS DILATACIONES O ANGULACIONES EN VENAS PULMONARES Y ARTERIAS CORONARIAS SIN EMBARGO CON DILATACION DEL TRONCO Y RAMAS PULMONARES SIN EMBARGO EL ESTUDIO ES LIMITADO POR INCAPACIDAD DE HACER APNEA ADECUADA, ANTE LO ANTEIROR SE CONTINUA MANEJO HOSPITALARIO CON OPTIMIZACION DE MANEJO MEDICO. PENDIENTE SE SOLICITAN GASES ARTERIALES. EN PPARACLINICOS SE EVIDENCIA IONOGRAMA EN LIMITES DE NORMALIDAD, FUNCION RENAL CONSERVADA, ANEMIA MODERADA, BILIRRUBINAS SIN LATARACIONES, TRANSAMINASAS ELEVADAS. PACIENTE CON ALTO RIESGO DE MORTALIDAD DEBIDO A PATOLOGIAS DE BASE. MAL PRONOSTICO. SE EXPLICA A PACIENTE CONTEXTO ACTUAL Y CONDUCTA A SEGUIR. ATENTOS A EVOLUCION CLINICA

Fecha: 14/03/2022: 12:45:24, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

PACIENTE DE 40 AÑOS DE EDAD, CON LOS SIGUIENTES DIAGNOSTICOS:

1. DISNEA SECUNDARIO A: 1.1. TUBERCULOSIS PULMONAR ACTIVA 1.1.1. TUBERCULOSIS MEDISTINICA 1.1.1.1. HIPERTENSION PULMONAR SEVERA 1.1.1.1.1 ESTENOSIS DE LA VENA PULMONAR IZQUIERDA SUPERIOR 1.2. NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD CURB 65 2 PUNTOS RESUELTA 2. ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIA PSICOATIVAS 3. ANTECEDENTES DE TBC HACE 4 AÑOS NO ADHERENTE AL TRATAMIENTO 4. ANTECEDENTES DE HEMOPTISIS MASIVA (2021) 5. ANTECEDENTES DE ESTENOSIS ESOFAGICA(UNION ESOFAGO PROXIMA Y MEDIO DE 2CM) CON REQUERIMIENTO DE DILATACIÓN 6. DEFICIT ABSOLUTO DE HIERRO

Subjetivo:

PACIENTE RELATA SENTIRSE BIEN, MEJORIA SIGNIFICATIVA DE LA DISNEA

Objetivo:

SIGNOS VITALES: PA: 110/60 MMHG, FC: 87 LPM, FR: 17 RPM, SATO₂: 95

PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, ALERTA, ORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA, CABEZA Y CUELLO: PUPILAS ISOCORICAS NORMOREACTIVAS A LA LUZ, MUCOSA ORAL HUMEDA, CUELLO MOVIL, SIMETRICO, NO ADENOPATIAS, SIN RIGIDEZ DE NUCA TORAX: RUIDOS CARDIACOS RITMICOS SIN SOPLOS, NO S3, RUIDOS RESPIRATORIOS PRESENTES PERO DISMINUIDOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO DERECHO, NO CREPITOS, SIBILANCIAS OCASIONALES. ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMDADES: SIMETRICAS HIPOTROFICAS SIN EDEMA LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS, PULSOS PERIFERICOS PRESENTES SIMETRICOS DE BUENA INTENSIDAD SNC: SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE. GLASGOW 15/15.

Análisis:

PACIENTE MASCULINO DE 40 AÑOS DE EDAD CON ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOATIVAS Y TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS, ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR. DURANTE RONDA MEDICA PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES PROTEICOCALÓRICAS, CLINICA Y HEMODINAMICAMENTE ESTABLE, CIFRAS TENSIONALES NORMALES, TAQUICARDICO, TAQUIPNEICO, SATURACIÓN EN METAS, EN OXIGENOTERAPIA CON VENTURY AL 50% NO TOLERANDO DESTETE. ACTUALMENTE PACIENTE EN ACEPTABLES CONDICIONES GENERALES, ESTABLE HEMODINAMICAMENTE, TIENE TAC CARDIACO SIN COMPROMISO DE VENAS PULMONARES, TIENE PENDIENTE GeneXpert MTB/RIF, CULTIVO DE ESPUTO PARA MCOBACTERIUM TUBERCULOSIS. PACIENTE QUE CONTINUA MANEJO MÉDICO TERAPIA RIPE PREVIAMENTE ESTABLECIDO. EN RESULTADOS DE PARACLINICOS SE EVIDENCIA MODERADA ANEMIA, AZOADOS SIN ALTERACIONES. SE SOLICITO UNIDAD DE CUIDADO CRONICO. ATENTOS A EVOLUCIÓN CLINICA SE EXPLICA CONDUCTA A PACIENTE QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR.

Fecha: 15/03/2022: 12:06:18, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

1. DISNEA SECUNDARIO A: 1.1. TUBERCULOSIS PULMONAR ACTIVA 1.1.1. TUBERCULOSIS MEDISTINICA 1.1.1.1. HIPERTENSION PULMONAR SEVERA

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

1.1.1.1.1 ESTENOSIS DE LA VENA PULMONAR IZQUIERDA SUPERIOR 1.2. NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD CURB 65 2 PUNTOS RESUELTA 2. ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIA PSICOATIVAS 3. ANTECEDENTES DE TBC HACE 4 AÑOS NO ADHERENTE AL TRATAMIENTO 4. ANTECEDENTES DE HEMOPTISIS MASIVA (2021) 5. ANTECEDENTES DE ESTENOSIS ESOFAGICA(UNION ESOFAGO PROXIMA Y MEDIO DE 2CM) CON REQUERIMIENTO DE DILATACIÓN 6. DEFICIT ABSOLUTO DE HIERRO

Subjetivo:

REFIERE HABER PASADO BUENA NOCHE. APARENTE MEJORES CONDICIONES EN CUANTO A DISNEA Y TAQUIPNEA

Objetivo:

PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, ALERTA, ORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA, CABEZA Y CUELLO: PUPILAS ISOCORICAS NORMOREACTIVAS A LA LUZ, MUCOSA ORAL HUMEDA, CUELLO MOML, SIMETRICO, NO ADENOPATIAS, SIN RIGIDEZ DE NUCA. TORAX: RUIDOS CARDIACOS RITMICOS SIN SOPLOS, NO S3, RUIDOS RESPIRATORIOS PRESENTES PERO DISMINUIDOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO DERECHO, NO CREPITOS, SIBILANCIAS OCASIONALES. ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMIDADES: SIMETRICAS HIPOTROFICAS SIN EDEMA LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS, PULSOS PERIFERICOS PRESENTES SIMETRICOS DE BUENA INTENSIDAD SNC: SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE. GLASGOW 15/15.

Análisis:

PACIENTE MASCULINO DE 40 AÑOS DE EDAD CON ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOATIVAS Y TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS, ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR. DURANTE RONDA MEDICA PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES PROTEICOCALÓRICAS, CLINICA Y HEMODINAMICAMENTE ESTABLE, CIFRAS TENSIONALES NORMALES, TAQUICARDICO, TAQUIPNEICO, SATURACIÓN EN METAS, EN OXIGENOTERAPIA CON VENTURY AL 50% NO TOLERANDO DESTETE. ACTUALMENTE PACIENTE EN ACEPTABLES CONDICIONES GENERALES, ESTABLE HEMODINAMICAMENTE, TIENE TAC CARDIACO SIN COMPROMISO DE VENAS PULMONARES, TIENE PENDIENTE GeneXpert MTB/RIF, CULTIVO DE ESPUTO PARA MCOBACTERIUM TUBERCULOSIS. PACIENTE QUE CONTINUA MANEJO MÉDICO TERAPIA RIPE PREVIAMENTE ESTABLECIDO. EN RESULTADOS DE PARACLINICOS SE EVIDENCIA MODERADA ANEMIA, AZOADOS SIN ALTERACIONES. SE SOLICITO UNIDAD DE CUIDADO CRONICO. ATENTOS Y ACOMPAÑAMIENTO POR TRABAJO SOCIAL. SE EXPLICA SITUACION ACTUAL Y CONDUCTA A SEGUIR A PACIENTE QUIEN ENTIENDE. ATENTOS A EVOLUCION.

Fecha: 16/03/2022: 11:38:05, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

1. DISNEA SECUNDARIO A: 1.1. TUBERCULOSIS PULMONAR ACTIVA 1.1.1. TUBERCULOSIS MEDISTINICA 1.1.1.1. HIPERTENSION PULMONAR SEVERA 1.1.1.1.1 ESTENOSIS DE LA VENA PULMONAR IZQUIERDA SUPERIOR 1.2. NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD CURB 65 2 PUNTOS RESUELTA 2. ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIA PSICOATIVAS 3. ANTECEDENTES DE TBC HACE 4 AÑOS NO ADHERENTE AL TRATAMIENTO 4. ANTECEDENTES DE HEMOPTISIS MASIVA (2021) 5. ANTECEDENTES DE ESTENOSIS ESOFAGICA(UNION ESOFAGO PROXIMA Y MEDIO DE 2CM) CON REQUERIMIENTO DE DILATACIÓN 6. DEFICIT ABSOLUTO DE HIERRO

Subjetivo:

REFIERE HABER PASADO BUENA NOCHE. APARENTE MEJORES CONDICIONES EN CUANTO A DISNEA Y TAQUIPNEA

Objetivo:

PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, ALERTA, ORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA, CABEZA Y CUELLO: PUPILAS ISOCORICAS NORMOREACTIVAS A LA LUZ, MUCOSA ORAL HUMEDA, CUELLO MOML, SIMETRICO, NO ADENOPATIAS, SIN RIGIDEZ DE NUCA. TORAX: RUIDOS CARDIACOS RITMICOS SIN SOPLOS, NO S3, RUIDOS RESPIRATORIOS PRESENTES PERO DISMINUIDOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO DERECHO, NO CREPITOS, SIBILANCIAS OCASIONALES. ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMIDADES: SIMETRICAS HIPOTROFICAS SIN EDEMA LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS, PULSOS PERIFERICOS PRESENTES SIMETRICOS DE BUENA INTENSIDAD SNC: SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE. GLASGOW 15/15.

Análisis:

PACIENTE MASCULINO DE 40 AÑOS DE EDAD CON ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOATIVAS Y TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS, ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR. DURANTE RONDA MEDICA PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES PROTEICOCALÓRICAS, CLINICA Y HEMODINAMICAMENTE ESTABLE, CIFRAS TENSIONALES NORMALES, TAQUICARDICO, TAQUIPNEICO, SATURACIÓN EN METAS, EN OXIGENOTERAPIA CON VENTURY AL 50% NO TOLERANDO DESTETE. ACTUALMENTE PACIENTE EN ACEPTABLES CONDICIONES GENERALES, ESTABLE HEMODINAMICAMENTE, TIENE TAC CARDIACO SIN COMPROMISO DE VENAS PULMONARES, TIENE PENDIENTE GeneXpert MTB/RIF, CULTIVO DE ESPUTO PARA MCOBACTERIUM TUBERCULOSIS. PACIENTE QUE CONTINUA MANEJO MÉDICO TERAPIA RIPE PREVIAMENTE ESTABLECIDO. EL DIA DE HOY SE SOLICITA TERAPIA RESPIRATORIA, SE SOLICITO UNIDAD DE CUIDADO CRONICO. ATENTOS Y ACOMPAÑAMIENTO POR TRABAJO SOCIAL. SE EXPLICA SITUACION ACTUAL Y CONDUCTA A SEGUIR A PACIENTE QUIEN ENTIENDE. ATENTOS A EVOLUCION.

Fecha: 17/03/2022: 17:21:12, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

PACIENTE MASCULINO DE 40 AÑOS DE EDAD CON DIAGNÓSTICOS DE:

1. DISNEA SECUNDARIO A:

1.1. TUBERCULOSIS PULMONAR ACTIVA

1.1.1. TUBERCULOSIS MEDISTINICA

1.1.1.1. HIPERTENSION PULMONAR SEVERA

1.1.1.1.1 ESTENOSIS DE LA VENA PULMONAR IZQUIERDA SUPERIOR

1.2. NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD CURB 65 2 PUNTOS RESUELTA 2. ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIA PSICOATIVAS

3. ANTECEDENTES DE TBC HACE 4 AÑOS NO ADHERENTE AL TRATAMIENTO

4. ANTECEDENTES DE HEMOPTISIS MASIVA (2021)

5. ANTECEDENTES DE ESTENOSIS ESOFAGICA(UNION ESOFAGO PROXIMA Y MEDIO DE 2CM) CON REQUERIMIENTO DE DILATACIÓN

6. DEFICIT ABSOLUTO DE HIERRO

Subjetivo:

REFIERE HABER PASADO BUENA NOCHE. APARENTE MEJORES CONDICIONES EN CUANTO A DISNEA Y TAQUIPNEA

Objetivo:

SIGNOS VITALES: PA: 110/60 MMHG, FC: 80 LPM, FR: 17 RPM, SAT02: 95%

PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, ALERTA, ORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA, CABEZA Y CUELLO: PUPILAS ISOCORICAS NORMOREACTIVAS A LA LUZ, MUCOSA ORAL HUMEDA, CUELLO MOML, SIMETRICO, NO ADENOPATIAS, SIN RIGIDEZ DE NUCA. TORAX: RUIDOS CARDIACOS RITMICOS SIN SOPLOS, RUIDOS RESPIRATORIOS PRESENTES PERO DISMINUIDOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO DERECHO, NO CREPITOS, SIBILANCIAS OCASIONALES. ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMIDADES: SIMETRICAS HIPOTROFICAS SIN EDEMA LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS, PULSOS PERIFERICOS PRESENTES SIMETRICOS DE BUENA INTENSIDAD SNC: SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE. GLASGOW 15/15.

Análisis:

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

PACIENTE MASCULINO EN LA QUINTA DÉCADA DE LA VIDA CON ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS, ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR. AL MOMENTO, PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES PROTEICOCALÓRICAS, CLÍNICA Y HEMODINÁMICAMENTE ESTABLE, CIFRAS TENSIONALES NORMALES, TAQUICARDICO, TAQUIPNEICO, SATURACIÓN EN METAS, EN OXIGENOTERAPIA CON VENTURY AL 50% NO TOLERANDO DESTETE. TIENE TAC CARDIACO SIN COMPROMISO DE VENAS PULMONARES. PENDIENTE GENEXPERT MTB/RIF, CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS. PACIENTE QUE CONTINÚA MANEJO MÉDICO TERAPIA RIPE PREVIAMENTE ESTABLECIDO. SE SOLICITÓ UNIDAD DE CUIDADO CRÓNICO CON OXIGENOTERAPIA AMBULATORIO POR LO QUE SE INSISTE EN ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DEL SERVICIO TRABAJO SOCIAL. SE EXPLICA SITUACIÓN ACTUAL Y CONDUCTA A SEGUIR A PACIENTE QUIEN ENTIENDE. ATENTOS A EVOLUCIÓN CLÍNICA

Fecha: 18/03/2022: 12:24:47, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGÍA

Problema:

P:

PACIENTE MASCULINO DE 40 AÑOS DE EDAD CON DIAGNÓSTICOS DE:

1. DISNEA SECUNDARIO A:

1.1. TUBERCULOSIS PULMONAR ACTIVA

1.1.1. TUBERCULOSIS MEDISTINICA

1.1.1.1. HIPERTENSION PULMONAR SEVERA

1.1.1.1.1. ESTENOSIS DE LA VENA PULMONAR IZQUIERDA SUPERIOR

1.2. NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD CURB 65 2 PUNTOS RESUELTA 2. ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIA PSICOACTIVAS

3. ANTECEDENTES DE TBC HACE 4 AÑOS NO ADHERENTE AL TRATAMIENTO

4. ANTECEDENTES DE HEMOPTISIS MASIVA (2021)

5. ANTECEDENTES DE ESTENOSIS ESOFAGICA (UNION ESOFAGO PROXIMA Y MEDIO DE 2CM) CON REQUERIMIENTO DE DILATACIÓN

6. DEFICIT ABSOLUTO DE HIERRO

Subjetivo:

S:

REFIERE HABER PASADO BUENA NOCHE. APARENTE MEJORES CONDICIONES EN CUANTO A DISNEA Y TAQUIPNEA

Objetivo:

O:

SIGNOS VITALES: PA: 100/60 MMHG, FC: 90 LPM, FR: 22 RPM, SATO2: 99%

PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, ALERTA, ORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA, CABEZA Y CUELLO: PUPILAS ISOCÓRICAS NORMOREACTIVAS A LA LUZ, MUCOSA ORAL HUMEDA, CUELLO MÓVIL, SIMÉTRICO, NO ADENOPATIAS, SIN RIGIDEZ DE NUCA. TORAX: RUIDOS CARDIACOS RÍTMICOS SIN SOPLOS, RUIDOS RESPIRATORIOS PRESENTES PERO DISMINUIDOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO DERECHO, NO CREPITOS, SIBILANCIAS OCASIONALES. ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMIDADES: SIMÉTRICAS HIPOTRÓFICAS SIN EDEMA LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS, PULSOS PERIFÉRICOS PRESENTES SIMÉTRICOS DE BUENA INTENSIDAD SNC: SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE. GLASGOW 15/15.

Análisis:

A:

PACIENTE MASCULINO EN LA QUINTA DÉCADA DE LA VIDA CON ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS, ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR. AL MOMENTO, PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES PROTEICOCALÓRICAS, CLÍNICA Y HEMODINÁMICAMENTE ESTABLE, CIFRAS TENSIONALES NORMALES, TAQUICARDICO, TAQUIPNEICO, SATURACIÓN EN METAS, EN OXIGENOTERAPIA CON VENTURY AL 50% NO TOLERANDO DESTETE. TIENE TAC CARDIACO SIN COMPROMISO DE VENAS PULMONARES. PENDIENTE GENEXPERT MTB/RIF, CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS. PACIENTE QUE CONTINÚA CON IGUAL MANEJO MÉDICO TERAPIA RIPE PREVIAMENTE ESTABLECIDO. SE SOLICITÓ UNIDAD DE CUIDADO CRÓNICO CON OXIGENOTERAPIA AMBULATORIO POR LO QUE SE INSISTE EN ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DEL SERVICIO TRABAJO SOCIAL. SE SOLICITA HEMOGRAMA, FUNCIÓN RENAL, IONOGRAMA, GLUCOSA CENTRAL Y GASES ARTERIALES DE CONTROL. SE EXPLICA SITUACIÓN ACTUAL Y CONDUCTA A SEGUIR A PACIENTE QUIEN ENTIENDE. ATENTOS A EVOLUCIÓN CLÍNICA

Fecha: 19/03/2022: 12:58:42, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: JAIME SARMIENTO CALDERON, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

P: PACIENTE MASCULINO DE 40 AÑOS DE EDAD CON DIAGNÓSTICOS DE: 1. DISNEA SECUNDARIO A: 1.1. TUBERCULOSIS PULMONAR ACTIVA 1.1.1. TUBERCULOSIS MEDISTINICA 1.1.1.1. HIPERTENSION PULMONAR SEVERA 1.1.1.1.1. ESTENOSIS DE LA VENA PULMONAR IZQUIERDA SUPERIOR 1.2. NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD CURB 65 2 PUNTOS RESUELTA 2. ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIA PSICOACTIVAS 3. ANTECEDENTES DE TBC HACE 4 AÑOS NO ADHERENTE AL TRATAMIENTO 4. ANTECEDENTES DE HEMOPTISIS MASIVA (2021) 5. ANTECEDENTES DE ESTENOSIS ESOFAGICA (UNION ESOFAGO PROXIMA Y MEDIO DE 2CM) CON REQUERIMIENTO DE DILATACIÓN 6. DEFICIT ABSOLUTO DE HIERRO.

Subjetivo:

S: REFIERE HABER PASADO BUENA NOCHE. REFIERE DOLOR LUMBAR LEVE.

Objetivo:

O: SIGNOS VITALES: PA: 100/60 MMHG, FC: 90 LPM, FR: 22 RPM, SATO2: 99% PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, ALERTA, ORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA, CABEZA Y CUELLO: PUPILAS ISOCÓRICAS NORMOREACTIVAS A LA LUZ, MUCOSA ORAL HUMEDA, CUELLO MÓVIL, SIMÉTRICO, NO ADENOPATIAS, SIN RIGIDEZ DE NUCA. TORAX: RUIDOS CARDIACOS RÍTMICOS SIN SOPLOS, RUIDOS RESPIRATORIOS PRESENTES PERO DISMINUIDOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO DERECHO, NO CREPITOS, SIBILANCIAS OCASIONALES. ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMIDADES: SIMÉTRICAS HIPOTRÓFICAS SIN EDEMA LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS, PULSOS PERIFÉRICOS PRESENTES SIMÉTRICOS DE BUENA INTENSIDAD SNC: SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE. GLASGOW 15/15. 18/03/22: LEU 12.19 NEU 83.6% LINF 6.1% HB 9.9 HTO 34.8 VCM 75 HCM 21.3 PLAQ 584 GLUC 139 NA 132 K 3.7 CL 94 BUN 23 CREAT 0.67 GASES ARTERIALES: PH 7.446 PCO2 43 PO2 189.6 HCO3 ACT 28.9 HCO3 STD 28.5 BE(B) 4.4 BE(ECF) 4.9 CTCO2 30.3 HCT 28 THB 9.5 SO2 99.3 FO2HB 98.7 FCOHB 0.1 FMETHB 0.5 FHHB 0.7 PO2/FIO2 3.79 PH(T) 7.452 PCO2(T) 42.3 PO2(T) PO2(A) 61 GLU 107 LACT 1.33 TEMP 36.6 FIO2 50 BILIRRUBINA <2.0 ANGAP 12.5

Análisis:

A: PACIENTE MASCULINO EN LA QUINTA DÉCADA DE LA VIDA CON ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS, ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR. AL MOMENTO, PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES PROTEICOCALÓRICAS, CLÍNICA Y HEMODINÁMICAMENTE ESTABLE, CIFRAS TENSIONALES NORMALES, TAQUICARDICO, TAQUIPNEICO, SATURACIÓN EN METAS, EN OXIGENOTERAPIA CON VENTURY AL 50% NO TOLERANDO DESTETE. TIENE TAC CARDIACO SIN COMPROMISO DE VENAS PULMONARES. PENDIENTE GENEXPERT MTB/RIF, CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS. PACIENTE QUE CONTINÚA CON IGUAL MANEJO MÉDICO TERAPIA RIPE PREVIAMENTE ESTABLECIDO, HOY CUMPLIENDO DÍA 30. PENDIENTE AUTORIZACIÓN DE TRASLADO A UNIDAD DE CUIDADO CRÓNICO CON OXIGENOTERAPIA AMBULATORIO POR LO QUE SE INSISTE EN ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DEL SERVICIO TRABAJO SOCIAL, EL DÍA DE HOY CON DOLOR LUMBAR POR LO CUAL SE FORMULA ANALGESICO. SE EXPLICA A PACIENTE QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR CONDUCTA MÉDICA

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

Fecha: 20/03/2022: 13:23:59, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: JAIME SARMIENTO CALDERON, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

P: PACIENTE MASCULINO DE 40 AÑOS DE EDAD CON DIAGNÓSTICOS DE: 1. DISNEA SECUNDARIO A: 1.1. TUBERCULOSIS PULMONAR ACTIVA 1.1.1. TUBERCULOSIS MEDISTINICA 1.1.1.1. HIPERTENSION PULMONAR SEVERA 1.1.1.1.1 ESTENOSIS DE LA VENA PULMONAR IZQUIERDA SUPERIOR 1.2. NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD CURB 65 2 PUNTOS RESUELTA 2. ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIA PSICOATIVAS 3. ANTECEDENTES DE TBC HACE 4 AÑOS NO ADHERENTE AL TRATAMIENTO 4. ANTECEDENTES DE HEMOPTISIS MASIVA (2021) 5. ANTECEDENTES DE ESTENOSIS ESOFAGICA(UNION ESOFAGO PROXIMA Y MEDIO DE 2CM) CON REQUERIMIENTO DE DILATACIÓN 6. DEFICIT ABSOLUTO DE HIERRO.

Subjetivo:

REFIERE HABER PASADO BUENA NOCHE. REFIERE DOLOR LUMBAR LEVE.

Objetivo:

O: SIGNOS VITALES: PA: 100/60 MMHG, FC: 90 LPM, FR: 22 RPM, SAT02: 99% PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, ALERTA, ORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA, CABEZA Y CUELLO: PUPILAS ISOCORICAS NORMOREACTIVAS A LA LUZ, MUCOSA ORAL HUMEDA, CUELLO MOML, SIMETRICO, NO ADENOPATIAS, SIN RIGIDEZ DE NUCA. TORAX: RUIDOS CARDIACOS RITMICOS SIN SOPLOS, RUIDOS RESPIRATORIOS PRESENTES PERO DISMINUIDOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO DERECHO, NO CREPITOS, SIBILANCIAS OCASIONALES. ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMIDADES: SIMETRICAS HIPOTROFICAS SIN EDEMA LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS, PULSOS PERIFERICOS PRESENTES SIMETRICOS DE BUENA INTENSIDAD SNC: SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE. GLASGOW 15/15.

Análisis:

A: PACIENTE MASCULINO EN LA QUINTA DÉCADA DE LA VIDA CON ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOATIVAS Y TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS, ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR. AL MOMENTO, PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES PROTEICOCALÓRICAS, CLINICA Y HEMODINAMICAMENTE ESTABLE, CIFRAS TENSIONALES NORMALES, TAQUICARDICO, TAQUIPNEICO, SATURACIÓN EN METAS, EN OXIGENOTERAPIA CON VENTURY AL 50% NO TOLERANDO DESTETE. TIENE TAC CARDIACO SIN COMPROMISO DE VENAS PULMONARES. PENDIENTE GENEXPERT MTB/RIF, CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS. PACIENTE QUE CONTINÚA CON IGUAL MANEJO MÉDICO TERAPIA RIPE PREVIAMENTE ESTABLECIDO, HOY CUMPLIENDO DIA 31. PENDIENTE AUTORIZACION DE TRASLADO A UNIDAD DE CUIDADO CRONICO CON OXIGENOTERAPIA AMBULATORIO POR LO QUE SE INSISTE EN ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DEL SERVICIO TRABAJO SOCIAL, SE EXPLICA A PACIENTE QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR CONDUCTA MÉDICA.

Fecha: 21/03/2022: 12:48:26, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: JAIME SARMIENTO CALDERON, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

P: PACIENTE MASCULINO DE 40 AÑOS DE EDAD CON DIAGNÓSTICOS DE: 1. DISNEA SECUNDARIO A: 1.1. TUBERCULOSIS PULMONAR ACTIVA 1.1.1. TUBERCULOSIS MEDISTINICA 1.1.1.1. HIPERTENSION PULMONAR SEVERA 1.1.1.1.1 ESTENOSIS DE LA VENA PULMONAR IZQUIERDA SUPERIOR 1.2. NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD CURB 65 2 PUNTOS RESUELTA 2. ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIA PSICOATIVAS 3. ANTECEDENTES DE TBC HACE 4 AÑOS NO ADHERENTE AL TRATAMIENTO 4. ANTECEDENTES DE HEMOPTISIS MASIVA (2021) 5. ANTECEDENTES DE ESTENOSIS ESOFAGICA(UNION ESOFAGO PROXIMA Y MEDIO DE 2CM) CON REQUERIMIENTO DE DILATACIÓN 6. DEFICIT ABSOLUTO DE HIERRO.

Subjetivo:

REFIERE HABER PASADO BUENA NOCHE. REFIERE DOLOR LUMBAR LEVE.

Objetivo:

O: SIGNOS VITALES: PA: 100/60 MMHG, FC: 90 LPM, FR: 22 RPM, SAT02: 99% PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, ALERTA, ORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA, CABEZA Y CUELLO: PUPILAS ISOCORICAS NORMOREACTIVAS A LA LUZ, MUCOSA ORAL HUMEDA, CUELLO MOML, SIMETRICO, NO ADENOPATIAS, SIN RIGIDEZ DE NUCA. TORAX: RUIDOS CARDIACOS RITMICOS SIN SOPLOS, RUIDOS RESPIRATORIOS PRESENTES PERO DISMINUIDOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO DERECHO, NO CREPITOS, SIBILANCIAS OCASIONALES. ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMIDADES: SIMETRICAS HIPOTROFICAS SIN EDEMA LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS, PULSOS PERIFERICOS PRESENTES SIMETRICOS DE BUENA INTENSIDAD SNC: SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE. GLASGOW 15/15.

Análisis:

A: PACIENTE MASCULINO EN LA QUINTA DÉCADA DE LA VIDA CON ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOATIVAS Y TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS, ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR. AL MOMENTO, PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES PROTEICOCALÓRICAS, CLINICA Y HEMODINAMICAMENTE ESTABLE, CIFRAS TENSIONALES NORMALES, TAQUICARDICO, TAQUIPNEICO, SATURACIÓN EN METAS, EN OXIGENOTERAPIA CON VENTURY AL 50% NO TOLERANDO DESTETE. PENDIENTE GENEXPERT MTB/RIF, CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS. PACIENTE QUE CONTINÚA CON IGUAL MANEJO MÉDICO TERAPIA RIPE PREVIAMENTE ESTABLECIDO, HOY CUMPLIENDO DIA 32. PENDIENTE AUTORIZACION DE TRASLADO A UNIDAD DE CUIDADO CRONICO CON OXIGENOTERAPIA AMBULATORIO POR LO QUE SE INSISTE EN ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DEL SERVICIO TRABAJO SOCIAL, SE EXPLICA A PACIENTE QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR CONDUCTA MÉDICA.

Fecha: 22/03/2022: 13:27:43, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

P: PACIENTE MASCULINO DE 40 AÑOS DE EDAD CON DIAGNÓSTICOS DE: 1. DISNEA SECUNDARIO A: 1.1. TUBERCULOSIS PULMONAR ACTIVA 1.1.1. TUBERCULOSIS MEDISTINICA 1.1.1.1. HIPERTENSION PULMONAR SEVERA 1.1.1.1.1 ESTENOSIS DE LA VENA PULMONAR IZQUIERDA SUPERIOR 1.2. NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD CURB 65 2 PUNTOS RESUELTA 2. ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIA PSICOATIVAS 3. ANTECEDENTES DE TBC HACE 4 AÑOS NO ADHERENTE AL TRATAMIENTO 4. ANTECEDENTES DE HEMOPTISIS MASIVA (2021) 5. ANTECEDENTES DE ESTENOSIS ESOFAGICA(UNION ESOFAGO PROXIMA Y MEDIO DE 2CM) CON REQUERIMIENTO DE DILATACIÓN 6. DEFICIT ABSOLUTO DE HIERRO.

Subjetivo:

REFIERE HABER PASADO BUENA NOCHE. REFIERE DOLOR LUMBAR LEVE.

Objetivo:

SIGNOS VITALES: PA: 90/60 MMHG, FC: 96 LPM, FR: 22 RPM, SAT02: 98% PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, ALERTA, ORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA, CABEZA Y CUELLO: PUPILAS ISOCORICAS NORMOREACTIVAS A LA LUZ, MUCOSA ORAL HUMEDA, CUELLO MOML, SIMETRICO, NO ADENOPATIAS, SIN RIGIDEZ DE NUCA. TORAX: RUIDOS CARDIACOS RITMICOS SIN SOPLOS, RUIDOS RESPIRATORIOS PRESENTES PERO DISMINUIDOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO DERECHO, NO CREPITOS, SIBILANCIAS OCASIONALES. ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMIDADES: SIMETRICAS HIPOTROFICAS SIN EDEMA LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS, PULSOS PERIFERICOS PRESENTES SIMETRICOS DE BUENA INTENSIDAD SNC: SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE. GLASGOW 15/15.

Análisis:

A: PACIENTE MASCULINO EN LA QUINTA DÉCADA DE LA VIDA CON ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOATIVAS Y TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS, ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR. AL MOMENTO, PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES PROTEICOCALÓRICAS, CLINICA Y HEMODINAMICAMENTE ESTABLE, CIFRAS TENSIONALES NORMALES, TAQUICARDICO, TAQUIPNEICO, SATURACIÓN EN METAS, EN OXIGENOTERAPIA CON VENTURY AL 50% NO TOLERANDO DESTETE. PENDIENTE GENEXPERT MTB/RIF, CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS. PACIENTE QUE CONTINÚA CON IGUAL MANEJO MÉDICO TERAPIA RIPE PREVIAMENTE ESTABLECIDO,

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

HOY CUMPLIENDO DIA 33, EL DIA DE HOY SE SOLICITAN HEMOGRAMA IONOGRAMA Y PERFIL HEPATICO CONTROL PARA EVALUAR EFECTOS SECUNDARIOS DE LESION HEPATICA ASOCIADA A TERAPIA RIPE, PENDIENTE AUTORIZACION DE TRASLADO A UNIDAD DE CUIDADO CRONICO CON OXIGENOTERAPIA AMBULATORIO POR LO QUE SE INSISTE EN ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DEL SERVICIO TRABAJO SOCIAL, SE EXPLICA A PACIENTE QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR CONDUCTA MÉDICA

Fecha: 23/03/2022: 11:50:10, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

P: PACIENTE MASCULINO DE 40 AÑOS DE EDAD CON DIAGNÓSTICOS DE: 1. DISNEA SECUNDARIO A: 1.1. TUBERCULOSIS PULMONAR ACTIVA 1.1.1. TUBERCULOSIS MEDISTINICA 1.1.1.1. HIPERTENSION PULMONAR SEVERA 1.1.1.1.1 ESTENOSIS DE LA VENA PULMONAR IZQUIERDA SUPERIOR 1.2. NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD CURB 65 2 PUNTOS RESUELTA 2. ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIA PSICOATIVAS 3. ANTECEDENTES DE TBC HACE 4 AÑOS NO ADHERENTE AL TRATAMIENTO 4. ANTECEDENTES DE HEMOPTISIS MASIVA (2021) 5. ANTECEDENTES DE ESTENOSIS ESOFAGICA(UNION ESOFAGO PROXIMA Y MEDIO DE 2CM) CON REQUERIMIENTO DE DILATACIÓN 6. DEFICIT ABSOLUTO DE HIERRO.

Subjetivo:

REFIERE HABER PASADO BUENA NOCHE. REFIERE DOLOR LUMBAR LEVE.

Objetivo:

SIGNOS VITALES: PA: 90/60 MMHG, FC: 96 LPM, FR: 22 RPM, SATO2: 98% PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, ALERTA, ORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA, CABEZA Y CUELLO: PUPILAS ISOCORICAS NORMOREACTIVAS A LA LUZ, MUCOSA ORAL HUMEDA, CUELLO MOVIL, SIMETRICO, NO ADENOPATIAS, SIN RIGIDEZ DE NUCA. TORAX: RUIDOS CARDIACOS RITMICOS SIN SOPLOS, RUIDOS RESPIRATORIOS PRESENTES PERO DISMINUIDOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO DERECHO, NO CREPITOS, SIBILANCIAS OCASIONALES. ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMIDADES: SIMETRICAS HIPOTROFICAS SIN EDEMA LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS, PULSOS PERIFERICOS PRESENTES SIMETRICOS DE BUENA INTENSIDAD SNC: SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE. GLASGOW 15/15.

Análisis:

A: PACIENTE MASCULINO EN LA QUINTA DÉCADA DE LA VIDA CON ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOATIVAS Y TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS, ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR. AL MOMENTO, PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES PROTEICOCALÓRICAS, CLINICA Y HEMODINAMICAMENTE ESTABLE, CIFRAS TENSIONALES NORMALES, TAQUICARDICO, TAQUIPNEICO, SATURACIÓN EN METAS, EN OXIGENOTERAPIA CON VENTURY AL 50% NO TOLERANDO DESTETE. PENDIENTE GENEXPERT MTB/RIF, CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS. PACIENTE QUE CONTINÚA CON IGUAL MANEJO MÉDICO TERAPIA RIPE PREVIAMENTE ESTABLECIDO, HOY CUMPLIENDO DIA 34, PENDIENTE A RESULTADOS DE PARACLINICOS DE CONTROL SOLICITADOS EL DIA 22/03/22, PENDIENTE AUTORIZACION DE TRASLADO A UNIDAD DE CUIDADO CRONICO CON OXIGENOTERAPIA AMBULATORIO POR LO QUE SE INSISTE EN ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DEL SERVICIO TRABAJO SOCIAL, SE EXPLICA A PACIENTE QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR CONDUCTA MÉDICA

Fecha: 24/03/2022: 15:29:35, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

P: PACIENTE MASCULINO DE 40 AÑOS DE EDAD CON DIAGNÓSTICOS DE: 1. DISNEA SECUNDARIO A: 1.1. TUBERCULOSIS PULMONAR ACTIVA 1.1.1. TUBERCULOSIS MEDISTINICA 1.1.1.1. HIPERTENSION PULMONAR SEVERA 1.1.1.1.1 ESTENOSIS DE LA VENA PULMONAR IZQUIERDA SUPERIOR 1.2. NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD CURB 65 2 PUNTOS RESUELTA 2. ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIA PSICOATIVAS 3. ANTECEDENTES DE TBC HACE 4 AÑOS NO ADHERENTE AL TRATAMIENTO 4. ANTECEDENTES DE HEMOPTISIS MASIVA (2021) 5. ANTECEDENTES DE ESTENOSIS ESOFAGICA(UNION ESOFAGO PROXIMA Y MEDIO DE 2CM) CON REQUERIMIENTO DE DILATACIÓN 6. DEFICIT ABSOLUTO DE HIERRO.

Subjetivo:

REFIERE HABER PASADO BUENA NOCHE. REFIERE DOLOR LUMBAR LEVE.

Objetivo:

SIGNOS VITALES: PA: 90/60 MMHG, FC: 96 LPM, FR: 22 RPM, SATO2: 98% PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, ALERTA, ORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA, CABEZA Y CUELLO: PUPILAS ISOCORICAS NORMOREACTIVAS A LA LUZ, MUCOSA ORAL HUMEDA, CUELLO MOVIL, SIMETRICO, NO ADENOPATIAS, SIN RIGIDEZ DE NUCA. TORAX: RUIDOS CARDIACOS RITMICOS SIN SOPLOS, RUIDOS RESPIRATORIOS PRESENTES PERO DISMINUIDOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO DERECHO, NO CREPITOS, SIBILANCIAS OCASIONALES. ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMIDADES: SIMETRICAS HIPOTROFICAS SIN EDEMA LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS, PULSOS PERIFERICOS PRESENTES SIMETRICOS DE BUENA INTENSIDAD SNC: SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE. GLASGOW 15/15.

PARACLINICOS

22/03/22: LEUC 3.81 NEU 46.6% LINF 32.8% HB 9.5 HTO 30.5 VCM 84.6 HCM 35.4 PLAQ 325 BUN 18 CREAT 0.72 CREAT AST 110 ALT 106 BD 0.1 BT 1.23 NA 135 K 3.8 CL 101

LDH 250 BT 1.19 BD 0.1 PCR 4.8

Análisis:

A: PACIENTE MASCULINO EN LA QUINTA DÉCADA DE LA VIDA CON ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOATIVAS Y TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS, ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR. AL MOMENTO, PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES PROTEICOCALÓRICAS, CLINICA Y HEMODINAMICAMENTE ESTABLE, CIFRAS TENSIONALES NORMALES, TAQUICARDICO, TAQUIPNEICO, SATURACIÓN EN METAS, EN OXIGENOTERAPIA CON VENTURY AL 50% NO TOLERANDO DESTETE. PENDIENTE GENEXPERT MTB/RIF, CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS. PACIENTE QUE CONTINÚA CON IGUAL MANEJO MÉDICO TERAPIA RIPE PREVIAMENTE ESTABLECIDO, HOY CUMPLIENDO DIA 35, SE RECIBEN PARACLINICOS SOLICITADOS EL DIA 22/03/22 LOS CUALES REPORTAN LEUCOPENIA Y ANEMIA MODERADA Y NIVELES ELEVADOS DE LDH, EL DIA DE HOY SE SOLICITA BACILOSCOPIA SERIADAX3, HEMOGRAMA CONTROL, IONOGRAMA CONTROL, Y PERFIL HEPATICO PARA EVALUAR LESION HEPATICA ASOCIADA A TERAPIA RIPE. PENDIENTE AUTORIZACION DE TRASLADO A UNIDAD DE CUIDADO CRONICO CON OXIGENOTERAPIA AMBULATORIO POR LO QUE SE INSISTE EN ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DEL SERVICIO TRABAJO SOCIAL, SE EXPLICA A PACIENTE QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR CONDUCTA MÉDICA

Fecha: 25/03/2022: 13:29:56, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

1. DISNEA SECUNDARIO A:

1.1. TUBERCULOSIS PULMONAR ACTIVA

1.1.1. TUBERCULOSIS MEDISTINICA

1.1.1.1. HIPERTENSION PULMONAR SEVERA

1.1.1.1.1 ESTENOSIS DE LA VENA PULMONAR IZQUIERDA SUPERIOR

1.2. NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD CURB 65 2 PUNTOS RESUELTA 2. ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIA PSICOATIVAS

3. ANTECEDENTES DE TBC HACE 4 AÑOS NO ADHERENTE AL TRATAMIENTO

4. ANTECEDENTES DE HEMOPTISIS MASIVA (2021)

5. ANTECEDENTES DE ESTENOSIS ESOFAGICA(UNION ESOFAGO PROXIMA Y MEDIO DE 2CM) CON REQUERIMIENTO DE DILATACIÓN

6. DEFICIT ABSOLUTO DE HIERRO

Subjetivo:

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

REFIERE HABER PASADO BUENA NOCHE. REFIERE DOLOR LUMBAR LEVE.

Objetivo:

SIGNOS VITALES: PA: 90/60 MMHG, FC: 96 LPM, FR: 22 RPM, SAT02: 98% PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, ALERTA, ORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA, CABEZA Y CUELLO: PUPILAS ISOCORICAS NORMOREACTIVAS A LA LUZ, MUCOSA ORAL HUMEDA, CUELLO MOVIL, SIMETRICO, NO ADENOPATIAS, SIN RIGIDEZ DE NUCA. TORAX: RUIDOS CARDIACOS RITMICOS SIN SOPLOS, RUIDOS RESPIRATORIOS PRESENTES PERO DISMINUIDOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO DERECHO, NO CREPITOS, SIBILANCIAS OCASIONALES. ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMIDADES: SIMETRICAS HIPOTROFICAS SIN EDEMA LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS, PULSOS PERIFERICOS PRESENTES SIMETRICOS DE BUENA INTENSIDAD SNC: SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE. GLASGOW 15/15.

PARACLINICOS

24/03/22:

- HEMOGRAMA: LEU 13.87 NEU 11.36 HB 10.4 HTO 36.6 VCM 74.9 HCM 21.2 CCMH 28.3 IDE 16.7 PLAQ 572

- BUN 21 CR 0.63 AST 66 ALT 153 NA 134 CL 94 K 4.0

Análisis:

A: PACIENTE MASCULINO EN LA QUINTA DÉCADA DE LA VIDA CON ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS, ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR. AL MOMENTO, PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES PROTEICOCALÓRICAS, CLÍNICA Y HEMODINÁMICAMENTE ESTABLE, CIFRAS TENSIONALES NORMALES, TAQUICARDICO, TAQUIPNEICO, SATURACIÓN EN METAS, EN OXIGENOTERAPIA CON VENTURY AL 50% NO TOLERANDO DESTETE. PENDIENTE GENEXPERT MTB/RIF, CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS. PACIENTE QUE CONTINÚA CON IGUAL MANEJO MÉDICO TERAPIA RIPE PREVIAMENTE ESTABLECIDO, HOY CUMPLIENDO DÍA 36, SE RECIBEN PARACLINICOS LOS CUALES ANEMIA COMPENSADA CON MANEJO MEDICO AZOADOS SIN ALTERACIONES, IONOGRAMA ACON PARAMETROS NORMALES, Y ENZIMAS HEPATICAS DENTRO DE NORMALIDAD PENDIENTE BACILOSCOPIA SERIADAX3, EL DÍA DE HOY SE SOLICITAN PERFIL HEPATICO HEMOGRAMA Y FUNCION RENAL DE CONTROL PARA MONITORIZAR EFECTOS DE TERPIA RIPE A NIVEL HEPATICO, PENDIENTE AUTORIZACION DE TRASLADO A UNIDAD DE CUIDADO CRONICO CON OXIGENOTERAPIA AMBULATORIO POR LO QUE SE INSISTE EN ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DEL SERVICIO TRABAJO SOCIAL, SE EXPLICA A PACIENTE QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR CONDUCTA MÉDICA.

Fecha: 26/03/2022: 11:07:50, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: ORLANDO SANGUINO OMAÑA, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

1. DISNEA SECUNDARIO A:

1.1. TUBERCULOSIS PULMONAR ACTIVA

1.1.1. TUBERCULOSIS MEDISTINICA

1.1.1.1. HIPERTENSION PULMONAR SEVERA

1.1.1.1.1 ESTENOSIS DE LA VENA PULMONAR IZQUIERDA SUPERIOR

1.2. NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD CURB 65 2 PUNTOS RESUELTA 2. ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIA PSICOACTIVAS

3. ANTECEDENTES DE TBC HACE 4 AÑOS NO ADHERENTE AL TRATAMIENTO

4. ANTECEDENTES DE HEMOPTISIS MASIVA (2021)

5. ANTECEDENTES DE ESTENOSIS ESOFAGICA (UNION ESOFAGO PROXIMA Y MEDIO DE 2CM) CON REQUERIMIENTO DE DILATACIÓN

6. DEFICIT ABSOLUTO DE HIERRO

Subjetivo:

REFIERE HABER PASADO BUENA NOCHE

Objetivo:

SIGNOS VITALES: PA: 100/70 MMHG, FC: 101 LPM, FR: 22 RPM, SAT02: 96% PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, ALERTA, ORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA, CABEZA Y CUELLO: PUPILAS ISOCORICAS NORMOREACTIVAS A LA LUZ, MUCOSA ORAL HUMEDA, CUELLO MOVIL, SIMETRICO, NO ADENOPATIAS, SIN RIGIDEZ DE NUCA. TORAX: RUIDOS CARDIACOS RITMICOS SIN SOPLOS, RUIDOS RESPIRATORIOS PRESENTES PERO DISMINUIDOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO DERECHO, NO CREPITOS, SIBILANCIAS OCASIONALES. ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMIDADES: SIMETRICAS HIPOTROFICAS SIN EDEMA LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS, PULSOS PERIFERICOS PRESENTES SIMETRICOS DE BUENA INTENSIDAD SNC: SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE. GLASGOW 15/15. PARACLINICOS 25/03/22: LEU 13.14 NEU 80 % LINF 7.5% HB 9.9 HTO 35.4 VCM 75.1 HCM 21.1 PLAQ 630 BUN 20 CREAT 0.6 AST 46 ALT 121

Análisis:

PACIENTE MASCULINO EN LA QUINTA DÉCADA DE LA VIDA CON ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS, ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR. AL MOMENTO, PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES PROTEICOCALÓRICAS, CLÍNICA Y HEMODINÁMICAMENTE ESTABLE, CIFRAS TENSIONALES NORMALES, TAQUICARDICO, TAQUIPNEICO, SATURACIÓN EN METAS, EN OXIGENOTERAPIA CON VENTURY AL 50% NO TOLERANDO DESTETE. SE RECIBEN PARACLINICOS LOS CUALES REPORTAN ANEMIA MODERADA AZOADOS SIN ALTERACIONES Y ENZIMAS HEPATICAS DENTRO DE LA NORMALIDAD. PENDIENTE GENEXPERT MTB/RIF, CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS. EL DÍA DE HOY SE SOLICITAN HEMOGRAMA, PCR Y FUNCION RENAL DE CONTROL. PACIENTE QUE CONTINÚA CON IGUAL MANEJO MÉDICO CON TERAPIA RIPE PREVIAMENTE ESTABLECIDA. PENDIENTE AUTORIZACION DE TRASLADO A UNIDAD DE CUIDADO CRONICO CON OXIGENOTERAPIA AMBULATORIO POR LO QUE SE INSISTE EN ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DEL SERVICIO TRABAJO SOCIAL, SE EXPLICA A PACIENTE QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR CONDUCTA MÉDICA.

Fecha: 27/03/2022: 09:53:26, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: ORLANDO SANGUINO OMAÑA, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

1. DISNEA SECUNDARIO A: 1.1. TUBERCULOSIS PULMONAR ACTIVA 1.1.1. TUBERCULOSIS MEDISTINICA 1.1.1.1. HIPERTENSION PULMONAR SEVERA

1.1.1.1.1 ESTENOSIS DE LA VENA PULMONAR IZQUIERDA SUPERIOR 1.2. NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD CURB 65 2 PUNTOS RESUELTA 2.

ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIA PSICOACTIVAS 3. ANTECEDENTES DE TBC HACE 4 AÑOS NO ADHERENTE AL TRATAMIENTO 4.

ANTECEDENTES DE HEMOPTISIS MASIVA (2021) 5. ANTECEDENTES DE ESTENOSIS ESOFAGICA (UNION ESOFAGO PROXIMA Y MEDIO DE 2CM) CON

REQUERIMIENTO DE DILATACIÓN 6. DEFICIT ABSOLUTO DE HIERRO

Subjetivo:

REFIERE HABER PASADO BUENA NOCHE

Objetivo:

SIGNOS VITALES: PA: 120/70 MMHG, FC: 100 LPM, FR: 20 RPM, SAT02: 98% PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, ALERTA, ORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA, CABEZA Y CUELLO: PUPILAS ISOCORICAS NORMOREACTIVAS A LA LUZ, MUCOSA ORAL HUMEDA, CUELLO MOVIL, SIMETRICO, NO ADENOPATIAS, SIN RIGIDEZ DE NUCA. TORAX: RUIDOS CARDIACOS RITMICOS SIN SOPLOS, RUIDOS RESPIRATORIOS PRESENTES PERO DISMINUIDOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO DERECHO, NO CREPITOS, SIBILANCIAS OCASIONALES. ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMIDADES: SIMETRICAS HIPOTROFICAS SIN EDEMA LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS, PULSOS PERIFERICOS PRESENTES SIMETRICOS DE BUENA INTENSIDAD SNC: SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE. GLASGOW 15/15.

Análisis:

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

PACIENTE MASCULINO EN LA QUINTA DÉCADA DE LA VIDA CON ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS, ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR. AL MOMENTO, PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES PROTEICOCALÓRICAS, CLÍNICA Y HEMODINÁMICAMENTE ESTABLE, CIFRAS TENSIONALES NORMALES, TAQUICARDICO, TAQUIPNEICO, SATURACIÓN EN METAS, EN OXIGENOTERAPIA CON VENTURY AL 50% NO TOLERANDO DESTETE. SE RECIBEN PARACLÍNICOS LOS CUALES REPORTAN ANEMIA MODERADA, AZOADOS SIN ALTERACIONES Y ENZIMAS HEPÁTICAS DENTRO DE LA NORMALIDAD. PENDIENTE GENEXPERT MTB/RIF, CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS. PACIENTE QUE CONTINÚA CON IGUAL MANEJO MÉDICO CON TERAPIA RIPE PREVIAMENTE ESTABLECIDA. PENDIENTE AUTORIZACIÓN DE TRASLADO A UNIDAD DE CUIDADO CRÓNICO CON OXIGENOTERAPIA AMBULATORIO POR LO QUE SE INSISTE EN ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DEL SERVICIO TRABAJO SOCIAL, SE EXPLICA A PACIENTE QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR CONDUCTA MÉDICA.

Fecha: 28/03/2022: 12:53:52, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

1. DISNEA SECUNDARIO A:

1.1. TUBERCULOSIS PULMONAR ACTIVA

1.1.1. TUBERCULOSIS MEDISTINICA

1.1.1.1. HIPERTENSION PULMONAR SEVERA

1.1.1.1.1. ESTENOSIS DE LA VENA PULMONAR IZQUIERDA SUPERIOR

1.2. NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD CURB 65 2 PUNTOS RESUELTA 2. ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIA PSICOACTIVAS

3. ANTECEDENTES DE TBC HACE 4 AÑOS NO ADHERENTE AL TRATAMIENTO

4. ANTECEDENTES DE HEMOPTISIS MASIVA (2021)

5. ANTECEDENTES DE ESTENOSIS ESOFAGICA (UNION ESOFAGO PROXIMA Y MEDIO DE 2CM) CON REQUERIMIENTO DE DILATACIÓN

6. DEFICIT ABSOLUTO DE HIERRO

Subjetivo:

REFIERE HABER PASADO BUENA NOCHE

Objetivo:

SIGNOS VITALES: PA: 120/70 MMHG, FC: 111 LPM, FR: 22 RPM, SAT02: 98% PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, ALERTA, ORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA, CABEZA Y CUELLO: PUPILAS ISOCÓRICAS NORMOREACTIVAS A LA LUZ, MUCOSA ORAL HUMEDA, CUELLO MÓML, SIMÉTRICO, NO ADENOPATIAS, SIN RIGIDEZ DE NUCA. TORAX: RUIDOS CARDIACOS RÍTMICOS SIN SOPLOS, RUIDOS RESPIRATORIOS PRESENTES PERO DISMINUIDOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO DERECHO, NO CREPITOS, SIBILANCIAS OCASIONALES. ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMIDADES: SIMÉTRICAS HIPOTRÓFICAS SIN EDEMA LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS, PULSOS PERIFÉRICOS PRESENTES SIMÉTRICOS DE BUENA INTENSIDAD SNC: SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE. GLASGOW 15/15. PARACLÍNICOS: 27/03/2022

HEMOGRAMA: HB 9.6, HTO 34.6, VCM 75.5, HCM 21.0, PLAQ 583, LEU 10.46, NEU 77.0, LINF 8.7, MON 8.4, EOSINÓFILO 3.6, BASÓFILOS 0.6

BUN 22, CREATININA 0.72, PCR 11.9

Análisis:

PACIENTE MASCULINO EN LA QUINTA DÉCADA DE LA VIDA CON ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS, ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR. AL MOMENTO, PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES PROTEICOCALÓRICAS, CLÍNICA Y HEMODINÁMICAMENTE ESTABLE, CIFRAS TENSIONALES NORMALES, TAQUICARDICO, TAQUIPNEICO, SATURACIÓN EN METAS, EN OXIGENOTERAPIA CON VENTURY AL 50% NO TOLERANDO DESTETE. SE RECIBEN PARACLÍNICOS DE CONTROL QUE REPORTAN ANEMIA MODERADA, AZOADOS SIN ALTERACIONES. PENDIENTE GENEXPERT MTB/RIF, CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS. PACIENTE QUE CONTINÚA CON IGUAL MANEJO MÉDICO CON TERAPIA RIPE. PACIENTE EN NOTABLE MEJORÍA CLÍNICA, EL CUAL SE ENCUENTRA A LA ESPERA DE AUTORIZACIÓN DE TRASLADO A UNIDAD DE CUIDADO CRÓNICO CON OXIGENOTERAPIA AMBULATORIO POR LO QUE SE INSISTE EN ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DEL SERVICIO TRABAJO SOCIAL, SE EXPLICA A PACIENTE QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR CONDUCTA MÉDICA.

Fecha: 29/03/2022: 11:14:22, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

1. DISNEA SECUNDARIO A: 1.1. TUBERCULOSIS PULMONAR ACTIVA 1.1.1. TUBERCULOSIS MEDISTINICA 1.1.1.1. HIPERTENSION PULMONAR SEVERA

1.1.1.1.1. ESTENOSIS DE LA VENA PULMONAR IZQUIERDA SUPERIOR 1.2. NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD CURB 65 2 PUNTOS RESUELTA 2.

ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIA PSICOACTIVAS 3. ANTECEDENTES DE TBC HACE 4 AÑOS NO ADHERENTE AL TRATAMIENTO 4.

ANTECEDENTES DE HEMOPTISIS MASIVA (2021) 5. ANTECEDENTES DE ESTENOSIS ESOFAGICA (UNION ESOFAGO PROXIMA Y MEDIO DE 2CM) CON

REQUERIMIENTO DE DILATACIÓN 6. DEFICIT ABSOLUTO DE HIERRO

Subjetivo:

REFIERE HABER PASADO BUENA NOCHE

Objetivo:

SIGNOS VITALES: PA: 95/70 MMHG, FC: 103 LPM, FR: 20 RPM, SAT02: 98% PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, ALERTA, ORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA, CABEZA Y CUELLO: PUPILAS ISOCÓRICAS NORMOREACTIVAS A LA LUZ, MUCOSA ORAL HUMEDA, CUELLO MÓML, SIMÉTRICO, NO ADENOPATIAS, SIN RIGIDEZ DE NUCA. TORAX: RUIDOS CARDIACOS RÍTMICOS SIN SOPLOS, RUIDOS RESPIRATORIOS PRESENTES PERO DISMINUIDOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO DERECHO, NO CREPITOS, SIBILANCIAS OCASIONALES. ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMIDADES: SIMÉTRICAS HIPOTRÓFICAS SIN EDEMA LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS, PULSOS PERIFÉRICOS PRESENTES SIMÉTRICOS DE BUENA INTENSIDAD SNC: SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE. GLASGOW 15/15.

Análisis:

PACIENTE MASCULINO EN LA QUINTA DÉCADA DE LA VIDA CON ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS, ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR. AL MOMENTO, PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES PROTEICOCALÓRICAS, CLÍNICA Y HEMODINÁMICAMENTE ESTABLE, CIFRAS TENSIONALES NORMALES, TAQUICARDICO, TAQUIPNEICO, SATURACIÓN EN METAS, EN OXIGENOTERAPIA CON VENTURY AL 50% NO TOLERANDO DESTETE. SE SOLICITAN HEMOGRAMA, IONOGRAMA, TRANSAMINASAS PARA EL DÍA DE MAÑANA. PENDIENTE GENEXPERT MTB/RIF, CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS. PACIENTE QUE CONTINÚA CON IGUAL MANEJO MÉDICO CON TERAPIA RIPE, EN NOTABLE MEJORÍA CLÍNICA, EL CUAL SE ENCUENTRA A LA ESPERA DE AUTORIZACIÓN DE TRASLADO A UNIDAD DE CUIDADO CRÓNICO CON OXIGENOTERAPIA AMBULATORIO POR LO QUE SE INSISTE EN ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DEL SERVICIO TRABAJO SOCIAL, SE EXPLICA A PACIENTE QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR CONDUCTA MÉDICA.

Fecha: 30/03/2022: 10:34:46, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

1. DISNEA SECUNDARIO A: 1.1. TUBERCULOSIS PULMONAR ACTIVA 1.1.1. TUBERCULOSIS MEDISTINICA 1.1.1.1. HIPERTENSION PULMONAR SEVERA

1.1.1.1.1. ESTENOSIS DE LA VENA PULMONAR IZQUIERDA SUPERIOR 1.2. NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD CURB 65 2 PUNTOS RESUELTA 2.

ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIA PSICOACTIVAS 3. ANTECEDENTES DE TBC HACE 4 AÑOS NO ADHERENTE AL TRATAMIENTO 4.

ANTECEDENTES DE HEMOPTISIS MASIVA (2021) 5. ANTECEDENTES DE ESTENOSIS ESOFAGICA (UNION ESOFAGO PROXIMA Y MEDIO DE 2CM) CON

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

REQUERIMIENTO DE DILATACIÓN 6. DEFICIT ABSOLUTO DE HIERRO

Subjetivo:

REFIERE HABER PASADO BUENA NOCHE

Objetivo:

SIGNOS VITALES: PA: 95/70 MMHG, FC: 103 LPM, FR: 20 RPM, SATO2: 98% PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, ALERTA, ORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA, CABEZA Y CUELLO: PUPILAS ISOCORICAS NORMOREACTIVAS A LA LUZ, MUCOSA ORAL HUMEDA, CUELLO MOVIL, SIMETRICO, NO ADENOPATIAS, SIN RIGIDEZ DE NUCA. TORAX: RUIDOS CARDIACOS RITMICOS SIN SOPLOS, RUIDOS RESPIRATORIOS PRESENTES PERO DISMINUIDOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO DERECHO, NO CREPITOS, SIBILANCIAS OCASIONALES. ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMIDADES: SIMETRICAS HIPOTROFICAS SIN EDEMA LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS, PULSOS PERIFERICOS PRESENTES SIMETRICOS DE BUENA INTENSIDAD SNC: SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE. GLASGOW 15/15.

PARACLINICOS

29/03/2022 AST: 50, ALT: 80, NA: 135, CL: 95, K: 4.1, BD: 0.4, BT: 0.79

Análisis:

PACIENTE MASCULINO EN LA QUINTA DÉCADA DE LA VIDA CON ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS, ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR. AL MOMENTO, PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES PROTEICOCALÓRICAS, CLÍNICA Y HEMODINAMICAMENTE ESTABLE, CIFRAS TENSIONALES NORMALES, TAQUICARDICO, TAQUIPNEICO, SATURACIÓN EN METAS, EN OXIGENOTERAPIA CON VENTURY AL 50% NO TOLERANDO DESTETE. SE SOLICITAN HEMOGRAMA, IONOGRAMA, TRANSAMINASAS PARA EL DÍA DE MAÑANA. PENDIENTE GENEXPERT MTB/RIF, CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS. EL DÍA DE HOY SE SOLICITA BACILOSCOPIASX3, PACIENTE QUE CONTINÚA CON IGUAL MANEJO MÉDICO CON TERAPIA RIPE, EN NOTABLE MEJORÍA CLÍNICA, EL CUAL SE ENCUENTRA A LA ESPERA DE AUTORIZACIÓN DE TRASLADO A UNIDAD DE CUIDADO CRÓNICO CON OXIGENOTERAPIA AMBULATORIO POR LO QUE SE INSISTE EN ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DEL SERVICIO TRABAJO SOCIAL, SE EXPLICA A PACIENTE QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR CONDUCTA MÉDICA.

Fecha: 31/03/2022: 16:49:42, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

1. DISNEA SECUNDARIO A: 1.1. TUBERCULOSIS PULMONAR ACTIVA 1.1.1. TUBERCULOSIS MEDISTINICA 1.1.1.1. HIPERTENSION PULMONAR SEVERA 1.1.1.1.1 ESTENOSIS DE LA VENA PULMONAR IZQUIERDA SUPERIOR 1.2. NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD CURB 65 2 PUNTOS RESUELTA 2. ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIA PSICOACTIVAS 3. ANTECEDENTES DE TBC HACE 4 AÑOS NO ADHERENTE AL TRATAMIENTO 4. ANTECEDENTES DE HEMOPTISIS MASIVA (2021) 5. ANTECEDENTES DE ESTENOSIS ESOFAGICA (UNION ESOFAGO PROXIMA Y MEDIO DE 2CM) CON REQUERIMIENTO DE DILATACIÓN 6. DEFICIT ABSOLUTO DE HIERRO

Subjetivo:

REFIERE MEJORIA

Objetivo:

SIGNOS VITALES: PA: 95/70 MMHG, FC: 103 LPM, FR: 20 RPM, SATO2: 98% PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, ALERTA, ORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA, CABEZA Y CUELLO: PUPILAS ISOCORICAS NORMOREACTIVAS A LA LUZ, MUCOSA ORAL HUMEDA, CUELLO MOVIL, SIMETRICO, NO ADENOPATIAS, SIN RIGIDEZ DE NUCA. TORAX: RUIDOS CARDIACOS RITMICOS SIN SOPLOS, RUIDOS RESPIRATORIOS PRESENTES PERO DISMINUIDOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO DERECHO, NO CREPITOS, SIBILANCIAS OCASIONALES. ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMIDADES: SIMETRICAS HIPOTROFICAS SIN EDEMA LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS, PULSOS PERIFERICOS PRESENTES SIMETRICOS DE BUENA INTENSIDAD SNC: SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE. GLASGOW 15/15.

Análisis:

PACIENTE MASCULINO EN LA QUINTA DÉCADA DE LA VIDA CON ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS, ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR. AL MOMENTO, PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES PROTEICOCALÓRICAS, CLÍNICA Y HEMODINAMICAMENTE ESTABLE, CIFRAS TENSIONALES NORMALES, TAQUICARDICO, TAQUIPNEICO, SATURACIÓN EN METAS, EN OXIGENOTERAPIA CON VENTURY AL 50% NO TOLERANDO DESTETE. SE SOLICITAN HEMOGRAMA, IONOGRAMA, TRANSAMINASAS PARA EL DÍA DE MAÑANA. PENDIENTE GENEXPERT MTB/RIF, CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS. EL DÍA DE HOY SE SOLICITA PARACLINICOS DE CONTROL, PACIENTE QUE CONTINÚA CON IGUAL MANEJO MÉDICO CON TERAPIA RIPE, EN NOTABLE MEJORÍA CLÍNICA, EL CUAL SE ENCUENTRA A LA ESPERA DE AUTORIZACIÓN DE TRASLADO A UNIDAD DE CUIDADO CRÓNICO CON OXIGENOTERAPIA AMBULATORIO POR LO QUE SE INSISTE EN ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DEL SERVICIO TRABAJO SOCIAL, SE EXPLICA A PACIENTE QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR CONDUCTA MÉDICA.

Fecha: 01/04/2022: 12:25:57, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

1. DISNEA SECUNDARIO A:
1.1. TUBERCULOSIS PULMONAR ACTIVA
1.1.1. TUBERCULOSIS MEDISTINICA
1.1.1.1. HIPERTENSION PULMONAR SEVERA
1.1.1.1.1 ESTENOSIS DE LA VENA PULMONAR IZQUIERDA SUPERIOR
1.2. NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD CURB 65 2 PUNTOS RESUELTA 2. ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIA PSICOACTIVAS
3. ANTECEDENTES DE TBC HACE 4 AÑOS NO ADHERENTE AL TRATAMIENTO
4. ANTECEDENTES DE HEMOPTISIS MASIVA (2021)
5. ANTECEDENTES DE ESTENOSIS ESOFAGICA (UNION ESOFAGO PROXIMA Y MEDIO DE 2CM) CON REQUERIMIENTO DE DILATACIÓN
6. DEFICIT ABSOLUTO DE HIERRO

Subjetivo:

REFIERE MEJORIA CLINICA, SIN SINTOMATOLOGIA

Objetivo:

SIGNOS VITALES: PA: 95/70 MMHG, FC: 103 LPM, FR: 20 RPM, SATO2: 98% PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, ALERTA, ORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA, CABEZA Y CUELLO: PUPILAS ISOCORICAS NORMOREACTIVAS A LA LUZ, MUCOSA ORAL HUMEDA, CUELLO MOVIL, SIMETRICO, NO ADENOPATIAS, SIN RIGIDEZ DE NUCA. TORAX: RUIDOS CARDIACOS RITMICOS SIN SOPLOS, RUIDOS RESPIRATORIOS PRESENTES PERO DISMINUIDOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO DERECHO, NO CREPITOS, SIBILANCIAS OCASIONALES. ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMIDADES: SIMETRICAS HIPOTROFICAS SIN EDEMA LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS, PULSOS PERIFERICOS PRESENTES SIMETRICOS DE BUENA INTENSIDAD SNC: SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE. GLASGOW 15/15.

Análisis:

PACIENTE MASCULINO DE 40 AÑOS DE EDAD CON ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS, ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR. AL MOMENTO, PACIENTE EN BUENAS CONDICIONES PROTEICOCALÓRICAS, CLÍNICA Y HEMODINAMICAMENTE ESTABLE, CIFRAS TENSIONALES NORMALES, CON CANULA NASAL A 3 LITROS X MIN SE

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

REPORTA HEMOGRAMA 31/03/22: LEU 10.12 NEU 7.62 HB 9.6 HTO 33.9 VCM 75.8 IDE 16.6 PLA 533, IONOGRAMA EN PARAMETROS NORMALES, PENDIENTE GENEXPERT MTB/RIF, CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS. EL DIA DE HOY SE SOLICITA PARA CLINICOS DE CONTROL, PACIENTE QUE CONTINUA CON IGUAL MANEJO MEDICO CON TERAPIA RIPE, EN NOTABLE MEJORIA CLINICA, EL CUAL SE ENCUENTRA A LA ESPERA DE AUTORIZACION DE TRASLADO A UNIDAD DE CUIDADO CRONICO CON OXIGENOTERAPIA AMBULATORIO POR LO QUE SE INSISTE EN ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DEL SERVICIO TRABAJO SOCIAL, SE EXPLICA A PACIENTE QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR CONDUCTA MEDICA

Fecha: 02/04/2022: 13:10:35, **Historia:** Evolución Clínica General, **Prestador:** JAIME SARMIENTO CALDERON, **Especialidad:** MEDICINA INTERNA

Problema:

1. DISNEA SECUNDARIO A: 1.1. TUBERCULOSIS PULMONAR ACTIVA 1.1.1. TUBERCULOSIS MEDIATINICA 1.1.1.1. HIPERTENSION PULMONAR SEVERA 1.1.1.1.1 ESTENOSIS DE LA VENA PULMONAR IZQUIERDA SUPERIOR 1.2. NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD CURB 65 2 PUNTOS RESUELTA 2. ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIA PSICOACTIVAS 3. ANTECEDENTES DE TBC HACE 4 AÑOS NO ADHERENTE AL TRATAMIENTO 4. ANTECEDENTES DE HEMOPTISIS MASIVA (2021) 5. ANTECEDENTES DE ESTENOSIS ESOFAGICA (UNION ESOFAGO PROXIMA Y MEDIO DE 2CM) CON REQUERIMIENTO DE DILATACION 6. DEFICIT ABSOLUTO DE HIERRO

Subjetivo:

REFIERE MEJORIA CLINICA, SIN SINTOMATOLOGIA

Objetivo:

PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, ALERTA, ORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA, CABEZA Y CUELLO: PUPILAS ISOCORICAS NORMOREACTIVAS A LA LUZ, MUCOSA ORAL HUMEDA, CUELLO MOVIL, SIMETRICO, NO ADENOPATIAS, SIN RIGIDEZ DE NUCA TORAX: RUIDOS CARDIACOS RITMICOS SIN SOPLOS, RUIDOS RESPIRATORIOS PRESENTES PERO DISMINUIDOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO DERECHO, NO CREPITOS, SIBILANCIAS OCASIONALES. ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACION, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACION PERITONEAL. EXTREMIDADES: SIMETRICAS HIPOTROFICAS SIN EDEMA LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS, PULSOS PERIFERICOS PRESENTES SIMETRICOS DE BUENA INTENSIDAD SNC: SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE. GLASGOW 15/15.

Análisis:

PACIENTE MASCULINO DE 40 AÑOS DE EDAD CON ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS, ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR. AL MOMENTO, PACIENTE EN BUENAS CONDICIONES PROTEICOCALÓRICAS, CLINICA Y HEMODINAMICAMENTE ESTABLE, CIFRAS TENSIONALES NORMALES, CON CANULA NASAL A 3 LITROS X MIN SE REPORTA HEMOGRAMA 31/03/22: LEU 10.12 NEU 7.62 HB 9.6 HTO 33.9 VCM 75.8 IDE 16.6 PLA 533, IONOGRAMA EN PARAMETROS NORMALES, PENDIENTE GENEXPERT MTB/RIF, CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS. EL DIA DE HOY SE SOLICITA PARA CLINICOS DE CONTROL, PACIENTE QUE CONTINUA CON IGUAL MANEJO MEDICO CON TERAPIA RIPE, EN NOTABLE MEJORIA CLINICA, EL CUAL SE ENCUENTRA A LA ESPERA DE AUTORIZACION DE TRASLADO A UNIDAD DE CUIDADO CRONICO CON OXIGENOTERAPIA AMBULATORIO POR LO QUE SE INSISTE EN ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DEL SERVICIO TRABAJO SOCIAL, SE EXPLICA A PACIENTE QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR CONDUCTA MEDICA

Fecha: 03/04/2022: 12:04:07, **Historia:** Evolución Clínica General, **Prestador:** JAIME SARMIENTO CALDERON, **Especialidad:** MEDICINA INTERNA

Problema:

PACIENTE MASCULINO DE 40 AÑOS DE EDAD CON DIAGNÓSTICOS DE:

1. DISNEA SECUNDARIO A:

1.1. TUBERCULOSIS PULMONAR ACTIVA

1.1.1. TUBERCULOSIS MADIATINICA

1.1.1.1. HIPERTENSION PULMONAR SEVERA

1.1.1.1.1 ESTENOSIS DE LA VENA PULMONAR IZQUIERDA SUPERIOR

1.2. NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD CURB 65 2 PUNTOS RESUELTA 2. ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIA PSICOACTIVAS

3. ANTECEDENTES DE TBC HACE 4 AÑOS NO ADHERENTE AL TRATAMIENTO

4. ANTECEDENTES DE HEMOPTISIS MASIVA (2021)

5. ANTECEDENTES DE ESTENOSIS ESOFAGICA (UNION ESOFAGO PROXIMA Y MEDIO DE 2CM) CON REQUERIMIENTO DE DILATACION

6. DEFICIT ABSOLUTO DE HIERRO

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE SENTIRSE BIEN, NIEGA FIEBRE, EMESIS, SANGRADO U OTRA SINTOMATOLOGIA ASOCIADA

Objetivo:

TA:120/80 FC:80 FR:18 SO2:99

PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, ALERTA, ORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA, CABEZA Y CUELLO: PUPILAS ISOCORICAS NORMOREACTIVAS A LA LUZ, MUCOSA ORAL HUMEDA, CUELLO MOVIL, SIMETRICO, NO ADENOPATIAS, SIN RIGIDEZ DE NUCA TORAX: RUIDOS CARDIACOS RITMICOS SIN SOPLOS, RUIDOS RESPIRATORIOS PRESENTES PERO DISMINUIDOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE PREDOMINIO DERECHO, NO CREPITOS, SIBILANCIAS OCASIONALES. ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACION, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACION PERITONEAL. EXTREMIDADES: SIMETRICAS HIPOTROFICAS SIN EDEMA LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS, PULSOS PERIFERICOS PRESENTES SIMETRICOS DE BUENA INTENSIDAD SNC: SIN DEFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE. GLASGOW 15/15.

Análisis:

PACIENTE MASCULINO DE 40 AÑOS DE EDAD CON ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS, ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR. AL MOMENTO, PACIENTE EN BUENAS CONDICIONES PROTEICO CALÓRICAS, CLINICA Y HEMODINAMICAMENTE ESTABLE, CIFRAS TENSIONALES NORMALES, CON CANULA NASAL A 3 LITROS X MIN SE REPORTA BACILOSCOPIA DEL 02.04.2022: POSITIVO PARA BAAR. HEMOGRAMA 31/03/22: LEU 10.12 NEU 7.62 HB 9.6 HTO 33.9 VCM 75.8 IDE 16.6 PLA 533, IONOGRAMA EN PARAMETROS NORMALES, PENDIENTE GENEXPERT MTB/RIF, CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS. EL DIA CONTINUA CON IGUAL MANEJO MEDICO CON TERAPIA RIPE, EN NOTABLE MEJORIA CLINICA, EL CUAL SE ENCUENTRA A LA ESPERA DE AUTORIZACION DE TRASLADO A UNIDAD DE CUIDADO CRONICO CON OXIGENOTERAPIA AMBULATORIO POR LO QUE SE INSISTE EN ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DEL SERVICIO TRABAJO SOCIAL, SE EXPLICA A PACIENTE QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR CONDUCTA MEDICA

Fecha: 05/04/2022: 12:30:18, **Historia:** Evolución Clínica General, **Prestador:** FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, **Especialidad:** INFECTOLOGIA

Problema:

PACIENTE MASCULINO DE 40 AÑOS DE EDAD CON DIAGNÓSTICOS DE:

1. DISNEA SECUNDARIO A:

1.1. TUBERCULOSIS PULMONAR ACTIVA

1.1.1. TUBERCULOSIS MADIATINICA

1.1.1.1. HIPERTENSION PULMONAR SEVERA

1.1.1.1.1 ESTENOSIS DE LA VENA PULMONAR IZQUIERDA SUPERIOR

1.2. NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD CURB 65 2 PUNTOS RESUELTA 2. ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIA PSICOACTIVAS

3. ANTECEDENTES DE TBC HACE 4 AÑOS NO ADHERENTE AL TRATAMIENTO

4. ANTECEDENTES DE HEMOPTISIS MASIVA (2021)

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

5. ANTECEDENTES DE ESTENOSIS ESOFAGICA(UNIÓN ESOFAGO PROXIMA Y MEDIO DE 2CM) CON REQUERIMIENTO DE DILATACIÓN
6. DÉFICIT ABSOLUTO DE HIERRO

Subjetivo:

SUBJETIVO: PACIENTE REFIERE SENTIRSE BIEN, NIEGA FIEBRE, EMESIS, SANGRADO U OTRA SINTOMATOLOGÍA ASOCIADA

Objetivo:

TA:120/80 FC:80 FR:18 SO2:99

PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, ALERTA, ORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA, CABEZA Y CUELLO: PUPILAS ISOCÓRICAS NORMORREACTIVAS A LA LUZ, MUCOSA ORAL HÚMEDA, CUELLO MÓVIL, SIMÉTRICO, NO ADENOPATÍAS, SIN RIGIDEZ DE NUCA TÓRAX: RUIDOS CARDIACOS RÍTMICOS SIN SOPLOS, RUIDOS RESPIRATORIOS PRESENTES PERO DISMINUIDOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES. DE PREDOMINIO DERECHO, NO CRÉPITOS, SIBILANCIAS OCASIONALES. ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMIIDADES: SIMÉTRICAS HIPOTROFICAS SIN EDEMA LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS, PULSOS PERIFÉRICOS PRESENTES SIMÉTRICOS DE BUENA INTENSIDAD SNC: SIN DÉFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE. GLASGOW 15/15.

Análisis:

PACIENTE MASCULINO DE 40 AÑOS DE EDAD CON ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS, ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR. AL MOMENTO, PACIENTE EN BUENAS CONDICIONES PROTEICO CALÓRICAS, CLÍNICA Y HEMODINÁMICAMENTE ESTABLE, CIFRAS TENSIONALES NORMALES, CON CÁNULA NASAL A 3 LITROS X MIN SE REPORTA BACILOSCOPIA DEL 02.04.2022: POSITIVO PARA BAAR. HEMOGRAMA 31/03/22: LEU 10.12 NEU 7.62 HB 9.6 HTO 33.9 VCM 75.8 IDE 16.6 PLA 533, IONOGRAMA EN PARÁMETROS NORMALES, PENDIENTE GENEXPERT MTB/RIF, CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS. EL DÍA CONTINÚA CON IGUAL MANEJO MÉDICO CON TERAPIA RIPE, EN NOTABLE MEJORÍA CLÍNICA, EL CUAL SE ENCUENTRA A LA ESPERA DE AUTORIZACIÓN DE TRASLADO A UNIDAD DE CUIDADO CRÓNICO CON OXIGENOTERAPIA AMBULATORIO POR LO QUE SE SOLICITA HOSTAL PARA CONTINUAR CON REHABILITACION PULMONAR, CON OXIGENINO POR CANULA NASAL A 3L/M PERMANENTE. SE EXPLICA A PACIENTE QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR CONDUCTA MÉDICA

Fecha: 06/04/2022: 10:19:27, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

DIAGNÓSTICOS

1. DISNEA SECUNDARIO A:

1.1. TUBERCULOSIS PULMONAR ACTIVA

1.1.1. TUBERCULOSIS MEDISTINICA

1.1.1.1. HIPERTENSION PULMONAR SEVERA

1.1.1.1.1. ESTENOSIS DE LA VENA PULMONAR IZQUIERDA SUPERIOR

1.2. NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD CURB 65 2 PUNTOS RESUELTA 2. ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIA PSICOATIVAS

3. ANTECEDENTES DE TBC HACE 4 AÑOS NO ADHERENTE AL TRATAMIENTO

4. ANTECEDENTES DE HEMOPTISIS MASIVA (2021)

5. ANTECEDENTES DE ESTENOSIS ESOFAGICA(UNION ESOFAGO PROXIMA Y MEDIO DE 2CM) CON REQUERIMIENTO DE DILATACIÓN

6. DEFICIT ABSOLUTO DE HIERRO

Subjetivo:

SUBJETIVO

Paciente refiere sentirse en aceptables condiciones generales, pasa la noche tranquilo

Objetivo:

OBJETIVO

Paciente en cama, en posición de sedestación, con soporte de oxígeno con cánula nasal

SIGNOS VITALES

FC 90 lpm PA: 100/80 mmHg SATO2 98%

EXAMEN FÍSICO POR REGIONES

CABEZA: Mucosas húmedas, hidratadas, con atrofia de temporales

CUELLO: No doloroso, no masas palpables

TÓRAX: Simétrico, ruidos cardiacos rítmicos y regulares, no se auscultan ruidos agregados.

ABDOMEN: Blando, depresible, no masas, no megalias

EXTREMIIDADES: Simétricas, ausente de edema

Análisis:

Paciente de 40 años con antecedente de consumo de sustancias psicoactivas, y VH C3, historia de TB pulmonar no adherente a tratamiento. Quien ingresa en contexto de tuberculosis pulmonar y mediastínica, actualmente en manejo con terapia RIPE, con adecuada tolerancia, en quien llama la atención persistencia de baciloscopias positivas, por lo cual ante sospecha de germen multidrogorresistente se solicita Genexpert por lavado bronquioalveolar. En el momento permanece estable, continuaremos atentos a evolución clínica del paciente.

Fecha: 06/04/2022: 10:31:22, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

DIAGNÓSTICOS

1. DISNEA SECUNDARIO A:

1.1. TUBERCULOSIS PULMONAR ACTIVA

1.1.1. TUBERCULOSIS MEDISTINICA

1.1.1.1. HIPERTENSION PULMONAR SEVERA

1.1.1.1.1. ESTENOSIS DE LA VENA PULMONAR IZQUIERDA SUPERIOR

1.2. NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD CURB 65 2 PUNTOS RESUELTA 2. ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIA PSICOATIVAS

3. ANTECEDENTES DE TBC HACE 4 AÑOS NO ADHERENTE AL TRATAMIENTO

4. ANTECEDENTES DE HEMOPTISIS MASIVA (2021)

5. ANTECEDENTES DE ESTENOSIS ESOFAGICA(UNION ESOFAGO PROXIMA Y MEDIO DE 2CM) CON REQUERIMIENTO DE DILATACIÓN

6. DEFICIT ABSOLUTO DE HIERRO

Subjetivo:

SUBJETIVO

Paciente refiere sentirse en aceptables condiciones generales, pasa la noche tranquilo

Objetivo:

OBJETIVO

Paciente en cama, en posición de sedestación, con soporte de oxígeno con cánula nasal

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

SIGNOS VITALES

FC 90 lpm PA: 100/80 mmHg SATO2 98%

EXAMEN FÍSICO POR REGIONES

CABEZA: Mucosas húmedas, hidratadas, con atrofia de temporales

CUELLO: No doloroso, no masas palpables

TÓRAX: Simétrico, ruidos cardíacos rítmicos y regulares, no se auscultan ruidos agregados.

ABDOMEN: Blando, depresible, no masas, no megalias

EXTREMIDADES: Simétricas, ausente de edema

Análisis:

Paciente de 40 años con antecedente de consumo de sustancias psicoactivas, y VIH C3, historia de TB pulmonar no adherente a tratamiento. Quien ingresa en contexto de tuberculosis pulmonar y mediastínica, actualmente en manejo con terapia RIPE, con adecuada tolerancia, por ser el día 63 de tratamiento nos encontramos a espera de autorización y programación de traslado a hospital para continuidad de tratamiento, y cumplimiento del mismo, sin embargo, revisando baciloscopias el paciente persiste con resultado positivo, esto implica inicio de estudios para germen multidrogorresistente, por lo tanto, en vista de contexto social y clínico del paciente no puede ser trasladado en el momento a hospital, puesto que para esto se necesita que el paciente no este bacilífero, de acuerdo a esto se cancela traslado. Nos encontramos a la espera de toma de Genexpert para evaluar perfil de sensibilidad. En el momento permanece estable, continuaremos atentos a evolución clínica del paciente.

Fecha: 07/04/2022: 10:55:23, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: ARIEL BELLO, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

DIAGNÓSTICOS

1. DISNEA SECUNDARIO A:

1.1. TUBERCULOSIS PULMONAR ACTIVA

1.1.1. TUBERCULOSIS MEDITINICA

1.1.1.1. HIPERTENSION PULMONAR SEVERA

1.1.1.1.1 ESTENOSIS DE LA VENA PULMONAR IZQUIERDA SUPERIOR

1.2. NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD CURB 65 2 PUNTOS RESUELTA 2. ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIA PSICOATIVAS

3. ANTECEDENTES DE TBC HACE 4 AÑOS NO ADHERENTE AL TRATAMIENTO

4. ANTECEDENTES DE HEMOPTISIS MASIVA (2021)

5. ANTECEDENTES DE ESTENOSIS ESOFAGICA(UNION ESOFAGO PROXIMA Y MEDIO DE 2CM) CON REQUERIMIENTO DE DILATACIÓN

6. DEFICIT ABSOLUTO DE HIERRO

Subjetivo:

SUBJETIVO

Paciente refiere sentirse en aceptables condiciones gnerales, pasa la noche tranquilo, manifiesta dudas al respecto de proceso de remisión a hospital, se le explica aque ante condición clínica actual en el momento no puede realizarse traslado.

Objetivo:

OBJETIVO

Paciente en cama, en posición de sedestación, con soporte de oxígeno con cánula nasal

SIGNOS VITALES FC 88 lpm PA: 110/70 mmHg SATO2 98%

EXAMEN FÍSICO POR REGIONES **CABEZA:** Mucosas húmedas, hidratadas, con atrofia de temporales **CUELLO:** No doloroso, no masas palpables **TÓRAX:** Simétrico, ruidos cardíacos rítmicos y regulares, no se auscultan ruidos agregados. **ABDOMEN:** Blando, depresible, no masas, no megalias **EXTREMIDADES:** Simétricas, ausente de edema

Análisis:

Paciente de 40 años con antecedente de consumo de sustancias psicoactivas, y VIH C3, historia de TB pulmonar no adherente a tratamiento. Quien ingresa en contexto de tuberculosis pulmonar y mediastínica, actualmente en manejo con terapia RIPE, con adecuada tolerancia, por ser el día 64 de tratamiento, aún con persistencia de baciloscopias positivas, a espera de realización de GeneExpert ya solicitado. En el momento permanece estable, continuaremos atentos a evolución clínica del paciente.

Fecha: 08/04/2022: 10:34:38, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

DIAGNÓSTICOS

1. DISNEA SECUNDARIO A:

1.1. TUBERCULOSIS PULMONAR ACTIVA

1.1.1. TUBERCULOSIS MEDITINICA

1.1.1.1. HIPERTENSION PULMONAR SEVERA

1.1.1.1.1 ESTENOSIS DE LA VENA PULMONAR IZQUIERDA SUPERIOR

1.2. NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD CURB 65 2 PUNTOS RESUELTA 2. ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIA PSICOATIVAS

3. ANTECEDENTES DE TBC HACE 4 AÑOS NO ADHERENTE AL TRATAMIENTO

4. ANTECEDENTES DE HEMOPTISIS MASIVA (2021)

5. ANTECEDENTES DE ESTENOSIS ESOFAGICA(UNION ESOFAGO PROXIMA Y MEDIO DE 2CM) CON REQUERIMIENTO DE DILATACIÓN

6. DEFICIT ABSOLUTO DE HIERRO

Subjetivo:

SUBJETIVO

Paciente pasa la noche tranquilo, niega alzas térmicas, niega dolor.

Objetivo:

OBJETIVO Paciente en cama, en posición de decúbito lateral derecho, con soporte de oxígeno con cánula nasal, luce tranquilo

SIGNOS VITALES

FC 83 lpm PA: 110/60 mmHg SATO2 98%

EXAMEN FÍSICO POR REGIONES **CABEZA:** Mucosas húmedas, hidratadas, con atrofia de temporales **CUELLO:** No doloroso, no masas palpables **TÓRAX:** Simétrico, ruidos cardíacos rítmicos y regulares, no se auscultan ruidos agregados. **ABDOMEN:** Blando, depresible, no masas, no megalias **EXTREMIDADES:** Simétricas, ausente de edema

Análisis:

Paciente de 40 años con antecedente de consumo de sustancias psicoactivas, y VIH C3, historia de TB pulmonar no adherente a tratamiento. Quien ingresa en

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

contexto de tuberculosis pulmonar y mediastínica, actualmente en manejo con terapia RIPE, con adecuada tolerancia, por ser el día 65 de tratamiento, aún con persistencia de baciloscopias positivas, a espera de realización de GeneExpert ya solicitado puesto que ante persistencia de positividad sugiere la presencia de un germen multidrogo-resistente, por lo tanto, a espera de toma de examen y por el momento deberá continuar con seguimiento clínico. En el momento permanece estable, continuaremos atentos a evolución clínica del paciente.

Fecha: 09/04/2022: 11:18:27, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: ORLANDO SANGUINO OMAÑA, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

DIAGNÓSTICOS

1. DISNEA SECUNDARIO A:

1.1. TUBERCULOSIS PULMONAR ACTIVA

1.1.1. TUBERCULOSIS MEDISTINICA

1.1.1.1. HIPERTENSION PULMONAR SEVERA

1.1.1.1.1. ESTENOSIS DE LA VENA PULMONAR IZQUIERDA SUPERIOR

1.2. NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD CURB 65 2 PUNTOS RESUELTA 2. ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIA PSICOATIVAS

3. ANTECEDENTES DE TBC HACE 4 AÑOS NO ADHERENTE AL TRATAMIENTO

4. ANTECEDENTES DE HEMOPTISIS MASIVA (2021)

5. ANTECEDENTES DE ESTENOSIS ESOFAGICA(UNION ESOFAGO PROXIMA Y MEDIO DE 2CM) CON REQUERIMIENTO DE DILATACIÓN

6. DEFICIT ABSOLUTO DE HIERRO

Subjetivo:

SUBJETIVO

Paciente refiere sentirse en aceptables condiciones.

Objetivo:

OBJETIVO

Paciente en cama, en posición decúbito supino, sin acompañante, luce tranquilo.

SIGNOS VITALES.

FC 90 lpm PA: 100/60 mmHg

EXAMEN FÍSICO POR REGIONES CABEZA: Mucosas húmedas, hidratadas, con atrofia de temporales CUELLO: No doloroso, no masas palpables TÓRAX: Simétrico, ruidos cardiacos rítmicos y regulares, no se auscultan ruidos agregados. ABDOMEN: Blando, depresible, no masas, no megalias EXTREMIDADES: Simétricas, ausente de edema

Análisis:

Paciente de 40 años con antecedente de consumo de sustancias psicoactivas, y VIH C3, historia de TB pulmonar no adherente a tratamiento. Quien ingresa en contexto de tuberculosis pulmonar y mediastínica, actualmente en manejo con terapia RIPE, con adecuada tolerancia, por ser el día 66 de tratamiento, aún con persistencia de baciloscopias positivas, ya tiene orden de realización de GeneExpert a espera de toma realización. En el momento permanece estable, continuaremos atentos a evolución clínica del paciente.

Fecha: 10/04/2022: 10:56:09, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: ORLANDO SANGUINO OMAÑA, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

DIAGNÓSTICOS 1. DISNEA SECUNDARIO A: 1.1. TUBERCULOSIS PULMONAR ACTIVA 1.1.1. TUBERCULOSIS MEDISTINICA 1.1.1.1. HIPERTENSION PULMONAR SEVERA 1.1.1.1.1. ESTENOSIS DE LA VENA PULMONAR IZQUIERDA SUPERIOR 1.2. NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD CURB 65 2 PUNTOS RESUELTA 2. ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIA PSICOATIVAS 3. ANTECEDENTES DE TBC HACE 4 AÑOS NO ADHERENTE AL TRATAMIENTO 4. ANTECEDENTES DE HEMOPTISIS MASIVA (2021) 5. ANTECEDENTES DE ESTENOSIS ESOFAGICA(UNION ESOFAGO PROXIMA Y MEDIO DE 2CM) CON REQUERIMIENTO DE DILATACIÓN 6. DEFICIT ABSOLUTO DE HIERRO

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE SENTIRSE BIEN CON MEJORIA DE DISNEA SIN TOS

Objetivo:

PACIENTE EN ACEPTABLES CONDICIONES GENERALES ESTABLE HEMODINAMICAMENTE, CON DESNUTRICION PROTEICO CALORICA, NO SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA, TÓRAX SIMÉTRICO EXPANDIBLE SIN TIRAJES, MURMULLO VESICULAR UNIVERSAL, SIN RUIDOS AGREGADOS. RUIDOS CARDIACOS RÍTMICOS, SIN SOPLOS AUDIBLES, ABDOMEN SIMÉTRICO, BLANDO, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN SUPERFICIAL NI PROFUNDA, NO SE PALPAN MASAS, NO MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL, GENITOURINARIO: NO EXPLORADO, EXTREMIDADES: SIMÉTRICAS, EDEMA,

Análisis:

PACIENTE DE 40 AÑOS CON ANTECEDENTE DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOATIVAS, Y VIH C3, HISTORIA DE TB PULMONAR NO ADHERENTE A TRATAMIENTO. QUIEN INGRESA EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR Y MEDIASTINICA, ACTUALMENTE EN MANEJO CON TERAPIA RIPE, CON ADECUADA TOLERANCIA SIN EMBARGO A PESAR DE HABER COMPLETADO PRIMERA FASE DE TERAPIA RIPE, PERSISTEN BACILOSCOPIAS POSITIVAS, POR LO CUAL SE ORDENA REALIZACION DE GENEEXPERT EL CUAL SE ENCUENTRA PENDIENTE PARA DEFINIR SI SE TRATA DE TBC MULTIDROGORESISTENTE. EN EL MOMENTO PERMANECE ESTABLE, CONTINUAREMOS ATENTOS A EVOLUCIÓN CLÍNICA DEL PACIENTE.

Fecha: 11/04/2022: 12:00:36, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

PACIENTE MASCULINO DE 40 AÑOS DE EDAD CON DIAGNÓSTICOS DE:

1. DISNEA SECUNDARIO A:

1.1. TUBERCULOSIS PULMONAR ACTIVA

1.1.1. TUBERCULOSIS MEDIASTINICA

1.1.1.1. HIPERTENSION PULMONAR SEVERA

1.1.1.1.1. ESTENOSIS DE LA VENA PULMONAR IZQUIERDA SUPERIOR

1.2. NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD CURB 65 2 PUNTOS RESUELTA 2. ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIA PSICOATIVAS

3. ANTECEDENTES DE TBC HACE 4 AÑOS NO ADHERENTE AL TRATAMIENTO

4. ANTECEDENTES DE HEMOPTISIS MASIVA (2021)

5. ANTECEDENTES DE ESTENOSIS ESOFAGICA(UNIÓN ESOFAGO PROXIMA Y MEDIO DE 2CM) CON REQUERIMIENTO DE DILATACIÓN

6. DÉFICIT ABSOLUTO DE HIERRO

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE SENTIRSE BIEN, NIEGA FIEBRE, EMESIS, SANGRADO U OTRA SINTOMATOLOGÍA ASOCIADA

Objetivo:

TA:120/80 FC:80 FR:18 SO2:99

PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, ALERTA, ORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA, CABEZA Y CUELLO: PUPILAS ISOCÓRICAS NORMORREACTIVAS A LA LUZ, MUCOSA ORAL HÚMEDA, CUELLO MÓVIL, SIMÉTRICO, NO ADENOPATÍAS, SIN RIGIDEZ DE NUCA TÓRAX: RUIDOS CARDIACOS RÍTMICOS SIN SOPLOS, RUIDOS RESPIRATORIOS PRESENTES PERO DISMINUIDOS EN AMBOS CAMPOS PULMONARES DE

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

PREDOMINIO DERECHO, NO CRÉPITOS, SIBILANCIAS OCASIONALES. ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. EXTREMIDADES: SIMÉTRICAS HIPOTROFICAS SIN EDEMA LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS, PULSOS PERIFÉRICOS PRESENTES SIMÉTRICOS DE BUENA INTENSIDAD SNC: SIN DÉFICIT MOTOR O SENSITIVO APARENTE. GLASGOW 15/15.

Análisis:

PACIENTE MASCULINO DE 40 AÑOS DE EDAD CON ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS, ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR. AL MOMENTO, PACIENTE EN BUENAS CONDICIONES PROTEICO CALÓRICAS, CLÍNICA Y HEMODINÁMICAMENTE ESTABLE, CIFRAS TENSIONALES NORMALES, CON CÁNULA NASAL A 3 LITROS X MIN SE REPORTA BACILOSCOPIA DEL 02.04.2022: POSITIVO PARA BAAR. HEMOGRAMA 31/03/22: LEU 10.12 NEU 7.62 HB 9.6 HTO 33.9 VCM 75.8 IDE 16.6 PLA 533, IONOGRAMA EN PARÁMETROS NORMALES, REPORTE DE GENEXPERT MTB/RIF Y CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS POSITIVO SENSIBLE. EL DÍA CONTINÚA CON IGUAL MANEJO MÉDICO CON TERAPIA RIPE, EN NOTABLE MEJORÍA CLÍNICA, EL CUAL SE ENCUENTRA A LA ESPERA DE AUTORIZACIÓN DE TRASLADO A UNIDAD DE CUIDADO CRÓNICO CON OXIGENOTERAPIA AMBULATORIO POR LO QUE SE INSISTE EN ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DEL SERVICIO TRABAJO SOCIAL, SE EXPLICA A PACIENTE QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR CONDUCTA MÉDICA.

Fecha: 12/04/2022: 11:08:15, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

DIAGNÓSTICOS:

1. DISNEA SECUNDARIO A:

1.1. TUBERCULOSIS PULMONAR ACTIVA

1.1.1. TUBERCULOSIS MEDISTINICA

1.1.1.1. HIPERTENSION PULMONAR SEVERA

1.1.1.1.1. ESTENOSIS DE LA VENA PULMONAR IZQUIERDA SUPERIOR

1.2. NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD CURB 65 2 PUNTOS RESUELTA 2. ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIA PSICOACTIVAS

3. ANTECEDENTES DE TBC HACE 4 AÑOS NO ADHERENTE AL TRATAMIENTO

4. ANTECEDENTES DE HEMOPTISIS MASIVA (2021)

5. ANTECEDENTES DE ESTENOSIS ESOFAGICA (UNION ESOFAGO PROXIMA Y MEDIO DE 2CM) CON REQUERIMIENTO DE DILATACIÓN

6. DEFICIT ABSOLUTO DE HIERRO

Subjetivo:

SUBJETIVO

Paciente refiere sentirse en aceptables condiciones generales.

Objetivo:

OBJETIVO

Paciente en cama, en posición decúbito supino, con soporte de oxígeno con cánula nasal 3L/min, luce crónicamente enfermo.

SIGNOS VITALES

FC: 75 lpm PA: 100/80 mmHg

EXAMEN FÍSICO POR REGIONES

CABEZA: Mucosas húmedas, hidratadas, con atrofia de temporales

CUELLO: No doloroso, no masas palpables

TÓRAX: Simétrico, ruidos cardiacos rítmicos y regulares, no se auscultan ruidos agregados.

ABDOMEN: Blando, depresible, no masas, no megalias

EXTREMIDADES: Simétricas, ausente de edema

Análisis:

PACIENTE MASCULINO DE 40 AÑOS DE EDAD CON ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS, ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR. SE ACLARA QUE EL PACIENTE ES VIH NEGATIVO. ACTUALMENTE EN TRATAMIENTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR, QUIEN A PESAR DE 66 DÍAS DE TRATAMIENTO CON ADECUADA ADHERENCIA A ESQUEMA INTRAHOSPITALRIO, HA PERSISTIDO CON BK POSITIVO, POR LO TANTO, SE SOLICITÓ PRUEBA DE SENSIBILIDAD CON RESULTADO SENSIBLE EL 08/04/2022, DE ACUERDO A ESTOS HALLAZGOS, NO SE REALIZA MODIFICACIÓN EN TRATAMIENTO ESTABLECIDO, SE REALIZARÁ EXTENSIÓN DE TRATAMIENTO DE PRIMERA FASE, Y CONTROL CON BACILOSCOPIAS EN 2-3 SEMANAS. POR EL MOMENTO TIENE DIFERIDO EL TRASLADO A UNIDAD DE CRÓNICOS PUESTO QUE PERSISTE CON BACILOSCOPIAS POSITIVAS. SE EXPLICA A PACIENTE CONDUCTA MÉDICA A TOMAR, SE SOLUCIONAN DUDAS, REFIERE COMPRENDER.

Fecha: 13/04/2022: 12:16:47, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: FERNANDO DE LA VEGA DEL RISCO, Especialidad: INFECTOLOGIA

Problema:

DIAGNÓSTICOS

1. DISNEA SECUNDARIO A:

1.1. TUBERCULOSIS PULMONAR ACTIVA

1.1.1. TUBERCULOSIS MEDISTINICA

1.1.1.1. HIPERTENSION PULMONAR SEVERA

1.1.1.1.1. ESTENOSIS DE LA VENA PULMONAR IZQUIERDA SUPERIOR

1.2. NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD CURB 65 2 PUNTOS RESUELTA 2. ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIA PSICOACTIVAS

3. ANTECEDENTES DE TBC HACE 4 AÑOS NO ADHERENTE AL TRATAMIENTO

4. ANTECEDENTES DE HEMOPTISIS MASIVA (2021)

5. ANTECEDENTES DE ESTENOSIS ESOFAGICA (UNION ESOFAGO PROXIMA Y MEDIO DE 2CM) CON REQUERIMIENTO DE DILATACIÓN

6. DEFICIT ABSOLUTO DE HIERRO

Subjetivo:

SUBJETIVO

Refiere sentirse en aceptables condiciones generales, pasa la noche tranquilo.

Objetivo:

OBJETIVO

Paciente en cama, en posición decúbito supino, sin acompañante, sin signos de dificultad respiratoria.

SIGNOS VITALES

FC: 80 PA: 110/80 mmHg

EXAMEN FÍSICO POR REGIONES CABEZA: Mucosas húmedas, hidratadas, con atrofia de temporales CUELLO: No doloroso, no masas palpables TÓRAX:

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

Simétrico, ruidos cardiacos rítmicos y regulares, no se auscultan ruidos agregados. ABDOMEN: Blando, depresible, no masas, no megalias EXTREMIDADES: Simétricas, ausente de edema

Análisis:

PACIENTE MASCULINO DE 40 AÑOS DE EDAD CON ANTECEDENTES DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y TUBERCULOSIS PULMONAR TRATADA HACE 4 AÑOS, ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR. SE ACLARA QUE EL PACIENTE ES VIH NEGATIVO. ACTUALMENTE EN TRATAMIENTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR, QUIEN A PESAR DE 70 DÍAS DE TRATAMIENTO CON ADECUADA ADHERENCIA A ESQUEMA INTRAHOSPITALRIO, HA PERSISTIDO CON BK POSITIVO, POR LO TANTO, SE SOLICITÓ PRUEBA DE SENSIBILIDAD CON RESULTADO SENSIBLE EL 08/04/2022, DE ACUERDO A ESTOS HALLAZGOS, NO SE REALIZA MODIFICACIÓN EN TRATAMIENTO ESTABLECIDO, SE REALIZARÁ EXTENSIÓN DE TRATAMIENTO DE PRIMERA FASE PARA COMPLETAR 3 MESES, Y SE REALIZARÁ NUEVAMENTE BACILOSCOPIAS EN 3 SEMANAS PARA DEFINIR PASO A SEGUNDA FASE. SE ACORDO CON TRABAJADORA SOCIAL Y HOSTAL PERMANENCIA EN HABITACIÓN INDIVIDUAL. POR LO TANTO, SE AUTORIZA Y ESPERA TRASLADO A HOSTAL DONDE DEBERÁ CONTINUAR TRATAMIENTO ESTABLECIDO. SE EXPLICA A PACIENTE CONDUCTA MÉDICA A TOMAR, SE SOLUCIONAN DUDAS, REFIERE COMPRENDER.

Procedimientos Realizados y Ordenados:

Fecha: 01/02/2022

-902210 - HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO- Cantidad: 1

-903856 - NITROGENO UREICO - Cantidad: 1

-903859 - POTASIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

-903864 - SODIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

-903866 - TRANSAMINASA GLUTAMICO-PIRUVICA [ALANINO AMINO TRANSFERASA] - Cantidad: 1

-903867 - TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICA [ASPARTATO AMINO TRANSFERASA] - Cantidad: 1

-903895 - CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

Fecha: 02/03/2022

-902210 - HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO- Cantidad: 1

-903813 - CLORO - Cantidad: 1

-903856 - NITROGENO UREICO - Cantidad: 1

-903859 - POTASIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

-903864 - SODIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

-903895 - CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

Fecha: 03/02/2022

-876121 - ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO DERECHO E IZQUIERDO- Cantidad: 1

Fecha: 03/03/2022

-903016 - FERRITINA- Cantidad: 1

-903044 - SATURACIÓN DE TRANSFERRINA - Cantidad: 1

-903846 - HIERRO TOTAL - Cantidad: 1

Fecha: 04/02/2022

-360501 - ANGIOPLASTIA CORONARIA POR VIA PERCUTANEA (ENDOVASCULAR) (ATERECTOMA CORONARIA) REALIZADA DURANTE LA MISMA INTERVENCION - ANGIOPLASTIA CORONARIA (INCLUYE: COLOCACION MARCAPASO Y CORONARIOGRAFIA POST ANGIOPLASTIA INMEDIATA)- Cantidad: 1

-902045 - TIEMPO DE PROTROMBINA [TP] - Cantidad: 1

-902048 - TIEMPO DE TROMBINA - Cantidad: 1

-902210 - HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO - Cantidad: 1

-903813 - CLORO - Cantidad: 1

-903856 - NITROGENO UREICO - Cantidad: 1

-903859 - POTASIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

-903864 - SODIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

-903895 - CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

Fecha: 04/04/2022

-908825 - Mycobacterium tuberculosis IDENTIFICACION REACCION EN CADENA DE LA POLIMERASA- Cantidad: 2

Fecha: 07/02/2022

-902104 - DIMERO D AUTOMATIZADO- Cantidad: 1

-902210 - HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO - Cantidad: 1

-903436 - TROPONINA I CUALITATIVA - Cantidad: 1

-903809 - BILIRRUBINAS TOTAL Y DIRECTA - Cantidad: 1

-903854 - MAGNESIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

-903859 - POTASIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

-903864 - SODIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

-903866 - TRANSAMINASA GLUTAMICO-PIRUVICA [ALANINO AMINO TRANSFERASA] - Cantidad: 1

-903867 - TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICA [ASPARTATO AMINO TRANSFERASA] - Cantidad: 1

Fecha: 08/02/2022

-879301 - TOMOGRAFIA COMPUTADA DE TORAX- Cantidad: 1

Fecha: 08/03/2022

-902045 - TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]- Cantidad: 1

-902049 - TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL [TTP] - Cantidad: 1

-902210 - HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO - Cantidad: 1

-903856 - NITROGENO UREICO - Cantidad: 1

-903895 - CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

Fecha: 09/02/2022

-902045 - TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]- Cantidad: 1

-902049 - TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL [TTP] - Cantidad: 1

-902210 - HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO - Cantidad: 1

-903856 - NITROGENO UREICO - Cantidad: 1

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

-903895 - CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

Fecha: 09/04/2022

-902210 - HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO- Cantidad: 1

-903809 - BILIRRUBINAS TOTAL Y DIRECTA - Cantidad: 1

-903813 - CLORO - Cantidad: 1

-903859 - POTASIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

-903864 - SODIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

-903866 - TRANSAMINASA GLUTAMICO-PIRUVICA [ALANINO AMINO TRANSFERASA] - Cantidad: 1

-903867 - TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICA [ASPARTATO AMINO TRANSFERASA] - Cantidad: 1

Fecha: 12/01/2022

-879301 - TOMOGRAFIA COMPUTADA DE TORAX- Cantidad: 1

-901111 - BACILOSCOPIA COLORACIÓN ÁCIDO ALCOHOL RESISTENTE [ZIELH-NEELEN] LECTURA SERIADA TRES MUESTRAS - Cantidad: 1

-901217 - CULTIVO PARA MICROORGANISMOS EN CUALQUIER MUESTRA DIFERENTE A MEDULA OSEA ORINA Y HECES - Cantidad: 1

-902045 - TIEMPO DE PROTROMBINA [TP] - Cantidad: 1

-902049 - TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL [TTP] - Cantidad: 1

-902210 - HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO - Cantidad: 1

-903809 - BILIRRUBINAS TOTAL Y DIRECTA - Cantidad: 1

-903813 - CLORO - Cantidad: 1

-903828 - DESHIDROGENASA LACTICA - Cantidad: 1

-903841 - GLUCOSA EN SUERO U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA - Cantidad: 1

-903856 - NITROGENO UREICO - Cantidad: 1

-903859 - POTASIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

-903864 - SODIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

-903866 - TRANSAMINASA GLUTAMICO-PIRUVICA [ALANINO AMINO TRANSFERASA] - Cantidad: 1

-903867 - TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICA [ASPARTATO AMINO TRANSFERASA] - Cantidad: 1

-903895 - CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

-906249 - VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA 1 Y 2 ANTICUERPOS - Cantidad: 1

-906340 - SARS CoV2 (COVID - 19) ANTIGENO - Cantidad: 1

-906913 - PROTEINA C REACTIVA ALTA PRECISION AUTOMATIZADO - Cantidad: 1

-908825 - Mycobacterium tuberculosis IDENTIFICACION REACCION EN CADENA DE LA POLIMERASA - Cantidad: 1

Fecha: 12/03/2022

-902210 - HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO- Cantidad: 1

-903809 - BILIRRUBINAS TOTAL Y DIRECTA - Cantidad: 1

-903813 - CLORO - Cantidad: 1

-903839 - GASES ARTERIALES (EN REPOSO O EN EJERCICIO) - Cantidad: 1

-903856 - NITROGENO UREICO - Cantidad: 1

-903859 - POTASIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

-903864 - SODIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

-903866 - TRANSAMINASA GLUTAMICO-PIRUVICA [ALANINO AMINO TRANSFERASA] - Cantidad: 1

-903867 - TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICA [ASPARTATO AMINO TRANSFERASA] - Cantidad: 1

-903895 - CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

Fecha: 13/01/2022

-901111 - BACILOSCOPIA COLORACIÓN ÁCIDO ALCOHOL RESISTENTE [ZIELH-NEELEN] LECTURA SERIADA TRES MUESTRAS- Cantidad: 1

-901230 - MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS CULTIVO - Cantidad: 1

-906249 - VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA 1 Y 2 ANTICUERPOS - Cantidad: 1

Fecha: 14/02/2022

-902210 - HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO- Cantidad: 1

-903856 - NITROGENO UREICO - Cantidad: 1

-903864 - SODIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

-903866 - TRANSAMINASA GLUTAMICO-PIRUVICA [ALANINO AMINO TRANSFERASA] - Cantidad: 1

-903867 - TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICA [ASPARTATO AMINO TRANSFERASA] - Cantidad: 1

-903895 - CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

-906913 - PROTEINA C REACTIVA ALTA PRECISION AUTOMATIZADO - Cantidad: 1

Fecha: 15/03/2022

-902210 - HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO- Cantidad: 1

-903813 - CLORO - Cantidad: 1

-903859 - POTASIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

-903864 - SODIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

-903866 - TRANSAMINASA GLUTAMICO-PIRUVICA [ALANINO AMINO TRANSFERASA] - Cantidad: 1

-903867 - TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICA [ASPARTATO AMINO TRANSFERASA] - Cantidad: 1

Fecha: 17/01/2022

-901313 - MYCOBACTERIUM IDENTIFICACION- Cantidad: 1

Fecha: 18/03/2022

-902210 - HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO- Cantidad: 1

-903813 - CLORO - Cantidad: 1

-903839 - GASES ARTERIALES (EN REPOSO O EN EJERCICIO) - Cantidad: 1

-903841 - GLUCOSA EN SUERO U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA - Cantidad: 1

-903856 - NITROGENO UREICO - Cantidad: 1

-903859 - POTASIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

-903864 - SODIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

-903895 - CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS - Cantidad: 1

Fecha: 22/01/2022

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

-901217 - CULTIVO PARA MICROORGANISMOS EN CUALQUIER MUESTRA DIFERENTE A MEDULA OSEA ORINA Y HECES- Cantidad: 1
 -901221 - HEMOCULTIVO AEROBIO AUTOMATIZADO CADA MUESTRA- Cantidad: 2
 -901223 - HEMOCULTIVO ANAEROBIO AUTOMATIZADO CADA MUESTRA- Cantidad: 2
 -902210 - HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO- Cantidad: 1
 -903813 - CLORO- Cantidad: 1
 -903859 - POTASIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS- Cantidad: 1
 -903864 - SODIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS- Cantidad: 1
 -906913 - PROTEINAC REACTIVA ALTA PRECISION AUTOMATIZADO- Cantidad: 1

Fecha: 22/03/2022

-902210 - HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO- Cantidad: 1
 -903813 - CLORO- Cantidad: 1
 -903859 - POTASIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS- Cantidad: 1
 -903864 - SODIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS- Cantidad: 1
 -903866 - TRANSAMINASA GLUTAMICO-PIRUVICA [ALANINO AMINO TRANSFERASA]- Cantidad: 1
 -903867 - TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICA [ASPARTATO AMINO TRANSFERASA]- Cantidad: 1

Fecha: 23/02/2022

-903856 - NITROGENO UREICO- Cantidad: 1
 -903895 - CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS- Cantidad: 1

Fecha: 24/01/2022

-902210 - HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO- Cantidad: 1
 -903839 - GASES ARTERIALES (EN REPOSO O EN EJERCICIO)- Cantidad: 1
 -906913 - PROTEINAC REACTIVA ALTA PRECISION AUTOMATIZADO- Cantidad: 1

Fecha: 24/03/2022

-901111 - BACILOSCOPIA COLORACIÓN ÁCIDO ALCOHOL RESISTENTE [ZIELH-NEELSEN] LECTURA SERIADA TRES MUESTRAS- Cantidad: 1
 -902210 - HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO- Cantidad: 1
 -903813 - CLORO- Cantidad: 1
 -903856 - NITROGENO UREICO- Cantidad: 1
 -903859 - POTASIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS- Cantidad: 1
 -903864 - SODIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS- Cantidad: 1
 -903866 - TRANSAMINASA GLUTAMICO-PIRUVICA [ALANINO AMINO TRANSFERASA]- Cantidad: 1
 -903867 - TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICA [ASPARTATO AMINO TRANSFERASA]- Cantidad: 1
 -903895 - CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS- Cantidad: 1

Fecha: 25/03/2022

-902210 - HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO- Cantidad: 1
 -903856 - NITROGENO UREICO- Cantidad: 1
 -903866 - TRANSAMINASA GLUTAMICO-PIRUVICA [ALANINO AMINO TRANSFERASA]- Cantidad: 1
 -903867 - TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICA [ASPARTATO AMINO TRANSFERASA]- Cantidad: 1
 -903895 - CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS- Cantidad: 1

Fecha: 26/03/2022

-902210 - HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO- Cantidad: 1
 -903856 - NITROGENO UREICO- Cantidad: 1
 -903895 - CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS- Cantidad: 1
 -906913 - PROTEINAC REACTIVA ALTA PRECISION AUTOMATIZADO- Cantidad: 1

Fecha: 29/03/2022

-902210 - HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO- Cantidad: 1
 -903809 - BILIRRUBINAS TOTAL Y DIRECTA- Cantidad: 1
 -903813 - CLORO- Cantidad: 1
 -903859 - POTASIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS- Cantidad: 1
 -903864 - SODIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS- Cantidad: 1
 -903866 - TRANSAMINASA GLUTAMICO-PIRUVICA [ALANINO AMINO TRANSFERASA]- Cantidad: 1
 -903867 - TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICA [ASPARTATO AMINO TRANSFERASA]- Cantidad: 1

Fecha: 30/01/2022

-881202 - ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO - MODO M, BIDIMENSIONAL Y DOPPLER COLOR- Cantidad: 1

Fecha: 30/03/2022

-901111 - BACILOSCOPIA COLORACIÓN ÁCIDO ALCOHOL RESISTENTE [ZIELH-NEELSEN] LECTURA SERIADA TRES MUESTRAS- Cantidad: 1

Fecha: 31/03/2022

-902210 - HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO- Cantidad: 1
 -903813 - CLORO- Cantidad: 1
 -903856 - NITROGENO UREICO- Cantidad: 1
 -903859 - POTASIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS- Cantidad: 1
 -903864 - SODIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS- Cantidad: 1
 -903866 - TRANSAMINASA GLUTAMICO-PIRUVICA [ALANINO AMINO TRANSFERASA]- Cantidad: 1
 -903867 - TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICA [ASPARTATO AMINO TRANSFERASA]- Cantidad: 1
 -903895 - CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS- Cantidad: 1

Medicamentos Ordenados y Administrados:

Fecha: 01/02/2022

-0015 - Jeringa 10 ml- Cantidad: 3
 -10090 - Solucion Salina Normal x 100 ml SSN- Cantidad: 3

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

-A02BO002101 - Omeprazol - Cantidad: 1
 -A11HP015141 - Piridoxina clorhidrato - Cantidad: 1
 -MasN95 - mascarilla para riesgo bio- N 95 desechables - Cantidad: 1
 -N02BD026701 - Dipirona - Cantidad: 2
 Fecha: 01/03/2022
 -10090 - Solucion Salina Normal x 100 ml SSN- Cantidad: 3
 -A02BO002101 - Omeprazol - Cantidad: 1
 -A11HP015141 - Piridoxina clorhidrato - Cantidad: 1
 -B01AH003704 - DALTEPARINA SODICA (Heparina de bajo peso molecular) - Cantidad: 1
 -HUCDES162 - JERINGA 5 ML - Cantidad: 3
 -HUCDES71 - EQUIPO MACROGOTEO - Cantidad: 1
 -IM6235 - Alimento hiperproteico con HMB y Vitamina D ENSURE CLINICAL - Cantidad: 2
 -MasN95 - mascarilla para riesgo bio- N 95 desechables - Cantidad: 1
 -N02AT020701 - Tramadol clorhidrato - Cantidad: 3
 Fecha: 01/04/2022
 -0015 - Jeringa 10 ml- Cantidad: 10
 -10090 - Solucion Salina Normal x 100 ml SSN - Cantidad: 4
 -B01AH003707 - Heparina de bajo peso molecular (Enoxaparina) - Cantidad: 2
 -C03CF017701 - Furosemida - Cantidad: 6
 -HUCDES71 - EQUIPO MACROGOTEO - Cantidad: 1
 -IM6235 - Alimento hiperproteico con HMB y Vitamina D ENSURE CLINICAL - Cantidad: 4
 -N02AT020702 - Tramadol clorhidrato - Cantidad: 4
 -N02BA001011 - Acetaminofen Tableta - Cantidad: 6
 Fecha: 02/02/2022
 -0015 - Jeringa 10 ml- Cantidad: 3
 -10090 - Solucion Salina Normal x 100 ml SSN - Cantidad: 3
 -A02BO002101 - Omeprazol - Cantidad: 1
 -A11HP015141 - Piridoxina clorhidrato - Cantidad: 1
 -HUCCAT40 - CATETER INTRACAT # 20 - Cantidad: 1
 -HUCDES162 - JERINGA 5 ML - Cantidad: 1
 -HUCDES173 - LLAVE DE TRES VAS - NIPRO - ITEM(176) - Cantidad: 1
 -HUCDES71 - EQUIPO MACROGOTEO - Cantidad: 1
 -MasN95 - mascarilla para riesgo bio- N 95 desechables - Cantidad: 1
 -N02BD026701 - Dipirona - Cantidad: 3
 Fecha: 02/03/2022
 -10090 - Solucion Salina Normal x 100 ml SSN- Cantidad: 3
 -A02BO002101 - Omeprazol - Cantidad: 1
 -A11HP015141 - Piridoxina clorhidrato - Cantidad: 1
 -B01AH003704 - DALTEPARINA SODICA (Heparina de bajo peso molecular) - Cantidad: 1
 -HUCCAT40 - CATETER INTRACAT # 20 - Cantidad: 1
 -HUCDES160 - JERINGA 20 CC - Cantidad: 3
 -HUCDES162 - JERINGA 5 ML - Cantidad: 1
 -HUCDES173 - LLAVE DE TRES VAS - NIPRO - ITEM(176) - Cantidad: 1
 -HUCDES200 - TAPABOCAS DESECHABLES - Cantidad: 1
 -IM6235 - Alimento hiperproteico con HMB y Vitamina D ENSURE CLINICAL - Cantidad: 2
 -N02AT020701 - Tramadol clorhidrato - Cantidad: 3
 Fecha: 02/04/2022
 -10090 - Solucion Salina Normal x 100 ml SSN- Cantidad: 2
 -B01AH003707 - Heparina de bajo peso molecular (Enoxaparina) - Cantidad: 1
 -C03CF017701 - Furosemida - Cantidad: 3
 -HUCDES160 - JERINGA 20 CC - Cantidad: 5
 -HUCDES189 - RECOLECTOR DE ORINA ADULTO - RYMCO - ITEM(195) - Cantidad: 2
 -HUCTR13 - CANULA NASAL DE OXIGENO CON ADAPTADOR UNIVERSAL Y EXTENSION DE 2MTS ADULTO - INTERSURGICAL - ITEM(13) - Cantidad: 1
 -HUCTR41 - HUMIDIFICADORES TAPA VERDE - OXITEC - ITEM(41) - Cantidad: 1
 -MasN95 - mascarilla para riesgo bio- N 95 desechables - Cantidad: 1
 -N02AT020702 - Tramadol clorhidrato - Cantidad: 2
 -N02BA001011 - Acetaminofen Tableta - Cantidad: 6
 Fecha: 03/02/2022
 -0015 - Jeringa 10 ml- Cantidad: 5
 -10090 - Solucion Salina Normal x 100 ml SSN - Cantidad: 3
 -A02BO002101 - Omeprazol - Cantidad: 1
 -A11HP015141 - Piridoxina clorhidrato - Cantidad: 1
 -HUCTR43 - KIT VENTURY ADULTO - Cantidad: 1
 -IM6235 - Alimento hiperproteico con HMB y Vitamina D ENSURE CLINICAL - Cantidad: 2
 -MasN95 - mascarilla para riesgo bio- N 95 desechables - Cantidad: 1
 -N02BD026701 - Dipirona - Cantidad: 1
 Fecha: 03/03/2022
 -0001 - Solucion Salina Normal 500 mL SSN- Cantidad: 1
 -A02BO002101 - Omeprazol - Cantidad: 1
 -A11HP015141 - Piridoxina clorhidrato - Cantidad: 1
 -B01AH003704 - DALTEPARINA SODICA (Heparina de bajo peso molecular) - Cantidad: 1
 -HUCDES71 - EQUIPO MACROGOTEO - Cantidad: 1
 -IM6235 - Alimento hiperproteico con HMB y Vitamina D ENSURE CLINICAL - Cantidad: 2
 -MasN95 - mascarilla para riesgo bio- N 95 desechables - Cantidad: 1
 Fecha: 04/02/2022
 -0015 - Jeringa 10 ml- Cantidad: 3
 -10090 - Solucion Salina Normal x 100 ml SSN - Cantidad: 3
 -A02BO002101 - Omeprazol - Cantidad: 1

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

-A11HP015141 - Piridoxina clorhidrato - Cantidad: 1
 -B01AH003707 - Heparina de bajo peso molecular (Enoxaparina) - Cantidad: 1
 -IM6235 - Alimento hiperproteico con HMB y Vitamina D ENSURE CLINICAL - Cantidad: 2
 -MasN95 - mascarilla para riesgo bio- N 95 desechables - Cantidad: 1
 -N02BD026701 - Dipirona - Cantidad: 3
 Fecha: 04/03/2022
 -0001 - Solucion Salina Normal 500 mL SSN- Cantidad: 4
 -A11HP015141 - Piridoxina clorhidrato - Cantidad: 1
 -B01AH003707 - Heparina de bajo peso molecular (Enoxaparina) - Cantidad: 1
 -HUCTR13 - CANULA NASAL DE OXIGENO CON ADAPTADOR UNIVERSAL Y EXTENSION DE 2MTS ADULTO - INTERSURGICAL - ITEM(13) - Cantidad: 1
 -HUCTR41 - HUMIDIFICADORES TAPA VERDE - OXITEC - ITEM(41) - Cantidad: 1
 -IM6235 - Alimento hiperproteico con HMB y Vitamina D ENSURE CLINICAL - Cantidad: 2
 -MasN95 - mascarilla para riesgo bio- N 95 desechables - Cantidad: 1
 Fecha: 04/04/2022
 -0015 - Jeringa 10 ml- Cantidad: 10
 -10090 - Solucion Salina Normal x 100 ml SSN - Cantidad: 4
 -A02BO002101 - Omeprazol - Cantidad: 2
 -A11HP015141 - Piridoxina clorhidrato - Cantidad: 2
 -B01AH003707 - Heparina de bajo peso molecular (Enoxaparina) - Cantidad: 2
 -C03CF017701 - Furosemida - Cantidad: 6
 -HUCCAT41 - CATETER INTRACAT# 22 - Cantidad: 1
 -HUCDES173 - LLAVE DE TRES VIAS - NIPRO - ITEM(176) - Cantidad: 1
 -HUCDES71 - EQUIPO MACROGOTEO - Cantidad: 1
 -MasN95 - mascarilla para riesgo bio- N 95 desechables - Cantidad: 2
 -N02AT020701 - Tramadol clorhidrato - Cantidad: 4
 -N02BA001011 - Acetaminofen Tableta - Cantidad: 8
 Fecha: 05/02/2022
 -0015 - Jeringa 10 ml- Cantidad: 3
 -10090 - Solucion Salina Normal x 100 ml SSN - Cantidad: 3
 -A02BO002101 - Omeprazol - Cantidad: 1
 -A11HP015141 - Piridoxina clorhidrato - Cantidad: 1
 -B01AH003707 - Heparina de bajo peso molecular (Enoxaparina) - Cantidad: 1
 -HUCCAT40 - CATETER INTRACAT # 20 - Cantidad: 1
 -HUCDES162 - JERINGA 5 ML - Cantidad: 1
 -HUCDES173 - LLAVE DE TRES VIAS - NIPRO - ITEM(176) - Cantidad: 1
 -HUCTR43 - KIT VENTURY ADULTO - Cantidad: 1
 -IM6235 - Alimento hiperproteico con HMB y Vitamina D ENSURE CLINICAL - Cantidad: 6
 -MasN95 - mascarilla para riesgo bio- N 95 desechables - Cantidad: 1
 -N02BD026701 - Dipirona - Cantidad: 3
 Fecha: 06/03/2022
 -9851 - Salbutamol sulfato INHALADOR- Cantidad: 1
 Fecha: 06/04/2022
 -0015 - Jeringa 10 ml- Cantidad: 4
 -10090 - Solucion Salina Normal x 100 ml SSN - Cantidad: 4
 -A02BO002101 - Omeprazol - Cantidad: 2
 -A11HP015141 - Piridoxina clorhidrato - Cantidad: 2
 -B01AH003707 - Heparina de bajo peso molecular (Enoxaparina) - Cantidad: 2
 -C03CF017011 - Furosemida - Cantidad: 2
 -HUCTR13 - CANULA NASAL DE OXIGENO CON ADAPTADOR UNIVERSAL Y EXTENSION DE 2MTS ADULTO - INTERSURGICAL - ITEM(13) - Cantidad: 1
 -HUCTR41 - HUMIDIFICADORES TAPA VERDE - OXITEC - ITEM(41) - Cantidad: 1
 -IM6235 - Alimento hiperproteico con HMB y Vitamina D ENSURE CLINICAL - Cantidad: 2
 -MasN95 - mascarilla para riesgo bio- N 95 desechables - Cantidad: 1
 -N02AT020701 - Tramadol clorhidrato - Cantidad: 4
 -N02BA001011 - Acetaminofen Tableta - Cantidad: 4
 Fecha: 07/02/2022
 -0015 - Jeringa 10 ml- Cantidad: 6
 -10090 - Solucion Salina Normal x 100 ml SSN - Cantidad: 6
 -A02BO002101 - Omeprazol - Cantidad: 2
 -A11HP015141 - Piridoxina clorhidrato - Cantidad: 2
 -B01AH003707 - Heparina de bajo peso molecular (Enoxaparina) - Cantidad: 2
 -HUCTR41 - HUMIDIFICADORES TAPA VERDE - OXITEC - ITEM(41) - Cantidad: 1
 -MasN95 - mascarilla para riesgo bio- N 95 desechables - Cantidad: 1
 -N02BD026701 - Dipirona - Cantidad: 6
 Fecha: 07/03/2022
 -0001 - Solucion Salina Normal 500 mL SSN- Cantidad: 3
 -0015 - Jeringa 10 ml - Cantidad: 2
 -10090 - Solucion Salina Normal x 100 ml SSN - Cantidad: 4
 -A02BO002101 - Omeprazol - Cantidad: 3
 -A11HP015141 - Piridoxina clorhidrato - Cantidad: 3
 -B01AH003707 - Heparina de bajo peso molecular (Enoxaparina) - Cantidad: 2
 -HUCCAT40 - CATETER INTRACAT # 20 - Cantidad: 1
 -HUCDES162 - JERINGA 5 ML - Cantidad: 1
 -HUCDES173 - LLAVE DE TRES VIAS - NIPRO - ITEM(176) - Cantidad: 1
 -HUCDES71 - EQUIPO MACROGOTEO - Cantidad: 2
 -HUCTR13 - CANULA NASAL DE OXIGENO CON ADAPTADOR UNIVERSAL Y EXTENSION DE 2MTS ADULTO - INTERSURGICAL - ITEM(13) - Cantidad: 1
 -HUCTR41 - HUMIDIFICADORES TAPA VERDE - OXITEC - ITEM(41) - Cantidad: 1
 -IM6235 - Alimento hiperproteico con HMB y Vitamina D ENSURE CLINICAL - Cantidad: 6
 -MasN95 - mascarilla para riesgo bio- N 95 desechables - Cantidad: 2

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

-N02AT020701 - Tramadol clorhidrato - Cantidad: 4
 -R01A017471 - Ipratropio bromuro 20 MCG - Cantidad: 1
 Fecha: 08/02/2022
 -0015 - Jeringa 10 ml- Cantidad: 2
 -10090 - Solucion Salina Normal x 100 ml SSN - Cantidad: 2
 -A02BO002101 - Omeprazol - Cantidad: 1
 -A11HP015141 - Piridoxina clorhidrato - Cantidad: 1
 -B01AH003702 - Heparina de bajo peso molecular (Enoxaparina) - Cantidad: 2
 -HUCCAT40 - CATETER INTRACAT # 20 - Cantidad: 1
 -HUCDES173 - LLAVE DE TRES VIAS - NIPRO - ITEM(176) - Cantidad: 1
 -HUCDES71 - EQUIPO MACROGOTEO - Cantidad: 1
 -MasN95 - mascarilla para riesgo bio- N 95 desechables - Cantidad: 1
 -N02BD026701 - Dipirona - Cantidad: 2
 Fecha: 08/03/2022
 -0015 - Jeringa 10 ml- Cantidad: 2
 -10090 - Solucion Salina Normal x 100 ml SSN - Cantidad: 2
 -A02BO002101 - Omeprazol - Cantidad: 1
 -A11HP015141 - Piridoxina clorhidrato - Cantidad: 1
 -B01AH003707 - Heparina de bajo peso molecular (Enoxaparina) - Cantidad: 1
 -HUCCAT40 - CATETER INTRACAT # 20 - Cantidad: 1
 -HUCDES166 - JERINGADE INSULINA 1 ML - ITEM(169) - Cantidad: 1
 -HUCDES173 - LLAVE DE TRES VIAS - NIPRO - ITEM(176) - Cantidad: 1
 -HUCDES71 - EQUIPO MACROGOTEO - Cantidad: 1
 -IM6235 - Alimento hiperproteico con HMB y Vitamina D ENSURE CLINICAL - Cantidad: 2
 -MasN95 - mascarilla para riesgo bio- N 95 desechables - Cantidad: 1
 -N02AT020701 - Tramadol clorhidrato - Cantidad: 2
 Fecha: 08/04/2022
 -0015 - Jeringa 10 ml- Cantidad: 4
 -10090 - Solucion Salina Normal x 100 ml SSN - Cantidad: 4
 -9851 - Salbutamol sulfato INHALADOR - Cantidad: 1
 -A02BO002101 - Omeprazol - Cantidad: 2
 -A11HP015141 - Piridoxina clorhidrato - Cantidad: 2
 -B01AH003707 - Heparina de bajo peso molecular (Enoxaparina) - Cantidad: 2
 -C03CF017011 - Furosemida - Cantidad: 2
 -HUCCAT41 - CATETER INTRACAT# 22 - Cantidad: 1
 -HUCDES173 - LLAVE DE TRES VIAS - NIPRO - ITEM(176) - Cantidad: 1
 -HUCDES71 - EQUIPO MACROGOTEO - Cantidad: 1
 -IM6235 - Alimento hiperproteico con HMB y Vitamina D ENSURE CLINICAL - Cantidad: 4
 -MasN95 - mascarilla para riesgo bio- N 95 desechables - Cantidad: 2
 -N02AT020701 - Tramadol clorhidrato - Cantidad: 4
 -N02BA001011 - Acetaminofen Tableta - Cantidad: 8
 -R01A017471 - Ipratropio bromuro 20 MCG - Cantidad: 1
 Fecha: 09/02/2022
 -0015 - Jeringa 10 ml- Cantidad: 3
 -10090 - Solucion Salina Normal x 100 ml SSN - Cantidad: 3
 -A02BO002101 - Omeprazol - Cantidad: 1
 -A11HP015141 - Piridoxina clorhidrato - Cantidad: 1
 -B01AH003702 - Heparina de bajo peso molecular (Enoxaparina) - Cantidad: 1
 -IM6235 - Alimento hiperproteico con HMB y Vitamina D ENSURE CLINICAL - Cantidad: 2
 -MasN95 - mascarilla para riesgo bio- N 95 desechables - Cantidad: 1
 -N02BD026701 - Dipirona - Cantidad: 3
 Fecha: 09/03/2022
 -0015 - Jeringa 10 ml- Cantidad: 2
 -10090 - Solucion Salina Normal x 100 ml SSN - Cantidad: 2
 -A02BO002101 - Omeprazol - Cantidad: 1
 -B01AH003707 - Heparina de bajo peso molecular (Enoxaparina) - Cantidad: 1
 -IM6235 - Alimento hiperproteico con HMB y Vitamina D ENSURE CLINICAL - Cantidad: 2
 -MasN95 - mascarilla para riesgo bio- N 95 desechables - Cantidad: 1
 -N02AT020701 - Tramadol clorhidrato - Cantidad: 2
 Fecha: 09/04/2022
 -0015 - Jeringa 10 ml- Cantidad: 2
 -10090 - Solucion Salina Normal x 100 ml SSN - Cantidad: 2
 -A02BO002101 - Omeprazol - Cantidad: 1
 -A11HP015141 - Piridoxina clorhidrato - Cantidad: 1
 -Ag18 - Aguja Hipodermica #18 - Cantidad: 3
 -B01AH003707 - Heparina de bajo peso molecular (Enoxaparina) - Cantidad: 1
 -C03CF017011 - Furosemida - Cantidad: 1
 -HUCCAT41 - CATETER INTRACAT# 22 - Cantidad: 1
 -HUCDES173 - LLAVE DE TRES VIAS - NIPRO - ITEM(176) - Cantidad: 1
 -IM6235 - Alimento hiperproteico con HMB y Vitamina D ENSURE CLINICAL - Cantidad: 6
 -MasN95 - mascarilla para riesgo bio- N 95 desechables - Cantidad: 1
 -N02AT020701 - Tramadol clorhidrato - Cantidad: 2
 -N02BA001011 - Acetaminofen Tableta - Cantidad: 2
 Fecha: 10/02/2022
 -0015 - Jeringa 10 ml- Cantidad: 3
 -10090 - Solucion Salina Normal x 100 ml SSN - Cantidad: 3
 -A02BO002101 - Omeprazol - Cantidad: 1
 -A11HP015141 - Piridoxina clorhidrato - Cantidad: 1

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

-B01AH003702 - Heparina de bajo peso molecular (Enoxaparina) - Cantidad: 2
 -HUCDES200 - TAPABOCAS DESECHABLES - Cantidad: 1
 -IM6235 - Alimento hiperproteico con HMB y Vitamina D ENSURE CLINICAL - Cantidad: 2
 -N02BD026701 - Dipirona - Cantidad: 3
 Fecha: 11/02/2022
 -0015 - Jeringa 10 ml- Cantidad: 2
 -10090 - Solucion Salina Normal x 100 ml SSN - Cantidad: 2
 -B01AH003707 - Heparina de bajo peso molecular (Enoxaparina) - Cantidad: 1
 -HUCDES71 - EQUIPO MACROGOTEO - Cantidad: 1
 -IM6235 - Alimento hiperproteico con HMB y Vitamina D ENSURE CLINICAL - Cantidad: 2
 -MasN95 - mascarilla para riesgo bio- N 95 desechables - Cantidad: 1
 -N02BD026701 - Dipirona - Cantidad: 2
 Fecha: 11/03/2022
 -0001 - Solucion Salina Normal 500 mL SSN- Cantidad: 1
 -0015 - Jeringa 10 ml - Cantidad: 4
 -10090 - Solucion Salina Normal x 100 ml SSN - Cantidad: 4
 -9851 - Salbutamol sulfato INHALADOR - Cantidad: 1
 -A02BO002101 - Omeprazol - Cantidad: 2
 -A11HP015141 - Piridoxina clorhidrato - Cantidad: 2
 -B01AH003707 - Heparina de bajo peso molecular (Enoxaparina) - Cantidad: 2
 -HUCDES71 - EQUIPO MACROGOTEO - Cantidad: 2
 -IM6235 - Alimento hiperproteico con HMB y Vitamina D ENSURE CLINICAL - Cantidad: 4
 -MasN95 - mascarilla para riesgo bio- N 95 desechables - Cantidad: 2
 -N02AT020701 - Tramadol clorhidrato - Cantidad: 4
 Fecha: 11/04/2022
 -0015 - Jeringa 10 ml- Cantidad: 4
 -10090 - Solucion Salina Normal x 100 ml SSN - Cantidad: 4
 -A02BO002101 - Omeprazol - Cantidad: 2
 -A11HP015141 - Piridoxina clorhidrato - Cantidad: 2
 -B01AH003707 - Heparina de bajo peso molecular (Enoxaparina) - Cantidad: 2
 -C03CF017011 - Furosemida - Cantidad: 2
 -HUCDES71 - EQUIPO MACROGOTEO - Cantidad: 1
 -HUCTR13 - CANULA NASAL DE OXIGENO CON ADAPTADOR UNIVERSAL Y EXTENSION DE 2MTS ADULTO - INTERSURGICAL - ITEM(13) - Cantidad: 1
 -HUCTR41 - HUMIDIFICADORES TAPA VERDE - OXITEC - ITEM(41) - Cantidad: 1
 -MasN95 - mascarilla para riesgo bio- N 95 desechables - Cantidad: 2
 -N02AT020701 - Tramadol clorhidrato - Cantidad: 4
 -N02BA001011 - Acetaminofen Tableta - Cantidad: 4
 Fecha: 12/01/2022
 -0006 - Lactato de Ringer (Hartman) x500 LR- Cantidad: 1
 -N02BA001011 - Acetaminofen Tableta - Cantidad: 6
 -R01A017471 - Ipratropio bromuro 20 MCG - Cantidad: 4
 Fecha: 12/02/2022
 -0015 - Jeringa 10 ml- Cantidad: 2
 -10090 - Solucion Salina Normal x 100 ml SSN - Cantidad: 2
 -A02BO002101 - Omeprazol - Cantidad: 1
 -A11HP015141 - Piridoxina clorhidrato - Cantidad: 1
 -B01AH003702 - Heparina de bajo peso molecular (Enoxaparina) - Cantidad: 2
 -N02BD026701 - Dipirona - Cantidad: 2
 Fecha: 12/03/2022
 -0015 - Jeringa 10 ml- Cantidad: 2
 -10090 - Solucion Salina Normal x 100 ml SSN - Cantidad: 2
 -A02BO002101 - Omeprazol - Cantidad: 1
 -A11HP015141 - Piridoxina clorhidrato - Cantidad: 1
 -B01AH003707 - Heparina de bajo peso molecular (Enoxaparina) - Cantidad: 1
 -HUCCAT40 - CATETER INTRACAT # 20 - Cantidad: 1
 -HUCDES162 - JERINGA 5 ML - Cantidad: 1
 -HUCDES173 - LLAVE DE TRES VIAS - NIPRO - ITEM(176) - Cantidad: 1
 -IM6235 - Alimento hiperproteico con HMB y Vitamina D ENSURE CLINICAL - Cantidad: 6
 -MasN95 - mascarilla para riesgo bio- N 95 desechables - Cantidad: 1
 -N02AT020701 - Tramadol clorhidrato - Cantidad: 2
 Fecha: 13/01/2022
 -0006 - Lactato de Ringer (Hartman) x500 LR- Cantidad: 3
 -0015 - Jeringa 10 ml - Cantidad: 2
 -10090 - Solucion Salina Normal x 100 ml SSN - Cantidad: 2
 -20019 - Electrodo Adultos - Cantidad: 5
 -HUCDES173 - LLAVE DE TRES VIAS - NIPRO - ITEM(176) - Cantidad: 1
 -HUCDES189 - RECOLECTOR DE ORINA ADULTO - RYMCO - ITEM(195) - Cantidad: 4
 -HUCDES200 - TAPABOCAS DESECHABLES - Cantidad: 1
 -HUCDES201 - TAPON VENOSO HEPARINIZADO - Cantidad: 1
 -HUCDES71 - EQUIPO MACROGOTEO - Cantidad: 1
 -HUCTR13 - CANULA NASAL DE OXIGENO CON ADAPTADOR UNIVERSAL Y EXTENSION DE 2MTS ADULTO - INTERSURGICAL - ITEM(13) - Cantidad: 1
 -HUCTR41 - HUMIDIFICADORES TAPA VERDE - OXITEC - ITEM(41) - Cantidad: 1
 -MasN95 - mascarilla para riesgo bio- N 95 desechables - Cantidad: 3
 -N02AT020701 - Tramadol clorhidrato - Cantidad: 2
 Fecha: 13/04/2022
 -0015 - Jeringa 10 ml- Cantidad: 2
 -10090 - Solucion Salina Normal x 100 ml SSN - Cantidad: 2
 -A02BO002101 - Omeprazol - Cantidad: 2

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

-A11HP015141 - Piridoxina clorhidrato - Cantidad: 2
 -B01AH003707 - Heparina de bajo peso molecular (Enoxaparina) - Cantidad: 2
 -C03CF017011 - Furosemida - Cantidad: 2
 -HUCDES71 - EQUIPO MACROGOTEO - Cantidad: 1
 -IM6235 - Alimento hiperproteico con HMB y Vitamina D ENSURE CLINICAL - Cantidad: 4
 -MasN95 - mascarilla para riesgo bio- N 95 desechables - Cantidad: 2
 -N02AT020701 - Tramadol clorhidrato - Cantidad: 4
 -N02BA001011 - Acetaminofen Tableta - Cantidad: 4
 Fecha: 14/01/2022
 -0006 - Lactato de Ringer (Hartman) x500 LR- Cantidad: 4
 -HUCDES189 - RECOLECTOR DE ORINA ADULTO - RYMCO - ITEM(195) - Cantidad: 2
 -HUCDES71 - EQUIPO MACROGOTEO - Cantidad: 1
 -MasN95 - mascarilla para riesgo bio- N 95 desechables - Cantidad: 1
 Fecha: 14/02/2022
 -0015 - Jeringa 10 ml- Cantidad: 6
 -10090 - Solucion Salina Normal x 100 ml SSN - Cantidad: 6
 -A02BO002101 - Omeprazol - Cantidad: 2
 -A11HP015141 - Piridoxina clorhidrato - Cantidad: 2
 -B01AH003707 - Heparina de bajo peso molecular (Enoxaparina) - Cantidad: 2
 -HUCCAT40 - CATETER INTRACAT # 20 - Cantidad: 1
 -HUCDES162 - JERINGA 5 ML - Cantidad: 1
 -HUCDES173 - LLAVE DE TRES VIAS - NIPRO - ITEM(176) - Cantidad: 1
 -HUCDES200 - TAPABOCAS DESECHABLES - Cantidad: 1
 -HUCDES71 - EQUIPO MACROGOTEO - Cantidad: 1
 -HUCTR43 - KIT VENTURY ADULTO - Cantidad: 1
 -IM6235 - Alimento hiperproteico con HMB y Vitamina D ENSURE CLINICAL - Cantidad: 6
 -MasN95 - mascarilla para riesgo bio- N 95 desechables - Cantidad: 1
 -N02BD026701 - Dipirona - Cantidad: 4
 Fecha: 14/03/2022
 -0015 - Jeringa 10 ml- Cantidad: 7
 -10090 - Solucion Salina Normal x 100 ml SSN - Cantidad: 7
 -A02BO002101 - Omeprazol - Cantidad: 2
 -A11HP015141 - Piridoxina clorhidrato - Cantidad: 2
 -B01AH003707 - Heparina de bajo peso molecular (Enoxaparina) - Cantidad: 2
 -H02AM013721 - Metilprednisolona succinato sódico - Cantidad: 1
 -HUCDES200 - TAPABOCAS DESECHABLES - Cantidad: 1
 -HUCDES71 - EQUIPO MACROGOTEO - Cantidad: 1
 -N02AT020701 - Tramadol clorhidrato - Cantidad: 4
 Fecha: 15/01/2022
 -HUCCAT39 - CATETER INTRACAT # 18 - Cantidad: 2
 -HUCDES173 - LLAVE DE TRES VIAS - NIPRO - ITEM(176) - Cantidad: 1
 -HUCDES201 - TAPON VENOSO HEPARINIZADO - Cantidad: 1
 -MasN95 - mascarilla para riesgo bio- N 95 desechables - Cantidad: 1
 Fecha: 15/02/2022
 -0015 - Jeringa 10 ml- Cantidad: 3
 -10090 - Solucion Salina Normal x 100 ml SSN - Cantidad: 3
 -A02BO002101 - Omeprazol - Cantidad: 1
 -A11HP015141 - Piridoxina clorhidrato - Cantidad: 1
 -B01AH003707 - Heparina de bajo peso molecular (Enoxaparina) - Cantidad: 1
 -HUCTR43 - KIT VENTURY ADULTO - Cantidad: 1
 -IM6235 - Alimento hiperproteico con HMB y Vitamina D ENSURE CLINICAL - Cantidad: 2
 -N02BD026701 - Dipirona - Cantidad: 3
 Fecha: 15/03/2022
 -10090 - Solucion Salina Normal x 100 ml SSN- Cantidad: 4
 -A02BO002101 - Omeprazol - Cantidad: 1
 -A11HP015141 - Piridoxina clorhidrato - Cantidad: 1
 -B01AH003707 - Heparina de bajo peso molecular (Enoxaparina) - Cantidad: 1
 -HUCCAT40 - CATETER INTRACAT # 20 - Cantidad: 1
 -HUCDES162 - JERINGA 5 ML - Cantidad: 1
 -HUCDES173 - LLAVE DE TRES VIAS - NIPRO - ITEM(176) - Cantidad: 1
 -HUCTR53 - MASCARA DE OXIGENO CON BOLSA DE RESERVORIO - GLOBAL HEALTH CARE - ITEM(53) - Cantidad: 1
 -IM6235 - Alimento hiperproteico con HMB y Vitamina D ENSURE CLINICAL - Cantidad: 2
 -N02AT020701 - Tramadol clorhidrato - Cantidad: 2
 Fecha: 16/01/2022
 -R01A017471 - Ipratropio bromuro 20 MCG- Cantidad: 1
 Fecha: 16/02/2022
 -0015 - Jeringa 10 ml- Cantidad: 3
 -10090 - Solucion Salina Normal x 100 ml SSN - Cantidad: 3
 -A02BO002101 - Omeprazol - Cantidad: 1
 -A11HP015141 - Piridoxina clorhidrato - Cantidad: 1
 -B01AH003707 - Heparina de bajo peso molecular (Enoxaparina) - Cantidad: 1
 -HUCCAT40 - CATETER INTRACAT # 20 - Cantidad: 1
 -HUCDES162 - JERINGA 5 ML - Cantidad: 1
 -HUCDES173 - LLAVE DE TRES VIAS - NIPRO - ITEM(176) - Cantidad: 1
 -IM6235 - Alimento hiperproteico con HMB y Vitamina D ENSURE CLINICAL - Cantidad: 2
 -MasN95 - mascarilla para riesgo bio- N 95 desechables - Cantidad: 1
 Fecha: 17/01/2022
 -A02BO002101 - Omeprazol - Cantidad: 1

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

-H02AH008721 - Hidrocortisona sódico - Cantidad: 1
 -MasN95 - mascarilla para riesgo bio- N 95 desechables - Cantidad: 1
 Fecha: 17/02/2022
 -0015 - Jeringa 10 ml- Cantidad: 3
 -10090 - Solucion Salina Normal x 100 ml SSN - Cantidad: 3
 -A02BO002101 - Omeprazol - Cantidad: 1
 -A11HP015141 - Piridoxina clorhidrato - Cantidad: 1
 -B01AH003707 - Heparina de bajo peso molecular (Enoxaparina) - Cantidad: 1
 -HUCDES71 - EQUIPO MACROGOTEO - Cantidad: 1
 -IM6235 - Alimento hiperproteico con HMB y Vitamina D ENSURE CLINICAL - Cantidad: 2
 -MasN95 - mascarilla para riesgo bio- N 95 desechables - Cantidad: 1
 Fecha: 17/03/2022
 -10090 - Solucion Salina Normal x 100 ml SSN- Cantidad: 4
 -A02BO002101 - Omeprazol - Cantidad: 2
 -A11HP015141 - Piridoxina clorhidrato - Cantidad: 2
 -Ag16 - Aguja Hipodermica # 16 - Cantidad: 3
 -B01AH003707 - Heparina de bajo peso molecular (Enoxaparina) - Cantidad: 2
 -C03CF017701 - Furosemida - Cantidad: 6
 -H02AP027011 - Prednisolona - Cantidad: 16
 -HUCDES160 - JERINGA 20 CC - Cantidad: 10
 -HUCDES71 - EQUIPO MACROGOTEO - Cantidad: 1
 -IM6235 - Alimento hiperproteico con HMB y Vitamina D ENSURE CLINICAL - Cantidad: 4
 -MasN95 - mascarilla para riesgo bio- N 95 desechables - Cantidad: 2
 -N02AT020701 - Tramadol clorhidrato - Cantidad: 4
 Fecha: 18/01/2022
 -A02BO002101 - Omeprazol - Cantidad: 2
 -HUCCAT40 - CATETER INTRACAT # 20 - Cantidad: 1
 -HUCDES173 - LLAVE DE TRES VIAS - NIPRO - ITEM(176) - Cantidad: 1
 -N02BD026701 - Dipirona - Cantidad: 3
 Fecha: 18/02/2022
 -0015 - Jeringa 10 ml- Cantidad: 3
 -10090 - Solucion Salina Normal x 100 ml SSN - Cantidad: 3
 -A02BO002101 - Omeprazol - Cantidad: 1
 -A11HP015141 - Piridoxina clorhidrato - Cantidad: 1
 -B01AH003707 - Heparina de bajo peso molecular (Enoxaparina) - Cantidad: 1
 -HUCTR43 - KIT VENTURY ADULTO - Cantidad: 1
 -IM6235 - Alimento hiperproteico con HMB y Vitamina D ENSURE CLINICAL - Cantidad: 2
 -MasN95 - mascarilla para riesgo bio- N 95 desechables - Cantidad: 1
 -N02AT020701 - Tramadol clorhidrato - Cantidad: 3
 Fecha: 18/03/2022
 -0001 - Solucion Salina Normal 500 mL SSN- Cantidad: 1
 -A02BO002101 - Omeprazol - Cantidad: 1
 -A11HP015141 - Piridoxina clorhidrato - Cantidad: 1
 -B01AH003707 - Heparina de bajo peso molecular (Enoxaparina) - Cantidad: 1
 -C03CF017701 - Furosemida - Cantidad: 3
 -H02AP027011 - Prednisolona - Cantidad: 8
 -HUCDES160 - JERINGA 20 CC - Cantidad: 1
 -HUCDES162 - JERINGA 5 ML - Cantidad: 1
 -HUCDES173 - LLAVE DE TRES VIAS - NIPRO - ITEM(176) - Cantidad: 1
 -HUCDES44 - BURETROL - Cantidad: 1
 -IM6235 - Alimento hiperproteico con HMB y Vitamina D ENSURE CLINICAL - Cantidad: 2
 -MasN95 - mascarilla para riesgo bio- N 95 desechables - Cantidad: 1
 -N02AT020701 - Tramadol clorhidrato - Cantidad: 3
 Fecha: 19/02/2022
 -0015 - Jeringa 10 ml- Cantidad: 1
 -HUCCAT40 - CATETER INTRACAT # 20 - Cantidad: 1
 -HUCDES173 - LLAVE DE TRES VIAS - NIPRO - ITEM(176) - Cantidad: 1
 Fecha: 19/03/2022
 -0015 - Jeringa 10 ml- Cantidad: 5
 -10090 - Solucion Salina Normal x 100 ml SSN - Cantidad: 2
 -A02BO002101 - Omeprazol - Cantidad: 1
 -A11HP015141 - Piridoxina clorhidrato - Cantidad: 1
 -B01AH003707 - Heparina de bajo peso molecular (Enoxaparina) - Cantidad: 1
 -C03CF017701 - Furosemida - Cantidad: 3
 -H02AP027011 - Prednisolona - Cantidad: 8
 -HUCDES71 - EQUIPO MACROGOTEO - Cantidad: 1
 -IM6235 - Alimento hiperproteico con HMB y Vitamina D ENSURE CLINICAL - Cantidad: 6
 -N02AT020701 - Tramadol clorhidrato - Cantidad: 2
 Fecha: 21/01/2022
 -9851 - Salbutamol sulfato INHALADOR- Cantidad: 1
 Fecha: 21/02/2022
 -0015 - Jeringa 10 ml- Cantidad: 3
 -10090 - Solucion Salina Normal x 100 ml SSN - Cantidad: 6
 -A02BO002101 - Omeprazol - Cantidad: 2
 -A11HP015141 - Piridoxina clorhidrato - Cantidad: 2
 -B01AH003702 - Heparina de bajo peso molecular (Enoxaparina) - Cantidad: 4
 -HUCDES200 - TAPABOCAS DESECHABLES - Cantidad: 1
 -HUCDES71 - EQUIPO MACROGOTEO - Cantidad: 1

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

-MasN95 - mascarilla para riesgo bio- N 95 desechables - Cantidad: 1
 -N02AT020701 - Tramadol clorhidrato - Cantidad: 6
 Fecha: 22/01/2022
 -0001 - Solucion Salina Normal 500 mL SSN- Cantidad: 1
 -0015 - Jeringa 10 ml - Cantidad: 1
 -H02AM013721 - Metilprednisolona succinato sódico - Cantidad: 1
 -HUCTR53 - MASCARA DE OXIGENO CON BOLSA DE RESERVORIO - GLOBAL HEALTH CARE - ITEM(53) - Cantidad: 1
 -HUCTR72 - RACOR UNIVERSAL MH - LM INSTRUMENT - ITEM(72) - Cantidad: 1
 Fecha: 22/02/2022
 -0001 - Solucion Salina Normal 500 mL SSN- Cantidad: 4
 -0015 - Jeringa 10 ml - Cantidad: 8
 -10090 - Solucion Salina Normal x 100 ml SSN - Cantidad: 8
 -A02BO002101 - Omeprazol - Cantidad: 2
 -A11HP015141 - Piridoxina clorhidrato - Cantidad: 2
 -B01AH003702 - Heparina de bajo peso molecular (Enoxaparina) - Cantidad: 2
 -HUCCAT39 - CATETER INTRACAT # 18 - Cantidad: 1
 -HUCCAT40 - CATETER INTRACAT # 20 - Cantidad: 1
 -HUCCAT41 - CATETER INTRACAT# 22 - Cantidad: 1
 -HUCDES162 - JERINGA 5 ML - Cantidad: 3
 -HUCDES173 - LLAVE DE TRES VIAS - NIPRO - ITEM(176) - Cantidad: 4
 -HUCDES71 - EQUIPO MACROGOTEO - Cantidad: 3
 -HUCTR43 - KIT VENTURY ADULTO - Cantidad: 1
 -IM6235 - Alimento hiperproteico con HMB y Vitamina D ENSURE CLINICAL - Cantidad: 8
 -IM6349 - MASCARILLA CON RESERVORIO PARA OXIGENO PEDIATRICO - Cantidad: 1
 -MasN95 - mascarilla para riesgo bio- N 95 desechables - Cantidad: 1
 -N02AT020701 - Tramadol clorhidrato - Cantidad: 6
 -N02BD026701 - Dipirona - Cantidad: 4
 Fecha: 22/03/2022
 -0015 - Jeringa 10 ml- Cantidad: 15
 -10090 - Solucion Salina Normal x 100 ml SSN - Cantidad: 6
 -A02BO002101 - Omeprazol - Cantidad: 3
 -A11HP015141 - Piridoxina clorhidrato - Cantidad: 3
 -B01AH003707 - Heparina de bajo peso molecular (Enoxaparina) - Cantidad: 3
 -C03CF017701 - Furosemida - Cantidad: 7
 -H02AP027011 - Prednisolona - Cantidad: 24
 -HUCCAT40 - CATETER INTRACAT # 20 - Cantidad: 1
 -HUCDES162 - JERINGA 5 ML - Cantidad: 1
 -HUCDES173 - LLAVE DE TRES VIAS - NIPRO - ITEM(176) - Cantidad: 1
 -HUCDES71 - EQUIPO MACROGOTEO - Cantidad: 1
 -HUCTR43 - KIT VENTURY ADULTO - Cantidad: 1
 -IM6235 - Alimento hiperproteico con HMB y Vitamina D ENSURE CLINICAL - Cantidad: 2
 -MasN95 - mascarilla para riesgo bio- N 95 desechables - Cantidad: 1
 -N02AT020701 - Tramadol clorhidrato - Cantidad: 6
 -N02BA001011 - Acetaminofen Tableta - Cantidad: 12
 Fecha: 23/01/2022
 -R01A017471 - Ipratropio bromuro 20 MCG- Cantidad: 1
 Fecha: 23/02/2022
 -A02BO002101 - Omeprazol - Cantidad: 1
 -A11HP015141 - Piridoxina clorhidrato - Cantidad: 1
 -HUCTR41 - HUMIDIFICADORES TAPA VERDE - OXITEC - ITEM(41) - Cantidad: 1
 -IM6235 - Alimento hiperproteico con HMB y Vitamina D ENSURE CLINICAL - Cantidad: 2
 -MasN95 - mascarilla para riesgo bio- N 95 desechables - Cantidad: 1
 -N02AT020701 - Tramadol clorhidrato - Cantidad: 3
 Fecha: 23/03/2022
 -0015 - Jeringa 10 ml- Cantidad: 2
 -10090 - Solucion Salina Normal x 100 ml SSN - Cantidad: 2
 -A02BO002101 - Omeprazol - Cantidad: 1
 -A11HP015141 - Piridoxina clorhidrato - Cantidad: 1
 -B01AH003707 - Heparina de bajo peso molecular (Enoxaparina) - Cantidad: 1
 -C03CF017701 - Furosemida - Cantidad: 3
 -H02AP027011 - Prednisolona - Cantidad: 8
 -HUCCAT40 - CATETER INTRACAT # 20 - Cantidad: 1
 -HUCDES162 - JERINGA 5 ML - Cantidad: 1
 -HUCDES173 - LLAVE DE TRES VIAS - NIPRO - ITEM(176) - Cantidad: 1
 -IM6235 - Alimento hiperproteico con HMB y Vitamina D ENSURE CLINICAL - Cantidad: 2
 -MasN95 - mascarilla para riesgo bio- N 95 desechables - Cantidad: 1
 -N02AT020701 - Tramadol clorhidrato - Cantidad: 2
 -N02BA001011 - Acetaminofen Tableta - Cantidad: 6
 Fecha: 24/01/2022
 -0001 - Solucion Salina Normal 500 mL SSN- Cantidad: 7
 -0006 - Lactato de Ringer (Hartman) x500 LR - Cantidad: 4
 -0009 - Agua Destilada 500 API - Cantidad: 1
 -0015 - Jeringa 10 ml - Cantidad: 25
 -10055 - PIPERACILINA + TAZOBACTAM- Cantidad: 8
 -10090 - Solucion Salina Normal x 100 ml SSN - Cantidad: 13
 -A02BO002101 - Omeprazol - Cantidad: 5
 -A11HP015141 - Piridoxina clorhidrato - Cantidad: 1
 -Ag18 - Aguja Hipodermica #18 - Cantidad: 2

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

-HUCCAT41 - CATETER INTRACAT# 22 - Cantidad: 1
 -HUCDES173 - LLAVE DE TRES VIAS - NIPRO - ITEM(176) - Cantidad: 1
 -HUCDES71 - EQUIPO MACROGOTEO - Cantidad: 1
 -HUCTR13 - CANULA NASAL DE OXIGENO CON ADAPTADOR UNIVERSAL Y EXTENSION DE 2MTS ADULTO - INTERSURGICAL - ITEM(13) - Cantidad: 2
 -HUCTR41 - HUMIDIFICADORES TAPA VERDE - OXITEC - ITEM(41) - Cantidad: 2
 -J01FC046721 - Claritromicina - Cantidad: 4
 -MasN95 - mascarilla para riesgo bio- N 95 desechables - Cantidad: 4
 -N02BD026701 - Dipirona - Cantidad: 14
 Fecha: 24/02/2022
 -0015 - Jeringa 10 ml- Cantidad: 3
 -10090 - Solucion Salina Normal x 100 ml SSN - Cantidad: 3
 -9851 - Salbutamol sulfato INHALADOR - Cantidad: 1
 -A02BO002101 - Omeprazol - Cantidad: 1
 -A11HP015141 - Piridoxina clorhidrato - Cantidad: 1
 -IM6235 - Alimento hiperproteico con HMB y Vitamina D ENSURE CLINICAL - Cantidad: 2
 -MasN95 - mascarilla para riesgo bio- N 95 desechables - Cantidad: 1
 -N02AT020701 - Tramadol clorhidrato - Cantidad: 3
 Fecha: 24/03/2022
 -0015 - Jeringa 10 ml- Cantidad: 2
 -10090 - Solucion Salina Normal x 100 ml SSN - Cantidad: 2
 -A02BO002101 - Omeprazol - Cantidad: 1
 -A11HP015141 - Piridoxina clorhidrato - Cantidad: 1
 -B01AH003707 - Heparina de bajo peso molecular (Enoxaparina) - Cantidad: 1
 -C03CF017701 - Furosemida - Cantidad: 3
 -H02AP027011 - Prednisolona - Cantidad: 5
 -IM6235 - Alimento hiperproteico con HMB y Vitamina D ENSURE CLINICAL - Cantidad: 2
 -MasN95 - mascarilla para riesgo bio- N 95 desechables - Cantidad: 1
 -N02AT020701 - Tramadol clorhidrato - Cantidad: 2
 Fecha: 25/01/2022
 -0006 - Lactato de Ringer (Hartman) x500 LR- Cantidad: 2
 -0015 - Jeringa 10 ml - Cantidad: 9
 -10055 - PIPERACILINA + TAZOBACTAM- Cantidad: 4
 -10090 - Solucion Salina Normal x 100 ml SSN - Cantidad: 7
 -A02BO002101 - Omeprazol - Cantidad: 1
 -A11HP015141 - Piridoxina clorhidrato - Cantidad: 1
 -Ag18 - Aguja Hipodermica #18 - Cantidad: 6
 -HUCCAT41 - CATETER INTRACAT# 22 - Cantidad: 1
 -HUCDES162 - JERINGA 5 ML - Cantidad: 1
 -HUCDES173 - LLAVE DE TRES VIAS - NIPRO - ITEM(176) - Cantidad: 1
 -J01FC046721 - Claritromicina - Cantidad: 2
 -MasN95 - mascarilla para riesgo bio- N 95 desechables - Cantidad: 1
 -N02BD026701 - Dipirona - Cantidad: 3
 Fecha: 25/02/2022
 -0015 - Jeringa 10 ml- Cantidad: 4
 -10090 - Solucion Salina Normal x 100 ml SSN - Cantidad: 3
 -A02BO002101 - Omeprazol - Cantidad: 1
 -A11HP015141 - Piridoxina clorhidrato - Cantidad: 1
 -HUCCAT40 - CATETER INTRACAT # 20 - Cantidad: 1
 -HUCDES173 - LLAVE DE TRES VIAS - NIPRO - ITEM(176) - Cantidad: 1
 -HUCDES71 - EQUIPO MACROGOTEO - Cantidad: 1
 -HUCTR13 - CANULA NASAL DE OXIGENO CON ADAPTADOR UNIVERSAL Y EXTENSION DE 2MTS ADULTO - INTERSURGICAL - ITEM(13) - Cantidad: 1
 -HUCTR41 - HUMIDIFICADORES TAPA VERDE - OXITEC - ITEM(41) - Cantidad: 1
 -IM6235 - Alimento hiperproteico con HMB y Vitamina D ENSURE CLINICAL - Cantidad: 2
 -MasN95 - mascarilla para riesgo bio- N 95 desechables - Cantidad: 1
 -N02AT020701 - Tramadol clorhidrato - Cantidad: 3
 Fecha: 26/01/2022
 -0001 - Solucion Salina Normal 500 mL SSN- Cantidad: 1
 -0006 - Lactato de Ringer (Hartman) x500 LR - Cantidad: 2
 -0015 - Jeringa 10 ml - Cantidad: 9
 -10055 - PIPERACILINA + TAZOBACTAM- Cantidad: 4
 -10090 - Solucion Salina Normal x 100 ml SSN - Cantidad: 7
 -A02BO002101 - Omeprazol - Cantidad: 1
 -A11HP015141 - Piridoxina clorhidrato - Cantidad: 1
 -HUCDES71 - EQUIPO MACROGOTEO - Cantidad: 1
 -J01FC046721 - Claritromicina - Cantidad: 2
 -MasN95 - mascarilla para riesgo bio- N 95 desechables - Cantidad: 1
 -N02BD026701 - Dipirona - Cantidad: 3
 Fecha: 26/02/2022
 -0015 - Jeringa 10 ml- Cantidad: 3
 -10090 - Solucion Salina Normal x 100 ml SSN - Cantidad: 3
 -A02BO002101 - Omeprazol - Cantidad: 1
 -A11HP015141 - Piridoxina clorhidrato - Cantidad: 1
 -B01AH003704 - DALTEPARINA SODICA (Heparina de bajo peso molecular) - Cantidad: 1
 -HUCDES71 - EQUIPO MACROGOTEO - Cantidad: 1
 -HUCTR13 - CANULA NASAL DE OXIGENO CON ADAPTADOR UNIVERSAL Y EXTENSION DE 2MTS ADULTO - INTERSURGICAL - ITEM(13) - Cantidad: 1
 -HUCTR41 - HUMIDIFICADORES TAPA VERDE - OXITEC - ITEM(41) - Cantidad: 1
 -IM6235 - Alimento hiperproteico con HMB y Vitamina D ENSURE CLINICAL - Cantidad: 6
 -N02AT020701 - Tramadol clorhidrato - Cantidad: 3

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

Fecha: 27/01/2022

-0006 - Lactato de Ringer (Hartman) x500 LR- Cantidad: 2
 -0015 - Jeringa 10 ml - Cantidad: 8
 -10055 - PIPERACILINA + TAZOBACTAM- Cantidad: 4
 -10090 - Solucion Salina Normal x 100 ml SSN - Cantidad: 6
 -A11HP015141 - Piridoxina clorhidrato - Cantidad: 1
 -HUCCAT40 - CATETER INTRACAT # 20 - Cantidad: 1
 -HUCDES162 - JERINGA 5 ML - Cantidad: 1
 -HUCDES173 - LLAVE DE TRES VIAS - NIPRO - ITEM(176) - Cantidad: 1
 -HUCDES71 - EQUIPO MACROGOTEO - Cantidad: 1
 -HUCTR53 - MASCARA DE OXIGENO CON BOLSA DE RESERVORIO - GLOBAL HEALTH CARE - ITEM(53) - Cantidad: 1
 -J01FC046721 - Claritromicina - Cantidad: 2
 -N02BD026701 - Dipirona - Cantidad: 2

Fecha: 28/01/2022

-0006 - Lactato de Ringer (Hartman) x500 LR- Cantidad: 2
 -0015 - Jeringa 10 ml - Cantidad: 9
 -10055 - PIPERACILINA + TAZOBACTAM- Cantidad: 4
 -10090 - Solucion Salina Normal x 100 ml SSN - Cantidad: 7
 -A02BO002101 - Omeprazol - Cantidad: 1
 -A11HP015141 - Piridoxina clorhidrato - Cantidad: 1
 -HUCDES71 - EQUIPO MACROGOTEO - Cantidad: 1
 -HUCTR43 - KIT VENTURY ADULTO - Cantidad: 1
 -J01FC046721 - Claritromicina - Cantidad: 2
 -MasN95 - mascarilla para riesgo bio- N 95 desechables - Cantidad: 1
 -N02BD026701 - Dipirona - Cantidad: 3

Fecha: 28/02/2022

-0002 - Solucion Salina Normal 250 ML SSN- Cantidad: 3
 -0015 - Jeringa 10 ml - Cantidad: 3
 -10090 - Solucion Salina Normal x 100 ml SSN - Cantidad: 3
 -A02BO002101 - Omeprazol - Cantidad: 2
 -A11HP015141 - Piridoxina clorhidrato - Cantidad: 2
 -Ag16 - Aguja Hipodermica # 16 - Cantidad: 2
 -B01AH003704 - DALTEPARINA SODICA (Heparina de bajo peso molecular) - Cantidad: 2
 -HUCCAT40 - CATETER INTRACAT # 20 - Cantidad: 1
 -HUCDES162 - JERINGA 5 ML - Cantidad: 5
 -HUCDES173 - LLAVE DE TRES VIAS - NIPRO - ITEM(176) - Cantidad: 1
 -MasN95 - mascarilla para riesgo bio- N 95 desechables - Cantidad: 2
 -N02AT020701 - Tramadol clorhidrato - Cantidad: 6

Fecha: 28/03/2022

-0015 - Jeringa 10 ml- Cantidad: 17
 -10090 - Solucion Salina Normal x 100 ml SSN - Cantidad: 8
 -A02BO002101 - Omeprazol - Cantidad: 2
 -A11HP015141 - Piridoxina clorhidrato - Cantidad: 4
 -B01AH003707 - Heparina de bajo peso molecular (Enoxaparina) - Cantidad: 4
 -C03CF017701 - Furosemda - Cantidad: 12
 -H02AP027011 - Prednisolona - Cantidad: 8
 -HUCCAT40 - CATETER INTRACAT # 20 - Cantidad: 1
 -HUCDES162 - JERINGA 5 ML - Cantidad: 1
 -HUCDES173 - LLAVE DE TRES VIAS - NIPRO - ITEM(176) - Cantidad: 1
 -HUCDES189 - RECOLECTOR DE ORINA ADULTO - RYMCO - ITEM(195) - Cantidad: 3
 -HUCDES71 - EQUIPO MACROGOTEO - Cantidad: 1
 -HUCTR13 - CANULA NASAL DE OXIGENO CON ADAPTADOR UNIVERSAL Y EXTENSION DE 2MTS ADULTO - INTERSURGICAL - ITEM(13) - Cantidad: 1
 -HUCTR41 - HUMIDIFICADORES TAPA VERDE - OXITEC - ITEM(41) - Cantidad: 1
 -HUCTR43 - KIT VENTURY ADULTO - Cantidad: 1
 -IM6235 - Alimento hiperproteico con HMB y Vitamina D ENSURE CLINICAL - Cantidad: 8
 -MasN95 - mascarilla para riesgo bio- N 95 desechables - Cantidad: 4
 -N02AT020701 - Tramadol clorhidrato - Cantidad: 8
 -N02BA001011 - Acetaminofen Tableta - Cantidad: 24

Fecha: 29/01/2022

-0006 - Lactato de Ringer (Hartman) x500 LR- Cantidad: 2
 -0015 - Jeringa 10 ml - Cantidad: 9
 -10055 - PIPERACILINA + TAZOBACTAM- Cantidad: 4
 -10090 - Solucion Salina Normal x 100 ml SSN - Cantidad: 7
 -A02BO002101 - Omeprazol - Cantidad: 1
 -A11HP015141 - Piridoxina clorhidrato - Cantidad: 1
 -J01FC046721 - Claritromicina - Cantidad: 2
 -MasN95 - mascarilla para riesgo bio- N 95 desechables - Cantidad: 1
 -N02BD026701 - Dipirona - Cantidad: 3

Fecha: 30/03/2022

-0015 - Jeringa 10 ml- Cantidad: 7
 -10090 - Solucion Salina Normal x 100 ml SSN - Cantidad: 4
 -A02BO002101 - Omeprazol - Cantidad: 2
 -B01AH003707 - Heparina de bajo peso molecular (Enoxaparina) - Cantidad: 2
 -C03CF017701 - Furosemda - Cantidad: 6
 -HUCCAT40 - CATETER INTRACAT # 20 - Cantidad: 1
 -HUCDES173 - LLAVE DE TRES VIAS - NIPRO - ITEM(176) - Cantidad: 1
 -HUCDES44 - BURETROL - Cantidad: 1
 -HUCDES71 - EQUIPO MACROGOTEO - Cantidad: 1

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

-HUCTR13 - CANULA NASAL DE OXIGENO CON ADAPTADOR UNIVERSAL Y EXTENSION DE 2MTS ADULTO - INTERSURGICAL - ITEM(13) - Cantidad: 1
 -HUCTR41 - HUMIDIFICADORES TAPA VERDE - OXITEC - ITEM(41) - Cantidad: 1
 -IN6235 - Alimento hiperproteico con HMB y Vitamina D ENSURE CLINICAL - Cantidad: 4
 -MasN95 - mascarilla para riesgo bio- N 95 desechables - Cantidad: 1
 -N02BA001011 - Acetaminofen Tableta - Cantidad: 12
 Fecha: 31/01/2022
 -0006 - Lactato de Ringer (Hartman) x500 LR- Cantidad: 2
 -0015 - Jeringa 10 ml - Cantidad: 7
 -10055 - PIPERACILINA + TAZOBACTAM - Cantidad: 4
 -10090 - Solucion Salina Normal x 100 ml SSN - Cantidad: 5
 -A02BO002101 - Omeprazol - Cantidad: 1
 -A11HP015141 - Piridoxina clorhidrato - Cantidad: 1
 -Ag18 - Aguja Hipodermica #18 - Cantidad: 2
 -HUCCAT40 - CATETER INTRACAT # 20 - Cantidad: 1
 -HUCDES162 - JERINGA 5 ML - Cantidad: 1
 -HUCDES173 - LLAVE DE TRES VIAS - NIPRO - ITEM(176) - Cantidad: 1
 -HUCDES71 - EQUIPO MACROGOTEO - Cantidad: 1
 -J01FC046721 - Claritromicina - Cantidad: 2
 -MasN95 - mascarilla para riesgo bio- N 95 desechables - Cantidad: 1

Medidas Generales Ordenadas:

Fecha: 01/02/2022

Indicaciones:

HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA

DIETA NORMAL

MASCARILLA N95 PERMANENTE

TAPON VENOSO

ASLAMENTO RESPIRATORIO

MASCARA DE NO REINHALACION A 10 LTS/MIN, PASAR A VENTURY**EN DESTETE**

DIPIRONA 1 GR IV CADA 8 HORAS POR RAZON NECESARIA

RIPE 4 TAB VO CADA 24 HORAS FECHA DE SOLICITUD 16/01/22, FECHA DE INICIO: 26/01/22 D5

PIRIDOXINA TAB 50 MG VO. DAR 1 TAB CADA 24 H

FORMULA MAGISTRAL: NISTATINA 100.000 UI (5CC) + LIDOCAINA AL 2% JALEA 10 GR (5CC) + HIDROXIDO DE ALUMINIO (5 CC)

REALIZAR LIMPIEZA DE LESIONES CON GASA Y GARGARAS CADA 6 HORAS.

SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 6 HORAS

BROMURO DE IPRATRO INH 4 PUFF CADA 8 HORAS

OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS

SCORE DE PADUA BAJO RIESGO

P/ VALORACION POR NUTRICION

P/ ECOCARDIOGRAMA TT

P/ CULTIVO DE ESPUTO ((MUESTRA NO TOMADA)

P/ GeneXpert MTB/RIF (MUESTRA NO TOMADA)

P/ CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS (AMARILLA)

CONTROL DE SIGNOS VITALES, AMSAR CAMBIOS

SS GASES CONTROL, TERAPIA RESPIRATORIA EN INCENTIVO RESPIRATORIO

PENDIENTE

HEMOCULTIVOS 30/01/2022

Fecha: 01/03/2022

Indicaciones:

ALIMENTO HIPERPROTEICO, DENSAMENTE CALORICO CON HMB Y ALTO CONTENIDO DE VITAMINA D PARA USO ESPECIAL EN

ADULTO MAYOR CON DESNUTRICION MODERADA O SEVERA EN CONDICION DE HOSPITALIZACION Y/O CON RECIENTE ALTA

HOSPITALARIA - ENSURE CLINICAL. BOTELLA DE 220 ML DAR DOS AL DIA HORARIO 10:00 Y 3:00

Fecha: 01/03/2022

Indicaciones:

HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA

DIETA NORMAL

MASCARILLA N95 PERMANENTE

TAPON VENOSO

ASLAMENTO RESPIRATORIO

OXIGENOTERAPIA POR CANULA NASAL A 3 L/MIN

TRAMADOL 50 MG IV CADA 8 HORAS E INFUSION LENTA Y DILUIDA

RIPE 4 TAB VO CADA 24 HORAS **FECHA DE SOLICITUD 16/01/22, (RECIBIO 19-20-26) FECHA DE REINICIO: 26/01/22*** (NO

RECIBIO DEL DIA 12 Y 13, 14, 15.)*** REINICIO 16/02 D13

PIRIDOXINA TAB 50 MG VO. DAR 1 TAB CADA 24 H

FORMULA MAGISTRAL: NISTATINA 100.000 UI (5CC) + LIDOCAINA AL 2% JALEA 10 GR (5CC) + HIDROXIDO DE ALUMINIO (5 CC)

REALIZAR LIMPIEZA DE LESIONES CON GASA Y GARGARAS CADA 6 HORAS.

SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 6 HORAS

BROMURO DE IPRATROPIO INH 4 PUFF CADA 8 HORAS

OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS

DALTEPARINA 5000 UI SC CADA DIA

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

CONTROL DE SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS
CONTROL DE LIQUIDOS ADMISINSTRADOS Y ELIMINADOS
SEGUIMIENTO POR MEDICINA INTERNA E INFECTOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL

PENDIENTE
TOMOGRFIA COMPUTADA DE CORONARIAS CODIGO CUPS 879902
TOMOGRFIA COMPUTADA RECONSTRUCCION VIRTUAL CODIGO CUPS 879911
CATETERISMO CARDIACO DERECHO (JUEVES)
CULTIVO DE ESPUTO (MUESTRA NO TOMADA)
GeneXpert MTB/RIF (MUESTRA NO TOMADA)
CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS (AMARILLA)

Fecha: 01/04/2022

Indicaciones:

- HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA
- MASCARILLA N95 PERMANENTE
- AISLAMIENTO RESPIRATORIO
- DIETA CORRIENTE
- TAPON VENOSO
- OXIGENOTERAPIA POR CANULA NASAL PARA SAT02 MAYOR A 88%
- TRAMADOL 50 MG IV CADA 12 HORAS
- TERAPIA RIPE 4 TABLETAS VO CADA 24 HORAS **FECHA DE SOLICITUD 16/01/22, (RECIBIO 19-20-26) FECHA DE REINICIO: 26/01/22*** (NO RECIBIO DEL DIA 12 Y 13, 14, 15)*** REINICIO 17/02 D51/56
- PIRIDOXINA TAB 50 MG VO CADA 24 H
- SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 4 HORAS
- BROMURO DE IPRATROPIO INH 4 PUFF CADA 4 HORAS
- OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS
- ENOXAPARINA 40 MG SC CADA DIAS
- FUROSEMIDA 20 MG IV CADA 8 HORAS
- ACETAMINOFEN 1 GR VIA ORAL POR FIEBRE O DOLOR**MODIFICADO**
- P/OXIGENO DOMICILIARIO **FS31/03/22 NUEVO
- P BACILOSCIPIA X3 FS:30/03/22 (REPORTADA #1)
- TERAPIA RESPIRATORIA DIARIA
- CONTROL DE SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS
- CONTROL DE LIQUIDOS ADMISINSTRADOS Y ELIMINADOS
- SEGUIMIENTO POR MEDICINA INTERNA E INFECTOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL

PENDIENTE
CULTIVO DE ESPUTO (MUESTRA NO TOMADA)
GeneXpert MTB/RIF (MUESTRA NO TOMADA)
CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS (AMARILLA)

Fecha: 01/04/2022

Indicaciones:

ALIMENTO HIPERPROTEICO, DENSAMENTE CALORICO CON HMB Y ALTO CONTENIDO DE VITAMINA D PARA USO ESPECIAL EN ADULTO MAYOR CON DESNUTRICION MODERADA O SEVERA EN CONDICION DE HOSPITALIZACION Y/O CON RECIENTE ALTA HOSPITALARIA - ENSURE CLINICAL. BOTELLA DE 220 ML DAR DOS AL DIA HORARIO 10:00 Y 3:00 PM POR 72 HORAS

Fecha: 02/02/2022

Indicaciones:

ALIMENTO HIPERPROTEICO, DENSAMENTE CALORICO CON HMB Y ALTO CONTENIDO DE VITAMINA D PARA USO ESPECIAL EN ADULTO MAYOR CON DESNUTRICION MODERADA O SEVERA EN CONDICION DE HOSPITALIZACION Y/O CON RECIENTE ALTA HOSPITALARIA - ENSURE CLINICAL. BOTELLA DE 220 ML DAR DOS AL DIA HORARIO 10:00 Y 3:00 PM

Fecha: 02/02/2022

Indicaciones:

HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA
DIETA NORMAL
MASCARILLA N95 PERMANENTE
TAPON VENOSO
AISLAMIENTO RESPIRATORIO
O2 POR VENTURY AL 50% **EN DESTETE**

DIPIRONA 1 GR IV CADA 8 HORAS POR RAZON NECESARIA
RIPE 4 TAB VO CADA 24 HORAS FECHA DE SOLICITUD 16/01/22, FECHA DE INICIO: 26/01/22 D6
PIRIDOXINA TAB 50 MG VO. DAR 1 TAB CADA 24 H
FORMULA MAGISTRAL: NISTATINA 100.000 UI (5CC) + LIDOCAINA AL 2% JALEA 10 GR (5CC) + HIDROXIDO DE ALUMINIO (5 CC)
REALIZAR LIMPIEZA DE LESIONES CON GASA Y GARGARAS CADA 6 HORAS.
SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 6 HORAS
BROMURO DE IPRATRO INH 4 PUFF CADA 8 HORAS
OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

SS HEMOGRAMA, PCR, BUN, CRETININA, IONOGE, BILIRRUBINAS, AST, ALT**TOMAR HOY 01/02/2022**
SS/ PLAN DE ATENCION DOMICILIARIO CON OXIGENO

CONTROL DE SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS
CONTROL DE LIQUIDOS ADMISINSTRADOS Y ELIMINADOS

PENDIENTE
VALORACION POR NUTRICION
ECOCARDIOGRAMA TT
CULTIVO DE ESPUTO ((MUESTRA NO TOMADA)
GeneXpert MTB/RIF (MUESTRA NO TOMADA)
CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS (AMARILLA)
HEMOCULTIVOS 30/01/2022

Fecha: 02/02/2022

Indicaciones:

HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA
DIETA NORMAL
MASCARILLA N95 PERMANENTE
TAPON VENOSO
AISLAMIENTO RESPIRATORIO
O2 POR VENTURY AL 50% **EN DESTETE**

DIPIRONA 1 GR IV CADA 8 HORAS POR RAZON NECESARIA
RIPE 4 TAB VO CADA 24 HORAS FECHA DE SOLICITUD 16/01/22, FECHA DE INICIO: 26/01/22 D7
PIRIDOXINA TAB 50 MG VO. DAR 1 TAB CADA 24 H
FORMULA MAGISTRAL: NISTATINA 100.000 UI (5CC) + LIDOCAINA AL 2% JALEA 10 GR (5CC) + HIDROXIDO DE ALUMINIO (5 CC)
REALIZAR LIMPIEZA DE LESIONES CON GASA Y GARGARAS CADA 6 HORAS.
SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 6 HORAS
BROMURO DE IPRATRO INH 4 PUFF CADA 8 HORAS
OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS

SS HEMOGRAMA, PCR, BUN, CRETININA, IONOGE, BILIRRUBINAS, AST, ALT**TOMAR HOY 01/02/2022**
SS/ PLAN DE ATENCION DOMICILIARIO CON OXIGENO

CONTROL DE SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS
CONTROL DE LIQUIDOS ADMISINSTRADOS Y ELIMINADOS

PENDIENTE
VALORACION POR NUTRICION
CULTIVO DE ESPUTO ((MUESTRA NO TOMADA)
GeneXpert MTB/RIF (MUESTRA NO TOMADA)
CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS (AMARILLA)
HEMOCULTIVOS 30/01/2022

Fecha: 02/03/2022

Indicaciones:

ALIMENTO HIPERPROTEICO, DENSAMENTE CALORICO CON HMB Y ALTO CONTENIDO DE VITAMINA D PARA USO ESPECIAL EN
ADULTO MAYOR CON DESNUTRICION MODERADA O SEVERA EN CONDICION DE HOSPITALIZACION Y/O CON RECIENTE ALTA
HOSPITALARIA - ENSURE CLINICAL. BOTELLA DE 220 ML. DAR DOS AL DIA HORARIO 10:00 Y 3:00

Fecha: 02/03/2022

Indicaciones:

HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA
MASCARILLA N95 PERMANENTE
AISLAMIENTO RESPIRATORIO
DIETA NORMAL
SSN 0.9% PASAR A 60 CC HORA ***NUEVO**
OXIGENOTERAPIA POR CANULA NASAL A 3 L/MIN

TRAMADOL 50 MG IV CADA 8 HORAS E INFUSION LENTA Y DILUIDA***SUSPENDER***
RIPE 4 TAB VO CADA 24 HORAS **FECHA DE SOLICITUD 16/01/22, (RECIBIO 19-20-26) FECHA DE REINICIO: 26/01/22*** (NO
RECIBIO DEL DIA 12 Y 13, 14, 15.)*** REINICIO 16/02 D13
PIRIDOXINA TAB 100 MG VO CADA 24 H
FORMULA MAGISTRAL: NISTATINA 100.000 UI (5CC) + LIDOCAINA AL 2% JALEA 10 GR (5CC) + HIDROXIDO DE ALUMINIO (5 CC)
REALIZAR LIMPIEZA DE LESIONES CON GASA Y GARGARAS CADA 6 HORAS.
SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 6 HORAS
BROMURO DE IPRATROPIO INH 4 PUFF CADA 8 HORAS
OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS
DALTEPARINA 5000 UI SC CADA DIA

S/S HLG, BUN, CREATININA, IONOGRAMA

CONTROL DE SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS
CONTROL DE LIQUIDOS ADMISINSTRADOS Y ELIMINADOS

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

SEGUIMIENTO POR MEDICINA INTERNA E INFECTOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL

PENDIENTE

TOMOGRFIA COMPUTADA DE CORONARIAS CODIGO CUPS 879902

TOMOGRFIA COMPUTADA RECONSTRUCCION VIRTUAL CODIGO CUPS 879911

CATETERISMO CARDIACO DERECHO (JUEVES)

CULTIVO DE ESPUTO (MUESTRA NO TOMADA)

GeneXpert MTB/RIF (MUESTRA NO TOMADA)

CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS (AMARILLA)

Fecha: 02/04/2022

Indicaciones:

- HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA

- MASCARILLA N95 PERMANENTE

- AISLAMIENTO RESPIRATORIO

- DIETA CORRIENTE

- TAPON VENOSO

- OXIGENOTERAPIA POR CANULA NASAL PARA SAT02 MAYOR A 88%

- TRAMADOL 50 MG IV CADA 12 HORAS

- TERAPIA RIPE 4 TABLETAS VO CADA 24 HORAS **FECHA DE SOLICITUD 16/01/22, (RECIBIO 19-20-26) FECHA DE REINICIO:

26/01/22*** (NO RECIBIO DEL DIA 12 Y 13, 14, 15)*** REINICIO 17/02 D52/56

- PIRIDOXINA TAB 50 MG VO CADA 24 H

- SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 4 HORAS

- BROMURO DE IPRATROPIO INH 4 PUFF CADA 4 HORAS

- OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS

- ENOXAPARINA 40 MG SC CADA DIAS

- FUROSEMIDA 20 MG IV CADA 8 HORAS

- ACETAMINOFEN 1 GR VIA ORAL POR FIEBRE O DOLOR**MODIFICADO**

- P/OXIGENO DOMICILIARIO **FS31/03/22 NUEVO

- P BACILOSCIPIA X3 FS:30/03/22 (REPORTADA #1)

- TERAPIA RESPIRATORIA DIARIA

- CONTROL DE SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS

- CONTROL DE LIQUIDOS ADMISINSTRADOS Y ELIMINADOS

- SEGUIMIENTO POR MEDICINA INTERNA E INFECTOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL

Fecha: 03/02/2022

Indicaciones:

ALIMENTO HIPERPROTEICO, DENSAMENTE CALORICO CON HMB Y ALTO CONTENIDO DE VITAMINA D PARA USO ESPECIAL EN ADULTO MAYOR CON DESNUTRICION MODERADA O SEVERA EN CONDICION DE HOSPITALIZACION Y/O CON RECIENTE ALTA HOSPITALARIA - ENSURE CLINICAL. BOTELLA DE 220 ML. DAR DOS AL DIA HORARIO 10:00 Y 3:00 PM

Fecha: 03/02/2022

Indicaciones:

HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA

DIETA NORMAL

MASCARILLA N95 PERMANENTE

TAPON VENOSO

AISLAMIENTO RESPIRATORIO

O2 POR VENTURY AL 50% **EN DESTETE**

DIPIRONA 1 GR IV CADA 8 HORAS POR RAZON NECESARIA

RIPE 4 TAB VO CADA 24 HORAS FECHA DE SOLICITUD 16/01/22, FECHA DE INICIO: 26/01/22 D8

PIRIDOXINA TAB 50 MG VO. DAR 1 TAB CADA 24 H

FORMULA MAGISTRAL: NISTATINA 100.000 UI (5CC) + LIDOCAINA AL 2% JALEA 10 GR (5CC) + HIDROXIDO DE ALUMINIO (5 CC)

REALIZAR LIMPIEZA DE LESIONES CON GASA Y GARGARAS CADA 6 HORAS.

SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 6 HORAS

BROMURO DE IPRATRO INH 4 PUFF CADA 8 HORAS

OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS

ENOXAPARINA 40 MG SC DIA

SS/ PLAN DE ATENCION DOMICILIARIO CON OXIGENO

CONTROL DE SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS

CONTROL DE LIQUIDOS ADMISINSTRADOS Y ELIMINADOS

PENDIENTE

CULTIVO DE ESPUTO ((MUESTRA NO TOMADA)

GeneXpert MTB/RIF (MUESTRA NO TOMADA)

CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS (AMARILLA)

HEMOCULTIVOS 30/01/2022

Fecha: 03/03/2022

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

Indicaciones:

ALIMENTO HIPERPROTEICO, DENSAMENTE CALORICO CON HMB Y ALTO CONTENIDO DE VITAMINA D PARA USO ESPECIAL EN ADULTO MAYOR CON DESNUTRICION MODERADA O SEVERA EN CONDICION DE HOSPITALIZACION Y/O CON RECIENTE ALTA HOSPITALARIA- ENSURE CLINICAL. BOTELLA DE 220 ML DAR DOS AL DIA HORARIO 10:00 Y 3:00

Fecha: 03/03/2022

Indicaciones:

HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA

MASCARILLA N95 PERMANENTE

ASLAMIENTO RESPIRATORIO

DIETA CORRIENTE

SSN 0.9% 80 CC/ HORA IV

OXIGENOTERAPIA POR CANULA NASAL A 3 L/MIN

RIPE 4 TAB VO CADA 24 HORAS **FECHA DE SOLICITUD 16/01/22, (RECIBIO 19-20-26) FECHA DE REINICIO: 26/01/22*** (NO RECIBIO DEL DIA 12 Y 13, 14, 15.)*** REINICIO 16/02 D16

PIRIDOXINA TAB 50 MG VO CADA 24 H

FORMULA MAGISTRAL: NISTATINA 100.000 UI (5CC) + LIDOCAINA AL 2% JALEA 10 GR (5CC) + HIDROXIDO DE ALUMINIO (5 CC)

REALIZAR LIMPIEZA DE LESIONES CON GASA Y GARGARAS CADA 6 HORAS.

SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 6 HORAS

BROMURO DE IPRATROPIO INH 4 PUFF CADA 8 HORAS

OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS

ENOXAPARINA 40 MG SC CADA DIA

S/S HIERRO, FERRITINA, SATURACIÓN DE TRANSFERRINA***NUEVO***FS03/03/22

CONTROL DE SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS

CONTROL DE LIQUIDOS ADMISINSTRADOS Y ELIMINADOS

SEGUIMIENTO POR MEDICINA INTERNA E INFECTOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL

PENDIENTE

PTE TAC CARDIACA

TOMOGRFIA COMPUTADA RECONSTRUCCION VIRTUAL CODIGO CUPS 879911

CATETERISMO CARDIACO DERECHO

CULTIVO DE ESPUTO (MUESTRA NO TOMADA)

GeneXpert MTB/RIF (MUESTRA NO TOMADA)

CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS (AMARILLA)

Fecha: 03/04/2022

Indicaciones:

- HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA

- MASCARILLA N95 PERMANENTE

- ASLAMIENTO RESPIRATORIO

- DIETA CORRIENTE

- TAPON VENOSO

- OXIGENOTERAPIA POR CANULA NASAL PARA SATO2 MAYOR A 88%

- TRAMADOL 50 MG IV CADA 12 HORAS

- TERAPIA RIPE 4 TABLETAS VO CADA 24 HORAS **FECHA DE SOLICITUD 16/01/22, (RECIBIO 19-20-26) FECHA DE REINICIO: 26/01/22*** (NO RECIBIO DEL DIA 12 Y 13, 14, 15)*** REINICIO 17/02 D52/56

- PIRIDOXINA TAB 50 MG VO CADA 24 H

- SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 4 HORAS

- BROMURO DE IPRATROPIO INH 4 PUFF CADA 4 HORAS

- OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS

- ENOXAPARINA 40 MG SC CADA DIAS

- FUROSEMIDA 20 MG IV CADA 8 HORAS

- ACETAMINOFEN 1 GR VIA ORAL POR FIEBRE O DOLOR**MODIFICADO**

- P/OXIGENO DOMICILIARIO **FS31/03/22 NUEVO

- P BACILOSCPIA X3 FS:30/03/22 (REPORTADA #1)

- TERAPIA RESPIRATORIA DIARIA

- CONTROL DE SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS

- CONTROL DE LIQUIDOS ADMISINSTRADOS Y ELIMINADOS

- SEGUIMIENTO POR MEDICINA INTERNA E INFECTOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL

Fecha: 04/02/2022

Indicaciones:

ALIMENTO HIPERPROTEICO, DENSAMENTE CALORICO CON HMB Y ALTO CONTENIDO DE VITAMINA D PARA USO ESPECIAL EN ADULTO MAYOR CON DESNUTRICION MODERADA O SEVERA EN CONDICION DE HOSPITALIZACION Y/O CON RECIENTE ALTA HOSPITALARIA- ENSURE CLINICAL. BOTELLA DE 220 ML DAR DOS AL DIA HORARIO 10:00 Y 3:00 PM POR 72 HORAS

Fecha: 04/02/2022

Indicaciones:

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA
DIETA NORMAL
MASCARILLA N95 PERMANENTE
TAPON VENOSO
AISLAMIENTO RESPIRATORIO
MASCARA DE REINALACION PARCILA 15 L/MIN **EN DESTETE**

DIPIRONA 1 GR IV CADA 8 HORAS POR RAZON NECESARIA
RIPE 4 TAB VO CADA 24 HORAS FECHA DE SOLICITUD 16/01/22, FECHA DE INICIO: 26/01/22 D8
PIRIDOXINA TAB 50 MG VO. DAR 1 TAB CADA 24 H
FORMULA MAGISTRAL: NISTATINA 100.000 UI (5CC) + LIDOCAINA AL 2% JALEA 10 GR (5CC) + HIDROXIDO DE ALUMINIO (5 CC)
REALIZAR LIMPIEZA DE LESIONES CON GASA Y GARGARAS CADA 6 HORAS.
SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 6 HORAS
BROMURO DE IPRATRO INH 4 PUFF CADA 8 HORAS
OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS
ENOXAPARINA 40 MG SC DIA

SS CATETERISMO CARDIOCA DERECHO

CONTROL DE SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS
CONTROL DE LIQUIDOS ADMISINSTRADOS Y ELIMINADOS

PENDIENTE
CULTIVO DE ESPUTO ((MUESTRA NO TOMADA)
GeneXpert MTB/RIF (MUESTRA NO TOMADA)
CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS (AMARILLA)

Fecha: 04/03/2022

Indicaciones:

ALIMENTO HIPERPROTEICO, DENSAMENTE CALORICO CON HMB Y ALTO CONTENIDO DE VITAMINA D PARA USO ESPECIAL EN ADULTO MAYOR CON DESNUTRICION MODERADA O SEVERA EN CONDICION DE HOSPITALIZACION Y/O CON RECIENTE ALTA HOSPITALARIA - ENSURE CLINICAL. BOTELLA DE 220 ML DAR DOS AL DIA HORARIO 10:00 Y 3:00 POR 72 HORAS

Fecha: 04/03/2022

Indicaciones:

HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA
MASCARILLA N95 PERMANENTE
AISLAMIENTO RESPIRATORIO
DIETA CORRIENTE
SSN 0.9% 80 CC/ HORA IV
OXIGENOTERAPIA POR CANULA NASAL A 3 L/MIN

RIPE 4 TAB VO CADA 24 HORAS **FECHA DE SOLICITUD 16/01/22, (RECIBIO 19-20-26) FECHA DE REINICIO: 26/01/22*** (NO RECIBIO DEL DIA 12 Y 13, 14, 15.)*** REINICIO 16/02 D16
PIRIDOXINA TAB 50 MG VO CADA 24 H
FORMULA MAGISTRAL: NISTATINA 100.000 UI (5CC) + LIDOCAINA AL 2% JALEA 10 GR (5CC) + HIDROXIDO DE ALUMINIO (5 CC)
REALIZAR LIMPIEZA DE LESIONES CON GASA Y GARGARAS CADA 6 HORAS.
SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 6 HORAS
BROMURO DE IPRATROPIO INH 4 PUFF CADA 8 HORAS
OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS
ENOXAPARINA 40 MG SC CADA DIA

CONTROL DE SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS
CONTROL DE LIQUIDOS ADMISINSTRADOS Y ELIMINADOS
SEGUIMIENTO POR MEDICINA INTERNA E INFECTOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL

PENDIENTE
HIERRO, FERRITINA, SATURACIÓN DE TRANSFERRINA (FS03/03/22)
PTE TAC CARDIACA
TOMOGRFIA COMPUTADA RECONSTRUCCION VIRTUAL CODIGO CUPS 879911
CATETERISMO CARDIACO DERECHO
CULTIVO DE ESPUTO (MUESTRA NO TOMADA)
GeneXpert MTB/RIF (MUESTRA NO TOMADA)
CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS (AMARILLA)

Fecha: 04/04/2022

Indicaciones:

- HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA
- MASCARILLA N95 PERMANENTE
- AISLAMIENTO RESPIRATORIO
- DIETA CORRIENTE
- TAPON VENOSO
- OXIGENOTERAPIA POR CANULA NASAL PARA SAT02 MAYOR A 88%

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

- TRAMADOL 50 MG IV CADA 12 HORAS
 - TERAPIA RIPE 4 TABLETAS VO CADA 24 HORAS **FECHA DE SOLICITUD 16/01/22, (RECIBIO 19-20-26) FECHA DE REINICIO: 26/01/22*** (NO RECIBIO DEL DIA 12 Y 13, 14, 15)*** REINICIO 17/02 D52/56
 - PIRIDOXINA TAB 50 MG VO CADA 24 H
 - SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 4 HORAS
 - BROMURO DE IPRATROPIO INH 4 PUFF CADA 4 HORAS
 - OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS
 - ENOXAPARINA 40 MG SC CADA DIAS
 - FUROSEMIDA 40 MG VO CADA 24 HORAS ***AJUSTADO***
 - ACETAMINOFEN 1 GR VIA ORAL POR FIEBRE O DOLOR**MODIFICADO**
 - P/OXIGENO DOMICILIARIO **FS: 31/03/22 **

- P BACILOSCIPIA X3 FS:30/03/22 (REPORTADA #1)
 - TERAPIA RESPIRATORIA DIARIA
 - CONTROL DE SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS
 - CONTROL DE LIQUIDOS ADMISINSTRADOS Y ELIMINADOS
 - SEGUIMIENTO POR MEDICINA INTERNA E INFECTOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL

PENDIENTE
 CULTIVO DE ESPUTO (MUESTRA NO TOMADA)
 GeneXpert MTB/RIF (MUESTRA NO TOMADA)
 CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS (AMARILLA)

Fecha: 04/04/2022

Indicaciones:

ALIMENTO HIPERPROTEICO, DENSAMENTE CALORICO CON HMB Y ALTO CONTENIDO DE VITAMINA D PARA USO ESPECIAL EN ADULTO MAYOR CON DESNUTRICION MODERADA O SEVERA EN CONDICION DE HOSPITALIZACION Y/O CON RECIENTE ALTA HOSPITALARIA - ENSURE CLINICAL. BOTELLA DE 220 ML DAR DOS AL DIA HORARIO 10:00 Y 3:00

Fecha: 05/02/2022

Indicaciones:

HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA
 DIETA NORMAL
 MASCARILLA N95 PERMANENTE
 TAPON VENOSO
 AISLAMIENTO RESPIRATORIO
 MASCARA DE REINALACION PARCILA 15 L/MIN **EN DESTETE**

DIPIRONA 1 GR IV CADA 8 HORAS POR RAZON NECESARIA
 RIPE 4 TAB VO CADA 24 HORAS FECHA DE SOLICITUD 16/01/22, FECHA DE INICIO: 26/01/22 D9
 PIRIDOXINA TAB 50 MG VO. DAR 1 TAB CADA 24 H
 FORMULA MAGISTRAL: NISTATINA 100.000 UI (5CC) + LIDOCAINA AL 2% JALEA 10 GR (5CC) + HIDROXIDO DE ALUMINIO (5 CC)
 REALIZAR LIMPIEZA DE LESIONES CON GASA Y GARGARAS CADA 6 HORAS.
 SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 6 HORAS
 BROMURO DE IPRATRO INH 4 PUFF CADA 8 HORAS
 OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS
 ENOXAPARINA 40 MG SC DIA

SS CATETERISMO CARDIOCA DERECHO
 SS ANGIOTAC DE TORAX
 SS TROPONINA, DIMERO D
 SS EKG AHORA

CONTROL DE SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS
 CONTROL DE LIQUIDOS ADMISINSTRADOS Y ELIMINADOS

PENDIENTE
 CATETERISMO CARDIOCA DERECHO
 CULTIVO DE ESPUTO ((MUESTRA NO TOMADA)
 GeneXpert MTB/RIF (MUESTRA NO TOMADA)
 CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS (AMARILLA)

Fecha: 05/03/2022

Indicaciones:

HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA
 MASCARILLA N95 PERMANENTE
 AISLAMIENTO RESPIRATORIO
 DIETA CORRIENTE
 SSN 0.9% 80 CC/ HORA IV
 OXIGENOTERAPIA POR CANULA NASAL A 3 L/MIN

RIPE 4 TAB VO CADA 24 HORAS **FECHA DE SOLICITUD 16/01/22, (RECIBIO 19-20-26) FECHA DE REINICIO: 26/01/22*** (NO RECIBIO DEL DIA 12 Y 13, 14, 15.)*** REINICIO 16/02 D17
 PIRIDOXINA TAB 50 MG VO CADA 24 H

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

FORMULA MAGISTRAL: NISTATINA 100.000 UI (5CC) + LIDOCAINA AL 2% JALEA 10 GR (5CC) + HIDROXIDO DE ALUMINIO (5 CC)
REALIZAR LIMPIEZA DE LESIONES CON GASA Y GARGARAS CADA 6 HORAS.
SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 6 HORAS
BROMURO DE IPRATROPIO INH 4 PUFF CADA 8 HORAS
OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS
ENOXAPARINA 40 MG SC CADA DIA

CONTROL DE SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS
CONTROL DE LIQUIDOS ADMISINSTRADOS Y ELIMINADOS
SEGUIMIENTO POR MEDICINA INTERNA E INFECTOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL

PENDIENTE
PTE TAC CARDIACA
TOMOGRFIA COMPUTADA RECONSTRUCCION VIRTUAL CODIGO CUPS 879911
CATETERISMO CARDIACO DERECHO
CULTIVO DE ESPUTO (MUESTRA NO TOMADA)
GeneXpert MTB/RIF (MUESTRA NO TOMADA)
CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS (AMARILLA)

Fecha: 05/03/2022

Indicaciones:

SSN 0.9% 80 CC/ HORA IV **** SUSPENDER ****
TRAMADOL 50 MG IV CADA 12 HORAS ***NUEVO *****

Fecha: 05/04/2022

Indicaciones:

- HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA
- MASCARILLA N95 PERMANENTE
- AISLAMIENTO RESPIRATORIO
- DIETA CORRIENTE
- TAPON VENOSO
- OXIGENOTERAPIA POR CANULA NASAL PARA SATO2 MAYOR A 88%
- TRAMADOL 50 MG IV CADA 12 HORAS
- TERAPIA RIPE 3 TABLETAS VO CADA 24 HORAS **FECHA DE SOLICITUD 16/01/22, (RECIBIO 19-20-26) FECHA DE REINICIO: 26/01/22*** (NO RECIBIO DEL DIA 12 Y 13, 14, 15)*** REINICIO 17/02 D52/56 ***DOSIS 61 HOY 04/04/2022****
- PIRIDOXINA TAB 50 MG VO CADA 24 H
- SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 4 HORAS
- BROMURO DE IPRATROPIO INH 4 PUFF CADA 4 HORAS
- OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS
- ENOXAPARINA 40 MG SC CADA DIAS
- FUROSEMIDA 40 MG VO CADA 24 HORAS
- ACETAMINOFEN 1 GR VIA ORAL POR FIEBRE O DOLOR
- P/OXIGENO DOMICILIARIO **FS: 31/03/22 **
- SS/ GENEXPERT ****NUEVO***** 04/04/2022
- P BACILOSCIPIA X3 FS:30/03/22 (REPORTADA #1) 02/04/2022 Postiva
- TERAPIA RESPIRATORIA DIARIA
- CONTROL DE SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS
- CONTROL DE LIQUIDOS ADMISINSTRADOS Y ELIMINADOS
- SEGUIMIENTO POR MEDICINA INTERNA E INFECTOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL

Fecha: 05/04/2022

Indicaciones:

ALIMENTO HIPERPROTEICO, DENSAMENTE CALORICO CON HMB Y ALTO CONTENIDO DE VITAMINA D PARA USO ESPECIAL EN ADULTO MAYOR CON DESNUTRICION MODERADA O SEVERA EN CONDICION DE HOSPITALIZACION Y/O CON RECIENTE ALTA HOSPITALARIA - ENSURE CLINICAL. BOTELLA DE 220 ML DAR DOS AL DIA HORARIO 10:00 Y 3:00

Fecha: 06/02/2022

Indicaciones:

HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA
DIETA NORMAL
MASCARILLA N95 PERMANENTE
TAPON VENOSO
AISLAMIENTO RESPIRATORIO
SS/ PASAR O2 A CANULA NASAL A 3 L/MN **EN DESTETE** (DEPENDIENDO DE TOLERANCIA)

DIPIRONA 1 GR IV CADA 8 HORAS POR RAZON NECESARIA
RIPE 4 TAB VO CADA 24 HORAS FECHA DE SOLICITUD 16/01/22, FECHA DE INICIO: 26/01/22 D9
PIRIDOXINA TAB 50 MG VO. DAR 1 TAB CADA 24 H
FORMULA MAGISTRAL: NISTATINA 100.000 UI (5CC) + LIDOCAINA AL 2% JALEA 10 GR (5CC) + HIDROXIDO DE ALUMINIO (5 CC)
REALIZAR LIMPIEZA DE LESIONES CON GASA Y GARGARAS CADA 6 HORAS.
SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 6 HORAS

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

BROMURO DE IPRATRO INH 4 PUFF CADA 8 HORAS
 OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS
 ENOXAPARINA 40 MG SC DIA

P CATETERISMO CARDIOCA DERECHO
 P ANGIOTAC DE TORAX
 P TROPONINA, DIMERO D
 SS ELECTROCARDIOGRAMA

CONTROL DE SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS
 CONTROL DE LIQUIDOS ADMISINSTRADOS Y ELIMINADOS

PENDIENTE
 CATETERISMO CARDICAO DERECHO
 CULTIVO DE ESPUTO ((MUESTRA NO TOMADA)
 GeneXpert MTB/RIF (MUESTRA NO TOMADA)
 CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS (AMARILLA)

Fecha: 06/03/2022

Indicaciones:

HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA
 MASCARILLA N95 PERMANENTE
 AISLAMIENTO RESPIRATORIO
 DIETA CORRIENTE
 TAPON VENOSO
 OXIGENOTERAPIA POR CANULA NASAL A 3 L/MIN

TRAMADOL 50 MG IV CADA 12 HORAS
 RIPE 4 TAB VO CADA 24 HORAS **FECHA DE SOLICITUD 16/01/22, (RECIBIO 19-20-26) FECHA DE REINICIO: 26/01/22*** (NO RECIBIO DEL DIA 12 Y 13, 14, 15.)*** REINICIO 16/02 D18
 PIRIDOXINA TAB 50 MG VO CADA 24 H
 FORMULA MAGISTRAL: NISTATINA 100.000 UI (5CC) + LIDOCAINA AL 2% JALEA 10 GR (5CC) + HIDROXIDO DE ALUMINIO (5 CC)
 REALIZAR LIMPIEZA DE LESIONES CON GASA Y GARGARAS CADA 6 HORAS.
 SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 6 HORAS
 BROMURO DE IPRATROPIO INH 4 PUFF CADA 8 HORAS
 OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS
 ENOXAPARINA 40 MG SC CADA DIA

CONTROL DE SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS
 CONTROL DE LIQUIDOS ADMISINSTRADOS Y ELIMINADOS
 SEGUIMIENTO POR MEDICINA INTERNA E INFECTOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL

Fecha: 06/04/2022

Indicaciones:

- HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA
 - MASCARILLA N95 PERMANENTE
 - AISLAMIENTO RESPIRATORIO
 - DIETA CORRIENTE
 - TAPON VENOSO
 - OXIGENOTERAPIA POR CANULA NASAL PARA SATO2 MAYOR A 88%

- TRAMADOL 50 MG IV CADA 12 HORAS
 - TERAPIA RIPE 3 TABLETAS VO CADA 24 HORAS **FECHA DE SOLICITUD 16/01/22, (RECIBIO 19-20-26) FECHA DE REINICIO: 26/01/22*** (NO RECIBIO DEL DIA 12 Y 13, 14, 15)*** REINICIO 17/02 D52/56 ***DOSIS 63 HOY 06/04/2022****
 - PIRIDOXINA TAB 50 MG VO CADA 24 H
 - SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 4 HORAS
 - BROMURO DE IPRATROPIO INH 4 PUFF CADA 4 HORAS
 - OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS
 - ENOXAPARINA 40 MG SC CADA DIAS
 - FUROSEMIDA 40 MG VO CADA 24 HORAS
 - ACETAMINOFEN 1 GR VIA ORAL POR FIEBRE O DOLOR
 - P/OXIGENO DOMICILIARIO **FS: 31/03/22 **
 - P/ REPORTE GENEXPERT**05/04/22**
 - P BACILOSCIPIA X3 FS:30/03/22 (REPORTADA #1) 02/04/2022 Postiva
 - TERAPIA RESPIRATORIA DIARIA
 - CONTROL DE SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS
 - CONTROL DE LIQUIDOS ADMISINSTRADOS Y ELIMINADOS
 - SEGUIMIENTO POR MEDICINA INTERNA E INFECTOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL

Fecha: 06/04/2022

Indicaciones:

ALIMENTO HIPERPROTEICO, DENSAMENTE CALORICO CON HMB Y ALTO CONTENIDO DE VITAMINA D PARA USO ESPECIAL EN ADULTO MAYOR CON DESNUTRICION MODERADA O SEVERA EN CONDICION DE HOSPITALIZACION Y/O CON RECIENTE ALTA HOSPITALARIA - ENSURE CLINICAL. BOTELLA DE 220 ML DAR DOS AL DIA HORARIO 10:00 Y 3:00

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

Fecha: 07/02/2022

Indicaciones:

ALIMENTO HIPERPROTEICO, DENSAMENTE CALORICO CON HMB Y ALTO CONTENIDO DE VITAMINA D PARA USO ESPECIAL EN ADULTO MAYOR CON DESNUTRICION MODERADA O SEVERA EN CONDICION DE HOSPITALIZACION Y/O CON RECIENTE ALTA HOSPITALARIA - ENSURE CLINICAL. BOTELLA DE 220 ML DAR DOS AL DIA HORARIO 10:00 Y 3:00

Fecha: 07/02/2022

Indicaciones:

HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA

DIETA NORMAL

MASCARILLA N95 PERMANENTE

TAPON VENOSO

AISLAMIENTO RESPIRATORIO

SS/ PASAR O2 A CANULA NASAL A 3 L/MN **EN DESTETE** (DEPENDIENDO DE TOLERANCIA)

DIPIRONA 1 GR IV CADA 8 HORAS POR RAZON NECESARIA

RIPE 4 TAB VO CADA 24 HORAS FECHA DE SOLICITUD 16/01/22, FECHA DE INICIO: 26/01/22 D13

PIRIDOXINA TAB 50 MG VO. DAR 1 TAB CADA 24 H

FORMULA MAGISTRAL: NISTATINA 100.000 UI (5CC) + LIDOCAINA AL 2% JALEA 10 GR (5CC) + HIDROXIDO DE ALUMINIO (5 CC)

REALIZAR LIMPIEZA DE LESIONES CON GASA Y GARGARAS CADA 6 HORAS.

SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 6 HORAS

BROMURO DE IPRATROPIO INH 4 PUFF CADA 8 HORAS

OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS

ENOXAPARINA 40 MG SC DIA

P TROPONINA, DIMERO D, HEMOGRAMA, PCR, BUN, CREATININA, IONOGRAMA, BIL, ALT*** TOMAR HOY 7 FEB***

SS TOMOGRAFIA TORAX SIMPLE Y CONTRASTADA

CONTROL DE SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS

CONTROL DE LIQUIDOS ADMISINSTRADOS Y ELIMINADOS

SEGUIMIENTO POR MEDICINA INTERNA E INFECTOLOGIA

PENDIENTE

ANGIOTAC DE TORAX (POR FAVOR CCARGAR)

CATETERISMO CARDIACO DERECHO

CULTIVO DE ESPUTO ((MUESTRA NO TOMADA)

GeneXpert MTB/RIF (MUESTRA NO TOMADA)

CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS (AMARILLA)

Fecha: 07/03/2022

Indicaciones:

ALIMENTO HIPERPROTEICO, DENSAMENTE CALORICO CON HMB Y ALTO CONTENIDO DE VITAMINA D PARA USO ESPECIAL EN ADULTO MAYOR CON DESNUTRICION MODERADA O SEVERA EN CONDICION DE HOSPITALIZACION Y/O CON RECIENTE ALTA HOSPITALARIA - ENSURE CLINICAL. BOTELLA DE 220 ML DAR DOS AL DIA HORARIO 10:00 Y 3:00

Fecha: 07/03/2022

Indicaciones:

HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA

MASCARILLA N95 PERMANENTE

AISLAMIENTO RESPIRATORIO

DIETA CORRIENTE

TAPON VENOSO

OXIGENOTERAPIA POR CANULA NASAL A 3 L/MN

TRAMADOL 50 MG IV CADA 12 HORAS

RIPE 4 TAB VO CADA 24 HORAS **FECHA DE SOLICITUD 16/01/22, (RECIBIO 19-20-26) FECHA DE REINICIO: 26/01/22*** (NO

RECIBIO DEL DIA 12 Y 13, 14, 15.)*** REINICIO 16/02 D19

PIRIDOXINA TAB 50 MG VO CADA 24 H

FORMULA MAGISTRAL: NISTATINA 100.000 UI (5CC) + LIDOCAINA AL 2% JALEA 10 GR (5CC) + HIDROXIDO DE ALUMINIO (5 CC)

REALIZAR LIMPIEZA DE LESIONES CON GASA Y GARGARAS CADA 6 HORAS.

SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 6 HORAS

BROMURO DE IPRATROPIO INH 4 PUFF CADA 8 HORAS

OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS

ENOXAPARINA 40 MG SC CADA DIA

CONTROL DE SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS

CONTROL DE LIQUIDOS ADMISINSTRADOS Y ELIMINADOS

SEGUIMIENTO POR MEDICINA INTERNA E INFECTOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL

PENDIENTE

PTE TAC CARDIACA

TOMOGRAFIA COMPUTADA RECONSTRUCCION VIRTUAL CODIGO CUPS 879911

CATETERISMO CARDIACO DERECHO

CULTIVO DE ESPUTO (MUESTRA NO TOMADA)

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

GeneXpert MTB/RIF (MUESTRA NO TOMADA)
CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS (AMARILLA)

Fecha: 07/04/2022

Indicaciones:

- HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA
- MASCARILLA N95 PERMANENTE
- AISLAMIENTO RESPIRATORIO
- DIETA CORRIENTE
- TAPON VENOSO
- OXIGENOTERAPIA POR CANULA NASAL PARA SAT02 MAYOR A 88%
- TRAMADOL 50 MG IV CADA 12 HORAS
- TERAPIA RIPE 3 TABLETAS VO CADA 24 HORAS **FECHA DE SOLICITUD 16/01/22, (RECIBIO 19-20-26) FECHA DE REINICIO: 26/01/22*** (NO RECIBIO DEL DIA 12 Y 13, 14, 15)*** REINICIO 17/02 D52/56 ***DOSIS 63 HOY 06/04/2022****
- PIRIDOXINA TAB 50 MG VO CADA 24 H
- SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 4 HORAS
- BROMURO DE IPRATROPIO INH 4 PUFF CADA 4 HORAS
- OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS
- ENOXAPARINA 40 MG SC CADA DIAS
- FUROSEMIDA 40 MG VO CADA 24 HORAS
- ACETAMINOFEN 1 GR VIA ORAL POR FIEBRE O DOLOR
- P/OXIGENO DOMICILIARIO **FS: 31/03/22 **
- P/ REPORTE GENEXPERT**05/04/22**
- P BACILOSCPIA X3 FS:30/03/22 (REPORTADA #1) 02/04/2022 Positiva
- TERAPIA RESPIRATORIA DIARIA
- CONTROL DE SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS
- CONTROL DE LIQUIDOS ADMISINSTRADOS Y ELIMINADOS
- SEGUIMIENTO POR MEDICINA INTERNA E INFECTOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL

Fecha: 07/04/2022

Indicaciones:

ALIMENTO HIPERPROTEICO, DENSAMENTE CALORICO CON HMB Y ALTO CONTENIDO DE VITAMINA D PARA USO ESPECIAL EN ADULTO MAYOR CON DESNUTRICION MODERADA O SEVERA EN CONDICION DE HOSPITALIZACION Y/O CON RECIENTE ALTA HOSPITALARIA - ENSURE CLINICAL. BOTELLA DE 220 ML DAR DOS AL DIA HORARIO 10:00 Y 3:00

Fecha: 08/02/2022

Indicaciones:

ALIMENTO HIPERPROTEICO, DENSAMENTE CALORICO CON HMB Y ALTO CONTENIDO DE VITAMINA D PARA USO ESPECIAL EN ADULTO MAYOR CON DESNUTRICION MODERADA O SEVERA EN CONDICION DE HOSPITALIZACION Y/O CON RECIENTE ALTA HOSPITALARIA - ENSURE CLINICAL. BOTELLA DE 220 ML DAR DOS AL DIA HORARIO 10:00 Y 3:00

Fecha: 08/02/2022

Indicaciones:

HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA
DIETA NORMAL
MASCARILLA N95 PERMANENTE
TAPON VENOSO
AISLAMIENTO RESPIRATORIO
SS/ PASAR O2 A CANULA NASAL A 3 L/MN **EN DESTETE** (DEPENDIENDO DE TOLERANCIA)

DIPIRONA 1 GR IV CADA 8 HORAS POR RAZON NECESARIA
RIPE 4 TAB VO CADA 24 HORAS FECHA DE SOLICITUD 16/01/22, (RECIBIO 19-20-26) FECHA DE REINICIO: 26/01/22**** D13
PIRIDOXINA TAB 50 MG VO. DAR 1 TAB CADA 24 H
FORMULA MAGISTRAL: NISTATINA 100.000 UI (5CC) + LIDOCAINA AL 2% JALEA 10 GR (5CC) + HIDROXIDO DE ALUMINIO (5 CC)
REALIZAR LIMPIEZA DE LESIONES CON GASA Y GARGARAS CADA 6 HORAS.
SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 6 HORAS
BROMURO DE IPRATROPIO INH 4 PUFF CADA 8 HORAS
OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS
ENOXAPARINA 40 MG SC DIA

P DIMERO D, HEMOGRAMA, PCR, BUN, CREATININA, IONOGRAMA, BIL, ALT*** MUESTRA NO TOMADA***
SS TOMOGRAFIA TORAX SIMPLE Y CONTRASTADA
SS TRABAJO SOCIAL

CONTROL DE SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS
CONTROL DE LIQUIDOS ADMISINSTRADOS Y ELIMINADOS
SEGUIMIENTO POR MEDICINA INTERNA E INFECTOLOGIA

PENDIENTE
CATETERISMO CARDIACO DERECHO (JUEVES)
CULTIVO DE ESPUTO ((MUESTRA NO TOMADA)
GeneXpert MTB/RIF (MUESTRA NO TOMADA)

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS (AMARILLA)

Fecha: 08/03/2022

Indicaciones:

ALIMENTO HIPERPROTEICO, DENSAMENTE CALORICO CON HMB Y ALTO CONTENIDO DE VITAMINA D PARA USO ESPECIAL EN ADULTO MAYOR CON DESNUTRICION MODERADA O SEVERA EN CONDICION DE HOSPITALIZACION Y/O CON RECIENTE ALTA HOSPITALARIA - ENSURE CLINICAL. BOTELLA DE 220 ML DAR DOS AL DIA HORARIO 10:00 Y 3:00

Fecha: 08/03/2022

Indicaciones:

HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA

MASCARILLA N95 PERMANENTE

ASLAMIENTO RESPIRATORIO

DIETA CORRIENTE

TAPON VENOSO

OXIGENOTERAPIA POR CANULA NASAL A 3 L/MIN

TRAMADOL 50 MG IV CADA 12 HORAS

RIPE 4 TAB VO CADA 24 HORAS **FECHA DE SOLICITUD 16/01/22, (RECIBIO 19-20-26) FECHA DE REINICIO: 26/01/22*** (NO RECIBIO DEL DIA 12 Y 13, 14, 15.)*** REINICIO 16/02 D20

PIRIDOXINA TAB 50 MG VO CADA 24 H

FORMULA MAGISTRAL: NISTATINA 100.000 UI (5CC) + LIDOCAINA AL 2% JALEA 10 GR (5CC) + HIDROXIDO DE ALUMINIO (5 CC)

REALIZAR LIMPIEZA DE LESIONES CON GASA Y GARGARAS CADA 6 HORAS.

SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 6 HORAS

BROMURO DE IPRATROPIO INH 4 PUFF CADA 8 HORAS

OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS

ENOXAPARINA 40 MG SC CADA DIA

SS HLG, BUN, CREATININA, TP, TPT. **NUEVO** FS08/03/22

CONTROL DE SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS

CONTROL DE LIQUIDOS ADMISINSTRADOS Y ELIMINADOS

SEGUIMIENTO POR MEDICINA INTERNA E INFECTOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL

PENDIENTE

PTE TAC CARDIACA (CITA PARA 09/03/22)

TOMOGRFIA COMPUTADA RECONSTRUCCION VIRTUAL CODIGO CUPS 879911

CATETERISMO CARDIACO DERECHO

CULTIVO DE ESPUTO (MUESTRA NO TOMADA)

GeneXpert MTB/RIF (MUESTRA NO TOMADA)

CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS (AMARILLA)

Fecha: 08/04/2022

Indicaciones:

- HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA

- MASCARILLA N95 PERMANENTE

- ASLAMIENTO RESPIRATORIO

- DIETA CORRIENTE

- TAPON VENOSO

- OXIGENOTERAPIA POR CANULA NASAL PARA SAT02 MAYOR A 88%

- TRAMADOL 50 MG IV CADA 12 HORAS

- TERAPIA RIPE 3 TABLETAS VO CADA 24 HORAS **FECHA DE SOLICITUD 16/01/22, (RECIBIO 19-20-26) FECHA DE REINICIO: 26/01/22*** (NO RECIBIO DEL DIA 12 Y 13, 14, 15)*** REINICIO 17/02 D52/56 ***DOSIS 65 HOY 08/04/2022****

- PIRIDOXINA TAB 50 MG VO CADA 24 H

- SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 4 HORAS

- BROMURO DE IPRATROPIO INH 4 PUFF CADA 4 HORAS

- OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS

- ENOXAPARINA 40 MG SC CADA DIAS

- FUROSEMIDA 40 MG VO CADA 24 HORAS

- ACETAMINOFEN 1 GR VIA ORAL POR FIEBRE O DOLOR

- P/OXIGENO DOMICILIARIO **FS: 31/03/22 **

- P/ REPORTE GENEXPERT**05/04/22**

- P BACILOSCPIA X3 FS:30/03/22 (REPORTADA #1) 02/04/2022 Positiva

- TERAPIA RESPIRATORIA DIARIA

- CONTROL DE SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS

- CONTROL DE LIQUIDOS ADMISINSTRADOS Y ELIMINADOS

- SEGUIMIENTO POR MEDICINA INTERNA E INFECTOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL

Fecha: 08/04/2022

Indicaciones:

ALIMENTO HIPERPROTEICO, DENSAMENTE CALORICO CON HMB Y ALTO CONTENIDO DE VITAMINA D PARA USO ESPECIAL EN ADULTO MAYOR CON DESNUTRICION MODERADA O SEVERA EN CONDICION DE HOSPITALIZACION Y/O CON RECIENTE ALTA

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

HOSPITALARIA- ENSURE CLINICAL. BOTELLA DE 220 ML DAR DOS AL DIA HORARIO 10:00 Y 3:00 PM POR 72 HORAS

Fecha: 09/02/2022

Indicaciones:

ALIMENTO HIPERPROTEICO, DENSAMENTE CALORICO CON HMB Y ALTO CONTENIDO DE VITAMINA D PARA USO ESPECIAL EN ADULTO MAYOR CON DESNUTRICION MODERADA O SEVERA EN CONDICION DE HOSPITALIZACION Y/O CON RECIENTE ALTA HOSPITALARIA- ENSURE CLINICAL. BOTELLA DE 220 ML DAR DOS AL DIA HORARIO 10:00 Y 3:00

Fecha: 09/02/2022

Indicaciones:

HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA

DIETA NORMAL

MASCARILLA N95 PERMANENTE

TAPON VENOSO

AISLAMIENTO RESPIRATORIO

OXIGENOTERAPIA POR CANULA NASAL A 3 L/MIN ***** AJUSTADO *****

DIPIRONA 1 GR IV CADA 8 HORAS POR RAZON NECESARIA

RIPE 4 TAB VO CADA 24 HORAS FECHA DE SOLICITUD 16/01/22, (RECIBIO 19-20-26) FECHA DE REINICIO: 26/01/22**** D13

PIRIDOXINA TAB 50 MG VO. DAR 1 TAB CADA 24 H

FORMULA MAGISTRAL: NISTATINA 100.000 UI (5CC) + LIDOCAINA AL 2% JALEA 10 GR (5CC) + HIDROXIDO DE ALUMINIO (5 CC)

REALIZAR LIMPIEZA DE LESIONES CON GASA Y GARGARAS CADA 6 HORAS.

SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 6 HORAS

BROMURO DE IPRATROPIO INH 4 PUFF CADA 8 HORAS

OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS

ENOXAPARINA 40 MG SC DIA

SS TP, TPT DIMERO D, HEMOGRAMA, PCR, BUN, CREATININA, IONOGRAMA, BIL, ALT, *** TOMAR HOY 9/02/2022***

CONTROL DE SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS

CONTROL DE LIQUIDOS ADMISTRADOS Y ELIMINADOS

SEGUIMIENTO POR MEDICINA INTERNA E INFECTOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL

PENDIENTE

CATETERISMO CARDIACO DERECHO (JUEVES)

CULTIVO DE ESPUTO ((MUESTRA NO TOMADA)

GeneXpert MTB/RIF (MUESTRA NO TOMADA)

CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS (AMARILLA)

Fecha: 09/03/2022

Indicaciones:

ALIMENTO HIPERPROTEICO, DENSAMENTE CALORICO CON HMB Y ALTO CONTENIDO DE VITAMINA D PARA USO ESPECIAL EN ADULTO MAYOR CON DESNUTRICION MODERADA O SEVERA EN CONDICION DE HOSPITALIZACION Y/O CON RECIENTE ALTA HOSPITALARIA- ENSURE CLINICAL. BOTELLA DE 220 ML DAR DOS AL DIA HORARIO 10:00 Y 3:00 PM

Fecha: 09/03/2022

Indicaciones:

HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA

MASCARILLA N95 PERMANENTE

AISLAMIENTO RESPIRATORIO

DIETA CORRIENTE

TAPON VENOSO

SSN 0.9% PASAR A 60 CC HORA*** EN EL MOMENTO DEL ESTUDIO *****

OXIGENOTERAPIA POR CANULA NASAL A 3 L/MIN

TRAMADOL 50 MG IV CADA 12 HORAS

RIPE 4 TAB VO CADA 24 HORAS **FECHA DE SOLICITUD 16/01/22, (RECIBIO 19-20-26) FECHA DE REINICIO: 26/01/22*** (NO RECIBIO DEL DIA 12 Y 13, 14, 15.)*** REINICIO 16/02 D20

PIRIDOXINA TAB 50 MG VO CADA 24 H

FORMULA MAGISTRAL: NISTATINA 100.000 UI (5CC) + LIDOCAINA AL 2% JALEA 10 GR (5CC) + HIDROXIDO DE ALUMINIO (5 CC)

REALIZAR LIMPIEZA DE LESIONES CON GASA Y GARGARAS CADA 6 HORAS.

SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 6 HORAS

BROMURO DE IPRATROPIO INH 4 PUFF CADA 8 HORAS

OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS

ENOXAPARINA 40 MG SC CADA DIA

CONTROL DE SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS

CONTROL DE LIQUIDOS ADMISTRADOS Y ELIMINADOS

SEGUIMIENTO POR MEDICINA INTERNA E INFECTOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL

PENDIENTE

PTE TAC CARDIACA (CITA PARA 09/03/22)

TOMOGRAFIA COMPUTADA RECONSTRUCCION VIRTUAL CODIGO CUPS 879911

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

CATETERISMO CARDIACO DERECHO

Fecha: 09/04/2022

Indicaciones:

- HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA
- MASCARILLA N95 PERMANENTE
- AISLAMIENTO RESPIRATORIO
- DIETA CORRIENTE
- TAPON VENOSO
- OXIGENOTERAPIA POR CANULA NASAL PARA SAT02 MAYOR A 88%
- TRAMADOL 50 MG IV CADA 12 HORAS
- TERAPIA RIPE 3 TABLETAS VO CADA 24 HORAS **FECHA DE SOLICITUD 16/01/22, (RECIBIO 19-20-26) FECHA DE REINICIO: 26/01/22*** (NO RECIBIO DEL DIA 12 Y 13, 14, 15)*** REINICIO 17/02 D52/56 ***DOSIS 65 HOY 08/04/2022****
- PIRIDOXINA TAB 50 MG VO CADA 24 H
- SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 4 HORAS
- BROMURO DE IPRATROPIO INH 4 PUFF CADA 4 HORAS
- OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS
- ENOXAPARINA 40 MG SC CADA DIAS
- FUROSEMIDA 40 MG VO CADA 24 HORAS
- ACETAMINOFEN 1 GR VIA ORAL POR FIEBRE O DOLOR
- SS/ HEMOGRAMA, AST, ALT, BT, IONOGRAMA ***NUEVO**** 09/04/2022***
- P/OXIGENO DOMICILIARIO **FS: 31/03/22 **
- P/ REPORTE GENEXPERT**05/04/22**
- P BACILOSCIPIA X3 FS:30/03/22 (REPORTADA #1) 02/04/2022 Postiva
- TERAPIA RESPIRATORIA DIARIA
- CONTROL DE SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS
- CONTROL DE LIQUIDOS ADMISINSTRADOS Y ELIMINADOS
- SEGUIMIENTO POR MEDICINA INTERNA E INFECTOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL

Fecha: 09/04/2022

Indicaciones:

- HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA
- MASCARILLA N95 PERMANENTE
- AISLAMIENTO RESPIRATORIO
- DIETA CORRIENTE
- TAPON VENOSO
- OXIGENOTERAPIA POR CANULA NASAL PARA SAT02 MAYOR A 88%
- TRAMADOL 50 MG IV CADA 12 HORAS
- TERAPIA RIPE 3 TABLETAS VO CADA 24 HORAS **FECHA DE SOLICITUD 16/01/22, (RECIBIO 19-20-26) FECHA DE REINICIO: 26/01/22*** (NO RECIBIO DEL DIA 12 Y 13, 14, 15)*** REINICIO 17/02 D52/56 ***DOSIS 66 HOY 09/04/2022****
- PIRIDOXINA TAB 50 MG VO CADA 24 H
- SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 4 HORAS
- BROMURO DE IPRATROPIO INH 4 PUFF CADA 4 HORAS
- OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS
- ENOXAPARINA 40 MG SC CADA DIAS
- FUROSEMIDA 40 MG VO CADA 24 HORAS
- ACETAMINOFEN 1 GR VIA ORAL POR FIEBRE O DOLOR
- SS/ HEMOGRAMA, AST, ALT, BT, IONOGRAMA ***NUEVO**** 09/04/2022***
- P/OXIGENO DOMICILIARIO **FS: 31/03/22 **
- P/ REPORTE GENEXPERT**05/04/22**
- P BACILOSCIPIA X3 FS:30/03/22 (REPORTADA #1) 02/04/2022 Postiva
- TERAPIA RESPIRATORIA DIARIA
- CONTROL DE SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS
- CONTROL DE LIQUIDOS ADMISINSTRADOS Y ELIMINADOS
- SEGUIMIENTO POR MEDICINA INTERNA E INFECTOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL

Fecha: 10/02/2022

Indicaciones:

ALIMENTO HIPERPROTEICO, DENSAMENTE CALORICO CON HMB Y ALTO CONTENIDO DE VITAMINA D PARA USO ESPECIAL EN ADULTO MAYOR CON DESNUTRICION MODERADA O SEVERA EN CONDICION DE HOSPITALIZACION Y/O CON RECIENTE ALTA HOSPITALARIA - ENSURE CLINICAL. BOTELLA DE 220 ML DAR DOS AL DIA HORARIO 10:00 Y 3:00

Fecha: 10/02/2022

Indicaciones:

HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA
DIETA NORMAL
MASCARILLA N95 PERMANENTE
TAPON VENOSO
AISLAMIENTO RESPIRATORIO
OXIGENOTERAPIA VENTURIA AL 50%, INTENTAR DESCALONAR*****AJUSTADO*****

DIPIRONA 1 GR IV CADA 8 HORAS POR RAZON NECESARIA

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

RIPE 4 TAB VO CADA 24 HORAS FECHA DE SOLICITUD 16/01/22, (RECIBIO 19-20-26) FECHA DE REINICIO: 26/01/22**** D13
PIRIDOXINA TAB 50 MG VO. DAR 1 TAB CADA 24 H
FORMULA MAGISTRAL: NISTATINA 100.000 UI (5CC) + LIDOCAINA AL 2% JALEA 10 GR (5CC) + HIDROXIDO DE ALUMINIO (5 CC)
REALIZAR LIMPIEZA DE LESIONES CON GASA Y GARGARAS CADA 6 HORAS.
SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 6 HORAS
BROMURO DE IPRATROPIO INH 4 PUFF CADA 8 HORAS
OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS
ENOXAPARINA 40 MG SC DIA

SS TP, TPT DIMERO D, HEMOGRAMA, PCR, BUN, CREATININA, IONOGRAMA, BIL, ALT,

CONTROL DE SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS
CONTROL DE LIQUIDOS ADMISINSTRADOS Y ELIMINADOS
SEGUIMIENTO POR MEDICINA INTERNA E INFECTOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL

PENDIENTE
CATETERISMO CARDIAO DERECHO (JUEVES)
CULTIVO DE ESPUTO ((MUESTRA NO TOMADA)
GeneXpert MTB/RIF (MUESTRA NO TOMADA)
CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS (AMARILLA)

Fecha: 10/03/2022

Indicaciones:

- HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA
- MASCARILLA N95 PERMANENTE
- AISLAMIENTO RESPIRATORIO
- DIETA CORRIENTE
- TAPON VENOSO
- SSN 0.9% PASAR A 60 CC HORA*** EN EL MOMENTO DEL ESTUDIO ****
- OXIGENOTERAPIA POR CANULA NASAL A 3 L/MIN

- TRAMADOL 50 MG IV CADA 12 HORAS
- RIPE 4 TAB VO CADA 24 HORAS **FECHA DE SOLICITUD 16/01/22, (RECIBIO 19-20-26) FECHA DE REINICIO: 26/01/22*** (NO RECIBIO DEL DIA 12 Y 13, 14, 15.)*** REINICIO 16/02 D22
- PIRIDOXINA TAB 50 MG VO CADA 24 H
- FORMULA MAGISTRAL: NISTATINA 100.000 UI (5CC) + LIDOCAINA AL 2% JALEA 10 GR (5CC) + HIDROXIDO DE -ALUMINIO (5 CC)
- REALIZAR LIMPIEZA DE LESIONES CON GASA Y GARGARAS CADA 6 HORAS.
- SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 6 HORAS
- BROMURO DE IPRATROPIO INH 4 PUFF CADA 8 HORAS
- OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS
- ENOXAPARINA 40 MG SC CADA DIA

- CONTROL DE SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS
- CONTROL DE LIQUIDOS ADMISINSTRADOS Y ELIMINADOS
- SEGUIMIENTO POR MEDICINA INTERNA E INFECTOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL

PENDIENTE
TOMOGRFIA COMPUTADA RECONSTRUCCION VIRTUAL CODIGO CUPS 879911
CATETERISMO CARDIACO DERECHO
CULTIVO DE ESPUTO (MUESTRA NO TOMADA)
GeneXpert MTB/RIF (MUESTRA NO TOMADA)
CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS (AMARILLA)

Fecha: 10/03/2022

Indicaciones:

ALIMENTO HIPERPROTEICO, DENSAMENTE CALORICO CON HMB Y ALTO CONTENIDO DE VITAMINA D PARA USO ESPECIAL EN ADULTO MAYOR CON DESNUTRICION MODERADA O SEVERA EN CONDICION DE HOSPITALIZACION Y/O CON RECIENTE ALTA HOSPITALARIA - ENSURE CLINICAL. BOTELLA DE 220 ML DAR DOS AL DIA HORARIO 10:00 Y 3:00 PM

Fecha: 10/04/2022

Indicaciones:

- HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA
- MASCARILLA N95 PERMANENTE
- AISLAMIENTO RESPIRATORIO
- DIETA CORRIENTE
- TAPON VENOSO
- OXIGENOTERAPIA POR CANULA NASAL PARA SATO2 MAYOR A 88%

- TRAMADOL 50 MG IV CADA 12 HORAS
- TERAPIA RIPE 3 TABLETAS VO CADA 24 HORAS **FECHA DE SOLICITUD 16/01/22, (RECIBIO 19-20-26) FECHA DE REINICIO: 26/01/22*** (NO RECIBIO DEL DIA 12 Y 13, 14, 15)*** REINICIO 17/02 D52/56 ***DOSIS 66 HOY 09/04/2022****
- PIRIDOXINA TAB 50 MG VO CADA 24 H
- SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 4 HORAS
- BROMURO DE IPRATROPIO INH 4 PUFF CADA 4 HORAS
- OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

- ENOXAPARINA 40 MG SC CADA DIAS
- FUROSEMIDA 40 MG VO CADA 24 HORAS
- ACETAMINOFEN 1 GR VIA ORAL POR FIEBRE O DOLOR
- P/OXIGENO DOMICILIARIO **FS: 31/03/22 **
- P/ REPORTE GENEXPERT **05/04/22**
- P BACILOSCPIA X3 FS:30/03/22 (REPORTADA #1) 02/04/2022 Postiva
- TERAPIA RESPIRATORIA DIARIA
- CONTROL DE SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS
- CONTROL DE LIQUIDOS ADMISINSTRADOS Y ELIMINADOS
- SEGUIMIENTO POR MEDICINA INTERNA E INFECTOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL

Fecha: 11/02/2022

Indicaciones:

ALIMENTO HIPERPROTEICO, DENSAMENTE CALORICO CON HMB Y ALTO CONTENIDO DE VITAMINA D PARA USO ESPECIAL EN ADULTO MAYOR CON DESNUTRICION MODERADA O SEVERA EN CONDICION DE HOSPITALIZACION Y/O CON RECIENTE ALTA HOSPITALARIA - ENSURE CLINICAL. BOTELLA DE 220 ML. DAR DOS AL DIA HORARIO 10:00 Y 3:00 POR 72 HORAS

Fecha: 11/02/2022

Indicaciones:

HOSPITALIZACION EN SALA GENERAL NO COVID
USO DE MASCARRILLA N 95
DIETA HIPOGLUCIDA E HIPOSODICA FRACCIONADA EN 6 PORCIONES
GLUCERNA LIQUIDO. 2 UNIDADES AL DIA
LACTATO DE RINGER PASAR A 40 CC /HORA ** MODIFICADO **

OMEPRAZOL 40 MG IV CADA 12 HORAS
LOSARTAN 50MG VO CADA DIA
CARVEDILOL 12.5 MG VO C/12H
ESPIRONOLACTONA 25 MG VO CADA DIA
ATORVASTATINA 80MG VO NOCHE
INSULINA GLARGINA 20 UI SC EN LA NOCHE ****AJUSTADO 11/02/22*****
INSULINA GLULISINA -6-6-6 UI SC PRECOMIDAS ****AJUSTADO 11/02/22*****
MEDIAS DE COMPRESION MECANICA
SODIO FOSFATO DIBASICO SOLUCION ORAL, DAR 3 DOSIS VO CADA 8 HORAS PREVIO AL PROCEDIMIENTO
SODIO FOSFATO DIABASICO SOLUCION INTRARECTAL. APLICAR 1 ENEMA INTRARECAL PREVIO AL PROCEDIMIENTO

GLUCOMETRIA PRECOMIDAS Y A LAS 21 HORAS
SEGUIMIENTO POR MEDICINA INTERNA
CONTROL DE SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS

PENDIENTE
REPORTE DE HBA1C 08/02/2022
P/COLONOSCOPIA (REPROGRAMADA PARA MAÑANA)

Fecha: 11/02/2022

Indicaciones:

HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGIA
DIETA NORMAL
MASCARILLA N95 PERMANENTE
TAPON VENOSO
AISLAMIENTO RESPIRATORIO
OXIGENOTERAPIA VENTURIA AL 50%, INTENTAR DESCALONAR *****AJUSTADO*****

DIPIRONA 1 GR IV CADA 8 HORAS POR RAZON NECESARIA
RIPE 4 TAB VO CADA 24 HORAS FECHA DE SOLICITUD 16/01/22, (RECIBIO 19-20-26) FECHA DE REINICIO: 26/01/22**** D13
PIRIDOXINA TAB 50 MG VO. DAR 1 TAB CADA 24 H
FORMULA MAGISTRAL: NISTATINA 100.000 UI (5CC) + LIDOCAINA AL 2% JALEA 10 GR (5CC) + HIDROXIDO DE ALUMINIO (5 CC)
REALIZAR LIMPIEZA DE LESIONES CON GASA Y GARGARAS CADA 6 HORAS.
SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 6 HORAS
BROMURO DE IPRATROPIO INH 4 PUFF CADA 8 HORAS
OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS
ENOXAPARINA 40 MG SC DIA

SS TP, TPT DIMERO D, HEMOGRAMA, PCR, BUN, CREATININA, IONOGRAMA, BIL, ALT,

CONTROL DE SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS
CONTROL DE LIQUIDOS ADMISINSTRADOS Y ELIMINADOS
SEGUIMIENTO POR MEDICINA INTERNA E INFECTOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL

PENDIENTE
CATETERISMO CARDIACO DERECHO (JUEVES)
CULTIVO DE ESPUTO ((MUESTRA NO TOMADA)
GeneXpert MTB/RIF (MUESTRA NO TOMADA)
CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS (AMARILLA)

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

Fecha: 11/03/2022

Indicaciones:

- HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA
- MASCARILLA N95 PERMANENTE
- AISLAMIENTO RESPIRATORIO
- DIETA CORRIENTE
- TAPON VENOSO
- OXIGENOTERAPIA POR CANULA NASAL A 3 L/MIN

- TRAMADOL 50 MG IV CADA 12 HORAS
- RIPE 4 TAB VO CADA 24 HORAS **FECHA DE SOLICITUD 16/01/22, (RECIBIO 19-20-26) FECHA DE REINICIO: 26/01/22*** (NO RECIBIO DEL DIA 12 Y 13, 14, 15.)*** REINICIO 16/02 D23
- PIRIDOXINA TAB 50 MG VO CADA 24 H
- FORMULA MAGISTRAL: NISTATINA 100.000 UI (5CC) + LIDOCAINA AL 2% JALEA 10 GR (5CC) + HIDROXIDO DE -ALUMINIO (5 CC)
- REALIZAR LIMPIEZA DE LESIONES CON GASA Y GARGARAS CADA 6 HORAS.
- SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 6 HORAS
- BROMURO DE IPRATROPIO INH 4 PUFF CADA 8 HORAS
- OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS
- ENOXAPARINA 40 MG SC CADA DIAS

SS VALORACION POR NEUMOLOGIA **NUEVO**FS11/03/22

- CONTROL DE SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS
- CONTROL DE LIQUIDOS ADMISTRADOS Y ELIMINADOS
- SEGUIMIENTO POR MEDICINA INTERNA E INFECTOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL

PENDIENTE

TOMOGRFIA COMPUTADA RECONSTRUCCION VIRTUAL CODIGO CUPS 879911

CATERISMO CARDIACO DERECHO

CULTIVO DE ESPUTO (MUESTRA NO TOMADA)

GeneXpert MTB/RIF (MUESTRA NO TOMADA)

CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS (AMARILLA)

Fecha: 11/03/2022

Indicaciones:

- HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGIA
- AISLAMIENTO POR GOTAS
- MASCARILLA N95 PERMANENTE
- DIETA PARA PACIENTE INMUNOCOMPROMETIDO
- TAPON VENOSO

- ACETAMINOFEN 1 GR VO CADA 8 HORAS
- OMEPRAZOL 20 MG VO CADA DIA
- TERAPIA RIPE RIFAMPICINA/ISONIACIDA/PIRACINAMIDA/ETAMBUTOL 150/75/400/275 MG 3 TAB VO CADA DIA) (FI: 27/02/22); D9/56
- ***DIFERIDO 08/03/22***
- PIRIDOXINA 50 MG VO CADA DIA
- ABACAVIR SULFATO Y LAMIVUDINA TAB 600MG/300MG, 1 TAB DIA (LO TIENE EL PACIENTE)
- TRIMETROPIN SULFAMETOXAZOL 160/800 MG IV CADA 8 HORAS **DOSIS PLENA** (FI10/03/22) D1
- ENOXAPARINA 20MG SC CADA 24 HORAS
- MEROPENEM 1 GR IV CADA 8 HORAS (FI 08/03/22) D3
- LINEZOLID 600 MG IV CADA 12 HORAS (FI 08/03/22) D3
- AMIKACINA 250 MG IV CADA 12 HORAS (FI 08/03/22) D3
- CONTROL DE LIQUIDOS ADMISTRADOS Y ELIMINADOS
- SEGUIMIENTO POR MEDICINA INTERNA E INFECTOLOGIA

PENDIENTE

GASES ARTERIALES, UROCULTIVO FS09/03/22

FIBROBRONCOSCOPIA MAS LAVADO BRONQUIAL VEOLAR GENEXPERT (FS 02/03/22)

REPONER HIERRO

ACIDO FOLICO (EN ROJO 24/02)

PTE CARGA VIRAL, AGSHB, IGM HEP A, IGG E IGM HERPES, BACILOSCOPIA 3RA (FS 03/03/22)

Fecha: 11/03/2022

Indicaciones:

ALIMENTO HIPERPROTEICO, DENSAMENTE CALORICO CON HMB Y ALTO CONTENIDO DE VITAMINA D PARA USO ESPECIAL EN ADULTO MAYOR CON DESNUTRICION MODERADA O SEVERA EN CONDICION DE HOSPITALIZACION Y/O CON RECIENTE ALTA HOSPITALARIA - ENSURE CLINICAL. BOTELLA DE 220 ML DAR DOS AL DIA HORARIO 10:00 Y 3:00 PM POR 72 HORAS

Fecha: 11/04/2022

Indicaciones:

- HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

- MASCARILLA N95 PERMANENTE
- AISLAMIENTO RESPIRATORIO
- DIETA CORRIENTE
- TAPON VENOSO
- OXIGENOTERAPIA POR CANULA NASAL PARA SAT02 MAYOR A 88%
- TRAMADOL 50 MG IV CADA 12 HORAS***EN CASO DE DOLOR****
- TERAPIA RIPE 3 TABLETAS VO CADA 24 HORAS **FECHA DE SOLICITUD 16/01/22, (RECIBIO 19-20-26) FECHA DE REINICIO: 26/01/22*** (NO RECIBIO DEL DIA 12 Y 13, 14, 15)*** REINICIO 17/02 D52/56 ***DOSIS 66 HOY 09/04/2022****
- PIRIDOXINA TAB 50 MG VO CADA 24 H
- SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 4 HORAS
- BROMURO DE IPRATROPIO INH 4 PUFF CADA 4 HORAS
- OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS
- ENOXAPARINA 40 MG SC CADA DIAS
- FUROSEMIDA 40 MG VO CADA 24 HORAS
- ACETAMINOFEN 1 GR VIA ORAL POR FIEBRE O DOLOR
- P/OXIGENO DOMICILIARIO **FS: 31/03/22 **
- P/ REPORTE GENEXPERT**05/04/22**
- P BACILOSCIPIA X3 FS:30/03/22 (REPORTADA#1) 02/04/2022 Postiva
- TERAPIA RESPIRATORIA DIARIA
- CONTROL DE SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS
- CONTROL DE LIQUIDOS ADMISTRADOS Y ELIMINADOS
- SEGUIMIENTO POR MEDICINA INTERNA E INFECTOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL

Fecha: 11/04/2022

Indicaciones:

ALIMENTO HIPERPROTEICO, DENSAMENTE CALORICO CON HMB Y ALTO CONTENIDO DE VITAMINA D PARA USO ESPECIAL EN ADULTO MAYOR CON DESNUTRICION MODERADA O SEVERA EN CONDICION DE HOSPITALIZACION Y/O CON RECIENTE ALTA HOSPITALARIA - ENSURE CLINICAL. BOTELLA DE 220 ML DAR DOS AL DIA HORARIO 10:00 Y 3:00PM 6:00 PM

Fecha: 12/01/2022

Indicaciones:

- HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGIA SEGUN RESULTADO DE ANTIGENO SARS COV-2
- AISLAMIENTO RESPIRATORIO Y DE CONTACTO (MASCARILLA N95)
- DIETA CORRIENTE
- TAPON VENOSO
- OXIGENO POR CÁNULA NASAL 2L/MIN SIN SATURACION MENOR A 90%
- LACTATO DE RINGER 500 CC PASAR IV A RAZON DE 80 CC HORA
- BROMURO DE IPRATROPIO INHALADOR 4 PUFF CADA 6 HORAS
- S/S BK SERIADO DE ESPUTO, CULTIVO DE ESPUTO, VIH 1 Y 2
- P/ HEMOGRAMA, BUN, CREATININA, TP, TPT, IONOGRAMA, GLICEMIA, TRANSAMINASAS, BILIRRUBINAS, PCR, LDH
- P/ TAC DE TORAX, ANTIGENO PARA SARS-CoV-2
- CONTROL DE SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS

Fecha: 12/01/2022

Indicaciones:

- TRASLADAR A SALA DE AISLAMIENTO RESPIRATORIO
- AISLAMIENTO RESPIRATORIO Y DE CONTACTO (MASCARILLA N95)
- LACTATO DE RINGER 500 CC PASAR IV A RAZON DE 80 CC HORA
- BROMURO DE IPRATROPIO INHALADOR 4 PUFF CADA 6 HORAS
- S/S HEMOGRAMA, BUN, CREATININA, TP, TPT, IONOGRAMA, GLICEMIA, TRANSAMINASAS, BILIRRUBINAS, PCR, LDH
- S/S TAC DE TORAX
- S/S ANTIGENO PARA SARS-CoV-2
- S/S VALORACION POR MEDICINA INTERNA
- CONTROL DE SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS

Fecha: 12/02/2022

Indicaciones:

- HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA
- DIETA NORMAL
- MASCARILLA N95 PERMANENTE
- TAPON VENOSO
- AISLAMIENTO RESPIRATORIO
- OXIGENOTERAPIA VENTURY AL 50%, INTENTAR DESCALONAR*****AJUSTADO*****
- DIPIRONA 1 GR IV CADA 8 HORAS POR RAZON NECESARIA
- RIPE 4 TAB VO CADA 24 HORAS FECHA DE SOLICITUD 16/01/22, (RECIBIO 19-20-26) FECHA DE REINICIO: 26/01/22**** D15
- PIRIDOXINA TAB 50 MG VO. DAR 1 TAB CADA 24 H
- FORMULA MAGISTRAL: NISTATINA 100.000 UI (5CC) + LIDOCAINA AL 2% JALEA 10 GR (5CC) + HIDROXIDO DE ALUMINIO (5 CC)
- REALIZAR LIMPIEZA DE LESIONES CON GASA Y GARGARAS CADA 6 HORAS.
- SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 6 HORAS
- BROMURO DE IPRATROPIO INH 4 PUFF CADA 8 HORAS
- OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS
- ENOXAPARINA 40 MG SC DIA

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

CONTROL DE SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS
 CONTROL DE LIQUIDOS ADMISINSTRADOS Y ELIMINADOS
 SEGUIMIENTO POR MEDICINA INTERNA E INFECTOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL

PENDIENTE

CATETERISMO CARDIACO DERECHO (JUEVES)

CULTIVO DE ESPUTO ((MUESTRA NO TOMADA)

GeneXpert MTB/RIF (MUESTRA NO TOMADA)

CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS (AMARILLA)

Fecha: 12/03/2022

Indicaciones:

- HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA
- MASCARILLA N95 PERMANENTE
- AISLAMIENTO RESPIRATORIO
- DIETA CORRIENTE
- TAPON VENOSO
- OXIGENOTERAPIA POR MASCARA DE RESERVORIO A 15LTXMIN
- TRAMADOL 50 MG IV CADA 12 HORAS
- RIPE 4 TAB VO CADA 24 HORAS **FECHA DE SOLICITUD 16/01/22, (RECIBIO 19-20-26) FECHA DE REINICIO: 26/01/22*** (NO RECIBIO DEL DIA 12 Y 13, 14, 15.)*** REINICIO 17/02 D23
- PIRIDOXINA TAB 50 MG VO CADA 24 H
- FORMULA MAGISTRAL: NISTATINA 100.000 UI (5CC) + LIDOCAINA AL 2% JALEA 10 GR (5CC) + HIDROXIDO DE -ALUMINIO (5 CC)
- REALIZAR LIMPIEZA DE LESIONES CON GASA Y GARGARAS CADA 6 HORAS.
- METILPREDNISOLONA 40 MG IV DIA FI; 12-03-22
- METILPREDNISOLONA 40 MG IV DIA FI; 12-03-22
- SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 6 HORAS
- BROMURO DE IPRATROPIO INH 4 PUFF CADA 8 HORAS
- OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS
- ENOXAPARINA 40 MG SC CADA DIAS
- SS HEMOGRAMA BUN CREATININA IONOGRAMA GASES ARTERIALES LACTATO ALT AST BILIRRUBINAS
- P/ VALORACION POR NEUMOLOGIA **NUEVO**FS11/03/22
- CONTROL DE SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS
- CONTROL DE LIQUIDOS ADMISINSTRADOS Y ELIMINADOS
- SEGUIMIENTO POR MEDICINA INTERNA E INFECTOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL

Fecha: 12/03/2022

Indicaciones:

- OXIGENOTERAPIA POR MASCARA DE RESERVORIO A 15LTXMIN

Fecha: 12/03/2022

Indicaciones:

- SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 4 HORAS
- BROMURO DE IPRATROPIO INH 4 PUFF CADA 4 HORAS

Fecha: 12/03/2022

Indicaciones:

- METILPREDNISOLONA 80 MG IV AHORA
- CICLO DE RESCATE 3-4 PUFF CADA 20 MIN X 1 HORA REVALORAR

Fecha: 12/04/2022

Indicaciones:

- HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA
- MASCARILLA N95 PERMANENTE
- AISLAMIENTO RESPIRATORIO
- DIETA CORRIENTE
- TAPON VENOSO
- OXIGENOTERAPIA POR CANULA NASAL PARA SATO2 MAYOR A 88%
- TRAMADOL 50 MG IV CADA 12 HORAS***EN CASO DE DOLOR****
- TERAPIA RIPE 3 TABLETAS VO CADA 24 HORAS **FECHA DE SOLICITUD 16/01/22, (RECIBIO 19-20-26) FECHA DE REINICIO: 26/01/22*** (NO RECIBIO DEL DIA 12 Y 13, 14, 15)*** REINICIO 17/02 D52/56 ***DOSIS 66 HOY 09/04/2022****
- PIRIDOXINA TAB 50 MG VO CADA 24 H
- SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 4 HORAS
- BROMURO DE IPRATROPIO INH 4 PUFF CADA 4 HORAS
- OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS
- ENOXAPARINA 40 MG SC CADA DIAS
- FUROSEMIDA 40 MG VO CADA 24 HORAS
- ACETAMINOFEN 1 GR VIA ORAL POR FIEBRE O DOLOR

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

- P BACILOSCIPAX3 FS:30/03/22 (REPORTADA#1) 02/04/2022 Positiva
- TERAPIA RESPIRATORIA DIARIA
- CONTROL DE SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS
- CONTROL DE LIQUIDOS ADMISINSTRADOS Y ELIMINADOS
- SEGUIMIENTO POR MEDICINA INTERNA E INFECTOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL

Fecha: 12/04/2022

Indicaciones:

ALIMENTO HIPERPROTEICO, DENSAMENTE CALORICO CON HMB Y ALTO CONTENIDO DE VITAMINA D PARA USO ESPECIAL EN ADULTO MAYOR CON DESNUTRICION MODERADA O SEVERA EN CONDICION DE HOSPITALIZACION Y/O CON RECIENTE ALTA HOSPITALARIA - ENSURE CLINICAL. BOTELLA DE 220 ML DAR DOS AL DIA HORARIO 10:00 Y 3:00 PM 6:00 PM

Fecha: 13/01/2022

Indicaciones:

1. HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA
2. DIETA NORMAL
3. MASCARILLA N95 PERMANENTE
4. TAPÓN VENOSO
5. OXÍGENO POR CÁNULA NASAL A 2L/MIN SI SATO2 MENOR A 90%
6. LACTATO DE RINGER 500 CC PASAR IV A RAZON DE 80 CC HORA
7. SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 20 MIN POR UNA HORA, LUEGO CADA HORA POR 4 HORAS Y LUEGO CADA 4 HORAS
8. BROMURO DE IPRATROPIO INH 4 PUFF CADA 20 MIN POR UNA HORA, LUEGO CADA HORA POR 4 HORAS Y LUEGO CADA 4 HORAS
9. SS VH 1 Y 2, CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS
10. SS/ VALORACIÓN POR INFECTOLOGÍA CRÍTICA
11. P/ BK SERIADO
12. CSV Y AC

Fecha: 13/01/2022

Indicaciones:

- HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGIA
- AISLAMIENTO RESPIRATORIO Y DE CONTACTO (MASCARILLA N95)
- DIETA CORRIENTE
- TAPON VENOSO
- OXÍGENO POR CÁNULA NASAL 2L/MIN SIN SATURACION MENOR A 90%
- LACTATO DE RINGER 500 CC PASAR IV A RAZON DE 80 CC HORA
- BROMURO DE IPRATROPIO INHALADOR 4 PUFF CADA 6 HORAS
- S/S BK SERIADO DE ESPUTO, CULTIVO DE ESPUTO, VIH 1 Y 2
- S/S VALORACION POR INFECTOLOGIA
- P/ HEMOGRAMA, BUN, CREATININA, TP, TPT, IONOGRAMA, GLICEMIA, TRANSAMINASAS, BILIRRUBINAS, PCR, LDH
- CONTROL DE SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS

Fecha: 13/02/2022

Indicaciones:

- HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA
- DIETA NORMAL
- MASCARILLA N95 PERMANENTE
- TAPON VENOSO
- AISLAMIENTO RESPIRATORIO
- OXIGENOTERAPIA VENTURIAL 50%, INTENTAR DESCALONAR*****AJUSTADO*****
- DIPIRONA 1 GR IV CADA 8 HORAS POR RAZON NECESARIA
- RIPE 4 TAB VO CADA 24 HORAS FECHA DE SOLICITUD 16/01/22, (RECIBIO 19-20-26) FECHA DE REINICIO: 26/01/22**** D15 *** NO RECIBIO DEL DIA 12 Y 13)
- PIRIDOXINA TAB 50 MG VO. DAR 1 TAB CADA 24 H
- FORMULA MAGISTRAL: NISTATINA 100.000 UI (5CC) + LIDOCAINA AL 2% JALEA 10 GR (5CC) + HIDROXIDO DE ALUMINIO (5 CC)
- REALIZAR LIMPIEZA DE LESIONES CON GASA Y GARGARAS CADA 6 HORAS.
- SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 6 HORAS
- BROMURO DE IPRATROPIO INH 4 PUFF CADA 8 HORAS
- OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS
- ENOXAPARINA 40 MG SC DIA

- CONTROL DE SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS
- CONTROL DE LIQUIDOS ADMISINSTRADOS Y ELIMINADOS
- SEGUIMIENTO POR MEDICINA INTERNA E INFECTOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL

PENDIENTE

- CATETERISMO CARDIACO DERECHO (JUEVES)
- CULTIVO DE ESPUTO ((MUESTRA NO TOMADA)
- GeneXpert MTB/RIF (MUESTRA NO TOMADA)
- CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS (AMARILLA)

Fecha: 13/03/2022

Indicaciones:

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

- HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA
 - MASCARILLA N95 PERMANENTE
 - AISLAMIENTO RESPIRATORIO
 - DIETA CORRIENTE
 - TAPON VENOSO
 - OXIGENOTERAPIA POR MASCARA DE RESERVORIO A 15LTXMIN
 - TRAMADOL 50 MG IV CADA 12 HORAS
 - RIPE 4 TAB VO CADA 24 HORAS **FECHA DE SOLICITUD 16/01/22, (RECIBIO 19-20-26) FECHA DE REINICIO: 26/01/22*** (NO RECIBIO DEL DIA 12 Y 13, 14, 15.)*** REINICIO 17/02 D23
 - METILPREDNISOLONA 40 MG IV DIA FI; 12-03-22
 - PIRIDOXINA TAB 50 MG VO CADA 24 H
 - FORMULA MAGISTRAL: NISTATINA 100.000 UI (5CC) + LIDOCAINA AL 2% JALEA 10 GR (5CC) + HIDROXIDO DE -ALUMINIO (5 CC)
 REALIZAR LIMPIEZA DE LESIONES CON GASA Y GARGARAS CADA 6 HORAS.
 - SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 4 HORAS
 - BROMURO DE IPRATROPIO INH 4 PUFF CADA 4 HORAS
 - OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS
 - ENOXAPARINA 40 MG SC CADA DIAS
 - P/ VALORACION POR NEUMOLOGIA **NUEVO** FS11/03/22
 CONTROL DE SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS
 - CONTROL DE LIQUIDOS ADMISINSTRADOS Y ELIMINADOS
 - SEGUIMIENTO POR MEDICINA INTERNA E INFECTOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL

PENDIENTE

TOMOGRFIA COMPUTADA RECONSTRUCCION VIRTUAL CODIGO CUPS 879911

CATETERISMO CARDIACO DERECHO

CULTIVO DE ESPUTO (MUESTRA NO TOMADA)

GeneXpert MTB/RIF (MUESTRA NO TOMADA)

CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS (AMARILLA)

Fecha: 13/04/2022

Indicaciones:

- HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA
 - MASCARILLA N95 PERMANENTE
 - AISLAMIENTO RESPIRATORIO
 - DIETA CORRIENTE
 - TAPON VENOSO
 - OXIGENOTERAPIA POR CANULA NASAL PARA SATO2 MAYOR A 88%

- TRAMADOL 50 MG IV CADA 12 HORAS ***EN CASO DE DOLOR***
 - TERAPIA RIPE 3 TABLETAS VO CADA 24 HORAS **FECHA DE SOLICITUD 16/01/22, (RECIBIO 19-20-26) FECHA DE REINICIO: 26/01/22*** (NO RECIBIO DEL DIA 12 Y 13, 14, 15)*** REINICIO 17/02 D52/56 ***DOSIS 69 HOY 12/04/2022***
 - PIRIDOXINA TAB 50 MG VO CADA 24 H
 - SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 4 HORAS
 - BROMURO DE IPRATROPIO INH 4 PUFF CADA 4 HORAS
 - OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS
 - ENOXAPARINA 40 MG SC CADA DIAS
 - FUROSEMIDA 40 MG VO CADA 24 HORAS
 - ACETAMINOFEN 1 GR VIA ORAL POR FIEBRE O DOLOR

- P BACILOSCIPIA X3 FS:30/03/22 (REPORTADA #1) 02/04/2022 Postiva
 - TERAPIA RESPIRATORIA DIARIA
 - CONTROL DE SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS
 - CONTROL DE LIQUIDOS ADMISINSTRADOS Y ELIMINADOS
 - SEGUIMIENTO POR MEDICINA INTERNA E INFECTOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL

Fecha: 13/04/2022

Indicaciones:

ALIMENTO HIPERPROTEICO, DENSAMENTE CALORICO CON HMB Y ALTO CONTENIDO DE VITAMINA D PARA USO ESPECIAL EN ADULTO MAYOR CON DESNUTRICION MODERADA O SEVERA EN CONDICION DE HOSPITALIZACION Y/O CON RECIENTE ALTA HOSPITALARIA - ENSURE CLINICAL. BOTELLA DE 220 ML DAR DOS AL DIA HORARIO 10:00 Y 3:00 PM 6:00 PM POR 72 HORAS

Fecha: 14/01/2022

Indicaciones:

1. HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA
2. DIETA NORMAL
3. MASCARILLA N95 PERMANENTE
4. TAPÓN VENOSO
5. OXÍGENO POR CANULA NASAL A 2L/MIN SI SATO2 MENOR A 90%
6. LACTATO DE RINGER 500 CC PASAR IV A RAZON DE 80 CC HORA
7. SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 20 MN POR UNA HORA, LUEGO CADA HORA POR 4 HORAS Y LUEGO CADA 4 HORAS
8. BROMURO DE IPRATRO INH 4 PUFF CADA 20 MN POR UNA HORA, LUEGO CADA HORA POR 4 HORAS Y LUEGO CADA 4 HORAS
9. P/ CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS
10. P/ VALORACIÓN POR INFECTOLOGÍA CRÍTICA
11. P/ BK SERIADO
12. CSV Y AC

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

Fecha: 14/02/2022

Indicaciones:

ALIMENTO HIPERPROTEICO, DENSAMENTE CALORICO CON HMB Y ALTO CONTENIDO DE VITAMINA D PARA USO ESPECIAL EN ADULTO MAYOR CON DESNUTRICION MODERADA O SEVERA EN CONDICION DE HOSPITALIZACION Y/O CON RECIENTE ALTA HOSPITALARIA - ENSURE CLINICAL. BOTELLA DE 220 ML DAR DOS AL DIA HORARIO 10:00 Y 3:00

Fecha: 14/02/2022

Indicaciones:

HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA

DIETA NORMAL

MASCARILLA N95 PERMANENTE

TAPON VENOSO

ASLAMIENTO RESPIRATORIO

OXIGENOTERAPIA VENTURIA AL 50%, INTENTAR DESCALONAR*****AJUSTADO*****

DIPIRONA 1 GR IV CADA 8 HORAS POR RAZON NECESARIA

RIPE 4 TAB VO CADA 24 HORAS FECHA DE SOLICITUD 16/01/22, (RECIBIO 19-20-26) FECHA DE REINICIO: 26/01/22**** D15 *** NO RECIBIO DEL DIA 12 Y 13)

PIRIDOXINA TAB 50 MG VO. DAR 1 TAB CADA 24 H

FORMULA MAGISTRAL: NISTATINA 100.000 UI (5CC) + LIDOCAINA AL 2% JALEA 10 GR (5CC) + HIDROXIDO DE ALUMINIO (5 CC)

REALIZAR LIMPIEZA DE LESIONES CON GASA Y GARGARAS CADA 6 HORAS.

SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 6 HORAS

BROMURO DE IPRATROPIO INH 4 PUFF CADA 8 HORAS

OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS

ENOXAPARINA 40 MG SC DIA

SS HEMOGRAMA, PCR, BUN, CREATININA, IONOGRAMA, PCR, AST, ALT, BIL, **** TOMAR HOY 14/02/2022**

CONTROL DE SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS

CONTROL DE LIQUIDOS ADMISTRADOS Y ELIMINADOS

SEGUIMIENTO POR MEDICINA INTERNA E INFECTOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL

PENDIENTE

CATETERISMO CARDIACO DERECHO (JUEVES)

CULTIVO DE ESPUTO ((MUESTRA NO TOMADA)

GeneXpert MTB/RIF (MUESTRA NO TOMADA)

CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS (AMARILLA)

Fecha: 14/03/2022

Indicaciones:

- HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA

- MASCARILLA N95 PERMANENTE

- ASLAMIENTO RESPIRATORIO

- DIETA CORRIENTE

- TAPON VENOSO

- OXIGENOTERAPIA POR MASCARA DE RESERVORIO A 15LTXMIN

- TRAMADOL 50 MG IV CADA 12 HORAS

- RIPE 4 TAB VO CADA 24 HORAS **FECHA DE SOLICITUD 16/01/22, (RECIBIO 19-20-26) FECHA DE REINICIO: 26/01/22*** (NO

RECIBIO DEL DIA 12 Y 13, 14, 15.)*** REINICIO 17/02 D25

-METILPREDNISOLONA 40 MG IV DIA FI; 12-03-22 **ULTIMA DOSIS HOY 14/03/22**

-PREDNISOLONA 40MG VO CADA 24 HORAS **NUEVO**

- PIRIDOXINA TAB 50 MG VO CADA 24 H

- FORMULA MAGISTRAL: NISTATINA 100.000 UI (5CC) + LIDOCAINA AL 2% JALEA 10 GR (5CC) + HIDROXIDO DE -ALUMINIO (5 CC)

REALIZAR LIMPIEZA DE LESIONES CON GASA Y GARGARAS CADA 6 HORAS.

- SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 4 HORAS

- BROMURO DE IPRATROPIO INH 4 PUFF CADA 4 HORAS

- OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS

- ENOXAPARINA 40 MG SC CADA DIAS

- FUROSEMIDA 20 MG IV CADA 8 HORAS *NUEVO**

SS HOSTAL **NUEVO** FS14/03/22

CONTROL DE SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS

- CONTROL DE LIQUIDOS ADMISTRADOS Y ELIMINADOS

- SEGUIMIENTO POR MEDICINA INTERNA E INFECTOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL

PENDIENTE

CATETERISMO CARDIACO DERECHO

CULTIVO DE ESPUTO (MUESTRA NO TOMADA)

GeneXpert MTB/RIF (MUESTRA NO TOMADA)

CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS (AMARILLA)

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

Fecha: 14/03/2022

Indicaciones:

- HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA
- MASCARILLA N95 PERMANENTE
- AISLAMIENTO RESPIRATORIO
- DIETA CORRIENTE
- TAPON VENOSO
- OXIGENOTERAPIA POR MASCARA DE RESERVORIO A 15LT X MIN
- TRAMADOL 50 MG IV CADA 12 HORAS
- RIPE 4 TAB VO CADA 24 HORAS **FECHA DE SOLICITUD 16/01/22, (RECIBIO 19-20-26) FECHA DE REINICIO: 26/01/22*** (NO RECIBIO DEL DIA 12 Y 13, 14, 15.)*** REINICIO 17/02 D25
- METILPREDNISOLONA 40 MG IV DIA FI; 12-03-22
- PIRIDOXINA TAB 50 MG VO CADA 24 H
- FORMULA MAGISTRAL: NISTATINA 100.000 UI (5CC) + LIDOCAINA AL 2% JALEA 10 GR (5CC) + HIDROXIDO DE -ALUMINIO (5 CC)
- REALIZAR LIMPIEZA DE LESIONES CON GASA Y GARGARAS CADA 6 HORAS.
- SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 4 HORAS
- BROMURO DE IPRATROPIO INH 4 PUFF CADA 4 HORAS
- OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS
- ENOXAPARINA 40 MG SC CADA DIAS
- CONTROL DE SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS
- CONTROL DE LIQUIDOS ADMISTRADOS Y ELIMINADOS
- SEGUIMIENTO POR MEDICINA INTERNA E INFECTOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL

PENDIENTE

CATETERISMO CARDIACO DERECHO

CULTIVO DE ESPUTO (MUESTRA NO TOMADA)

GeneXpert MTB/RIF (MUESTRA NO TOMADA)

CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS (AMARILLA)

Fecha: 14/03/2022

Indicaciones:

ALIMENTO HIPERPROTEICO, DENSAMENTE CALORICO CON HMB Y ALTO CONTENIDO DE VITAMINA D PARA USO ESPECIAL EN ADULTO MAYOR CON DESNUTRICION MODERADA O SEVERA EN CONDICION DE HOSPITALIZACION Y/O CON RECIENTE ALTA HOSPITALARIA - ENSURE CLINICAL. BOTELLA DE 220 ML DAR DOS AL DIA HORARIO 10:00 Y 3:00 PM

Fecha: 15/01/2022

Indicaciones:

HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA
 DIETA NORMAL
 MASCARILLA N95 PERMANENTE
 TAPON VENOSO
 AISLAMIENTO RESPIRATORIO
 SE DILIGENCIA FICHA PARA NOTIFICACION PARA TUBERCULOSIS
 OXIGENO POR CANULA NASAL A 2L/MIN SI SATO2 MENOR A 90%
 RIPE 4 TAB VO CADA 24 HORAS FI: 15
 PIRIDOXINA TAB 50 MG 1 TAB CADA 24 H VO
 SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 6 HORAS
 BROMURO DE IPRATRO INH 4 PUFF CADA 8 HORAS
 OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS
 SCORE DE PADUA BAJO RIESGO
 SS/ VALORACION NEUMOLOGIA
 P/ CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS
 CONTROL DE SIGNOS VITALES, AVISAR CAMBIOS

Fecha: 15/02/2022

Indicaciones:

ALIMENTO HIPERPROTEICO, DENSAMENTE CALORICO CON HMB Y ALTO CONTENIDO DE VITAMINA D PARA USO ESPECIAL EN ADULTO MAYOR CON DESNUTRICION MODERADA O SEVERA EN CONDICION DE HOSPITALIZACION Y/O CON RECIENTE ALTA HOSPITALARIA - ENSURE CLINICAL. BOTELLA DE 220 ML DAR DOS AL DIA HORARIO 10:00 Y 3:00

Fecha: 15/02/2022

Indicaciones:

HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA
 DIETA NORMAL
 MASCARILLA N95 PERMANENTE
 TAPON VENOSO
 AISLAMIENTO RESPIRATORIO
 OXIGENOTERAPIA VENTURIA AL 50%, INTENTAR DESCALONAR*****AJUSTADO*****

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

DIPIRONA 1 GR IV CADA 8 HORAS POR RAZON NECESARIA
RIPE 4 TAB VO CADA 24 HORAS FECHA DE SOLICITUD 16/01/22, (RECIBIO 19-20-26) FECHA DE REINICIO: 26/01/22**** D15 *** NO RECIBIO DEL DIA 12 Y 13)
PIRIDOXINA TAB 50 MG VO. DAR 1 TAB CADA 24 H
FORMULA MAGISTRAL: NISTATINA 100.000 UI (5CC) + LIDOCAINA AL 2% JALEA 10 GR (5CC) + HIDROXIDO DE ALUMINIO (5 CC)
REALIZAR LIMPIEZA DE LESIONES CON GASA Y GARGARAS CADA 6 HORAS.
SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 6 HORAS
BROMURO DE IPRATROPIO INH 4 PUFF CADA 8 HORAS
OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS
ENOXAPARINA 40 MG SC DIA

SS TAC DE CORAZON CARDIORESONANCIA CON RECONSTRUCCION 3 D

CONTROL DE SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS
CONTROL DE LIQUIDOS ADMISINSTRADOS Y ELIMINADOS
SEGUIMIENTO POR MEDICINA INTERNA E INFECTOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL

PENDIENTE
CATETERISMO CARDIAO DERECHO (JUEVES)
CULTIVO DE ESPUTO ((MUESTRA NO TOMADA)
GeneXpert MTB/RIF (MUESTRA NO TOMADA)
CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS (AMARILLA)

Fecha: 15/02/2022

Indicaciones:

SS TOMOGRAFIA COMPUTADA DE CORONARIAS CODIGO CUPS 879902
SS TOMOGRAFIA COMPUTADA RECONSTRUCCION VIRTUAL CODIGO CUPS 879911

Fecha: 15/03/2022

Indicaciones:

- HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA
- MASCARILLA N95 PERMANENTE
- AISLAMIENTO RESPIRATORIO
- DIETA CORRIENTE
- TAPON VENOSO
- OXIGENOTERAPIA POR MASCARA DE RESERVORIO A 15LTXMIN

- TRAMADOL 50 MG IV CADA 12 HORAS
- RIPE 4 TAB VO CADA 24 HORAS **FECHA DE SOLICITUD 16/01/22, (RECIBIO 19-20-26) FECHA DE REINICIO: 26/01/22*** (NO RECIBIO DEL DIA 12 Y 13, 14, 15.)*** REINICIO 17/02 D26
- PREDNISOLONA 40MG VO CADA 24 HORAS
- PIRIDOXINA TAB 50 MG VO CADA 24 H
- FORMULA MAGISTRAL: NISTATINA 100.000 UI (5CC) + LIDOCAINA AL 2% JALEA 10 GR (5CC) + HIDROXIDO DE -ALUMINIO (5 CC)
- REALIZAR LIMPIEZA DE LESIONES CON GASA Y GARGARAS CADA 6 HORAS.
- SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 4 HORAS
- BROMURO DE IPRATROPIO INH 4 PUFF CADA 4 HORAS
- OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS
- ENOXAPARINA 40 MG SC CADA DIAS
- FUROSEMIDA 20 MG IV CADA 8 HORAS

SS HEMOGRAMA, IONOGRAMA, AST, ALT**NUEVO** FS15/03/22
CONTROL DE SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS
- CONTROL DE LIQUIDOS ADMISINSTRADOS Y ELIMINADOS
- SEGUIMIENTO POR MEDICINA INTERNA E INFECTOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL

PENDIENTE
P HOSTAL FS14/03/22
CATETERISMO CARDIAO DERECHO
CULTIVO DE ESPUTO (MUESTRA NO TOMADA)
GeneXpert MTB/RIF (MUESTRA NO TOMADA)
CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS (AMARILLA)

Fecha: 15/03/2022

Indicaciones:

ALIMENTO HIPERPROTEICO, DENSAMENTE CALORICO CON HMB Y ALTO CONTENIDO DE VITAMINA D PARA USO ESPECIAL EN ADULTO MAYOR CON DESNUTRICION MODERADA O SEVERA EN CONDICION DE HOSPITALIZACION Y/O CON RECIENTE ALTA HOSPITALARIA - ENSURE CLINICAL. BOTELLA DE 220 ML DAR DOS AL DIA HORARIO 10:00 Y 3:00 PM

Fecha: 16/01/2022

Indicaciones:

HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA
DIETA NORMAL
MASCARILLA N95 PERMANENTE

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

TAPON VENOSO
AISLAMIENTO RESPIRATORIO
SE DILIGENCIA FICHA PARA NOTIFICACION PARA TUBERCULOSIS
OXIGENO POR CANULA NASAL A 2L/MIN SI SATO2 MENOR A 90%
RIPE 4 TAB VO CADA 24 HORAS FI: 15
PIRIDOZINA TAB 50 MG 1 TAB CADA 24 H VO
SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 6 HORAS
BROMURO DE IPRATRO INH 4 PUFF CADA 8 HORAS
OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS
SCORE DE PADUA BAJO RIESGO
P/ VALORACION NEUMOLOGIA
P/ CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS
CONTROL DE SIGNOS VITALES, AMSAR CAMBIOS

Fecha: 16/02/2022

Indicaciones:

ALIMENTO HIPERPROTEICO, DENSAMENTE CALORICO CON HMB Y ALTO CONTENIDO DE VITAMINA D PARA USO ESPECIAL EN ADULTO MAYOR CON DESNUTRICION MODERADA O SEVERA EN CONDICION DE HOSPITALIZACION Y/O CON RECIENTE ALTA HOSPITALARIA - ENSURE CLINICAL. BOTELLA DE 220 ML DAR DOS AL DIA HORARIO 10:00 Y 3:00

Fecha: 16/02/2022

Indicaciones:

HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA
DIETA NORMAL
MASCARILLA N95 PERMANENTE
TAPON VENOSO
AISLAMIENTO RESPIRATORIO
OXIGENOTERAPIA VENTURY AL 50%, INTENTAR DESCALONAR*****AJUTADO*****

DIPIRONA 1 GR IV CADA 8 HORAS POR RAZON NECESARIA
RIPE 4 TAB VO CADA 24 HORAS FECHA DE SOLICITUD 16/01/22, (RECIBIO 19-20-26) FECHA DE REINICIO: 26/01/22**** D15 *** NO RECIBIO DEL DIA 12 Y 13, 14, 15.
PIRIDOXINA TAB 50 MG VO. DAR 1 TAB CADA 24 H
FORMULA MAGISTRAL: NISTATINA 100.000 UI (5CC) + LIDOCAINA AL 2% JALEA 10 GR (5CC) + HIDROXIDO DE ALUMINIO (5 CC)
REALIZAR LIMPIEZA DE LESIONES CON GASA Y GARGARAS CADA 6 HORAS.
SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 6 HORAS
BROMURO DE IPRATROPIO INH 4 PUFF CADA 8 HORAS
OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS
ENOXAPARINA 40 MG SC DIA

SS TOMOGRAFIA COMPUTADA DE CORONARIAS CODIGO CUPS 879902
SS TOMOGRAFIA COMPUTADA RECONSTRUCCION VIRTUAL CODIGO CUPS 879911

CONTROL DE SIGNOS VITALES Y AMSAR CAMBIOS
CONTROL DE LIQUIDOS ADMISISTRADOS Y ELIMINADOS
SEGUIMIENTO POR MEDICINA INTERNA E INFECTOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL

PENDIENTE
CATETERISMO CARDIACO DERECHO (JUEVES)
CULTIVO DE ESPUTO ((MUESTRA NO TOMADA)
GeneXpert MTB/RIF (MUESTRA NO TOMADA)
CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS (AMARILLA)

Fecha: 16/03/2022

Indicaciones:

- HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA
- MASCARILLA N95 PERMANENTE
- AISLAMIENTO RESPIRATORIO
- DIETA CORRIENTE
- TAPON VENOSO
- OXIGENOTERAPIA POR MASCARA DE RESERVORIO A 15LTXMIN

- TRAMADOL 50 MG IV CADA 12 HORAS
- RIPE 4 TAB VO CADA 24 HORAS **FECHA DE SOLICITUD 16/01/22, (RECIBIO 19-20-26) FECHA DE REINICIO: 26/01/22*** (NO RECIBIO DEL DIA 12 Y 13, 14, 15.)*** REINICIO 17/02 D26
- PREDNISOLONA 40MG VO CADA 24 HORAS
- PIRIDOXINA TAB 50 MG VO CADA 24 H
- FORMULA MAGISTRAL: NISTATINA 100.000 UI (5CC) + LIDOCAINA AL 2% JALEA 10 GR (5CC) + HIDROXIDO DE -ALUMINIO (5 CC)
REALIZAR LIMPIEZA DE LESIONES CON GASA Y GARGARAS CADA 6 HORAS.
- SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 4 HORAS
- BROMURO DE IPRATROPIO INH 4 PUFF CADA 4 HORAS
- OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS
- ENOXAPARINA 40 MG SC CADA DIAS

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

- FUROSEMIDA 20 MG IV CADA 8 HORAS
- S/S TERAPIA RESPIRATORIA DIARIA ***NUEVO*** FS16/03/22
- CONTROL DE SIGNOS VITALES Y AMISAR CAMBIOS
- CONTROL DE LIQUIDOS ADMISINSTRADOS Y ELIMINADOS
- SEGUIMIENTO POR MEDICINA INTERNA E INFECTOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL

PENDIENTE

P HOSTAL FS14/03/22

CULTIVO DE ESPUTO (MUESTRA NO TOMADA)

GeneXpert MTB/RIF (MUESTRA NO TOMADA)

CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS (AMARILLA)

Fecha: 16/03/2022

Indicaciones:

ALIMENTO HIPERPROTEICO, DENSAMENTE CALORICO CON HMB Y ALTO CONTENIDO DE VITAMINA D PARA USO ESPECIAL EN ADULTO MAYOR CON DESNUTRICION MODERADA O SEVERA EN CONDICION DE HOSPITALIZACION Y/O CON RECIENTE ALTA HOSPITALARIA - ENSURE CLINICAL. BOTELLA DE 220 ML DAR DOS AL DIA HORARIO 10:00 Y 3:00 PM

Fecha: 17/01/2022

Indicaciones:

HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA

DIETA NORMAL

MASCARILLA N95 PERMANENTE

TAPON VENOSO

AISLAMIENTO RESPIRATORIO

SE DILIGENCIA FICHA PARA NOTIFICACION PARA TUBERCULOSIS

OXÍGENO POR CANULA NASAL A 2L/MIN SI SATO2 MENOR A 90%

RIPE 4 TAB VO CADA 24 HORAS FI: 15

PIRIDOXINA TAB 50 MG 1 TAB CADA 24 H VO

SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 6 HORAS

BROMURO DE IPRATRO INH 4 PUFF CADA 8 HORAS

OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS

SCORE DE PADUA BAJO RIESGO

SS/ GeneXpert MTB/RIF:.....NUEVO:.....

P/ VALORACION NEUMOLOGIA

P/ CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS

CONTROL DE SIGNOS VITALES, AMISAR CAMBIOS

Fecha: 17/02/2022

Indicaciones:

ALIMENTO HIPERPROTEICO, DENSAMENTE CALORICO CON HMB Y ALTO CONTENIDO DE VITAMINA D PARA USO ESPECIAL EN ADULTO MAYOR CON DESNUTRICION MODERADA O SEVERA EN CONDICION DE HOSPITALIZACION Y/O CON RECIENTE ALTA HOSPITALARIA - ENSURE CLINICAL. BOTELLA DE 220 ML DAR DOS AL DIA HORARIO 10:00 Y 3:00

Fecha: 17/02/2022

Indicaciones:

HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA

DIETA NORMAL

MASCARILLA N95 PERMANENTE

TAPON VENOSO

AISLAMIENTO RESPIRATORIO

OXIGENOTERAPIA VENTURIA AL 35 %%, INTENTAR DESCALONAR *****AJUSTADO*****

DIPIRONA 1 GR IV CADA 8 HORAS POR RAZON NECESARIA ***SUSPENDER**

TRAMADOL 50 MG IV CADA 8 HORAS E INFUSION ENDA Y DILUIDA ***NUEVO***

RIPE 4 TAB VO CADA 24 HORAS FECHA DE SOLICITUD 16/01/22, (RECIBIO 19-20-26) FECHA DE REINICIO: 26/01/22**** D15 *** (NO RECIBIO DEL DIA 12 Y 13, 14, 15.)

PIRIDOXINA TAB 50 MG VO. DAR 1 TAB CADA 24 H

FORMULA MAGISTRAL: NISTATINA 100.000 UI (5CC) + LIDOCAINA AL 2% JALEA 10 GR (5CC) + HIDROXIDO DE ALUMINIO (5 CC)

REALIZAR LIMPIEZA DE LESIONES CON GASA Y GARGARAS CADA 6 HORAS.

SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 6 HORAS

BROMURO DE IPRATROPIO INH 4 PUFF CADA 8 HORAS

OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS

ENOXAPARINA 40 MG SC DIA

CONTROL DE SIGNOS VITALES Y AMISAR CAMBIOS

CONTROL DE LIQUIDOS ADMISINSTRADOS Y ELIMINADOS

SEGUIMIENTO POR MEDICINA INTERNA E INFECTOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL

PENDIENTE

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

SS TOMOGRAFIA COMPUTADA DE CORONARIAS CODIGO CUPS 879902
 SS TOMOGRAFIA COMPUTADA RECONSTRUCCION VIRTUAL CODIGO CUPS 879911
 CATETERISMO CARDIACO DERECHO (JUEVES)
 CULTIVO DE ESPUTO ((MUESTRA NO TOMADA)
 GeneXpert MTB/RIF (MUESTRA NO TOMADA)
 CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS (AMARILLA)

Fecha: 17/03/2022

Indicaciones:

- HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA
- MASCARILLA N95 PERMANENTE
- AISLAMIENTO RESPIRATORIO
- DIETA CORRIENTE
- TAPON VENOSO
- OXIGENOTERAPIA POR MASCARA DE RESERVORIO A 15LTXMIN
- TRAMADOL 50 MG IV CADA 12 HORAS
- RIPE 4 TAB VO CADA 24 HORAS **FECHA DE SOLICITUD 16/01/22, (RECIBIO 19-20-26) FECHA DE REINICIO: 26/01/22*** (NO RECIBIO DEL DIA 12 Y 13, 14, 15.)*** REINICIO 17/02 D28
- PREDNISOLONA 40MG VO CADA 24 HORAS
- PIRIDOXINA TAB 50 MG VO CADA 24 H
- FORMULA MAGISTRAL: NISTATINA 100.000 UI (5CC) + LIDOCAINA AL 2% JALEA 10 GR (5CC) + HIDROXIDO DE -ALUMINIO (5 CC)
- REALIZAR LIMPIEZA DE LESIONES CON GASA Y GARGARAS CADA 6 HORAS.
- SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 4 HORAS
- BROMURO DE IPRATROPIO INH 4 PUFF CADA 4 HORAS
- OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS
- ENOXAPARINA 40 MG SC CADA DIAS
- FUROSEMIDA 20 MG IV CADA 8 HORAS
- TERAPIA RESPIRATORIA DIARIA
- CONTROL DE SIGNOS VITALES Y AMSAR CAMBIOS
- CONTROL DE LIQUIDOS ADMISISTRADOS Y ELIMINADOS
- SEGUIMIENTO POR MEDICINA INTERNA E INFECTOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL

PENDIENTE

P HOSTAL FS14/03/22

CULTIVO DE ESPUTO (MUESTRA NO TOMADA)

GeneXpert MTB/RIF (MUESTRA NO TOMADA)

CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS (AMARILLA)

Fecha: 17/03/2022

Indicaciones:

ALIMENTO HIPERPROTEICO, DENSAMENTE CALORICO CON HMB Y ALTO CONTENIDO DE VITAMINA D PARA USO ESPECIAL EN ADULTO MAYOR CON DESNUTRICION MODERADA O SEVERA EN CONDICION DE HOSPITALIZACION Y/O CON RECIENTE ALTA HOSPITALARIA - ENSURE CLINICAL. BOTELLA DE 220 ML DAR DOS AL DIA HORARIO 10:00 Y 3:00 PM

Fecha: 18/01/2022

Indicaciones:

HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA
 DIETA NORMAL
 MASCARILLA N95 PERMANENTE
 TAPON VENOSO
 AISLAMIENTO RESPIRATORIO
 SE DILIGENCIA FICHA PARA NOTIFICACION PARA TUBERCULOSIS
 OXIGENO POR CANULA NASAL A 2L/MIN SI SATO2 MENOR A 90%
 FORMULA MAGISTRAL: HACER GARGARAS ORALES CADA 8 HORAS ::: NUEVO :::
 DIPIRONA 1 GR IV CADA 8 HORAS ::: NUEVO :::
 RIPE 4 TAB VO CADA 24 HORAS
 PIRIDOXINA TAB 50 MG VO. DAR 1 TAB CADA 24 H
 SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 6 HORAS
 BROMURO DE IPRATRO INH 4 PUFF CADA 8 HORAS
 OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS
 SCORE DE PADUA BAJO RIESGO
 P/ GeneXpert MTB/RIF
 P/ CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS
 CONTROL DE SIGNOS VITALES, AMSAR CAMBIOS

Fecha: 18/02/2022

Indicaciones:

ALIMENTO HIPERPROTEICO, DENSAMENTE CALORICO CON HMB Y ALTO CONTENIDO DE VITAMINA D PARA USO ESPECIAL EN ADULTO MAYOR CON DESNUTRICION MODERADA O SEVERA EN CONDICION DE HOSPITALIZACION Y/O CON RECIENTE ALTA HOSPITALARIA - ENSURE CLINICAL. BOTELLA DE 220 ML DAR DOS AL DIA HORARIO 10:00 Y 3:00 POR 72 HORAS

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

Fecha: 18/02/2022

Indicaciones:

HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA

DIETA NORMAL

MASCARILLA N95 PERMANENTE

TAPON VENOSO

AISLAMIENTO RESPIRATORIO

OXIGENOTERAPIA VENTURIA AL 35 %%, INTENTAR DESCALONAR*****AJUTADO*****

TRAMADOL 50 MG IV CADA 8 HORAS E INFUSION ENDA Y DILUIDA**NUEVO***

RIPE 4 TAB VO CADA 24 HORAS FECHA DE SOLICITUD 16/01/22, (RECIBIO 19-20-26) FECHA DE REINICIO: 26/01/22**** D15 *** (NO RECIBIO DEL DIA 12 Y 13, 14, 15.)

PIRIDOXINA TAB 50 MG VO. DAR 1 TAB CADA 24 H

FORMULA MAGISTRAL: NISTATINA 100.000 UI (5CC) + LIDOCAINA AL 2% JALEA 10 GR (5CC) + HIDROXIDO DE ALUMINIO (5 CC)

REALIZAR LIMPIEZA DE LESIONES CON GASA Y GARGARAS CADA 6 HORAS.

SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 6 HORAS

BROMURO DE IPRATROPIO INH 4 PUFF CADA 8 HORAS

OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS

ENOXAPARINA 40 MG SC DIA

CONTROL DE SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS

CONTROL DE LIQUIDOS ADMISTRADOS Y ELIMINADOS

SEGUIMIENTO POR MEDICINA INTERNA E INFECTOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL

PENDIENTE

SS TOMOGRAFIA COMPUTADA DE CORONARIAS CODIGO CUPS 879902

SS TOMOGRAFIA COMPUTADA RECONSTRUCCION VIRTUAL CODIGO CUPS 879911

CATETERISMO CARDIACO DERECHO (JUEVES)

CULTIVO DE ESPUTO ((MUESTRA NO TOMADA)

GeneXpert MTB/RIF (MUESTRA NO TOMADA)

CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS (AMARILLA)

Fecha: 18/03/2022

Indicaciones:

- HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA

- MASCARILLA N95 PERMANENTE

- AISLAMIENTO RESPIRATORIO

- DIETA CORRIENTE

- TAPON VENOSO

- OXIGENOTERAPIA POR MASCARA DE RESERVORIO A 15LTXMIN

- TRAMADOL 50 MG IV CADA 12 HORAS

- RIPE 4 TAB VO CADA 24 HORAS **FECHA DE SOLICITUD 16/01/22, (RECIBIO 19-20-26) FECHA DE REINICIO: 26/01/22**** (NO RECIBIO DEL DIA 12 Y 13, 14, 15.)*** REINICIO 17/02 D29

- PREDNISOLONA 40MG VO CADA 24 HORAS

- PIRIDOXINA TAB 50 MG VO CADA 24 H

- FORMULA MAGISTRAL: NISTATINA 100.000 UI (5CC) + LIDOCAINA AL 2% JALEA 10 GR (5CC) + HIDROXIDO DE -ALUMINIO (5 CC)

REALIZAR LIMPIEZA DE LESIONES CON GASA Y GARGARAS CADA 6 HORAS.

- SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 4 HORAS

- BROMURO DE IPRATROPIO INH 4 PUFF CADA 4 HORAS

- OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS

- ENOXAPARINA 40 MG SC CADA DIAS

- FUROSEMIDA 20 MG IV CADA 8 HORAS

SS HEMOGRAMA FUNCION RENAL IONOGRAMA GLUCOSA CENTRAL GASES ARTERIALES **NUEVO** FS18/03/22

- TERAPIA RESPIRATORIA DIARIA

- CONTROL DE SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS

- CONTROL DE LIQUIDOS ADMISTRADOS Y ELIMINADOS

- SEGUIMIENTO POR MEDICINA INTERNA E INFECTOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL

PENDIENTE

P HOSTAL FS14/03/22

CULTIVO DE ESPUTO (MUESTRA NO TOMADA)

GeneXpert MTB/RIF (MUESTRA NO TOMADA)

CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS (AMARILLA)

Fecha: 18/03/2022

Indicaciones:

ALIMENTO HIPERPROTEICO, DENSAMENTE CALORICO CON HMB Y ALTO CONTENIDO DE VITAMINA D PARA USO ESPECIAL EN ADULTO MAYOR CON DESNUTRICION MODERADA O SEVERA EN CONDICION DE HOSPITALIZACION Y/O CON RECIENTE ALTA HOSPITALARIA - ENSURE CLINICAL. BOTELLA DE 220 ML DAR DOS AL DIA HORARIO 10:00 Y 3:00 PM por 72 horas

Fecha: 18/03/2022

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

Indicaciones:

SS// EKG AHORA

SS// VENTURI AL 50%

RESTO DE ORDENES IGUALES

Fecha: 19/01/2022

Indicaciones:

HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA

DIETA NORMAL

MASCARILLA N95 PERMANENTE

TAPON VENOSO

ASLAMIENTO RESPIRATORIO

SE DILIGENCIA FICHA PARA NOTIFICACION PARA TUBERCULOSIS

OXÍGENO POR CANULA NASAL A 2L/MIN SI SATO2 MENOR A 90%

FORMULA MAGISTRAL: HACER GARGARAS ORALES CADA 8 HORAS

DIPIRONA 1 GR IV CADA 8 HORAS

RIPE 4 TAB VO CADA 24 HORAS

PIRIDOXINA TAB 50 MG VO. DAR 1 TAB CADA 24 H

SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 6 HORAS

BROMURO DE IPRATRO INH 4 PUFF CADA 8 HORAS

OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS

SCORE DE PADUA BAJO RIESGO

P/ GeneXpert MTB/RIF

P/ CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS

CONTROL DE SIGNOS VITALES, AMSAR CAMBIOS

Fecha: 19/02/2022

Indicaciones:

HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA

DIETA NORMAL

MASCARILLA N95 PERMANENTE

TAPON VENOSO

ASLAMIENTO RESPIRATORIO

OXIGENOTERAPIA VENTURI AL 35 %%, INTENTAR DESCALONAR*****AJUTADO*****

TRAMADOL 50 MG IV CADA 8 HORAS E INFUSION LENTA Y DILUIDA**NUEVO***

RIPE 4 TAB VO CADA 24 HORAS *****FECHA DE SOLICITUD 16/01/22, (RECIBIO 19-20-26) FECHA DE REINICIO: 26/01/22*** (NO

RECIBIO DEL DIA 12 Y 13, 14, 15.)*** REINICIO 16/02

PIRIDOXINA TAB 50 MG VO. DAR 1 TAB CADA 24 H

FORMULA MAGISTRAL: NISTATINA 100.000 UI (5CC) + LIDOCAINA AL 2% JALEA 10 GR (5CC) + HIDROXIDO DE ALUMINIO (5 CC)

REALIZAR LIMPIEZA DE LESIONES CON GASA Y GARGARAS CADA 6 HORAS.

SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 6 HORAS

BROMURO DE IPRATROPIO INH 4 PUFF CADA 8 HORAS

OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS

ENOXAPARINA 40 MG SC DIA

CONTROL DE SIGNOS VITALES Y AMSAR CAMBIOS

CONTROL DE LIQUIDOS ADMISINSTRADOS Y ELIMINADOS

SEGUIMIENTO POR MEDICINA INTERNA E INFECTOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL

PENDIENTE

P TOMOGRAFIA COMPUTADA DE CORONARIAS CODIGO CUPS 879902

P TOMOGRAFIA COMPUTADA RECONSTRUCCION VIRTUAL CODIGO CUPS 879911

CATETERISMO CARDIACO DERECHO (JUEVES)

CULTIVO DE ESPUTO ((MUESTRA NO TOMADA)

GeneXpert MTB/RIF (MUESTRA NO TOMADA)

CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS (AMARILLA)

Fecha: 19/03/2022

Indicaciones:

- HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA

- MASCARILLA N95 PERMANENTE

- ASLAMIENTO RESPIRATORIO

- DIETA CORRIENTE

- TAPON VENOSO

- OXIGENOTERAPIA POR MASCARA DE RESERVORIO A 15LTXMIN

- TRAMADOL 50 MG IV CADA 12 HORAS

- RIPE 4 TAB VO CADA 24 HORAS **FECHA DE SOLICITUD 16/01/22, (RECIBIO 19-20-26) FECHA DE REINICIO: 26/01/22*** (NO

RECIBIO DEL DIA 12 Y 13, 14, 15.)*** REINICIO 17/02 D30

- PREDNISOLONA 40MG VO CADA 24 HORAS

- PIRIDOXINA TAB 50 MG VO CADA 24 H

- FORMULA MAGISTRAL: NISTATINA 100.000 UI (5CC) + LIDOCAINA AL 2% JALEA 10 GR (5CC) + HIDROXIDO DE -ALUMINIO (5 CC)

REALIZAR LIMPIEZA DE LESIONES CON GASA Y GARGARAS CADA 6 HORAS.

- SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 4 HORAS

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

- BROMURO DE IPRATROPIO INH 4 PUFF CADA 4 HORAS
- OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS
- ENOXAPARINA 40 MG SC CADA DIAS
- FUROSEMIDA 20 MG IV CADA 8 HORAS

- TERAPIA RESPIRATORIA DIARIA
- CONTROL DE SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS
- CONTROL DE LIQUIDOS ADMISISTRADOS Y ELIMINADOS
- SEGUIMIENTO POR MEDICINA INTERNA E INFECTOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL

PENDIENTE

P HOSTAL FS14/03/22

CULTIVO DE ESPUTO (MUESTRA NO TOMADA)

GeneXpert MTB/RIF (MUESTRA NO TOMADA)

CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS (AMARILLA)

Fecha: 20/01/2022

Indicaciones:

HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA

DIETA NORMAL

MASCARILLA N95 PERMANENTE

TAPON VENOSO

ASLAMIENTO RESPIRATORIO

OXÍGENO POR CANULA NASAL A 2L/MIN SI SATO2 MENOR A 90%

FORMULA MAGISTRAL: HACER GARGARAS ORALES CADA 8 HORAS

DIPIRONA 1 GR IV CADA 8 HORAS :::::PRN:::::

RIPE 4 TAB VO CADA 24 HORAS

PIRIDOXINA TAB 50 MG VO. DAR 1 TAB CADA 24 H

SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 6 HORAS

BROMURO DE IPRATRO INH 4 PUFF CADA 8 HORAS

OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS

SCORE DE PADUA BAJO RIESGO

P/ GeneXpert MTB/RIF

P/ CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS

CONTROL DE SIGNOS VITALES, AMSAR CAMBIOS

Fecha: 20/02/2022

Indicaciones:

HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA

DIETA NORMAL

MASCARILLA N95 PERMANENTE

TAPON VENOSO

ASLAMIENTO RESPIRATORIO

OXIGENOTERAPIA VENTURY AL 35 %, INTENTAR DESCALONAR*****AJUTADO*****

TRAMADOL 50 MG IV CADA 8 HORAS E INFUSION LENTA Y DILUIDA**NUEVO***

RIPE 4 TAB VO CADA 24 HORAS *****FECHA DE SOLICITUD 16/01/22, (RECIBIO 19-20-26) FECHA DE REINICIO: 26/01/22*** (NO RECIBIO DEL DIA 12 Y 13, 14, 15.)*** REINICIO 16/02 D4

PIRIDOXINA TAB 50 MG VO. DAR 1 TAB CADA 24 H

FORMULA MAGISTRAL: NISTATINA 100.000 UI (5CC) + LIDOCAINA AL 2% JALEA 10 GR (5CC) + HIDROXIDO DE ALUMINIO (5 CC)

REALIZAR LIMPIEZA DE LESIONES CON GASA Y GARGARAS CADA 6 HORAS.

SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 6 HORAS

BROMURO DE IPRATROPIO INH 4 PUFF CADA 8 HORAS

OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS

ENOXAPARINA 40 MG SC DIA

CONTROL DE SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS

CONTROL DE LIQUIDOS ADMISISTRADOS Y ELIMINADOS

SEGUIMIENTO POR MEDICINA INTERNA E INFECTOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL

PENDIENTE

P TOMOGRAFIA COMPUTADA DE CORONARIAS CODIGO CUPS 879902

P TOMOGRAFIA COMPUTADA RECONSTRUCCION VIRTUAL CODIGO CUPS 879911

CATETERISMO CARDIACO DERECHO (JUEVES)

CULTIVO DE ESPUTO (MUESTRA NO TOMADA)

GeneXpert MTB/RIF (MUESTRA NO TOMADA)

CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS (AMARILLA)

Fecha: 20/03/2022

Indicaciones:

- HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA

- MASCARILLA N95 PERMANENTE

- ASLAMIENTO RESPIRATORIO

- DIETA CORRIENTE

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

- TAPON VENOSO
- OXIGENOTERAPIA POR MASCARA DE RESERVORIO A 15LTXMIN

- TRAMADOL 50 MG IV CADA 12 HORAS
- RIPE 4 TAB VO CADA 24 HORAS **FECHA DE SOLICITUD 16/01/22, (RECIBIO 19-20-26) FECHA DE REINICIO: 26/01/22*** (NO RECIBIO DEL DIA 12 Y 13, 14, 15.)*** REINICIO 17/02 D30
- PREDNISOLONA 40MG VO CADA 24 HORAS
- PIRIDOXINA TAB 50 MG VO CADA 24 H
- FORMULA MAGISTRAL: NISTATINA 100.000 UI (5CC) + LIDOCAINA AL 2% JALEA 10 GR (5CC) + HIDROXIDO DE -ALUMINIO (5 CC)
REALIZAR LIMPIEZA DE LESIONES CON GASA Y GARGARAS CADA 6 HORAS.
- SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 4 HORAS
- BROMURO DE IPRATROPIO INH 4 PUFF CADA 4 HORAS
- OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS
- ENOXAPARINA 40 MG SC CADA DIAS
- FUROSEMIDA 20 MG IV CADA 8 HORAS
- ACETAMINOFEN 1 GR VO CADA 8 HRS

- TERAPIA RESPIRATORIA DIARIA
- CONTROL DE SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS
- CONTROL DE LIQUIDOS ADMISINSTRADOS Y ELIMINADOS
- SEGUIMIENTO POR MEDICINA INTERNA E INFECTOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL

Fecha: 21/01/2022

Indicaciones:

HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA

DIETA NORMAL

MASCARILLA N95 PERMANENTE

TAPON VENOSO

ASLAMIENTO RESPIRATORIO

OXIGENO POR CANULA NASAL A 2L/MIN SI SATO2 MENOR A 90%

FORMULA MAGISTRAL: HACER GARGARAS ORALES CADA 8 HORAS

DIPIRONA 1 GR IV CADA 8 HORAS ::::PRN:::::

RIPE 4 TAB VO CADA 24 HORAS (PENDIENTE INICO)

PIRIDOXINA TAB 50 MG VO. DAR 1 TAB CADA 24 H

FORMULA MAGISTRAL: NISTATINA 100.000 UI + LIDOCAINA AL 2% JALEA + HIDROXIDO DE ALUMINIO 5 CC, REALIZAR LIMPIEZA DE LESIONES CON GASA Y GARGARAS CADA 6 HORAS.

SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 6 HORAS

BROMURO DE IPRATRO INH 4 PUFF CADA 8 HORAS

OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS

SCORE DE PADUA BAJO RIESGO

SS/ HEMOGRAMA, PCR, TRANSAMINASAS CONTROL, FUNCION RENAL CONTROL (ULTIMOS PROCESADOS EL 16/01/2022)

P/ GeneXpert MTB/RIF

P/ CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS

CONTROL DE SIGNOS VITALES, AVISAR CAMBIOS

DEFINIR INICIO DE ANTIBIOTICO

Fecha: 21/02/2022

Indicaciones:

ALIMENTO HIPERPROTEICO, DENSAMENTE CALORICO CON HMB Y ALTO CONTENIDO DE VITAMINA D PARA USO ESPECIAL EN ADULTO MAYOR CON DESNUTRICION MODERADA O SEVERA EN CONDICION DE HOSPITALIZACION Y/O CON RECIENTE ALTA HOSPITALARIA - ENSURE CLINICAL. BOTELLA DE 220 ML. DAR DOS AL DIA HORARIO 10:00 Y 3:00

Fecha: 21/02/2022

Indicaciones:

HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA

DIETA NORMAL

MASCARILLA N95 PERMANENTE

TAPON VENOSO

ASLAMIENTO RESPIRATORIO

OXIGENOTERAPIA VENTURI AL 50 %, INTENTAR DESCALONAR*****AJUSTADO*****

TRAMADOL 50 MG IV CADA 8 HORAS E INFUSION LENTA Y DILUIDA**NUEVO***

RIPE 4 TAB VO CADA 24 HORAS *****FECHA DE SOLICITUD 16/01/22, (RECIBIO 19-20-26) FECHA DE REINICIO: 26/01/22*** (NO RECIBIO DEL DIA 12 Y 13, 14, 15.)*** REINICIO 16/02 D5

PIRIDOXINA TAB 50 MG VO. DAR 1 TAB CADA 24 H

FORMULA MAGISTRAL: NISTATINA 100.000 UI (5CC) + LIDOCAINA AL 2% JALEA 10 GR (5CC) + HIDROXIDO DE ALUMINIO (5 CC)

REALIZAR LIMPIEZA DE LESIONES CON GASA Y GARGARAS CADA 6 HORAS.

SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 6 HORAS

BROMURO DE IPRATROPIO INH 4 PUFF CADA 8 HORAS

OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS

ENOXAPARINA 40 MG SC DIA

CONTROL DE SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS

CONTROL DE LIQUIDOS ADMISINSTRADOS Y ELIMINADOS

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

SEGUIMIENTO POR MEDICINA INTERNA E INFECTOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL

PENDIENTE

TOMOGRFIA COMPUTADA DE CORONARIAS CODIGO CUPS 879902

TOMOGRFIA COMPUTADA RECONSTRUCCION VIRTUAL CODIGO CUPS 879911

CATETERISMO CARDIACO DERECHO (JUEVES)

CULTIVO DE ESPUTO (MUESTRA NO TOMADA)

GeneXpert MTB/RIF (MUESTRA NO TOMADA)

CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS (AMARILLA)

Fecha: 21/03/2022

Indicaciones:

- HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA

- MASCARILLA N95 PERMANENTE

- AISLAMIENTO RESPIRATORIO

- DIETA CORRIENTE

- TAPON VENOSO

- OXIGENOTERAPIA POR VENTURI **MODIFICADO**

- TRAMADOL 50 MG IV CADA 12 HORAS

- RIPE 4 TAB VO CADA 24 HORAS **FECHA DE SOLICITUD 16/01/22, (RECIBIO 19-20-26) FECHA DE REINICIO: 26/01/22*** (NO

RECIBIO DEL DIA 12 Y 13, 14, 15.)*** REINICIO 17/02 D30

- PREDNISOLONA 40MG VO CADA 24 HORAS

- PIRIDOXINA TAB 50 MG VO CADA 24 H

- FORMULA MAGISTRAL: NISTATINA 100.000 UI (5CC) + LIDOCAINA AL 2% JALEA 10 GR (5CC) + HIDROXIDO DE -ALUMINIO (5 CC)

REALIZAR LIMPIEZA DE LESIONES CON GASA Y GARGARAS CADA 6 HORAS.

- SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 4 HORAS

- BROMURO DE IPRATROPIO INH 4 PUFF CADA 4 HORAS

- OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS

- ENOXAPARINA 40 MG SC CADA DIAS

- FUROSEMIDA 20 MG IV CADA 8 HORAS

- ACETAMINOFEN 1 GR VO CADA 8 HRS

- TERAPIA RESPIRATORIA DIARIA

- CONTROL DE SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS

- CONTROL DE LIQUIDOS ADMISISTRADOS Y ELIMINADOS

- SEGUIMIENTO POR MEDICINA INTERNA E INFECTOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL

PENDIENTE

P HOSTAL FS14/03/22

CULTIVO DE ESPUTO (MUESTRA NO TOMADA)

GeneXpert MTB/RIF (MUESTRA NO TOMADA)

CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS (AMARILLA)

Fecha: 22/01/2022

Indicaciones:

HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA

DIETA NORMAL

MASCARILLA N95 PERMANENTE

TAPON VENOSO

AISLAMIENTO RESPIRATORIO

PIPERACILINA/TAZOBACTAM 4.5 GR IV CADA 6 HORAS FI: 22/01/2022 **NUEVO** INICIO POSTERIOR A TOMA DE HEMOCULTIVOS

CLARITROMICINA 500 MG IV CADA 12 HORAS FI: 22/01/2021 **NUEVO** INICIO POSTERIOR A TOMA DE HEMOCULTIVOS

OXIGENO POR CANULA NASAL A 2L/MIN SI SATO2 MENOR A 90%

DIPIRONA 1 GR IV CADA 8 HORAS POR RAZON NECESARIA

RIPE 4 TAB VO CADA 24 HORAS (PENDIENTE INICIO)

PIRIDOXINA TAB 50 MG VO. DAR 1 TAB CADA 24 H

FORMULA MAGISTRAL: NISTATINA 100.000 UI + LIDOCAINA AL 2% JALEA 10 GR + HIDROXIDO DE ALUMINIO 5 CC, REALIZAR

LIMPIEZA DE LESIONES CON GASA Y GARGARAS CADA 6 HORAS.

SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 6 HORAS

BROMURO DE IPRATRO INH 4 PUFF CADA 8 HORAS

OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS

SCORE DE PADUA BAJO RIESGO

SS/ HEMOCULTIVOS X2

SS/ IONOGRAMA CONTROL, HEMOGRAMA, PCR

SS/ CULTIVO DE ESPUTO

P/ GeneXpert MTB/RIF

P/ CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS

CONTROL DE SIGNOS VITALES, AVISAR CAMBIOS

Fecha: 22/02/2022

Indicaciones:

ALIMENTO HIPERPROTEICO, DENSAMENTE CALORICO CON HMB Y ALTO CONTENIDO DE VITAMINA D PARA USO ESPECIAL EN

ADULTO MAYOR CON DESNUTRICION MODERADA O SEVERA EN CONDICION DE HOSPITALIZACION Y/O CON RECIENTE ALTA

HOSPITALARIA - ENSURE CLINICAL. BOTELLA DE 220 ML DAR DOS AL DIA HORARIO 10:00 Y 3:00

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

Fecha: 22/02/2022

Indicaciones:

HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA

DIETA NORMAL

MASCARILLA N95 PERMANENTE

TAPON VENOSO

ASLAMIENTO RESPIRATORIO

OXIGENOTERAPIA POR CANULA NASAL A 3 L/MIN****AJUSTADO****

TRAMADOL 50 MG IV CADA 8 HORAS E INFUSION LENTA Y DILUIDA**NUEVO***

RIPE 4 TAB VO CADA 24 HORAS *****FECHA DE SOLICITUD 16/01/22, (RECIBIO 19-20-26) FECHA DE REINICIO: 26/01/22*** (NO

RECIBIO DEL DIA 12 Y 13, 14, 15.)*** REINICIO 16/02 D5

PIRIDOXINA TAB 50 MG VO. DAR 1 TAB CADA 24 H

FORMULA MAGISTRAL: NISTATINA 100.000 UI (5CC) + LIDOCAINA AL 2% JALEA 10 GR (5CC) + HIDROXIDO DE ALUMINIO (5 CC)

REALIZAR LIMPIEZA DE LESIONES CON GASA Y GARGARAS CADA 6 HORAS.

SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 6 HORAS

BROMURO DE IPRATROPIO INH 4 PUFF CADA 8 HORAS

OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS

ENOXAPARINA 40 MG SC DIA

CONTROL DE SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS

CONTROL DE LIQUIDOS ADMISINSTRADOS Y ELIMINADOS

SEGUIMIENTO POR MEDICINA INTERNA E INFECTOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL

PENDIENTE

TOMOGRFIA COMPUTADA DE CORONARIAS CODIGO CUPS 879902

TOMOGRFIA COMPUTADA RECONSTRUCCION VIRTUAL CODIGO CUPS 879911

CATETERISMO CARDIACO DERECHO (JUEVES)

CULTIVO DE ESPUTO (MUESTRA NO TOMADA)

GeneXpert MTB/RIF (MUESTRA NO TOMADA)

CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS (AMARILLA)

Fecha: 22/03/2022

Indicaciones:

- HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA

- MASCARILLA N95 PERMANENTE

- ASLAMIENTO RESPIRATORIO

- DIETA CORRIENTE

- TAPON VENOSO

- OXIGENOTERAPIA POR VENTURI

- TRAMADOL 50 MG IV CADA 12 HORAS

- RIPE 4 TAB VO CADA 24 HORAS **FECHA DE SOLICITUD 16/01/22, (RECIBIO 19-20-26) FECHA DE REINICIO: 26/01/22*** (NO

RECIBIO DEL DIA 12 Y 13, 14, 15.)*** REINICIO 17/02 D48/56

- PREDNISOLONA 40MG VO CADA 24 HORAS

- PIRIDOXINA TAB 50 MG VO CADA 24 H

- FORMULA MAGISTRAL: NISTATINA 100.000 UI (5CC) + LIDOCAINA AL 2% JALEA 10 GR (5CC) + HIDROXIDO DE -ALUMINIO (5 CC)

REALIZAR LIMPIEZA DE LESIONES CON GASA Y GARGARAS CADA 6 HORAS.

- SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 4 HORAS

- BROMURO DE IPRATROPIO INH 4 PUFF CADA 4 HORAS

- OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS

- ENOXAPARINA 40 MG SC CADA DIAS

- FUROSEMIDA 20 MG IV CADA 8 HORAS

- ACETAMINOFEN 1 GR VO CADA 8 HRS

SS HEMOGRAMA, IONOGRAMA AST, ALT **NUEVO** FS22/03/22

- TERAPIA RESPIRATORIA DIARIA

- CONTROL DE SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS

- CONTROL DE LIQUIDOS ADMISINSTRADOS Y ELIMINADOS

- SEGUIMIENTO POR MEDICINA INTERNA E INFECTOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL

PENDIENTE

P HOSTAL FS14/03/22

CULTIVO DE ESPUTO (MUESTRA NO TOMADA)

GeneXpert MTB/RIF (MUESTRA NO TOMADA)

CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS (AMARILLA)

Fecha: 22/03/2022

Indicaciones:

ALIMENTO HIPERPROTEICO, DENSAMENTE CALORICO CON HMB Y ALTO CONTENIDO DE VITAMINA D PARA USO ESPECIAL EN

ADULTO MAYOR CON DESNUTRICION MODERADA O SEVERA EN CONDICION DE HOSPITALIZACION Y/O CON RECIENTE ALTA

HOSPITALARIA - ENSURE CLINICAL. BOTELLA DE 220 ML. DAR DOS AL DIA HORARIO 10:00 Y 3:00

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

Fecha: 23/01/2022

Indicaciones:

HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA

DIETA NORMAL

MASCARILLA N95 PERMANENTE

TAPON VENOSO

AISLAMIENTO RESPIRATORIO

PIPERACILINA/TAZOBACTAM 4.5 GR IV CADA 6 HORAS FI: 22/01/2022 **NUEVO** INICIO POSTERIOR A TOMA DE HEMOCULTIVOS

CLARITROMICINA 500 MG IV CADA 12 HORAS FI: 22/01/2021 **NUEVO** INICIO POSTERIOR A TOMA DE HEMOCULTIVOS

OXÍGENO MASCARA DE RESERVORIO A 15L/MIN

DIPIRONA 1 GR IV CADA 8 HORAS POR RAZON NECESARIA

RIPE 4 TAB VO CADA 24 HORAS (PENDIENTE INICIO)

PIRIDOXINA TAB 50 MG VO. DAR 1 TAB CADA 24 H

FORMULA MAGISTRAL: NISTATINA 100.000 UI + LIDOCAINA AL 2% JALEA 10 GR + HIDROXIDO DE ALUMINIO 5 CC, REALIZAR

LIMPIEZA DE LESIONES CON GASA Y GARGARAS CADA 6 HORAS.

SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 6 HORAS

BROMURO DE IPRATRO INH 4 PUFF CADA 8 HORAS

OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS

SCORE DE PADUA BAJO RIESGO

P/ HEMOCULTIVOS X2

P/ CULTIVO DE ESPUTO

P/ GeneXpert MTB/RIF

P/ CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS

CONTROL DE SIGNOS VITALES, AMSAR CAMBIOS

Fecha: 23/01/2022

Indicaciones:

HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA

DIETA NORMAL

MASCARILLA N95 PERMANENTE

TAPON VENOSO

AISLAMIENTO RESPIRATORIO

PIPERACILINA/TAZOBACTAM 4.5 GR IV CADA 6 HORAS FI: 22/01/2022 **NUEVO** INICIO POSTERIOR A TOMA DE HEMOCULTIVOS

CLARITROMICINA 500 MG IV CADA 12 HORAS FI: 22/01/2021 **NUEVO** INICIO POSTERIOR A TOMA DE HEMOCULTIVOS

OXÍGENO POR CANULA NASAL A 2L/MIN SI SATO2 MENOR A 90%

DIPIRONA 1 GR IV CADA 8 HORAS POR RAZON NECESARIA

RIPE 4 TAB VO CADA 24 HORAS (PENDIENTE INICIO)

PIRIDOXINA TAB 50 MG VO. DAR 1 TAB CADA 24 H

FORMULA MAGISTRAL: NISTATINA 100.000 UI + LIDOCAINA AL 2% JALEA 10 GR + HIDROXIDO DE ALUMINIO 5 CC, REALIZAR

LIMPIEZA DE LESIONES CON GASA Y GARGARAS CADA 6 HORAS.

SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 6 HORAS

BROMURO DE IPRATRO INH 4 PUFF CADA 8 HORAS

OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS

SCORE DE PADUA BAJO RIESGO

P/ HEMOCULTIVOS X2

P/ CULTIVO DE ESPUTO

P/ GeneXpert MTB/RIF

P/ CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS

CONTROL DE SIGNOS VITALES, AMSAR CAMBIOS

Fecha: 23/02/2022

Indicaciones:

ALIMENTO HIPERPROTEICO, DENSAMENTE CALORICO CON HMB Y ALTO CONTENIDO DE VITAMINA D PARA USO ESPECIAL EN

ADULTO MAYOR CON DESNUTRICION MODERADA O SEVERA EN CONDICION DE HOSPITALIZACION Y/O CON RECIENTE ALTA

HOSPITALARIA - ENSURE CLINICAL. BOTELLA DE 220 ML. DAR DOS AL DIA HORARIO 10:00 Y 3:00

Fecha: 23/02/2022

Indicaciones:

HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA

DIETA NORMAL

MASCARILLA N95 PERMANENTE

TAPON VENOSO

AISLAMIENTO RESPIRATORIO

OXIGENOTERAPIA POR CANULA NASAL A 3 L/MIN****AJUSTADO****

TRAMADOL 50 MG IV CADA 8 HORAS E INFUSION LENTA Y DILUIDA**NUEVO**

RIPE 4 TAB VO CADA 24 HORAS *****FECHA DE SOLICITUD 16/01/22, (RECIBIO 19-20-26) FECHA DE REINICIO: 26/01/22*** (NO

RECIBIO DEL DIA 12 Y 13, 14, 15.)*** REINICIO 16/02 D5

PIRIDOXINA TAB 50 MG VO. DAR 1 TAB CADA 24 H

FORMULA MAGISTRAL: NISTATINA 100.000 UI (5CC) + LIDOCAINA AL 2% JALEA 10 GR (5CC) + HIDROXIDO DE ALUMINIO (5 CC)

REALIZAR LIMPIEZA DE LESIONES CON GASA Y GARGARAS CADA 6 HORAS.

SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 6 HORAS

BROMURO DE IPRATROPIO INH 4 PUFF CADA 8 HORAS

OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

ENOXAPARINA 40 MG SC DIA

CONTROL DE SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS
CONTROL DE LIQUIDOS ADMISINSTRADOS Y ELIMINADOS
SEGUIMIENTO POR MEDICINA INTERNA E INFECTOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL

PENDIENTE

TOMOGRFIA COMPUTADA DE CORONARIAS CODIGO CUPS 879902
TOMOGRFIA COMPUTADA RECONSTRUCCION VIRTUAL CODIGO CUPS 879911
CATETERISMO CARDIACO DERECHO (JUEVES)
CULTIVO DE ESPUTO (MUESTRA NO TOMADA)
GeneXpert MTB/RIF (MUESTRA NO TOMADA)
CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS (AMARILLA)

Fecha: 23/03/2022

Indicaciones:

- HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA
- MASCARILLA N95 PERMANENTE
- AISLAMIENTO RESPIRATORIO
- DIETA CORRIENTE
- TAPON VENOSO
- OXIGENOTERAPIA POR VENTURI

- TRAMADOL 50 MG IV CADA 12 HORAS
- RIPE 4 TAB VO CADA 24 HORAS **FECHA DE SOLICITUD 16/01/22, (RECIBIO 19-20-26) FECHA DE REINICIO: 26/01/22*** (NO RECIBIO DEL DIA 12 Y 13, 14, 15.)*** REINICIO 17/02 D49/56
- PREDNISOLONA 40MG VO CADA 24 HORAS
- PIRIDOXINA TAB 50 MG VO CADA 24 H
- FORMULA MAGISTRAL: NISTATINA 100.000 UI (5CC) + LIDOCAINA AL 2% JALEA 10 GR (5CC) + HIDROXIDO DE -ALUMINIO (5 CC)
REALIZAR LIMPIEZA DE LESIONES CON GASA Y GARGARAS CADA 6 HORAS.
- SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 4 HORAS
- BROMURO DE IPRATROPIO INH 4 PUFF CADA 4 HORAS
- OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS
- ENOXAPARINA 40 MG SC CADA DIAS
- FUROSEMIDA 20 MG IV CADA 8 HORAS
- ACETAMINOFEN 1 GR VO CADA 8 HRS

P/ HEMOGRAMA, IONOGRAMA AST, ALT * FS22/03/22*

- TERAPIA RESPIRATORIA DIARIA
- CONTROL DE SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS
- CONTROL DE LIQUIDOS ADMISINSTRADOS Y ELIMINADOS
- SEGUIMIENTO POR MEDICINA INTERNA E INFECTOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL

PENDIENTE

P HOSTAL FS14/03/22
CULTIVO DE ESPUTO (MUESTRA NO TOMADA)
GeneXpert MTB/RIF (MUESTRA NO TOMADA)
CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS (AMARILLA)

Fecha: 23/03/2022

Indicaciones:

ALIMENTO HIPERPROTEICO, DENSAMENTE CALORICO CON HMB Y ALTO CONTENIDO DE VITAMINA D PARA USO ESPECIAL EN ADULTO MAYOR CON DESNUTRICION MODERADA O SEVERA EN CONDICION DE HOSPITALIZACION Y/O CON RECIENTE ALTA HOSPITALARIA - ENSURE CLINICAL. BOTELLA DE 220 ML DAR DOS AL DIA HORARIO 10:00 Y 3:00 PM

Fecha: 24/01/2022

Indicaciones:

HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA
DIETA NORMAL
MASCARILLA N95 PERMANENTE
TAPON VENOSO
AISLAMIENTO RESPIRATORIO
OXIGENO POR MASCARA DE NO REINHALACION A 12 LTS/MIN **NUEVO**
PIPERACILINA/TAZOBACTAM 4.5 GR IV CADA 6 HORAS FI: 22/01/2022 **NUEVO*** INICIO POSTERIOR A TOMA DE HEMOCULTIVOS
CLARITROMICINA 500 MG IV CADA 12 HORAS FI: 22/01/2021 **NUEVO** INICIO POSTERIOR A TOMA DE HEMOCULTIVOS
OXÍGENO MASCARA DE RESERVORIO A 15L/MIN
DIPIRONA 1 GR IV CADA 8 HORAS POR RAZON NECESARIA
RIPE 4 TAB VO CADA 24 HORAS (PENDIENTE INICIO)
PIRIDOXINA TAB 50 MG VO. DAR 1 TAB CADA 24 H
FORMULA MAGISTRAL: NISTATINA 100.000 UI + LIDOCAINA AL 2% JALEA 10 GR + HIDROXIDO DE ALUMINIO 5 CC, REALIZAR LIMPIEZA DE LESIONES CON GASA Y GARGARAS CADA 6 HORAS.
SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 6 HORAS
BROMURO DE IPRATRO INH 4 PUFF CADA 8 HORAS
OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

SCORE DE PADUA BAJO RIESGO
 SS/ GASES ARTERIALES EN REPOSO
 P/ HEMOCULTIVOS X2
 P/ CULTIVO DE ESPUTO
 P/ GeneXpert MTB/RIF
 P/ CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS
 CONTROL DE SIGNOS VITALES, AMSAR CAMBIOS

Fecha: 24/02/2022

Indicaciones:

ALIMENTO HIPERPROTEICO, DENSAMENTE CALORICO CON HMB Y ALTO CONTENIDO DE VITAMINA D PARA USO ESPECIAL EN ADULTO MAYOR CON DESNUTRICION MODERADA O SEVERA EN CONDICION DE HOSPITALIZACION Y/O CON RECIENTE ALTA HOSPITALARIA - ENSURE CLINICAL. BOTELLA DE 220 ML DAR DOS AL DIA HORARIO 10:00 Y 3:00

Fecha: 24/02/2022

Indicaciones:

HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA
 DIETA NORMAL
 MASCARILLA N95 PERMANENTE
 TAPON VENOSO
 AISLAMIENTO RESPIRATORIO
 OXIGENOTERAPIA POR CANULA NASAL A 3 L/MIN****AJUSTADO*****

TRAMADOL 50 MG IV CADA 8 HORAS E INFUSION LENTA Y DILUIDA***NUEVO***
 RIPE 4 TAB VO CADA 24 HORAS *****FECHA DE SOLICITUD 16/01/22, (RECIBIO 19-20-26) FECHA DE REINICIO: 26/01/22*** (NO RECIBIO DEL DIA 12 Y 13, 14, 15.)*** REINICIO 16/02 D5
 PIRIDOXINA TAB 50 MG VO. DAR 1 TAB CADA 24 H
 FORMULA MAGISTRAL: NISTATINA 100.000 UI (5CC) + LIDOCAINA AL 2% JALEA 10 GR (5CC) + HIDROXIDO DE ALUMINIO (5 CC)
 REALIZAR LIMPIEZA DE LESIONES CON GASA Y GARGARAS CADA 6 HORAS.
 SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 6 HORAS
 BROMURO DE IPRATROPIO INH 4 PUFF CADA 8 HORAS
 OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS
 ENOXAPARINA 40 MG SC DIA

CONTROL DE SIGNOS VITALES Y AMSAR CAMBIOS
 CONTROL DE LIQUIDOS ADMISTRADOS Y ELIMINADOS
 SEGUIMIENTO POR MEDICINA INTERNA E INFECTOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL

PENDIENTE
 TOMOGRAFIA COMPUTADA DE CORONARIAS CODIGO CUPS 879902
 TOMOGRAFIA COMPUTADA RECONSTRUCCION VIRTUAL CODIGO CUPS 879911
 CATETERISMO CARDIACO DERECHO (JUEVES)
 CULTIVO DE ESPUTO (MUESTRA NO TOMADA)
 GeneXpert MTB/RIF (MUESTRA NO TOMADA)
 CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS (AMARILLA)

Fecha: 24/03/2022

Indicaciones:

- HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA
 - MASCARILLA N95 PERMANENTE
 - AISLAMIENTO RESPIRATORIO
 - DIETA CORRIENTE
 - TAPON VENOSO
 - OXIGENOTERAPIA POR VENTURI

- TRAMADOL 50 MG IV CADA 12 HORAS
 - RIPE 4 TAB VO CADA 24 HORAS **FECHA DE SOLICITUD 16/01/22, (RECIBIO 19-20-26) FECHA DE REINICIO: 26/01/22*** (NO RECIBIO DEL DIA 12 Y 13, 14, 15.)*** REINICIO 17/02 D50/56
 - PREDNISOLONA 40MG VO CADA 24 HORAS **SUSPENDER**
 - PIRIDOXINA TAB 50 MG VO CADA 24 H
 - FORMULA MAGISTRAL: NISTATINA 100.000 UI (5CC) + LIDOCAINA AL 2% JALEA 10 GR (5CC) + HIDROXIDO DE -ALUMINIO (5 CC)
 REALIZAR LIMPIEZA DE LESIONES CON GASA Y GARGARAS CADA 6 HORAS.
 - SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 4 HORAS
 - BROMURO DE IPRATROPIO INH 4 PUFF CADA 4 HORAS
 - OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS
 - ENOXAPARINA 40 MG SC CADA DIAS
 - FUROSEMIDA 20 MG IV CADA 8 HORAS
 - ACETAMINOFEN 1 GR VO CADA 8 HRS

SS/ BACILOSCPIA X3, HEMOGRAMA, IONOGRAMA, AST, ALT * FS24/03/22*

- TERAPIA RESPIRATORIA DIARIA
 - CONTROL DE SIGNOS VITALES Y AMSAR CAMBIOS

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

- CONTROL DE LIQUIDOS ADMISINSTRADOS Y ELIMINADOS
- SEGUIMIENTO POR MEDICINA INTERNA E INFECTOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL

PENDIENTE

P HOSTAL FS14/03/22

CULTIVO DE ESPUTO (MUESTRA NO TOMADA)

GeneXpert MTB/RIF (MUESTRA NO TOMADA)

CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS (AMARILLA)

Fecha: 24/03/2022

Indicaciones:

- HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA
- MASCARILLA N95 PERMANENTE
- AISLAMIENTO RESPIRATORIO
- DIETA CORRIENTE
- TAPON VENOSO
- OXIGENOTERAPIA POR VENTURI

- TRAMADOL 50 MG IV CADA 12 HORAS
- RIPE 4 TAB VO CADA 24 HORAS **FECHA DE SOLICITUD 16/01/22, (RECIBIO 19-20-26) FECHA DE REINICIO: 26/01/22*** (NO RECIBIO DEL DIA 12 Y 13, 14, 15.)*** REINICIO 17/02 D50/56
- PREDNISOLONA 40MG VO CADA 24 HORAS
- PIRIDOXINA TAB 50 MG VO CADA 24 H
- FORMULA MAGISTRAL: NISTATINA 100.000 UI (5CC) + LIDOCAINA AL 2% JALEA 10 GR (5CC) + HIDROXIDO DE -ALUMINIO (5 CC)
- REALIZAR LIMPIEZA DE LESIONES CON GASA Y GARGARAS CADA 6 HORAS.
- SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 4 HORAS
- BROMURO DE IPRATROPIO INH 4 PUFF CADA 4 HORAS
- OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS
- ENOXAPARINA 40 MG SC CADA DIAS
- FUROSEMIDA 20 MG IV CADA 8 HORAS
- ACETAMINOFEN 1 GR VO CADA 8 HRS

SS/ HEMOGRAMA, IONOGRAMA, BUN, CREAT, AST, ALT * FS24/03/22*

- TERAPIA RESPIRATORIA DIARIA
- CONTROL DE SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS
- CONTROL DE LIQUIDOS ADMISINSTRADOS Y ELIMINADOS
- SEGUIMIENTO POR MEDICINA INTERNA E INFECTOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL

PENDIENTE

P HOSTAL FS14/03/22

CULTIVO DE ESPUTO (MUESTRA NO TOMADA)

GeneXpert MTB/RIF (MUESTRA NO TOMADA)

CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS (AMARILLA)

Fecha: 24/03/2022

Indicaciones:

ALIMENTO HIPERPROTEICO, DENSAMENTE CALORICO CON HMB Y ALTO CONTENIDO DE VITAMINA D PARA USO ESPECIAL EN ADULTO MAYOR CON DESNUTRICION MODERADA O SEVERA EN CONDICION DE HOSPITALIZACION Y/O CON RECIENTE ALTA HOSPITALARIA - ENSURE CLINICAL. BOTELLA DE 220 ML DAR DOS AL DIA HORARIO 10:00 Y 3:00 PM

Fecha: 25/01/2022

Indicaciones:

- HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA
- DIETA NORMAL
- MASCARILLA N95 PERMANENTE
- TAPON VENOSO
- AISLAMIENTO RESPIRATORIO
- OXIGENO POR MASCARA DE NO REINHALACION A 12 LTS/MIN **SE SOLICITA INICIAR DESTETE**
- PIPERACILINA/TAZOBACTAM 4.5 GR IV CADA 6 HORAS FI: 22/01/2022
- CLARITROMICINA 500 MG IV CADA 12 HORAS FI: 22/01/2021 **NUEVO** INICIO POSTERIOR A TOMA DE HEMOCULTIVOS
- OXIGENO MASCARA DE RESERVORIO A 15L/MIN
- DIPIRONA 1 GR IV CADA 8 HORAS POR RAZON NECESARIA
- RIPE 4 TAB VO CADA 24 HORAS (PENDIENTE INICIO)
- PIRIDOXINA TAB 50 MG VO. DAR 1 TAB CADA 24 H
- FORMULA MAGISTRAL: NISTATINA 100.000 UI (5CC) + LIDOCAINA AL 2% JALEA 10 GR (5CC) + HIDROXIDO DE ALUMINIO (5 CC)
- REALIZAR LIMPIEZA DE LESIONES CON GASA Y GARGARAS CADA 6 HORAS.
- SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 6 HORAS
- BROMURO DE IPRATROPIO INH 4 PUFF CADA 8 HORAS
- OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS
- SCORE DE PADUA BAJO RIESGO
- SS/ HEMOGRAMA Y PCR
- P/ HEMOCULTIVOS X2 (MUESTRA NO TOMADA)
- P/ CULTIVO DE ESPUTO ((MUESTRA NO TOMADA)
- P/ GeneXpert MTB/RIF (MUESTRA NO TOMADA)

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

P/ CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS (AMARILLA)
CONTROL DE SIGNOS VITALES, AMSAR CAMBIOS

Fecha: 25/02/2022

Indicaciones:

ALIMENTO HIPERPROTEICO, DENSAMENTE CALORICO CON HMB Y ALTO CONTENIDO DE VITAMINA D PARA USO ESPECIAL EN ADULTO MAYOR CON DESNUTRICION MODERADA O SEVERA EN CONDICION DE HOSPITALIZACION Y/O CON RECIENTE ALTA HOSPITALARIA - ENSURE CLINICAL. BOTELLA DE 220 ML DAR DOS AL DIA HORARIO 10:00 Y 3:00 POR 72 HORAS

Fecha: 25/02/2022

Indicaciones:

HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA
DIETA NORMAL
MASCARILLA N95 PERMANENTE
TAPON VENOSO
AISLAMIENTO RESPIRATORIO
OXIGENOTERAPIA POR CANULA NASAL A 3 L/MIN

TRAMADOL 50 MG IV CADA 8 HORAS E INFUSION LENTA Y DILUIDA**NUEVO***
RIPE 4 TAB VO CADA 24 HORAS *****FECHA DE SOLICITUD 16/01/22, (RECIBIO 19-20-26) FECHA DE REINICIO: 26/01/22*** (NO RECIBIO DEL DIA 12 Y 13, 14, 15.)*** REINICIO 16/02 D5
PIRIDOXINA TAB 50 MG VO. DAR 1 TAB CADA 24 H
FORMULA MAGISTRAL: NISTATINA 100.000 UI (5CC) + LIDOCAINA AL 2% JALEA 10 GR (5CC) + HIDROXIDO DE ALUMINIO (5 CC)
REALIZAR LIMPIEZA DE LESIONES CON GASA Y GARGARAS CADA 6 HORAS.
SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 6 HORAS
BROMURO DE IPRATROPIO INH 4 PUFF CADA 8 HORAS
OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS
ENOXAPARINA 40 MG SC DIA*****SUSPENDER**
DALTEPARINA 5000 UI SC CADA DIA**NUEVO*

CONTROL DE SIGNOS VITALES Y AMSAR CAMBIOS
CONTROL DE LIQUIDOS ADMISINSTRADOS Y ELIMINADOS
SEGUIMIENTO POR MEDICINA INTERNA E INFECTOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL

PENDIENTE

TOMOGRFIA COMPUTADA DE CORONARIAS CODIGO CUPS 879902
TOMOGRFIA COMPUTADA RECONSTRUCCION VIRTUAL CODIGO CUPS 879911
CATETERISMO CARDIACO DERECHO (JUEVES)
CULTIVO DE ESPUTO (MUESTRA NO TOMADA)
GeneXpert MTB/RIF (MUESTRA NO TOMADA)
CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS (AMARILLA)

Fecha: 25/03/2022

Indicaciones:

- HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA
- MASCARILLA N95 PERMANENTE
- AISLAMIENTO RESPIRATORIO
- DIETA CORRIENTE
- TAPON VENOSO
- OXIGENOTERAPIA POR VENTURI

- TRAMADOL 50 MG IV CADA 12 HORAS
- RIPE 4 TAB VO CADA 24 HORAS **FECHA DE SOLICITUD 16/01/22, (RECIBIO 19-20-26) FECHA DE REINICIO: 26/01/22*** (NO RECIBIO DEL DIA 12 Y 13, 14, 15.)*** REINICIO 17/02 D50/56
- PIRIDOXINA TAB 50 MG VO CADA 24 H
- FORMULA MAGISTRAL: NISTATINA 100.000 UI (5CC) + LIDOCAINA AL 2% JALEA 10 GR (5CC) + HIDROXIDO DE -ALUMINIO (5 CC)
REALIZAR LIMPIEZA DE LESIONES CON GASA Y GARGARAS CADA 6 HORAS.
- SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 4 HORAS
- BROMURO DE IPRATROPIO INH 4 PUFF CADA 4 HORAS
- OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS
- ENOXAPARINA 40 MG SC CADA DIAS
- FUROSEMIDA 20 MG IV CADA 8 HORAS
- ACETAMINOFEN 1 GR VO CADA 8 HRS

SS AST, ALT, HEMOGRAMA, FUNCION RENAL **NUEVO** FS25/0322

- TERAPIA RESPIRATORIA DIARIA
- CONTROL DE SIGNOS VITALES Y AMSAR CAMBIOS
- CONTROL DE LIQUIDOS ADMISINSTRADOS Y ELIMINADOS
- SEGUIMIENTO POR MEDICINA INTERNA E INFECTOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL

PENDIENTE

P/ BACILOSCPIA X3 FS24/03/22

P HOSTAL FS14/03/22

CULTIVO DE ESPUTO (MUESTRA NO TOMADA)

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

GeneXpert MTB/RIF (MUESTRA NO TOMADA)
CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS (AMARILLA)

Fecha: 25/03/2022

Indicaciones:

ALIMENTO HIPERPROTEICO, DENSAMENTE CALORICO CON HMB Y ALTO CONTENIDO DE VITAMINA D PARA USO ESPECIAL EN ADULTO MAYOR CON DESNUTRICION MODERADA O SEVERA EN CONDICION DE HOSPITALIZACION Y/O CON RECIENTE ALTA HOSPITALARIA - ENSURE CLINICAL. BOTELLA DE 220 ML DAR DOS AL DIA HORARIO 10:00 Y 3:00 PM POR 72 HORAS

Fecha: 26/01/2022

Indicaciones:

HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA

DIETA NORMAL

MASCARILLA N95 PERMANENTE

TAPON VENOSO

ASLAMIENTO RESPIRATORIO

OXIGENO POR MASCARA DE NO REINHALACION A 12 LTS/MIN **SE SOLICITA INICIAR DESTETE**

PIPERACILINA/AZOBACTAM 4.5 GR IV CADA 6 HORAS FI: 22/01/2022

CLARITROMICINA 500 MG IV CADA 12 HORAS FI: 22/01/2021 **NUEVO** INICIO POSTERIOR A TOMA DE HEMOCULTIVOS

OXÍGENO MASCARA DE RESERVORIO A 15L/MIN

DIPIRONA 1 GR IV CADA 8 HORAS POR RAZON NECESARIA

RIPE 4 TAB VO CADA 24 HORAS (PENDIENTE INICIO)

PIRIDOXINA TAB 50 MG VO. DAR 1 TAB CADA 24 H

FORMULA MAGISTRAL: NISTATINA 100.000 UI (5CC) + LIDOCAINA AL 2% JALEA 10 GR (5CC) + HIDROXIDO DE ALUMINIO (5 CC)

REALIZAR LIMPIEZA DE LESIONES CON GASA Y GARGARAS CADA 6 HORAS.

SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 6 HORAS

BROMURO DE IPRATROPIO INH 4 PUFF CADA 8 HORAS

OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS

SCORE DE PADUA BAJO RIESGO

SS/ HEMOGRAMA Y PCR

P/ HEMOCULTIVOS X2 (MUESTRA NO TOMADA)

P/ CULTIVO DE ESPUTO ((MUESTRA NO TOMADA)

P/ GeneXpert MTB/RIF (MUESTRA NO TOMADA)

P/ CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS (AMARILLA)

CONTROL DE SIGNOS VITALES, AMSAR CAMBIOS

Fecha: 26/02/2022

Indicaciones:

HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA

DIETA NORMAL

MASCARILLA N95 PERMANENTE

TAPON VENOSO

ASLAMIENTO RESPIRATORIO

OXIGENOTERAPIA POR CANULA NASAL A 3 L/MIN

TRAMADOL 50 MG IV CADA 8 HORAS E INFUSION LENTA Y DILUIDA

RIPE 4 TAB VO CADA 24 HORAS *****FECHA DE SOLICITUD 16/01/22, (RECIBIO 19-20-26) FECHA DE REINICIO: 26/01/22*** (NO

RECIBIO DEL DIA 12 Y 13, 14, 15.)*** REINICIO 16/02 D6

PIRIDOXINA TAB 50 MG VO. DAR 1 TAB CADA 24 H

FORMULA MAGISTRAL: NISTATINA 100.000 UI (5CC) + LIDOCAINA AL 2% JALEA 10 GR (5CC) + HIDROXIDO DE ALUMINIO (5 CC)

REALIZAR LIMPIEZA DE LESIONES CON GASA Y GARGARAS CADA 6 HORAS.

SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 6 HORAS

BROMURO DE IPRATROPIO INH 4 PUFF CADA 8 HORAS

OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS

DALTEPARINA 5000 UI SC CADA DIA

CONTROL DE SIGNOS VITALES Y AMSAR CAMBIOS

CONTROL DE LIQUIDOS ADMISTRADOS Y ELIMINADOS

SEGUIMIENTO POR MEDICINA INTERNA E INFECTOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL

PENDIENTE

TOMOGRAMIA COMPUTADA DE CORONARIAS CODIGO CUPS 879902

TOMOGRAMIA COMPUTADA RECONSTRUCCION VIRTUAL CODIGO CUPS 879911

CATERISMO CARDIACO DERECHO (JUEVES)

CULTIVO DE ESPUTO (MUESTRA NO TOMADA)

GeneXpert MTB/RIF (MUESTRA NO TOMADA)

CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS (AMARILLA)

Fecha: 26/03/2022

Indicaciones:

- HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA

- MASCARILLA N95 PERMANENTE

- ASLAMIENTO RESPIRATORIO

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

- DIETA CORRIENTE
 - TAPON VENOSO
 - OXIGENOTERAPIA POR CANULA NASAL PARA SAT02 MAYOR A 88%
 - TRAMADOL 50 MG IV CADA 12 HORAS
 - RIPE 4 TAB VO CADA 24 HORAS **FECHA DE SOLICITUD 16/01/22, (RECIBIO 19-20-26) FECHA DE REINICIO: 26/01/22*** (NO RECIBIO DEL DIA 12 Y 13, 14, 15.)*** REINICIO 17/02 D50/56
 - PIRIDOXINA TAB 50 MG VO CADA 24 H
 - FORMULA MAGISTRAL: NISTATINA 100.000 UI (5CC) + LIDOCAINA AL 2% JALEA 10 GR (5CC) + HIDROXIDO DE -ALUMINIO (5 CC)
 REALIZAR LIMPIEZA DE LESIONES CON GASA Y GARGARAS CADA 6 HORAS.
 - SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 4 HORAS
 - BROMURO DE IPRATROPIO INH 4 PUFF CADA 4 HORAS
 - OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS
 - ENOXAPARINA 40 MG SC CADA DIAS
 - FUROSEMIDA 20 MG IV CADA 8 HORAS
 - ACETAMINOFEN 1 GR VO CADA 8 HRS
 S/S HLG, BUN, CREATININA, PCR ***NUEVO***
 TERAPIA RESPIRATORIA DIARIA
 - CONTROL DE SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS
 - CONTROL DE LIQUIDOS ADMISINSTRADOS Y ELIMINADOS
 - SEGUIMIENTO POR MEDICINA INTERNA E INFECTOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL PENDIENTE
 P/ BACILOSCPIA X3 FS24/03/22
 P HOSTAL FS14/03/22
 CULTIVO DE ESPUTO (MUESTRA NO TOMADA)
 GeneXpert MTB/RIF (MUESTRA NO TOMADA)
 CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS (AMARILLA)

Fecha: 27/01/2022

Indicaciones:

HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA

DIETA NORMAL

MASCARILLA N95 PERMANENTE

TAPON VENOSO

ASLAMIENTO RESPIRATORIO

OXIGENO POR VENTURY AL 50% A 10 LTS/MIN **SE SOLICITA INICIAR DESTETE**

PIPERACILINA/TAZOBACTAM 4.5 GR IV CADA 6 HORAS FI: 22/01/2022 D5

CLARITROMICINA 500 MG IV CADA 12 HORAS FI: 22/01/2021 D5

OXÍGENO VENTURY AL 50% A 12 LTS/MIN **INCIAR DESTETE DE OXIGENO**

DIPIRONA 1 GR IV CADA 8 HORAS POR RAZON NECESARIA

RIPE 4 TAB VO CADA 24 HORAS FECHA DE SOLICITUD 16/01/22, FECHA DE INICIO: 26/01/22

PIRIDOXINA TAB 50 MG VO. DAR 1 TAB CADA 24 H

FORMULA MAGISTRAL: NISTATINA 100.000 UI (5CC) + LIDOCAINA AL 2% JALEA 10 GR (5CC) + HIDROXIDO DE ALUMINIO (5 CC)

REALIZAR LIMPIEZA DE LESIONES CON GASA Y GARGARAS CADA 6 HORAS.

SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 6 HORAS

BROMURO DE IPRATRO INH 4 PUFF CADA 8 HORAS

OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS

SCORE DE PADUA BAJO RIESGO

SS/ HEMOGRAMA Y PCR

P/ HEMOCULTIVOS X2 (MUESTRA NO TOMADA)

P/ CULTIVO DE ESPUTO ((MUESTRA NO TOMADA)

P/ GeneXpert MTB/RIF (MUESTRA NO TOMADA)

P/ CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS (AMARILLA)

CONTROL DE SIGNOS VITALES, AMSAR CAMBIOS

Fecha: 27/02/2022

Indicaciones:

HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA

DIETA NORMAL

MASCARILLA N95 PERMANENTE

TAPON VENOSO

ASLAMIENTO RESPIRATORIO

OXIGENOTERAPIA POR CANULA NASAL A 3 L/MIN

TRAMADOL 50 MG IV CADA 8 HORAS E INFUSION LENTA Y DILUIDA

RIPE 4 TAB VO CADA 24 HORAS **FECHA DE SOLICITUD 16/01/22, (RECIBIO 19-20-26) FECHA DE REINICIO: 26/01/22*** (NO RECIBIO DEL DIA 12 Y 13, 14, 15.)*** REINICIO 16/02 D7

PIRIDOXINA TAB 50 MG VO. DAR 1 TAB CADA 24 H

FORMULA MAGISTRAL: NISTATINA 100.000 UI (5CC) + LIDOCAINA AL 2% JALEA 10 GR (5CC) + HIDROXIDO DE ALUMINIO (5 CC)

REALIZAR LIMPIEZA DE LESIONES CON GASA Y GARGARAS CADA 6 HORAS.

SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 6 HORAS

BROMURO DE IPRATROPIO INH 4 PUFF CADA 8 HORAS

OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS

DALTEPARINA 5000 UI SC CADA DIA

CONTROL DE SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS

CONTROL DE LIQUIDOS ADMISINSTRADOS Y ELIMINADOS

SEGUIMIENTO POR MEDICINA INTERNA E INFECTOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL

PENDIENTE

TOMOGRAMIA COMPUTADA DE CORONARIAS CODIGO CUPS 879902

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

TOMOGRFIA COMPUTADA RECONSTRUCCION VIRTUAL CODIGO CUPS 879911
CATETERISMO CARDIACO DERECHO (JUEVES)
CULTIVO DE ESPUTO (MUESTRA NO TOMADA)
GeneXpert MTB/RIF (MUESTRA NO TOMADA)
CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS (AMARILLA)

Fecha: 27/03/2022

Indicaciones:

- HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA
- MASCARILLA N95 PERMANENTE
- AISLAMIENTO RESPIRATORIO
- DIETA CORRIENTE
- TAPON VENOSO
- OXIGENOTERAPIA POR CANULA NASAL PARA SATO2 MAYOR A 88%
- TRAMADOL 50 MG IV CADA 12 HORAS
- RIPE 4 TAB VO CADA 24 HORAS **FECHA DE SOLICITUD 16/01/22, (RECIBIO 19-20-26) FECHA DE REINICIO: 26/01/22*** (NO RECIBIO DEL DIA 12 Y 13, 14, 15.)*** REINICIO 17/02 D50/56
- PIRIDOXINA TAB 50 MG VO CADA 24 H
- FORMULA MAGISTRAL: NISTATINA 100.000 UI (5CC) + LIDOCAINA AL 2% JALEA 10 GR (5CC) + HIDROXIDO DE -ALUMINIO (5 CC)
- REALIZAR LIMPIEZA DE LESIONES CON GASA Y GARGARAS CADA 6 HORAS.
- SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 4 HORAS
- BROMURO DE IPRATROPIO INH 4 PUFF CADA 4 HORAS
- OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS
- ENOXAPARINA 40 MG SC CADA DIAS
- FUROSEMIDA 20 MG IV CADA 8 HORAS
- ACETAMINOFEN 1 GR VO CADA 8 HRS
- TERAPIA RESPIRATORIA DIARIA
- CONTROL DE SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS
- CONTROL DE LIQUIDOS ADMISISTRADOS Y ELIMINADOS
- SEGUIMIENTO POR MEDICINA INTERNA E INFECTOLOGIA Y TRABAJO SOCIA

Fecha: 28/01/2022

Indicaciones:

- HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA
- DIETA NORMAL
- MASCARILLA N95 PERMANENTE
- TAPON VENOSO
- AISLAMIENTO RESPIRATORIO
- OXIGENO POR VENTURY AL 50% A 12 LTS/MIN **SE SOLICITA INICIAR DESTETE**
- PIPERACILINA/TAZOBACTAM 4.5 GR IV CADA 6 HORAS FI: 22/01/2022 D6
- CLARITROMICINA 500 MG IV CADA 12 HORAS FI: 22/01/2021 D6
- OXÍGENO VENTURY AL 50% A 12 LTS/MIN **INCIAR DESTETE DE OXIGENO**
- DIPIRONA 1 GR IV CADA 8 HORAS POR RAZON NECESARIA
- RIPE 4 TAB VO CADA 24 HORAS FECHA DE SOLICITUD 16/01/22, FECHA DE INICIO: 26/01/22
- PIRIDOXINA TAB 50 MG VO. DAR 1 TAB CADA 24 H
- FORMULA MAGISTRAL: NISTATINA 100.000 UI (5CC) + LIDOCAINA AL 2% JALEA 10 GR (5CC) + HIDROXIDO DE ALUMINIO (5 CC)
- REALIZAR LIMPIEZA DE LESIONES CON GASA Y GARGARAS CADA 6 HORAS.
- SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 6 HORAS
- BROMURO DE IPRATRO INH 4 PUFF CADA 8 HORAS
- OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS
- SCORE DE PADUA BAJO RIESGO
- SS/ VALORACION POR NUTRICION
- P/ HEMOCULTIVOS X2 (MUESTRA NO TOMADA)
- P/ CULTIVO DE ESPUTO ((MUESTRA NO TOMADA)
- P/ GeneXpert MTB/RIF (MUESTRA NO TOMADA)
- P/ CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS (AMARILLA)
- CONTROL DE SIGNOS VITALES, AMSAR CAMBIOS

Fecha: 28/02/2022

Indicaciones:

- ALIMENTO HIPERPROTEICO, DENSAMENTE CALORICO CON HMB Y ALTO CONTENIDO DE VITAMINA D PARA USO ESPECIAL EN ADULTO MAYOR CON DESNUTRICION MODERADA O SEVERA EN CONDICION DE HOSPITALIZACION Y/O CON RECIENTE ALTA HOSPITALARIA - ENSURE CLINICAL. BOTELLA DE 220 ML DAR DOS AL DIA HORARIO 10:00 Y 3:00

Fecha: 28/02/2022

Indicaciones:

- HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA
- DIETA NORMAL
- MASCARILLA N95 PERMANENTE
- TAPON VENOSO
- AISLAMIENTO RESPIRATORIO
- OXIGENOTERAPIA POR CANULA NASAL A 3 L/MIN

TRAMADOL 50 MG IV CADA 8 HORAS E INFUSION LENTA Y DILUIDA

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

RIPE 4 TAB VO CADA 24 HORAS **FECHA DE SOLICITUD 16/01/22, (RECIBIO 19-20-26) FECHA DE REINICIO: 26/01/22*** (NO RECIBIO DEL DIA 12 Y 13, 14, 15.)*** REINICIO 16/02 D12
 PIRIDOXINA TAB 50 MG VO. DAR 1 TAB CADA 24 H
 FORMULA MAGISTRAL: NISTATINA 100.000 UI (5CC) + LIDOCAINA AL 2% JALEA 10 GR (5CC) + HIDROXIDO DE ALUMINIO (5 CC)
 REALIZAR LIMPIEZA DE LESIONES CON GASA Y GARGARAS CADA 6 HORAS.
 SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 6 HORAS
 BROMURO DE IPRATROPIO INH 4 PUFF CADA 8 HORAS
 OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS
 DALTEPARINA 5000 UI SC CADA DIA
 CONTROL DE SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS
 CONTROL DE LIQUIDOS ADMISINSTRADOS Y ELIMINADOS
 SEGUIMIENTO POR MEDICINA INTERNA E INFECTOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL

PENDIENTE
 TOMOGRAFIA COMPUTADA DE CORONARIAS CODIGO CUPS 879902
 TOMOGRAFIA COMPUTADA RECONSTRUCCION VIRTUAL CODIGO CUPS 879911
 CATETERISMO CARDIACO DERECHO (JUEVES)
 CULTIVO DE ESPUTO (MUESTRA NO TOMADA)
 GeneXpert MTB/RIF (MUESTRA NO TOMADA)
 CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS (AMARILLA)

PASAR RESETARIO PARA TERAPIA RIPE 28/02

Fecha: 28/03/2022

Indicaciones:

- HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA
- MASCARILLA N95 PERMANENTE
- AISLAMIENTO RESPIRATORIO
- DIETA CORRIENTE
- TAPON VENOSO
- OXIGENOTERAPIA POR CANULA NASAL PARA SATO2 MAYOR A 88%

- TRAMADOL 50 MG IV CADA 12 HORAS
- RIPE 4 TAB VO CADA 24 HORAS **FECHA DE SOLICITUD 16/01/22, (RECIBIO 19-20-26) FECHA DE REINICIO: 26/01/22*** (NO RECIBIO DEL DIA 12 Y 13, 14, 15)*** REINICIO 17/02 D50/56
- PIRIDOXINA TAB 50 MG VO CADA 24 H
- FORMULA MAGISTRAL: NISTATINA 100.000 UI (5CC) + LIDOCAINA AL 2% JALEA 10 GR (5CC) + HIDROXIDO DE -ALUMINIO (5 CC)
- REALIZAR LIMPIEZA DE LESIONES CON GASA Y GARGARAS CADA 6 HORAS. ***SUSPENDER***
- SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 4 HORAS
- BROMURO DE IPRATROPIO INH 4 PUFF CADA 4 HORAS
- OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS
- ENOXAPARINA 40 MG SC CADA DIAS
- FUROSEMIDA 20 MG IV CADA 8 HORAS
- ACETAMINOFEN 1 GR VO CADA 8 HRS

- TERAPIA RESPIRATORIA DIARIA
- CONTROL DE SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS
- CONTROL DE LIQUIDOS ADMISINSTRADOS Y ELIMINADOS
- SEGUIMIENTO POR MEDICINA INTERNA E INFECTOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL

PENDIENTE

P/ BACILOSCPIA X3 FS24/03/22

P HOSTAL FS14/03/22

CULTIVO DE ESPUTO (MUESTRA NO TOMADA)

GeneXpert MTB/RIF (MUESTRA NO TOMADA)

CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS (AMARILLA)

Fecha: 28/03/2022

Indicaciones:

ALIMENTO HIPERPROTEICO, DENSAMENTE CALORICO CON HMB Y ALTO CONTENIDO DE VITAMINA D PARA USO ESPECIAL EN ADULTO MAYOR CON DESNUTRICION MODERADA O SEVERA EN CONDICION DE HOSPITALIZACION Y/O CON RECIENTE ALTA HOSPITALARIA - ENSURE CLINICAL. BOTELLA DE 220 ML DAR DOS AL DIA HORARIO 10:00 Y 3:00 PM

Fecha: 29/01/2022

Indicaciones:

- HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA
- DIETA NORMAL
- MASCARILLA N95 PERMANENTE
- TAPON VENOSO
- AISLAMIENTO RESPIRATORIO
- OXIGENO POR VENTURY AL 50% A 12 LTS/MIN **SE SOLICITA INICIAR DESTETE**
- PIPERACILINA/TAZOBACTAM 4.5 GR IV CADA 6 HORAS FI: 22/01/2022 D7
- CLARITROMICINA 500 MG IV CADA 12 HORAS FI: 22/01/2021 D7
- OXÍGENO VENTURY AL 50% A 12 LTS/MIN **INCIAR DESTETE DE OXIGENO**

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

DIPIRONA 1 GR IV CADA 8 HORAS POR RAZON NECESARIA
 RIPE 4 TAB VO CADA 24 HORAS FECHA DE SOLICITUD 16/01/22, FECHA DE INICIO: 26/01/22
 PIRIDOXINA TAB 50 MG VO. DAR 1 TAB CADA 24 H
 FORMULA MAGISTRAL: NISTATINA 100.000 UI (5CC) + LIDOCAINA AL 2% JALEA 10 GR (5CC) + HIDROXIDO DE ALUMINIO (5 CC)
 REALIZAR LIMPIEZA DE LESIONES CON GASA Y GARGARAS CADA 6 HORAS.
 SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 6 HORAS
 BROMURO DE IPRATRO INH 4 PUFF CADA 8 HORAS
 OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS
 SCORE DE PADUA BAJO RIESGO
 P// VALORACION POR NUTRICION
 P/ HEMOCULTIVOS X2 (MUESTRA NO TOMADA)
 P/ CULTIVO DE ESPUTO ((MUESTRA NO TOMADA)
 P/ GeneXpert MTB/RIF (MUESTRA NO TOMADA)
 P/ CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS (AMARILLA)
 CONTROL DE SIGNOS VITALES, AMSAR CAMBIOS

Fecha: 29/03/2022

Indicaciones:

- HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA
- MASCARILLA N95 PERMANENTE
- AISLAMIENTO RESPIRATORIO
- DIETA CORRIENTE
- TAPON VENOSO
- OXIGENOTERAPIA POR CANULA NASAL PARA SATO2 MAYOR A 88%

- TRAMADOL 50 MG IV CADA 12 HORAS
- RIPE 4 TAB VO CADA 24 HORAS **FECHA DE SOLICITUD 16/01/22, (RECIBIO 19-20-26) FECHA DE REINICIO: 26/01/22*** (NO RECIBIO DEL DIA 12 Y 13, 14, 15)*** REINICIO 17/02 D51/56
- PIRIDOXINA TAB 50 MG VO CADA 24 H
- SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 4 HORAS
- BROMURO DE IPRATROPIO INH 4 PUFF CADA 4 HORAS
- OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS
- ENOXAPARINA 40 MG SC CADA DIAS
- FUROSEMIDA 20 MG IV CADA 8 HORAS
- ACETAMINOFEN 1 GR VO CADA 8 HRS

SS HEMOGRAMA, IONOGRAMA, AST, ALT **NUEVO** FS29/03/22

- TERAPIA RESPIRATORIA DIARIA
- CONTROL DE SIGNOS VITALES Y AMSAR CAMBIOS
- CONTROL DE LIQUIDOS ADMISTRADOS Y ELIMINADOS
- SEGUIMIENTO POR MEDICINA INTERNA E INFECTOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL

PENDIENTE

P/ BACILOSCPIA X3 FS24/03/22

P HOSTAL FS14/03/22

CULTIVO DE ESPUTO (MUESTRA NO TOMADA)

GeneXpert MTB/RIF (MUESTRA NO TOMADA)

CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS (AMARILLA)

Fecha: 29/03/2022

Indicaciones:

ALIMENTO HIPERPROTEICO, DENSAMENTE CALORICO CON HMB Y ALTO CONTENIDO DE VITAMINA D PARA USO ESPECIAL EN ADULTO MAYOR CON DESNUTRICION MODERADA O SEVERA EN CONDICION DE HOSPITALIZACION Y/O CON RECIENTE ALTA HOSPITALARIA - ENSURE CLINICAL. BOTELLA DE 220 ML DAR DOS AL DIA HORARIO 10:00 Y 3:00 PM

Fecha: 30/01/2022

Indicaciones:

HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA

DIETA NORMAL

MASCARILLA N95 PERMANENTE

TAPON VENOSO

AISLAMIENTO RESPIRATORIO

MASCARA DE NO REINHALACION A 10 LTS/MIN **MODIFICADO**

PIPERACILINA/TAZOBACTAM 4.5 GR IV CADA 6 HORAS FI: 22/01/2022 **SUSPENDER**

CLARITROMICINA 500 MG IV CADA 12 HORAS FI: 22/01/2021 **SUSPENDER**

DIPIRONA 1 GR IV CADA 8 HORAS POR RAZON NECESARIA

RIPE 4 TAB VO CADA 24 HORAS FECHA DE SOLICITUD 16/01/22, FECHA DE INICIO: 26/01/22

PIRIDOXINA TAB 50 MG VO. DAR 1 TAB CADA 24 H

FORMULA MAGISTRAL: NISTATINA 100.000 UI (5CC) + LIDOCAINA AL 2% JALEA 10 GR (5CC) + HIDROXIDO DE ALUMINIO (5 CC)

REALIZAR LIMPIEZA DE LESIONES CON GASA Y GARGARAS CADA 6 HORAS.

SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 6 HORAS

BROMURO DE IPRATRO INH 4 PUFF CADA 8 HORAS

OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS

SCORE DE PADUA BAJO RIESGO

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

P/ VALORACION POR NUTRICION
 SS/ ECOCARDIOGRAMA TT **NUEVO**
 P/ CULTIVO DE ESPUTO ((MUESTRA NO TOMADA)
 P/ GeneXpert MTB/RIF (MUESTRA NO TOMADA)
 P/ CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS (AMARILLA)
 CONTROL DE SIGNOS VITALES, AMSAR CAMBIOS

Fecha: 30/03/2022

Indicaciones:

- HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA
- MASCARILLA N95 PERMANENTE
- AISLAMIENTO RESPIRATORIO
- DIETA CORRIENTE
- TAPON VENOSO
- OXIGENOTERAPIA POR CANULA NASAL PARA SATO2 MAYOR A 88%
- TRAMADOL 50 MG IV CADA 12 HORAS
- RIPE 4 TAB VO CADA 24 HORAS **FECHA DE SOLICITUD 16/01/22, (RECIBIO 19-20-26) FECHA DE REINICIO: 26/01/22*** (NO RECIBIO DEL DIA 12 Y 13, 14, 15)*** REINICIO 17/02 D51/56
- PIRIDOXINA TAB 50 MG VO CADA 24 H
- SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 4 HORAS
- BROMURO DE IPRATROPIO INH 4 PUFF CADA 4 HORAS
- OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS
- ENOXAPARINA 40 MG SC CADA DIAS
- FUROSEMIDA 20 MG IV CADA 8 HORAS
- ACETAMINOFEN 1 GR VO CADA 8 HRS

SS BACILOSCPIA X3 FS30/03/22

- TERAPIA RESPIRATORIA DIARIA
- CONTROL DE SIGNOS VITALES Y AMSAR CAMBIOS
- CONTROL DE LIQUIDOS ADMISTRADOS Y ELIMINADOS
- SEGUIMIENTO POR MEDICINA INTERNA E INFECTOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL

PENDIENTE

P HEMOGRAMA FS29/03/22

P HOSTAL FS14/03/22

CULTIVO DE ESPUTO (MUESTRA NO TOMADA)

GeneXpert MTB/RIF (MUESTRA NO TOMADA)

CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS (AMARILLA)

Fecha: 30/03/2022

Indicaciones:

ALIMENTO HIPERPROTEICO, DENSAMENTE CALORICO CON HMB Y ALTO CONTENIDO DE VITAMINA D PARA USO ESPECIAL EN ADULTO MAYOR CON DESNUTRICION MODERADA O SEVERA EN CONDICION DE HOSPITALIZACION Y/O CON RECIENTE ALTA HOSPITALARIA - ENSURE CLINICAL. BOTELLA DE 220 ML DAR DOS AL DIA HORARIO 10:00 Y 3:00 PM

Fecha: 31/01/2022

Indicaciones:

HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA
 DIETA NORMAL
 MASCARILLA N95 PERMANENTE
 TAPON VENOSO
 AISLAMIENTO RESPIRATORIO
 MASCARA DE NO REINHALACION A 10 LTS/MIN **EN DESTETE**
 DIPIRONA 1 GR IV CADA 8 HORAS POR RAZON NECESARIA
 RIPE 4 TAB VO CADA 24 HORAS FECHA DE SOLICITUD 16/01/22, FECHA DE INICIO: 26/01/22
 PIRIDOXINA TAB 50 MG VO. DAR 1 TAB CADA 24 H
 FORMULA MAGISTRAL: NISTATINA 100.000 UI (5CC) + LIDOCAINA AL 2% JALEA 10 GR (5CC) + HIDROXIDO DE ALUMINIO (5 CC)
 REALIZAR LIMPIEZA DE LESIONES CON GASA Y GARGARAS CADA 6 HORAS.
 SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 6 HORAS
 BROMURO DE IPRATRO INH 4 PUFF CADA 8 HORAS
 OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS
 SCORE DE PADUA BAJO RIESGO
 P/ VALORACION POR NUTRICION
 P/ ECOCARDIOGRAMA TT
 P/ CULTIVO DE ESPUTO ((MUESTRA NO TOMADA)
 P/ GeneXpert MTB/RIF (MUESTRA NO TOMADA)
 P/ CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS (AMARILLA)
 CONTROL DE SIGNOS VITALES, AMSAR CAMBIOS

Fecha: 31/01/2022

Indicaciones:

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA
 DIETA NORMAL
 MASCARILLA N95 PERMANENTE
 TAPON VENOSO
 AISLAMIENTO RESPIRATORIO
 MASCARA DE NO REINHALACION A 10 LTS/MIN **EN DESTETE**
 PIPERACILINA/TAZOBACTAM 4.5 GR IV CADA 6 HORAS FI: 22/01/2022 **SUSPENDER**
 CLARITROMICINA 500 MG IV CADA 12 HORAS FI: 22/01/2021 **SUSPENDER**
 DIPIRONA 1 GR IV CADA 8 HORAS POR RAZON NECESARIA
 RIPE 4 TAB VO CADA 24 HORAS FECHA DE SOLICITUD 16/01/22, FECHA DE INICIO: 26/01/22
 PIRIDOXINA TAB 50 MG VO. DAR 1 TAB CADA 24 H
 FORMULA MAGISTRAL: NISTATINA 100.000 UI (5CC) + LIDOCAINA AL 2% JALEA 10 GR (5CC) + HIDROXIDO DE ALUMINIO (5 CC)
 REALIZAR LIMPIEZA DE LESIONES CON GASA Y GARGARAS CADA 6 HORAS.
 SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 6 HORAS
 BROMURO DE IPRATRO INH 4 PUFF CADA 8 HORAS
 OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS
 SCORE DE PADUA BAJO RIESGO
 P/ VALORACION POR NUTRICION
 P/ ECOCARDIOGRAMA TT
 P/ CULTIVO DE ESPUTO ((MUESTRA NO TOMADA)
 P/ GeneXpert MTB/RIF (MUESTRA NO TOMADA)
 P/ CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS (AMARILLA)
 CONTROL DE SIGNOS VITALES, AMSAR CAMBIOS

Fecha: 31/03/2022

Indicaciones:

- HOSPITALIZAR EN SALA DE INFECTOLOGÍA
- MASCARILLA N95 PERMANENTE
- AISLAMIENTO RESPIRATORIO
- DIETA CORRIENTE
- TAPON VENOSO
- OXIGENOTERAPIA POR CANULA NASAL PARA SATO2 MAYOR A 88%
- TRAMADOL 50 MG IV CADA 12 HORAS
- RIPE 4 TAB VO CADA 24 HORAS **FECHA DE SOLICITUD 16/01/22, (RECIBIO 19-20-26) FECHA DE REINICIO: 26/01/22*** (NO RECIBIO DEL DIA 12 Y 13, 14, 15)*** REINICIO 17/02 D51/56
- PIRIDOXINA TAB 50 MG VO CADA 24 H
- SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 4 HORAS
- BROMURO DE IPRATROPIO INH 4 PUFF CADA 4 HORAS
- OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS
- ENOXAPARINA 40 MG SC CADA DIAS
- FUROSEMIDA 20 MG IV CADA 8 HORAS
- ACETAMINOFEN 1 GR VO CADA 8 HRS

SS HEMOGRAMA, AST, ALT, IONOGRAMA, BUN, CREAT **NUEVO** FS31/03/22

- P BACILOSCOPIA X3 FS30/03/22 (REPORTADS #1)
- TERAPIA RESPIRATORIA DIARIA
- CONTROL DE SIGNOS VITALES Y AMSAR CAMBIOS
- CONTROL DE LIQUIDOS ADMISINSTRADOS Y ELIMINADOS
- SEGUIMIENTO POR MEDICINA INTERNA E INFECTOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL

PENDIENTE

P HEMOGRAMA FS29/03/22

P HOSTAL FS14/03/22

CULTIVO DE ESPUTO (MUESTRA NO TOMADA)

GeneXpert MTB/RIF (MUESTRA NO TOMADA)

CULTIVO DE ESPUTO PARA MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS (AMARILLA)

Fecha: 31/03/2022

Indicaciones:

ALIMENTO HIPERPROTEICO, DENSAMENTE CALORICO CON HMB Y ALTO CONTENIDO DE VITAMINA D PARA USO ESPECIAL EN ADULTO MAYOR CON DESNUTRICION MODERADA O SEVERA EN CONDICION DE HOSPITALIZACION Y/O CON RECIENTE ALTA HOSPITALARIA - ENSURE CLINICAL. BOTELLA DE 220 ML DAR DOS AL DIA HORARIO 10:00 Y 3:00 PM

Fecha: 31/03/2022

Indicaciones:

SE SOLICITA OXIGENO DOMICILIARIO A 3LITROS POR MINUTO

Justificación de indicaciones Terapéuticas:

Complicaciones:

NO

Servicio de Egreso: 000014|Hospitalización 4to Piso

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:58:35 p. m.

Admisión: AD706188

Administradora: ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S.

Paciente: ANDERSON CASTILLO CARMONA

EPICRISIS

Fecha de Egreso: 13/04/2022 19:34

Motivo de Salida: Traslado

Estado a la Salida:

Vivo

DIAGNÓSTICOS DE SALIDA:

Diagnóstico Principal: A169 : TUBERCULOSIS RESPIRATORIA NO ESPECIFICADA, SIN MENCIÓN DE CONFIRMACIÓN BACTERIOLOGICA O HISTOLOGICA

Diagnóstico Relacionado 1: J158 : OTRAS NEUMONIAS BACTERIANAS

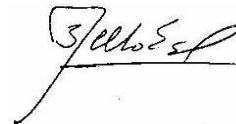
PLAN ATENCIÓN INTEGRAL POR MEDICINA:**Tratamiento Farmacológico:**

- TRASLADO A HOSTAL
- MASCARILLA N95 PERMANENTE
- AISLAMIENTO RESPIRATORIO
- DIETA CORRIENTE
- TAPON VENOSO
- OXIGENOTERAPIA POR CANULA NASAL PARA SATO2 MAYOR A 88%
- TRAMADOL 50 MG IV CADA 12 HORAS***EN CASO DE DOLOR****
- TERAPIA RIPE 3 TABLETAS VO CADA 24 HORAS **FECHA DE SOLICITUD 16/01/22, (RECIBIO 19-20-26) FECHA DE REINICIO: 26/01/22*** (NO RECIBIO DEL DIA 12 Y 13, 14, 15)*** REINICIO 17/02 D52/56 ***DOSIS 69 HOY 12/04/2022****
- PIRIDOXINA TAB 50 MG VO CADA 24 H
- SALBUTAMOL INH 4 PUFF CADA 4 HORAS
- BROMURO DE IPRATROPIO INH 4 PUFF CADA 4 HORAS
- OMEPRAZOL 20 MG VO CADA 24 HORAS
- ENOXAPARINA 40 MG SC CADA DIAS
- FUROSEMIDA 40 MG VO CADA 24 HORAS
- ACETAMINOFEN 1 GR VIA ORAL POR FIEBRE O DOLOR
- P BACILOSCIPIA X3 FS:30/03/22 (REPORTADA#1) 02/04/2022 Positiva
- TERAPIA RESPIRATORIA DIARIA
- CONTROL DE SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS
- CONTROL DE LIQUIDOS ADMISINSTRADOS Y ELIMINADOS
- SEGUIMIENTO POR MEDICINA INTERNA E INFECTOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL

Recomendaciones Adicionales:

- TERAPIA RESPIRATORIA DIARIA
- CONTROL DE SIGNOS VITALES Y AVISAR CAMBIOS
- CONTROL DE LIQUIDOS ADMISINSTRADOS Y ELIMINADOS
- SEGUIMIENTO POR MEDICINA INTERNA E INFECTOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL

Aplica Cuidados de Enfermería: No



ARIEL ALONSO BELLO ESPINOSA
MEDICINA INTERNA

CC.73094962 - RM.RM 0014 - CC 73094962